



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

RAYANE DE LIMA BRASIL

**“ESTÃO COBERTAS DE VÍRUS E QUASE MORIBUNDAS”: SECA, SAÚDE E
DOENÇAS NA PARAHYBA DO NORTE (1877-1880)**

JOÃO PESSOA - PB

2026

**“ESTÃO COBERTAS DE VÍRUS E QUASE MORIBUNDAS”: SECA, SAÚDE E
DOENÇAS NA PARAHYBA DO NORTE (1877-1880)**

RAYANE DE LIMA BRASIL

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba-UEPB, na área de concentração em História e Cultura Histórica, em cumprimento às exigências para obtenção do título de Mestra em História.

Orientadora Profa. Dra. Serioja R. C. Mariano
Área de Concentração: História e Cultura Histórica
Linha de Pesquisa: História e Regionalidades

JOÃO PESSOA - PB

2026

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

B823e Brasil, Rayane de Lima.

"Estão cobertas de vírus e quase moribundas" : seca, saúde e doenças na Parahyba do Norte (1877-1880) / Rayane de Lima Brasil. - João Pessoa, 2026.
294 f. : il.

Orientação: Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano.
Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCHLA.

1. História da Paraíba. 2. História da saúde - Paraíba - 1877-1880. 3. História das doenças - Paraíba - 1877-1880. 4. Seca - Paraíba - 1877-1879. 5. Parahyba do Norte - 1877-1880. I. Mariano, Serioja Rodrigues Cordeiro. II. Título.

UFPB/BC

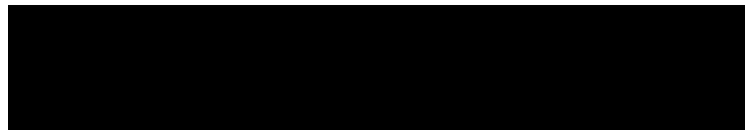
CDU 930.2(813.3)(043)

RAYANE DE LIMA BRASIL

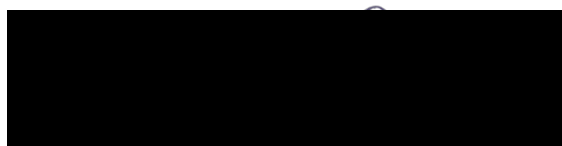
**“ESTÃO COBERTAS DE VÍRUS E QUASE MORIBUNDAS”: SECA, SAÚDE E
DOENÇAS NA PARAHYBA DO NORTE (1877-1880)**

Dissertação de Mestrado avaliada em 23/02/2026, com conceito APROVADO e recomendação para publicação.

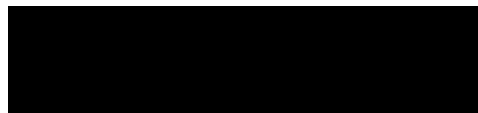
BANCA EXAMINADORA



Profª. Dra. Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano
(Orientadora – PPGH/CCHLA/UFPB)



Prof. Dr. Jucieldo Ferreira Alexandre
(Examinador Externo – PPGB-UFGA)



Profª. Dra. Arianne Norma de Menezes Sá
(Examinadora Interna – PPGH-UFPB)

Aos meus pais, Josinaldo e Rosiane, por tudo, hoje
e sempre.

AGRADECIMENTOS

Antes de agradecer àqueles que, de um modo ou de outro, contribuíram para a realização desta dissertação, gostaria de agradecer a Deus, que me deu forças para não desistir no meio dessa jornada.

Aos meus pais, Josinaldo e Rosiane, que sempre acreditaram em mim e me apoiaram desde sempre. Com o amor e o cuidado que vocês têm por mim, concluo mais essa etapa. Jamais vou me esquecer do suporte que me deram em todas as fases da minha vida, a mais recente delas, no processo seletivo do doutorado, em que vocês estavam mais empolgados do que eu mesma! Amo vocês, de todo o meu coração.

À minha irmã, meu xodozinho, a futura geógrafa da família, Jamilly. Amo você. Obrigada por ter sido meu outro apoio. Toda a sua ajuda, desde as considerações sobre como a Geografia poderia contribuir para esta dissertação, foi de grande importância. Obrigada também pelos momentos de descontração com as pérolas do BL 11.

À minha vó Rita, amo você. Obrigada por tudo!

À minha orientadora, Serioja Mariano, que sempre acreditou em mim e me acompanhou em todas as etapas de elaboração e conclusão desta dissertação. Sem dúvidas, somos a “dupla da seca”. Obrigada por toda a compreensão. Você é, e sempre será, minha referência como professora. Inclusive, sinto saudades das suas aulas.

Aos meus cachorrinhos, que são minha terapia: Pitucha (Pipi) e Loki (Lokinho).

Às minhas tias do coração, Lu e Hozana.

Aos professores Jucieldo Alexandre e Ariane Sá, pela disponibilidade em participar da banca de defesa e pelas contribuições a esta dissertação.

À minha turma do mestrado de 2024: vocês são incríveis! Obrigada por cada risada.

Ao Programa de Pós-Graduação em História, em especial aos(às) professores(as) Guilherme Queiroz, Tiago Bernardon, Solange Rocha e Nayana Mariano.

Ao Luka Romão, meu grande amigo, obrigado por estar sempre presente.

À Thalita, minha amiga de sempre. Amo você! Mal posso esperar para comemorarmos essa conquista juntas. Precisamos marcar nossos 300 encontros que estou te devendo, mas agora que somos vizinhas você pode vir me cobrar pessoalmente.

À Malu, minha dupla de qualquer trabalho sobre qualquer tema aleatório. Você surge com vários eventos para a gente apresentar e publicar, não tenho paz! Brincadeiras à parte, obrigada pela escuta, pelos conselhos e contribuições que foram importantes nesta pesquisa.

À Vera, minha outra dupla para qualquer hora. Amiga, obrigada por tudo. A “senhora” é fantástica. Desde a graduação, você tem sido a pessoa com quem posso contar. Já estou com saudades das nossas conversas no ônibus sobre qualquer assunto aleatório possível.

À Ana Paula, com quem pude compartilhar algumas inquietações sobre o tema. Obrigada pelos *podcasts* de madrugada sobre filmes e séries que provavelmente não vou assistir, mas amei saber de cada detalhe.

À Íris Laryssa, que me auxiliou na elaboração dos mapas.

Aos integrantes do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista (GPSCNO).

Aos funcionários do Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte, em especial ao “Seu Pedro”, sempre muito atencioso e paciente.

À família do boxe e muay thai: Prof. Joãozinho, Prof. Felipe, Didiu e Graci. Vocês são incríveis. Todo esse processo ficou mais leve com vocês, de segunda a sexta-feira.

Por fim, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), pelo apoio financeiro concedido por meio da bolsa, sem a qual não teria sido possível concluir este trabalho.

RESUMO

Esta dissertação analisa as condições de vida e saúde da população da Parahyba do Norte entre os anos de 1877 e 1880, no contexto que abrange a chamada “Grande Seca” de 1877-1879. Inserida no campo da História da Saúde e das Doenças, a pesquisa investiga as principais medidas de assistência à saúde, alimentação e moradia direcionadas tanto a população residente quanto as pessoas em deslocamento, aqui compreendidas analiticamente como migrantes, ambas afetadas, ainda que de formas distintas, pelos efeitos da seca. O estudo problematiza as representações construídas sobre esses migrantes nas fontes administrativas, médicas e jornalísticas, bem como as normas de higiene, as práticas de cura e as principais causas de morte do período. Consideramos, ainda, os fluxos migratórios do Sertão para as demais mesorregiões da Parahyba e, posteriormente, os movimentos de retorno ao interior a partir de 1880, bem como as políticas públicas de combate às secas, a exemplo da construção de açudes e centros emergenciais de apoio, como enfermarias, hospitais e núcleos coloniais. A análise dialoga com a Nova História Cultural e Social, mobilizando conceitos como representações sociais, para compreender as formas como os migrantes foram retratados nas fontes; biopolítica, para examinar os mecanismos de controle sobre a saúde coletiva; e culturas políticas, para interpretar as ações e discursos do governo diante da crise. O conceito de redes de sociabilidade e experiência são utilizados para identificar os vínculos familiares, institucionais e as relações de trabalho formadas nesse contexto. A abordagem metodológica está ancorada na Demografia Histórica, especialmente no uso sistemático dos Registros Paroquiais de Óbitos, que possibilitam reconstituir perfis etários, padrões de mortalidade e os efeitos da seca sobre os grupos sociais mais vulneráveis. Esse conjunto de fontes é complementado por relatórios médicos, correspondências, mapas estatísticos hospitalares, documentos administrativos e periódicos da época. Ao ampliar o recorte para o ano de 1880, a dissertação demonstra que os efeitos da seca ultrapassaram seu término climático, revelando a permanência de doenças, a precariedade das condições de vida e os limites das políticas públicas de assistência no pós-seca. Dessa forma, o trabalho contribui para a historiografia ao evidenciar a seca como uma crise social e sanitária historicamente produzida, marcada por profundas desigualdades e por experiências de adoecimento, sofrimento e resistência.

Palavras-chave: saúde; migrantes; doenças; seca; Parahyba do Norte.

ABSTRACT

This dissertation analyzes the living and health conditions of the population of Paraíba do Norte between 1877 and 1880, within the context of the so-called "Great Drought" of 1877-1879. Situated within the field of the History of Health and Disease, the research investigates the main measures of healthcare, food, and housing assistance directed at both the resident population and those in displacement, analytically understood here as migrants, both affected, albeit in different ways, by the effects of the drought. The study problematizes the representations constructed about these migrants in administrative, medical, and journalistic sources, as well as hygiene standards, healing practices, and the main causes of death during this period. We also consider the migratory flows from the Sertão region to the other mesoregions of Paraíba and, subsequently, the return movements to the interior from 1880 onwards, as well as public policies to combat droughts, such as the construction of dams and emergency support centers, like infirmaries, hospitals, and colonial settlements. The analysis engages with the New Cultural and Social History, mobilizing concepts such as social representations, to understand how migrants were portrayed in the sources; biopolitics, to examine the mechanisms of control over collective health; and political cultures, to interpret the government's actions and discourses in the face of the crisis. The concept of networks of sociability and experience is used to identify family and institutional ties and work relationships formed in this context. The methodological approach is anchored in Historical Demography, especially in the systematic use of Parish Death Registers, which make it possible to reconstruct age profiles, mortality patterns, and the effects of drought on the most vulnerable social groups. This set of sources is complemented by medical reports, correspondence, hospital statistical maps, administrative documents, and periodicals from the time. By broadening the scope to the year 1880, the dissertation demonstrates that the effects of the drought extended beyond its climatic end, revealing the persistence of diseases, the precariousness of living conditions, and the limitations of public assistance policies in the post-drought period. In this way, the work contributes to historiography by highlighting the drought as a historically produced social and sanitary crisis, marked by profound inequalities and experiences of illness, suffering, and resistance.

Keywords: health; migrants; diseases; drought; Parahyba do Norte.

LISTA DE ABREVIATURAS

AHWBD	–	Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte
N/i	–	Não identificado
S/d	–	Sem data
SCMPB	–	Santa Casa da Misericórdia da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa da Província da Parahyba do Norte (1868), com destaque para as mesorregiões	65
Figura 2 – Mapa dos Fluxos Migratórios dos Trabalhadores Empregados em Obras Públicas na Parahyba (1879).....	102
Figura 3 – Mapa dos Fluxos Migratórios dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte Empregados em Obras Públicas na Parahyba do Norte (1879).....	104
Figura 4 – Planta da Escola Pública Proposta pela Comissão de Socorros de Sousa (1878).	112
Figura 5 – Mapa de Distribuição dos Gêneros Alimentícios na Província da Parahyba (1877-1879).....	129
Figura 6 – Municípios da Parahyba afetados por febres diversas (1877-1879)	182
Figura 7 – Envio de ambulâncias com medicamentos aos municípios da Parahyba (1877-1879)	213
Figura 8 – Planta da Represa de Poços da Vila do Teixeira (1879)	255

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1– Distribuição etária dos óbitos por sexo – Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877-1879)	
.....	168
Gráfico 2 – Composição dos registros de óbitos por cor em Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877-1879).....	175

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – População dos Municípios da Parahyba do Norte (1872) identificados no Mapa 1 por numeração	66
Quadro 2 – Lista dos gêneros alimentícios enviados para as comarcas e vilas da Parahyba (1878)	127
Quadro 3 – Distribuição das doenças tratadas no Hospital de São Pedro em Mamanguape (1879)	151
Quadro 4 – Distribuição das doenças tratadas no Hospital de Areia (1879).....	154
Quadro 5 – Principais causas de morte por sexo nos municípios de Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877–1879)	169
Quadro 6 – Médicos que atuaram durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba.....	185
Quadro 7 – Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos na Comarca de Mamanguape (1877 e 1879)	196
Quadro 8 – Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos em Pitimbu (1879)	201
Quadro 9 – Lista de Medicamentos solicitados pelo Hospital de Areia (1879).....	205
Quadro 10 – Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos no Hospital dos Variolosos em Santa Rita (1879)	207
Quadro 11 – Lista dos práticos que atuaram durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba	208
Quadro 12 – Movimento dos doentes no Hospital da Cruz do Peixe (dezembro de 1879)....	231
Quadro 13 – Movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe (jan.–abr. 1880)	233
Quadro 14 – Núcleos coloniais fundados durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba do Norte (1880)	239

SUMÁRIO

1 OS PERCURSOS DA PESQUISA	15
1.1 NARRATIVAS DA SECA: CONSTRUÇÕES E SILÊNCIOS NA HISTORIOGRAFIA	25
1.2 DIÁLOGOS LITERÁRIOS E HISTORIOGRÁFICOS SOBRE A SAÚDE E AS DOENÇAS	40
1.3 DA REFLEXÃO À CONSTRUÇÃO: CONCEITOS, FONTES E METODOLOGIAS...	54
2 “DEVASTANDO A POPULAÇÃO E CEIFANDO MILHARES DE VIDA”: O INÍCIO DA SECA DE 1877-1879 NA PARAHYBA DO NORTE	63
2.1 “TÊM ENTRADO CADÁVERES AMBULANTES QUE SÓ TÊM A PELE E OS OSSOS”: A PROVÍNCIA DA PARAHYBA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX	64
2.2 “SEJA LIVRE SUA INCLUSÃO, SE NÃO FOREM ACTIVOS, E BEM COMPORTADOS”: AS RELAÇÕES DE TRABALHO NOS NÚCLEOS COLONIAIS DA PARAHYBA EM 1877-1879	88
2.2.1 “FAÇA-SE DESAPARECER A FEBRE-AMARELLA, A BÉRI-BÉRI”: OS CONGRESSOS AGRÍCOLAS DE 1878 E O ENSINO AGRÍCOLA NA PARAHYBA DO NORTE	105
2.3 “NUNCA CHEGOU [...] RELAÇÃO ALGUMA DAS PESSOAS QUE TEM RECEBIDO SOCORROS”: AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO NO CONTEXTO DA SECA.	113
2.3.1 “OS RECURSOS FORAM TAMBÉM ESCASSEANDO EM TODAS AS LOCALIDADES”: A REPRESENTAÇÃO DOS DEPUTADOS PARAHYBANOS NO PARLAMENTO BRASILEIRO	131
3 “EXTENUADOS DE FOME, CANSAÇO E MISÉRIA”: ASPECTOS SOBRE A SAÚDE, AS DOENÇAS E A MEDICINA	141
3.1 “ERAM DESVALIDOS, INDIGENTES E FLAGELADOS”: AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO PARAHYBANA	142
3.2 “A FOME, A NUDEZ E AS MOLÉSTIAS CONTINUAM A FAZER VÍCTIMAS”: AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE ENTRE 1877 À 1879	166
3.3 “TALVEZ IMERECIDAMENTE, AOS MEUS CUIDADOS NA MEDICINA”: SABERES MÉDICOS, PRÁTICAS DE CURA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.....	184
4 “IRREGULARIDADE DE CONDUTA E MAUS COSTUMES”: O CAMINHO DE VOLTA PARA CASA EM 1880	218
4.1 “TODA MASSA POPULAR TINHA A SAÚDE COMPLETAMENTE ARRUINADA”: AS DOENÇAS QUE AINDA GRASSAVAM NA PROVÍNCIA	219
4.2 “OS QUE FORÃO RICOS JÁ ESTARÃO POBRES, E OS ABASTADOS, MENDIGOS”: O TÉRMINO DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA E O RETORNO DOS MIGRANTES PARA CASA	235
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	264
REFERÊNCIAS	266

1 OS PERCURSOS DA PESQUISA

18 de abril de 1877. Era uma época difícil naquela província, castigada pela seca. Vicente, preso na Cadeia da Capital¹, acompanhava à distância a situação de sua família, que se viu forçada a migrar para a capital em busca de sobrevivência². Sua esposa e seus cinco filhos viviam abandonados em uma velha choupana, até que foram atingidos por uma terrível doença: a varíola. As condições eram tão precárias que as crianças estavam deitadas no chão, doentes e sem qualquer ajuda (Inspetoria de Saúde Pública da Parahiba, AHWBD, 18/05/1877).

Ao tomar conhecimento da situação, o Inspetor de Saúde Pública, Dr. Abdon Felinto Milanez, foi até o local para verificar o estado da família. O médico temia que os transferir para o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, no centro da cidade, pudesse espalhar a doença e colocar em risco a saúde de muitas outras pessoas. Pensando nisso, e com base nas teorias dos miasmas e dos contágios, o Dr. Milanez tomou uma decisão: alugou uma casa em uma área mais afastada e em melhores condições, buscando proteger tanto a saúde pública quanto a própria família. Ele providenciou camas, travesseiros e cobertores doados pela enfermaria da Cadeia, e designou enfermeiros para cuidar dos doentes e aplicar os remédios necessários (Inspetoria de Saúde Pública da Parahiba, AHWBD, 18/05/1877).

Histórias como a da família de Vicente revelam não apenas as precárias condições de vida e saúde da população na província da Parahyba no século XIX, mas também evidenciam como episódios de crise sanitária, epidêmica e climática mobilizaram ações, saberes e decisões institucionais. A aproximação com esse tipo de fonte histórica despertou, ainda na graduação, o interesse pelas dinâmicas que envolvem a saúde e as doenças, consolidado por meio da análise de um amplo acervo documental.

Desde então, buscamos compreender como diferentes grupos sociais foram afetados por epidemias e de que forma as práticas de cuidado, os discursos médico-higienistas e as ações do poder público se articularam aos aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais de cada época. Esse percurso investigativo permitiu reconhecer a temática como uma chave de leitura para interpretar experiências históricas mais amplas, revelando conflitos, desigualdades e formas de organização coletiva diante do adoecimento e da cura.

¹ Ao fazermos referência à Capital, então conhecida como Cidade da Parahyba, optamos por manter a grafia da época: “Parahyba”. Os documentos transcritos também seguirão esse critério.

² Inspetoria de Saúde Pública da Parahiba, em 18 de maio de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Em 2020, esse interesse ganhou forma nas discussões do Grupo de Pesquisa *Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista*³ e nas investigações do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFPB), coordenado pela Profa. Dra. Serioja R. C. Mariano. No plano de trabalho, intitulado *As condições de saúde da população escravizada durante as epidemias do cólera na Paraíba (1856-1862)*⁴, exploramos o modo como o cólera e outras doenças afetaram a saúde dos (as) escravizados (as), além de examinar a atuação médica e as práticas populares no cuidado aos (às) enfermos (as).

No segundo ano de Iniciação Científica, em 2022, o tema desta pesquisa de dissertação começou a ser desenvolvido no plano de trabalho⁵ acerca das *Doenças na Paraíba do Norte no Contexto da Seca de 1877-1879*.⁶ Por se tratar de uma abordagem ainda pouco explorada, iniciamos a coleta e catalogação de fontes nos arquivos físicos e digitais, com o objetivo de examinar os efeitos da seca sobre a saúde da população da Província da Parahyba, mapeando as principais doenças e as estratégias mobilizadas para lidar com a situação.

Essas discussões iniciais permitiram o aprofundamento da temática, que deu origem à monografia: *Tudo é Consternação, Miséria e Desespero: Seca e Doenças na Província da Parahyba na Década de 1870* (2023). A análise dos casos de doenças e mortes concentrou-se na chamada “Grande Seca” de 1877-1879, com foco na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no município de Areia. A escolha dessa localidade se deu em razão da disponibilidade documental e da própria historiografia, que apontam para os elevados números de mortes e de enfermos na região do Brejo, que apontam para aproximadamente duas mil mortes durante o período da seca.⁷

³ Coordenado pelas professoras Serioja Mariano e Ariane Sá.

⁴ Como fruto desta pesquisa, citamos o artigo: BRASIL, R. L.; MARIANO, S. R.C. A Saúde e as Doenças da População Escravizada nos anúncios de jornais da Paraíba (1850-1869). In: **XX Encontro Estadual de História: Independência, Revoluções e Modernismos**. João Pessoa: Editora do CCTA, 2022. v. 1. p. 767-776.

⁵ Ambos os planos estão vinculados ao Projeto de Pesquisa *Adoecer e Morrer na Província da Paraíba na Segunda Metade do Oitocentos*. Coordenado e orientado pela Profa. Dra. Serioja Mariano.

⁶ Para mais informações sobre os resultados desta pesquisa, ver: MARIANO, Serioja R. C.; BRASIL, R. L. Peste, Fome e Miséria: Doenças na Parahyba do Norte Durante a Seca de 1877-1879. In: CASTRO, T. C.; FARIAS, A. E. M.; SILVA, M. L. E. (Org.). **Pesquisa histórica em perspectiva: cultura, sociedade e política**. 1ª ed. Campina Grande/PB: Ampila Editora, 2023, v. 01, p. 58-74; BRASIL, R. L.; MARIANO, S. R. C. *Em todas as ruas veem-se cadáveres ambulantes e nus sem forças para implorarem uma esmola [...]. a morte tem arrebatado muitas vidas: Doenças na Parahyba no Contexto da Seca de 1877-1879*. **Revista Espacialidades**, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 704-720, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/espacialidades/article/view/38462>. Acesso em: 19 jun. 2025.

⁷ Essas e outras análises como a atuação médica e o tratamento dos enfermos da Santa Casa da Misericórdia, ver: BRASIL, Rayane de Lima. **Tudo é Consternação, Miséria e Desespero: Seca e Doenças na Província da Parahyba na Década de 1870**. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal da Paraíba (UFPB). João Pessoa, 2023.

Em relação ao tema desta dissertação, é importante lembrar que, ao longo do século XIX, inúmeros episódios de estiagens assolaram as regiões do Norte (atual Nordeste)⁸ - Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Piauí e Sergipe (Guerra & Guerra, 1980). A mais devastadora de todas ficou conhecida na historiografia brasileira como a “Grande Seca” de 1877-1879, que durou três anos e resultou em um cenário crítico de escassez de água, alimentos e rebanhos.

Esse quadro levou a população atingida por essa calamidade a realizar fluxos migratórios tanto intrarregionais (com deslocamentos do Sertão e da Borborema em direção ao Agreste e à capital Parahybana) quanto inter-regionais (entre as províncias da Parahyba, Ceará e Rio Grande do Norte), em busca de recursos, abrigo e assistência oferecida pelo governo (Almeida, J., 2012 [1923]; Albuquerque Jr., 1988a).

Sendo assim, essa dissertação tem como objetivo analisar as condições de vida e saúde da população da Parahyba do Norte, durante os anos de 1877 a 1880, no contexto que abrange a tão “temível Grande Seca” de 1877-1879.

A opção pelo uso do termo “migrantes”, em vez de retirantes, pode causar estranhamento ao leitor, motivo pelo qual se faz necessária uma breve justificativa. Em contato com a documentação da época, observamos que os deslocamentos não se davam exclusivamente de forma linear ou unidirecional, do sertão para o litoral, como sugere a imagem cristalizada nos romances literários que têm no retirante⁹ seu personagem central.

O termo “retirante”, nesse contexto, carrega forte carga simbólica e um caráter reducionista, sendo frequentemente associado à figura do sertanejo pobre em deslocamento rumo às capitais das províncias. Nas narrativas literárias, jornalísticas e administrativas do período, esse deslocamento aparece predominantemente descrito como resposta imediata à seca, à fome e à miséria, enfatizando o sofrimento e a vulnerabilidade desses sujeitos. Tal enquadramento tende a construir o “retirante” como figura passiva não no sentido de ausência de ação, mas enquanto sujeito cujas experiências são narradas a partir dos efeitos da catástrofe, e não das decisões cotidianas, dos arranjos possíveis e das práticas de sobrevivência que atravessaram esses percursos.

⁸ De acordo com Albuquerque Jr. (2011, p. 81): “O termo Nordeste é usado inicialmente para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), criada em 1919”.

⁹ Importa esclarecer, ainda, que quando o termo “retirantes” aparecer neste trabalho, será para preservar a linguagem original de fontes primárias ou de autores que utilizaram essa denominação em suas obras. Nessas situações, optamos por manter o vocabulário empregado nos textos analisados, respeitando o contexto e o pensamento de cada autor, sem que isso represente uma adesão ao uso do termo como categoria analítica central desta pesquisa.

Nosso entendimento também dialoga com as contribuições de Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011), ao demonstrar como os discursos produzidos sobre a região hoje conhecida como Nordeste foram historicamente atravessados por imagens simbólicas recorrentes, presentes, por exemplo, nas obras de Josué de Castro e Graciliano Ramos, bem como no imaginário construído em torno da seca de 1877, visível nos escritos de José do Patrocínio e Rodolfo Teófilo. Nessas formulações, o “retirante” emerge como emblema do sofrimento coletivo, frequentemente apresentado como objeto das circunstâncias extremas, o que contribui para o apagamento das dinâmicas de circulação, trabalho e negociação que também marcaram essas trajetórias.

Nesta pesquisa, optamos pelo uso do termo “migrantes” para evitar reforçar uma leitura estereotipada dos sujeitos em movimento, ampliando a compreensão sobre a diversidade de trajetórias, origens e destinos dos indivíduos e famílias afetados pela seca. A adoção do conceito de migrantes constitui uma das principais contribuições analíticas desta dissertação, pois desloca o foco da condição de vítima para a experiência histórica do deslocamento e suas múltiplas dimensões sociais, políticas e econômicas, expressas nas constantes movimentações em busca de trabalho, alimentos, cuidados médicos e outras formas de amparo.

Uma das propostas deste trabalho é justamente ampliar o olhar sobre os espaços percorridos e os sujeitos em trânsito. O termo “migrantes”, utilizado no plural ao longo do texto, refere-se tanto aos deslocamentos intrarregionais quanto inter-regionais, compreendendo o movimento de famílias entre diversas localidades da Parahyba e de províncias vizinhas, como também os fluxos internos dentro do próprio território provincial.

Muitos dos sujeitos referenciados nas fontes eram naturais da Parahyba, deslocando-se entre as zonas do Sertão, Agreste, Borborema e Mata, ou de províncias vizinhas como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí de acordo com as condições climáticas e a possibilidade de obtenção de auxílios emergenciais.

Para fundamentar essa escolha, recorreremos ao campo da Geografia da População, no trabalho *Ser migrante: implicações territoriais e existenciais da migração*, de Marandola Jr. e Dal Gallo (2010), que propõem uma abordagem fenomenológica e existencial da migração, compreendendo-a como um processo de ruptura da relação entre o sujeito e o lugar, capaz de abalar profundamente a identidade territorial e a segurança existencial do indivíduo. Ainda que voltado prioritariamente para as migrações contemporâneas, o artigo oferece um referencial teórico útil para pensarmos o impacto do deslocamento forçado sobre os sujeitos

históricos da seca, como no que diz respeito à perda de vínculos afetivos com seus territórios de origem e à necessidade de reconstrução de pertencimentos aos locais de destino.

Entretanto, reconhecemos os limites de transposição direta entre os contextos: o estudo de Marandola Jr. e Dal Gallo se debruça sobre fluxos internacionais recentes e incorpora conceitos da modernidade líquida, que não se aplicam de forma literal ao século XIX. Ainda assim, sua ênfase na territorialização, nas redes sociais e na experiência subjetiva dos deslocamentos nos permite refletir, com cuidado metodológico, sobre a complexidade dos movimentos migratórios em períodos históricos distintos, inclusive em situações marcadas por crises ambientais e colapso social, como a “grande seca”.

Já o termo *população*, será usado de forma mais ampla, incluindo tanto os migrantes quanto os habitantes que já residiam na capital da província e que também foram afetados pelos impactos da seca, das epidemias e da precariedade dos serviços públicos. Essa escolha busca evitar generalizações, pois entendemos a migração como um processo social amplo e multifacetado, marcado por motivações diversas e trajetórias múltiplas.

Cabe ainda trazer outras reflexões acerca do uso desses termos, como aquelas propostas por Daniel Macêdo (2024), cuja análise das categorias “retirante” e “flagelado” oferece uma contribuição importante ao demonstrar que tais denominações não operam como sinônimos naturais, mas como construções discursivas situadas, atravessadas pelas condições de possibilidade do espaço urbano e pelas sensibilidades dos sujeitos que as enunciam. Ao examinar os escritos de Rodolpho Teóphilo e José do Patrocínio, o autor evidencia como o termo “retirante” tende a designar a condição de deslocamento e de não pertencimento do sertanejo na cidade, enquanto “flagelado” assume uma carga moral mais intensa, associada à ideia de decadência, corrupção e ameaça à ordem urbana.

Sem desconsiderar a distinção conceitual apontada pela literatura, a análise aqui desenvolvida, apoiada entre fontes administrativas, relatórios oficiais e registros produzidos no âmbito da capital da província da Parahyba do Norte, permite observar um uso menos estabilizado e mais fluido dessas denominações. Nessas fontes, termos como “flagelado”, “indigente” e “ocioso” aparecem frequentemente sobrepostos, acionados não tanto para diferenciar experiências migratórias, mas para qualificar negativamente a presença desses sujeitos nos espaços urbanos.

Ainda que, em raros momentos, surja a designação “emigrante”, prevalece a nomeação associada à miséria, à desordem e ao incômodo social atribuído a esses indivíduos. Tal imprecisão vocabular sugere que, no plano da administração provincial, a nomeação operava prioritariamente como instrumento de deslegitimação social e de controle, mais do que como

categoria analítica coerente, revelando como os sentidos dessas palavras variavam conforme os interesses, os contextos e as disputas em torno da permanência dos migrantes na cidade e em seus arredores.

A partir destas considerações iniciais, esta dissertação busca investigar e discutir algumas questões ausentes na historiografia da Parahyba: Quais as condições de vida, higiene e saúde dessa população? Quais as doenças recorrentes? Quem eram esses migrantes? Quais as experiências e relações de trabalho formadas? Quais as medidas de assistência médica e de combate às secas que foram criadas pelas autoridades públicas da Parahyba? Problematisações que pretendemos explorar nesta dissertação.

José Américo de Almeida, já chamava atenção para a ausência de referências sobre a seca na Parahyba. Como ele próprio observou: “[...] os cearenses já registraram em livros minudentes os lances desses supremos desastres. **O martírio dos paraibanos ainda se acha,** porém, a bem dizer, **inédito**” (Almeida, J., 2012 [1923], p. 137, Grifos nossos). Como exploraremos mais à frente, poucos são os trabalhos que abordam sobre esse “martírio”, a saúde e as doenças. Pouco se sabe sobre os migrantes que chegavam à capital ou partiam para outras regiões vizinhas, diante de uma seca prolongada que se transformou em um “problema social” nunca visto antes.

Portanto, esta pesquisa propõe-se a preencher essas possíveis lacunas por meio de uma discussão historiográfica já produzida sobre o tema da seca e da história da saúde e das doenças. Inspirada pelos objetivos e pelas reflexões da História Cultural, com aportes da História Social, a análise se apoia em três eixos conceituais principais: o conceito de *representações sociais* para compreender como a população atingida foi descrita nos discursos oficiais, médicos e da imprensa. O campo das *práticas e ações institucionais*, com base nos conceitos de *biopolítica*, no sentido da regulação dos corpos pela ação estatal, e de *culturas políticas*, no que se refere às formas de atuação e posicionamento dos médicos e autoridades políticas diante da crise.

Embora não constitua o eixo central da pesquisa, a vivência dos sujeitos históricos também foi considerada, com base no conceito de *experiência*, que permite refletir sobre as formas de existência, sofrimento e apagamento daqueles que enfrentaram a seca de 1877–1879, como os migrantes. Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa adota uma abordagem histórico-qualitativa, apoiada na *Demografia Histórica*, já que as fontes permitem uma análise mais ampla sobre a seca de 1877-1879, não apenas restrita ao Litoral. Para enriquecer essa abordagem, emprega-se também o conceito de *redes de sociabilidade*,

entendido como o conjunto de laços afetivos, políticos e culturais que conectam os indivíduos entre si em contextos sociais e históricos específicos.

Buscamos, ainda, identificar os fatores que envolvem as motivações e os destinos dos fluxos migratórios, bem como a trajetória, os limites e as dificuldades enfrentadas pelos migrantes ao chegarem às localidades nas quais esperavam encontrar meios mínimos de subsistência (em termos de alimentação e abrigo). Essas abordagens só se tornaram possíveis graças à diversidade e à riqueza das fontes encontradas no Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD)¹⁰, muitas das quais ainda não foram analisadas pela historiografia ou por trabalhos acadêmicos recentes, o que permite uma tentativa aproximada das representações do contexto social em que essa população estava inserida.

Quando pensamos em uma temporalidade e seus respectivos acontecimentos históricos, lidamos com o que compreendemos por *cultura histórica*¹¹ – o conjunto de práticas, representações, e narrativas que configuram o conhecimento histórico, os saberes e diferentes expressões culturais do passado de uma sociedade sob uma nova perspectiva que ultrapassa o espaço acadêmico (Flores, 2007).

Além disso, a dissertação está concentrada na *Linha de Pesquisa História e Regionalidades* do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UFPB), e se caracteriza por sua dimensão de representação, “na medida em que Região é um conceito que se remete ao de território”, e de territorialidades como “conceito que remete a poder e cultura, Poder e Cultura são conceitos que remetem à História. Pois que não há Cultura Histórica desterritorializada” (Silveira, 2007, p. 39-40). Neste sentido, concordamos com Rosa Godoy Silveira (2007)¹² sobre como os sujeitos pensam a história, constroem sentidos e experiências, e reconfiguram o mundo social em suas múltiplas dimensões por meio de diferentes práticas.

Diante dessas considerações, a *Cultura Histórica* configura um dos fundamentos orientadores deste trabalho, em consonância com a área de concentração à qual ele está

¹⁰ Localizado no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa - PB, abriga um acervo vasto e diversificado, com registros valiosos sobre a História da Parahyba, incluindo documentos administrativos, fotografias, jornais e correspondências de diferentes épocas.

¹¹ Para mais informações, ver: FLORES, E. C. Dos feitos e dos ditos: História e Cultura Histórica. **Saeculum**, [S. l.], n. 16, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11374>. Acesso em: 2 ago. 2024. CURY, Claudia Engler; FLORES, Élio Chaves; CORDEIRO JÚNIOR, Raimundo Barroso. (Org.). **Cultura Histórica e Historiografia**: legados e contribuições do século 20. 1ªed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2010.

¹² Para informações mais detalhadas sobre a importância da *Cultura Histórica* como área de concentração do PPGH/UFPB, e também sua articulação com a Linha de Pesquisa *História e Regionalidades*, consultar: SILVEIRA, R. M. G. A Cultura Histórica em representações sobre territorialidades. **Saeculum**, [S. l.], n. 16, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11370>. Acesso em: 16 ago. 2024.

vinculado. Ela orienta o processo de escrita e construção da narrativa histórica por meio das fontes documentais e da historiografia, que nos fornecem elementos para compreender como as práticas de saúde, a atuação das autoridades públicas e as trocas de experiências entre os grupos sociais se relacionam com as problemáticas levantadas anteriormente, principalmente no que se refere às condições de vida, às doenças e às formas de assistência diante da Seca de 1877-1879.

Quanto à delimitação temporal, o trabalho está situado na chamada “Grande Seca” de 1877-1879. Buscamos analisar as condições de vida e saúde da população já existente e daquelas que migravam para o interior e/ou para a Capital da Parahyba, inseridas em situações precárias de higiene, alimentação e moradia, além de mapear as principais doenças que as acometiam, os tipos de assistência médica fornecida e as medidas de combate à seca propostas pelo governo.

Também é fundamental destacar que o recorte temporal desta pesquisa foi ampliado até o ano de 1880¹³, o que constitui um dos diferenciais analíticos do trabalho. Ao estender a análise para além do período tradicionalmente delimitado entre 1877 e 1879, buscamos compreender não apenas o auge da seca, mas principalmente seus desdobramentos imediatos, ainda pouco explorados pela historiografia.

Embora existam breves referências, como as pontuações de José Américo e as informações contidas nos relatórios dos Presidentes de Província de 1880, que mencionam a organização dos núcleos coloniais, a criação de mais um hospital, a permanência da fome e das doenças no interior da província e a chegada das chuvas em fevereiro daquele ano, permanecem lacunas importantes. O que ocorreu com a população após o fim da seca? Como se processaram os desdobramentos sociais e sanitários da crise? Para onde se dirigiram aquelas pessoas? Doenças como beribéri, sífilis, varíola e febres ainda persistiam de forma intensa? Em que medida o governo e os médicos continuaram a oferecer gêneros alimentícios e medicamentos?

De fato, a Seca de 1877 vai muito além do seu “término” formal em 1879. Ao considerar o ano de 1880 como parte constitutiva da análise, compreendemos esse período como o início de um lento processo de reestruturação social e econômica da província, que se encontrava profundamente abalada após três anos consecutivos de estiagem. Procuramos discutir os impactos causados na vida e na saúde da população afetada, bem como as

¹³ A ampliação do recorte temporal para 1880 foi inicialmente sugerida durante a apresentação da monografia que antecedeu esta pesquisa, em 2023, pelo professor Mozart Vergetti, cuja observação contribuiu para o amadurecimento desta proposta analítica.

dificuldades enfrentadas no retorno às localidades de origem, com base, entre outras fontes, nos relatórios apresentados pelas Comissões de Socorros Públicos, como a da vila do Teixeira, uma das regiões mais atingidas no sertão paraibano.

Desse modo, ao incorporar o ano de 1880, esta dissertação amplia o campo de observação da crise, evidenciando que os impactos da seca ultrapassaram o marco cronológico convencionalmente adotado. Mais do que um ano de encerramento, 1880 revela a permanência de doenças, carências materiais e tensões sociais, permitindo observar as continuidades da crise em meio às tentativas de reorganização da província.

No que se refere à estrutura da dissertação, o trabalho organiza-se em quatro capítulos. O capítulo inicial dedica-se à apresentação do tema, por meio da discussão das diferentes narrativas construídas acerca da seca, atentando para seus silenciamentos e para questões ainda pouco exploradas. Também são explicitadas as fontes mobilizadas e os referenciais conceituais que fundamentam os objetivos e as análises desenvolvidas ao longo da pesquisa.

No Capítulo 2, “Devastando a População e Ceifando Milhares de Vidas”: o início da seca de 1877–1879 na Parahyba, analisa os primeiros impactos da grande estiagem no território parahybano, situando-os no contexto político, social e econômico da segunda metade do século XIX. A análise parte das condições sanitárias e das principais enfermidades que acometiam a população, com destaque para as epidemias de cólera *morbus*, febre amarela e os surtos de varíola, bem como para as medidas médico-sanitárias adotadas.

O capítulo examina ainda o processo de urbanização da capital e suas reformas voltadas à modernização e ao controle das epidemias, evidenciando, ao mesmo tempo, o aprofundamento das desigualdades sociais e a precariedade das áreas que passaram a concentrar populações migrantes. Considera-se também o cenário político da década de 1870, marcado pelo pós-Guerra do Paraguai e pela Revolta dos Quebra-Quilos, destacando como essas experiências tensionaram as relações sociais e econômicas no período.

Por fim, são analisados os efeitos da seca sobre a economia regional e as relações de trabalho, os fluxos migratórios internos, as experiências dos núcleos coloniais e a inserção da população migrante em obras públicas. Além das políticas de assistência implementadas diante da calamidade, com especial atenção à atuação das Comissões de Socorros Públicos, à criação de enfermarias e hospitais emergenciais, bem como aos debates e denúncias registrados na Assembleia Provincial nos discursos dos deputados parahybanos Manoel Pedro Cardoso Vieira e João Florentino Meira de Vasconcelos.

Enquanto o Capítulo 3, “Extenuados de fome, cansaço e miséria”: aspectos sobre a saúde, as doenças e a medicina, aborda as condições de vida e saúde da população atingida

pela seca, com destaque para os migrantes, frequentemente caracterizados como ameaça à saúde e à segurança pública nas notícias de jornais e nas correspondências enviadas pelo presidente da província. Inicialmente, analisamos como esses grupos foram classificados pela documentação como “desvalidos”, “indigentes” e “flagelados”, e de que maneira tais representações se articularam às políticas de socorro e às formas de assistência médico-hospitalar disponíveis.

Em seguida, a partir dos dados de entrada e saída dos hospitais e dos registros de óbitos de diversos municípios, mapeamos as principais causas de morte e as doenças que acometeram a capital e outras regiões da Parahyba, com destaque para as febres diversas e a varíola, responsáveis por um elevado número de óbitos. O capítulo examina ainda como o discurso médico-higienista do período operou como instrumento de controle dos corpos, influenciando práticas e normas higiênicas impostas à população. Por fim, analisamos as práticas terapêuticas adotadas, com base na documentação relativa às solicitações de ambulâncias com remédios, sobretudo homeopáticos, o que permite observar a diversidade de métodos curativos empregados no enfrentamento das adversidades sanitárias daquele contexto.

Já no Capítulo 4, “Irregularidade de conduta e maus costumes”: o caminho de volta para casa em 1880, analisamos os desafios enfrentados pelos sobreviventes da chamada “Grande Seca” na Parahyba, em um contexto marcado pelo encerramento das medidas emergenciais e pelo progressivo desmonte da assistência pública. Inicialmente, identificamos as doenças que ainda persistiam na província após o auge da crise, a partir de relatórios administrativos, nos quais se expressa a preocupação das autoridades em dissolver, o mais rapidamente possível, os hospitais e enfermarias provisórias criados durante o período emergencial.

Além disso, os mapas estatísticos hospitalares permitem observar índices relevantes de mortalidade e tratamento, ao mesmo tempo em que revelam a redefinição das prioridades administrativas no pós-seca. Nos Relatórios dos Presidentes de Província, constatamos que, entre 1877 e 1879, foram estabelecidas 31 colônias, posteriormente dissolvidas em 1880. Soma-se a esse quadro a atuação das Comissões de Socorros Públicos, que passaram a apresentar dificuldades acerca das prestações de contas detalhadas e balanços gerais dos gastos realizados, marcando uma mudança do discurso de emergência para uma lógica de encerramento e fiscalização da assistência.

No entanto, cartas enviadas por autoridades locais, como as provenientes da Vila do Teixeira, no sertão da província, indicam que os efeitos da seca permaneciam profundamente presentes no cotidiano da população, desmentindo a ideia de normalização sustentada pelos

relatórios oficiais. Em relação aos migrantes, observa-se um evidente apagamento nas documentações administrativas acerca da chamada “volta para casa”, silenciando questões fundamentais: quais estratégias de sobrevivência foram possíveis nesse contexto? De que maneira esses indivíduos buscaram reconstruir suas vidas após a dispersão das colônias, o fechamento das instituições de socorro e a persistência das dificuldades econômicas e sanitárias?

Delimitados o problema e a organização do trabalho, consideramos necessário examinar como a temática da saúde e das doenças no contexto da Seca de 1877-1879 se insere no debate historiográfico. Buscamos identificar as principais abordagens adotadas, os silenciamentos e deslocamentos interpretativos, bem como os limites e as contribuições das obras que trataram do período, especialmente no que se refere às condições sanitárias, às práticas de assistência e à experiência da população afetada.

1.1 NARRATIVAS DA SECA: CONSTRUÇÕES E SILÊNCIOS NA HISTORIOGRAFIA

Reconhecemos, no nosso contato com a temática da saúde e das doenças no contexto da Seca de 1877-1879, que a própria seca não poderia ser tratada de forma secundária em nossas análises. Apesar de ser abordada, com frequência, como um fenômeno climático natural, atribuído à falta de chuvas no semiárido nordestino, é também comumente retratada pela historiografia sob uma perspectiva política e econômica, com ênfase na atuação das autoridades públicas, na construção de açudes, nas políticas de emergência, como o fornecimento de alimentos, moradia e assistência à saúde, e nas relações de trabalho no campo, que são afetadas pelas migrações forçadas ou pela perda das plantações.

Também encontramos, na própria historiografia sobre as secas, silêncios em torno das mulheres, que, em muitos casos, sequer são mencionadas nas documentações, apesar de sua atuação nas redes de cuidado, no tratamento de enfermos e na sustentação das famílias. A invisibilidade da infância e dos idosos é outro ponto que chama atenção: crianças e idosos costumam desaparecer das análises ou aparecem apenas como números de morte.

Pouco se fala, por exemplo, sobre as crianças que foram abandonadas durante a seca, separadas de seus familiares ou que ficaram órfãs, muitas vezes entregues a casas de caridade ou mesmo à morte por inanição ou doenças. Esses silenciamentos contribuem para a desumanização da experiência da seca, apagando dimensões afetivas e subjetivas.

Há ainda a negligência em relação às diferentes realidades regionais. As especificidades entre sertão, Borborema, agreste e litoral são frequentemente ignoradas, prevalecendo uma representação homogênea do sertão como espaço de “atraso”, estagnado e sem variações internas (Albuquerque Jr., 2011).

Esse olhar hegemônico desconsidera que nem todas as regiões foram atingidas da mesma maneira, já que algumas mantinham maior articulação com os centros urbanos, outras dispunham de obras públicas ou de mínima infraestrutura (Mariano, S.; Brasil, R., 2022) em certos locais, houve maior presença de ações governamentais ou de instituições religiosas. Desconsiderar tais diferenças contribui para a perpetuação de uma leitura reducionista da seca e de seus efeitos.

O objetivo deste tópico é, portanto, refletir sobre como a historiografia acerca da seca se articula e produz sentidos, examinando de que maneira o fenômeno foi interpretado, explicado e representado por diferentes autores e instituições. Para tanto, nos apoiamos na noção de operação historiográfica, que, como adverte Michel de Certeau (2011), não é neutra, tampouco desinteressada: ela se constrói a partir de um lugar social específico e é moldada por condições políticas, institucionais e discursivas.

Segundo o autor, toda pesquisa histórica parte de um “lugar de produção socioeconômico, político e cultural”, estando vinculada a categorias de letrados, à profissão docente e às instituições que definem e legitimam o saber histórico (Certeau, 2011, p. 66). Isso significa que o discurso histórico é condicionado por estruturas que determinam tanto o que se pode dizer quanto aquilo que se silencia.

A análise da historiografia das secas no Brasil, especialmente daquela produzida entre os séculos XIX e XX, exige considerar o contexto institucional e ideológico em que estavam inseridos seus autores, muitos dos quais vinculados ao governo, à engenharia ou à medicina, com interesses alinhados a determinadas representações do sertão e da fome. Como observa Certeau (2011, p. 77), o discurso historiográfico resulta de uma operação que envolve um lugar de onde se fala e um modo de constituir o objeto de que se fala, inclusive o “morto”, o excluído, o silenciado. Assim, compreender as formas como a seca foi narrada nesses períodos também implica refletir sobre os lugares sociais, os desejos e os limites que moldaram tais narrativas.

Nesse conjunto de narrativas, busca-se compreender as formas pelas quais o sertão, o clima e os sujeitos históricos foram significados ao longo do tempo, com destaque para as propostas técnicas e políticas formuladas por engenheiros e intelectuais do período. Iniciamos essa discussão a partir da abordagem da História Ambiental.

Ao explorar as múltiplas dimensões e intersecções da “Grande Seca” de 1877, Maria Verônica Secreto chama atenção para as formas como esse evento foi interpretado e narrado na literatura específica do tema. A autora destaca a escala global que a seca alcançou, um dado ainda pouco conhecido ou trabalhado na historiografia, lembrando que seus efeitos não se restringiram ao Brasil, mas também atingiram regiões como Java (Indonésia), Filipinas (Sudeste Asiático), Nova Caledônia (Oceania), Coreia (Leste Asiático), África do Sul e o Magreb (região norte da África) (Davis, 2002 *apud* Secreto, 2020, p. 34).

A reflexão feita por Secreto (2020) insere-se em um debate historiográfico mais amplo, que tem em Mike Davis¹⁴ uma de suas principais referências. Em *Holocaustos Coloniais* (2002), Davis constrói a tese de que as secas do século XIX não devem ser tratadas como eventos naturais isolados, mas como catástrofes historicamente produzidas por políticas econômicas e imperiais. Para o geógrafo, “a seca é o duelo recorrente entre a natural variabilidade de chuva e as defesas hidráulicas da agricultura. Sempre tem uma dimensão artificial e nunca é apenas um desastre natural” (Davis, 2002, p. 28).

Em sua tese, ele denuncia os “imperativos vitorianos” – uma lógica de dominação que, diante de crises como a seca, priorizava os interesses do mercado e do governo imperial em detrimento da sobrevivência das populações locais (Davis, 2002, p. 37). A resposta britânica às fomes na Índia, por exemplo, é comparável à negligência com que o Império brasileiro tratou a seca no Norte, evidenciando como o projeto de “modernização liberal”, tanto lá quanto aqui, excluía os mais pobres de sua promessa de “progresso”.

No caso brasileiro, Davis aponta que políticos liberais do Ceará, assim como o engenheiro André Rebouças, chegaram a exaltar os “métodos científicos britânicos”, adotados sob a administração de Lytton¹⁵ na Índia, como exemplo de eficiência, propondo medidas semelhantes como o condicionamento da ajuda à realização de trabalhos públicos pelas populações em situação de fome (Davis, 2002, p. 99).

De acordo com Yuri Simonini (2020, p. 121-122), as questões relacionadas à seca começam a ser tratadas, na historiografia, inicialmente com foco nos meios de arrecadação de verbas e nas práticas assistencialistas, além de serem analisadas sob uma *perspectiva técnico-*

¹⁴ Foi um geógrafo e escritor norte-americano, conhecido por suas análises críticas sobre desigualdade social, urbanização e os efeitos do capitalismo global. Entre suas obras mais influentes estão *Cidade de Quartzos* (1990) e *Holocaustos Coloniais* (2002).

¹⁵ De acordo com Davis, Edward Robert Bulwer-Lytton ocupou o cargo de vice-rei da Índia, entre 1876 e 1880, durante o governo britânico da Rainha Vitória. Lytton liderou a administração imperial no período da Seca de 1877-79, adotando políticas de contenção de gastos e também por recusar o fornecimento de socorro públicos às populações, entre as justificativas estava a de não interferir nas leis do mercado, o que resultou no agravamento da crise alimentar, em milhões de mortes, que também contribuiu para a lógica de negligência do imperialismo britânico (Davis, 2002).

científica, por grupos de engenheiros, intelectuais, geógrafos e naturalistas vinculados ao Instituto Politécnico Brasileiro (IPB).¹⁶

Entre as atividades desenvolvidas para combater os efeitos da seca de 1877, destaca-se a criação da Comissão Central Cearense de Socorros Públicos, que organizou um corpo técnico de engenheiros atuando em conjunto com as sessões do Instituto, sob a direção de Henrique Beaurepaire-Rohan, e com a colaboração de nomes como Giacomo Gabaglia, Guilherme S. Capanema e André Rebouças. A comissão, que começou em janeiro e foi dissolvida em junho de 1878, trouxe avanços técnicos que contribuíram para amenizar os efeitos das secas posteriores (Simonini, 2020). Nesse período destacam-se duas obras, a primeira:

A obra *Considerações acerca dos Melhoramentos de que, em relação as secas são suscetíveis algumas províncias do norte do Brazil*¹⁷ (1877 [1860]), de Henrique Beaurepaire-Rohan¹⁸, baseada em suas viagens por províncias como Bahia e Piauí durante a seca de 1827, relata que muitos rios classificados como permanentes nos mapas eram, na verdade, intermitentes, secando rapidamente após o fim das chuvas. Nesse contexto, defendia o aproveitamento dos depósitos naturais de água chamados de “poços”, e a implantação de açudes como solução mais realista, em razão do sucesso da vila de Campina Grande, na Parahyba, onde a assembleia legislativa “promove essas obras com o maior empenho” (Rohan, 1877, p. 10).

¹⁶ Apesar do enfoque central nos rumos da engenharia nacional brasileira, o Instituto, criado em 11 de setembro de 1862, também possuía interesses voltados para a modernização do Império Brasileiro como a construção de ferrovias, reservatórios de águas e sistema de saneamento básico. Segundo o Decreto n.º 2.882, de 25 de janeiro de 1862, da Coleção de Leis do Império do Brasil, entre as funções do IPB, que consta no Art.3º § 1º “O desenvolvimento das sciencias, dos conhecimentos do commercio, bellas artes e letras, e instruir tanto nestas, como naquelas os Sócios, e colocá-los ao par das novas descobertas” (Brasil, Coleção de Leis do Império do., 1862).

¹⁷ Na abertura da segunda edição do referido artigo, publicado em 1877, Beaurepaire-Rohan resgata um antigo debate travado nos jornais com João Ernesto Viriato de Medeiros – engenheiro militar, político e senador pelo Ceará. Ao reafirmar sua discordância quanto às propostas de Medeiros, Rohan contextualiza a origem de seu próprio posicionamento técnico, destacando, ao mesmo tempo, a cordialidade intelectual que marcou o diálogo entre ambos. O engenheiro ainda menciona que, mais recentemente, o senador Thomaz Pompeu de Souza Brasil também se posicionou criticamente em relação às ideias de Medeiros, reforçando os argumentos contrários às soluções até então apresentadas (Rohan, 1877, p. 3).

¹⁸ Além de engenheiro militar e geógrafo, Henrique Beaurepaire-Rohan destacou-se por seus estudos em cartografia, hidrografia e projetos de infraestrutura, como explorações fluviais e a expansão de estradas ferroviárias, que resultaram em publicações como *Estudos acerca da organização da carta geográfica e da história física e política do Brasil* (1877), *Dicionário de Vocábulo Brasileiros* (1889), *Corografia da Província da Paraíba do Norte* (1911), entre outras. Ocupou cargos relevantes na administração imperial, como presidente das províncias do Pará (1856–1857) e da Parahyba (1857–1859), além de ter atuado como Comandante-Geral do Corpo do Estado-Maior de 2ª Classe do Exército. Sua atuação técnica e política esteve vinculada aos projetos de urbanização e às iniciativas de combate às secas na segunda metade do século XIX. Para maiores informações sobre a vida e a atuação político-administrativa de Rohan, ver: SOUSA, Eveline Almeida de. **Território nacional em movimento**: a trajetória de Henrique Beaurepaire Rohan (1844–1884). 2022. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.

É nesse ponto que Rohan propõe uma comparação direta com o vale do Amazonas, com o intuito de evidenciar como determinadas condições naturais favorecem a retenção de umidade ao longo do ano. Ao concluir esse paralelo, Rohan afirma que a escassez de rios, lagos e matas nas províncias do Ceará, Parahyba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia é o fator decisivo para entender sua vulnerabilidade às secas. Pare ele, se essas regiões compartilhassem das mesmas condições naturais do vale amazônico¹⁹, no que diz respeito à retenção de umidade, também apresentariam padrões climáticos mais equilibrados (Rohan, 1877, p. 16-17).

Nos trechos seguintes do relatório, reafirma que o problema não decorre de modo exclusivo a fatores atmosféricos, mas da precariedade estrutural do semiárido. Por isso, defende que os açudes são a única medida eficaz e viável, com base na experiência acumulada e nos bons resultados já observados. Defende também sua generalização por meio de sistemas de represamento e nivelamento rigoroso dos leitos intermitentes, como forma de garantir múltiplos benefícios: água para consumo humano e animal durante todo o período seco; criação de peixes como fonte alimentar e econômica; além da atração de aves e outros animais silvestres que poderiam ser utilizados como recurso de caça e alimentação (Rohan, 1877, p. 18).

Outro estudo importante é o do engenheiro e abolicionista André Rebouças²⁰, publicado em 1877, por meio do conjunto de artigos intitulado *A Secca nas Províncias do Norte*, abre seu texto declarando que pretendia realizar um estudo técnico, comparativo e propositivo sobre os meios de mitigação das secas, com base na experiência da Índia sob domínio britânico.

Seu objetivo inicial era utilizar a experiência internacional como modelo de referência, numa tentativa de propor soluções práticas para o Norte do Brasil. Entretanto, o autor admite

¹⁹ Segundo o autor, trata-se de um território amplamente irrigado, com um grande rio central, inúmeros afluentes e vegetação densa, que contribuem para manter a umidade do solo e o equilíbrio do ciclo hidrológico, mesmo em períodos de calor intenso (Rohan, 1877, p. 16). A presença constante de água e matas torna essa região menos vulnerável às estiagens, diferente do que ocorre no semiárido nordestino.

²⁰ Engenheiro de formação militar, André Rebouças (1838–1898) destacou-se no Segundo Reinado como uma das figuras centrais nos debates sobre a modernização técnica e social do Brasil Oitocentista. Negro, abolicionista, republicano e defensor da reforma agrária, articulou ciência, política e engajamento cívico em uma trajetória marcada pela crítica às estruturas excludentes do Império. No artigo *Por uma socionomia oitocentista: pensamento, vida e ação de André Rebouças, século XIX*, Antônio Carlos Higinio da Silva analisa sua atuação a partir da noção de “socionomia” – um conceito que remete a uma engenharia social voltada à construção de um espaço urbano mais justo, integrando aspectos técnicos, sociais e morais. Segundo Higinio, Rebouças não via a técnica como neutra, mas como instrumento político e civilizatório, capaz de reorganizar a convivência coletiva a partir de uma base mais equitativa (Silva, A., 2018, p. 23). Sua proposta englobava desde a defesa de concessões públicas transparentes até a valorização do trabalho livre, em oposição à herança escravocrata ainda vigente no país.

que o texto acabou se tornando um “grito de dor”, sinal de que o agravamento da seca de 1877 transformou a racionalidade do projeto técnico em denúncia social diante da tragédia humana. Além disso, afirma que o Brasil não aprendeu com seus próprios erros históricos nem com experiências estrangeiras (Rebouças, 1877, p. 8).

Para ele, o plano de combate às secas estava na própria natureza e indicava a solução: seria necessário armazenar as “chuvas superabundantes” e evitar seu escoamento desordenado para o oceano. Assim, propõe uma série de obras hidráulicas que deveriam ser realizadas com os meios da época: drenar rios, construir represas, açudes e canais para irrigação das terras secas.

Rebouças argumenta que tais medidas, longe de serem inovadoras, já eram adotadas desde “tempos imemoriais” em civilizações como Egito, Índia e China – retomando aqui a referência à experiência da Índia inglesa, utilizada por ele como contraponto constante (Rebouças, 1877, p. 22). Ao apelar para exemplos históricos e internacionais, o engenheiro reforça a tese de que a tragédia da seca não era uma fatalidade natural, mas resultado direto da omissão política e do descaso técnico. A única condição necessária para que tais benefícios chegassem a população sertaneja, conclui, “só falta, pois, uma coisa: QUERER” (Rebouças, 1877, p. 22).

Apesar de parecer, à primeira vista, um projeto com viés hidráulico, o conjunto de propostas debatido no Instituto Politécnico, do qual André Rebouças era um dos participantes mais atuantes, também se articula com questões sociais. Entre as diretrizes aprovadas, estava a desapropriação dos terrenos marginais das linhas férreas para que fossem divididos entre migrantes ou “colonos nacionais” (Rebouças, 1877, p. 93). Era também uma tentativa embrionária de reforma agrária e colonização interna, que visava fixar produtivamente as populações deslocadas pela seca.

Vemos, assim, que esse tipo de proposta carrega consigo uma visão que busca organizar a vida dessas populações pobres e migrantes segundo uma lógica disciplinadora: seus deslocamentos, sua forma de produzir e até o lugar onde deveriam viver passariam a ser definidos por critérios externos, impostos de cima para baixo. Ou seja, trata-se de uma ajuda que, ao mesmo tempo em que oferece suporte, também procura moldar, integrar e controlar esses sujeitos dentro de um projeto mais amplo de reordenação social e territorial promovido pelo governo imperial.

Tanto Beaurepaire-Rohan quanto André Rebouças compartilham a confiança no saber técnico como ferramenta para o enfrentamento das secas no Norte do Império. Ambos consideravam que os efeitos do fenômeno não podiam ser resolvidos por medidas pontuais ou

assistencialistas, e propunham soluções de engenharia como forma de reorganizar o território e assegurar melhores condições de vida à população.

No entanto, há distinções importantes em suas abordagens. Rohan prioriza uma perspectiva mais voltada à contenção das secas, com foco na construção de açudes e no aproveitamento racional das águas temporárias, baseando-se na experiência administrativa local e em observações hidrológicas.

Já Rebouças vai além da questão ambiental: propõe um projeto que articula infraestrutura, reforma fundiária e integração nacional. Ao sugerir a divisão de terras ao longo das ferrovias para assentamento de retirantes, os chamados “colonos nacionais”, apresenta uma solução de redistribuição de terras e reorganização produtiva. Se Rohan pensa a seca como um problema natural que exige engenharia hidráulica, Rebouças a enxerga também como uma questão social e estrutural, cuja resposta deve incluir justiça distributiva e ação política.

Embora a questão da saúde não ocupe o centro de suas análises, Rebouças demonstra sensibilidade diante das implicações sanitárias das secas. Ele reconhece que a fome e a desnutrição tornavam a população vulnerável às doenças, e que a ausência de infraestrutura e água potável contribuía para a propagação de enfermidades. Suas propostas também podem ser lidas como medidas indiretas de saúde pública, pois defendia o abastecimento regular de água, além de “Dar aos retirantes abrigo, alimentos, cuidados médicos, trabalho e salario durante quatro a seis meses” (Rebouças, 1877, p. 82).

A partir desse panorama mais amplo da historiografia brasileira sobre as secas – marcado pela centralidade das interpretações técnico-científicas, pela politização do fenômeno e pela construção de um imaginário nacional – torna-se necessário deslocar o olhar para a produção historiográfica paraibana. Se, no plano nacional, a seca foi interpretada sobretudo a partir de soluções técnicas e discursos de progresso, no âmbito paraibano as narrativas assumiram feições próprias, marcadas pela memória local, pela denúncia moral e pela construção de identidades regionais.

Ao fazê-lo, não se trata apenas de aplicar modelos interpretativos já consolidados, mas de observar como esses discursos foram apropriados, reelaborados ou tensionados em escala regional. A historiografia paraibana, produzida especialmente por letrados vinculados a instituições locais e a projetos de afirmação da identidade provincial, tende a articular a seca como fenômeno natural recorrente, prova do abandono político do Norte ou elemento explicativo para a desordem social, as migrações e o sofrimento coletivo.

Ao mesmo tempo, essa produção também elenca denúncia, naturalização e funcionalização da catástrofe, ora enfatizando a tragédia humanitária, ora subordinando a memória da seca a narrativas de progresso, regeneração e integração nacional. É nesse entrecruzamento entre crítica, silenciamento e reiteração de estereótipos que se inscrevem os principais autores paraibanos, cujas interpretações serão analisadas a seguir.

Entre os autores da produção paraibana que trataram da temática das secas, destaca-se Irineu Joffily²¹, que, em *Notas sobre a Parahyba* (1892), dedicou uma seção específica ao tema com o objetivo de chamar a atenção dos letrados para as particularidades do fenômeno e, ao mesmo tempo, de oferecer uma leitura orientadora da seca aos seus conterrâneos.

Joffily estava inserido em um contexto institucional oitocentista no qual os letrados não apenas produziam conhecimento, mas também assumiam a função de torná-lo acessível, instrutivo e orientador da consciência pública. Essa lógica orientava a atuação de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP), voltadas à valorização da memória histórica regional e à produção de uma escrita com pretensão formadora, comprometida com a afirmação da identidade regional e a difusão do saber histórico junto à sociedade (Dias, 1996). Tendo vivenciado a estiagem de 1877, suas reflexões se inscrevem tanto no registro da experiência quanto na tentativa de oferecer interpretações e orientações diante da crise, aspecto ao qual nos voltamos a seguir.

Ao relembrar episódios de estiagem ocorridos desde o final do século XVII, Irineu Joffily associa as secas não apenas às perdas materiais e à fome, mas também à desordem social provocada por determinados grupos historicamente marginalizados. Em sua narrativa, os indígenas tapuias foragidos das serras, em 1692 e 1725, são descritos como protagonistas de saques e assassinatos, cujas ações violentas teriam devastado fazendas e ameaçado a população sertaneja. Ao classificá-los como “elemento palmarense” como “mais sanguinário”, Joffily (1892, p. 97) projeta os povos originários sob uma imagem de barbárie e indisciplina, inserindo-os numa visão que naturaliza comportamentos violentos como traços inerentes à sua condição étnica.²²

²¹ Irineu Joffily nasceu em 15 de dezembro de 1843, na antiga freguesia de Campina Grande, atual município de Esperança. Formado em Direito no Recife em 1866, atuou como juiz e jornalista. Fundador da *Gazeta do Sertão*, destacou-se pelas críticas ao governo provincial e, após perseguições políticas, refugiou-se no Rio de Janeiro, onde publicou *Notas sobre a Parahyba* (1892). Ao longo de sua trajetória, Joffily engajou-se nas questões políticas e sociais da Parahyba, foi defensor do movimento do Quebra-Quilos (1874) e idealizador do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP). Sua obra buscou afirmar uma identidade histórica e geográfica da Parahyba, especialmente frente à influência de Pernambuco e à marginalização do Sertão (Fernandes, O., 2003).

²² Sobre os limites da historiografia tradicional vinculada ao Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) e os silenciamentos em torno da presença negra e da escravidão na História da Paraíba, ver: ROCHA, Solange Pereira da. **Gente Negra na Paraíba Oitocentista: população, família e parentesco espiritual**. Recife: Tese

Essa construção se estende também aos africanos escravizados e seus descendentes, oriundos de Palmares, identificados pelo autor como os ancestrais dos “cangaceiros” que, nas últimas décadas, vinham aterrorizando o sertão com “*actos* da maior ferocidade”. Ao atribuir à população indígena e negra o papel de ameaçadores da ordem social, Joffily reforça uma visão racializada do sertão, em que a criminalidade e os saques não são explicados por desigualdades estruturais ou contextos de opressão, mas por supostas predisposições étnicas.

A imagem do sertão que emerge desse discurso é a de uma região habitada por populações perigosas e “selvagens”, cuja repressão se justificaria em nome da civilização e da paz (Joffily, 1892, p. 96-97). Vemos, assim, uma leitura que silencia as estruturas de dominação e exclusão social, deslocando para as categorias étnico-raciais a explicação das tensões em regiões do interior como o sertão e convertendo sujeitos historicamente oprimidos em símbolos da ameaça à ordem.

Ao articular uma visão que, embora reconheça a dimensão trágica da seca com milhares de mortes, migrações forçadas e o esvaziamento de regiões, Joffily (1892, p. 98) reposiciona o fenômeno dentro de uma lógica cíclica e quase naturalizada, na qual o sofrimento seria inevitavelmente sucedido por um período de abundância (com chuvas intensas) e recuperação (das plantações e criação do gado). Para ele, o retorno das chuvas e a “extraordinária força produtiva” da natureza sertaneja funcionariam como um mecanismo “espontâneo” de restauração, capaz de regenerar a população e a vida econômica da região.

Trata-se de uma interpretação que atribui à seca um papel paradoxal: ao mesmo tempo em que destrói, ela produziria um tipo humano mais forte, moldado na adversidade. É nesse sentido que Joffily define o sertão como um “viveiro humano para o Brasil”, apresentando a população da Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará como os “carirys-portuguez”, numa missão histórica: “será em pouco tempo contado como elemento de primeira ordem na evolução social”, além de manter a união nacional. Ao compará-los aos bandeirantes paulistas (tupy-portuguez), ele busca inserir os sertanejos empobrecidos em uma narrativa heroica e funcionalista.

Tal construção valoriza esses sujeitos não por suas experiências reais de sofrimento, mas por sua suposta utilidade política e social na formação da nação (Joffily, 1892, p. 98-99).

(Doutorado em História), PPGH/UFPE, 2007. Para uma análise crítica sobre como se consolidou uma cultura histórica excludente, marcada pela invisibilização da diáspora africana e seus desdobramentos sociais na Paraíba, pode ser encontrada em: GUIMARÃES, Matheus Silveira. **Diáspora Africana na Paraíba do Norte**: trabalho, tráfico e sociabilidades na primeira metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em História), PPGH/UFPB, João Pessoa, 2015.

Percebemos, assim, que o autor procura subordinar a memória da seca a um ideal de progresso e integração nacional.

Já a obra *A Paraíba e Seus Problemas*, publicada originalmente em 1923, ocupa um lugar de destaque na construção de uma narrativa crítica sobre a realidade parahyba na virada do século XIX para o XX. Escrita por José Américo de Almeida²³, a pedido do então presidente do Estado da Paraíba, Solon de Lucena, a obra tinha como propósito inicial elaborar um relatório sobre os benefícios promovidos pela gestão do político Eptácio Pessoa, no que se refere às ações de combate aos efeitos das secas.

No entanto, o resultado final superou os limites de um relatório técnico, revelando um estudo crítico e abrangente da realidade parahyba. José Américo percorreu todo o Estado, colhendo informações, fotografando e escrevendo um texto que, ao ser finalizado, adquiriu contornos mais amplos, misturando observações de cunho sociológico, histórico, geográfico e literário.

Ao tratar da seca, da migração, das fronteiras geográficas, da formação histórica e das dinâmicas políticas, o autor criou uma narrativa que expõe a complexidade do território e da identidade parahyba. No cenário da seca de 1877-179, o autor descreve a quantidade de migrantes que passeavam pelas ruas da capital com seus corpos “quase nus e fantasmagóricos”, também classifica a seca como elemento responsável “em seus ciclos mortais, pelo retardamento de nossa organização social e econômica” (Almeida, 2012 [1923], p. 133).

Como bem sabemos, a escassez de testemunhos diretos de quem vivenciou a seca de 1877-79 na província da Parahyba é uma dificuldade recorrente para quem trabalha com o tema. Nesse sentido, é mais comum encontrarmos relatos tardios, muitas vezes elaborados por memorialistas, como é o caso de Francisco Coutinho de Lima e Moura²⁴.

²³ José Américo de Almeida (1887–1980) foi um destacado intelectual, político e literato paraibano. Formou-se em Direito pela Faculdade do Recife em 1908 e atuou como promotor, procurador-geral do Estado e consultor jurídico. Foi um dos fundadores da revista modernista *Era Nova* e autor de obras como o romance regionalista *A Bagaceira* (1928). Ingressou na política como secretário-geral do governo de João Pessoa e teve papel central na Revolução de 1930, sendo nomeado governador civil do Norte e, posteriormente, ministro de Viação e Obras Públicas (Burity, 2021). Ocupou ainda os cargos de senador da República e ministro do Tribunal de Contas da União. Em 1937, foi escolhido como candidato governista à presidência da República, sendo uma das figuras mais influentes do chamado Bloco do Norte, articulado em torno das políticas contra as secas e do fortalecimento do Nordeste na cena nacional. Para essas e outras informações sobre a vida e obra de José Américo, ver: BURITY, Luiz Mário Dantas. **José Américo de Almeida: da infância no Engenho Olho d’Água à campanha presidencial de 1937.** Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

²⁴ Além de ter sido Tenente-Coronel, Francisco Coutinho de Lima e Moura foi professor e sócio-fundador do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP).

Em sua obra *Reminiscências: figuras e fatos da Parahyba* (1938), o autor dedica um breve, porém expressivo, relato sobre as impressões da seca na Capital, onde residia à época e da qual foi testemunha ocular. Tinha apenas dez anos de idade durante o evento, mas afirma que já era capaz de “compreender e sentir” a realidade ao seu redor: “minha alma e meu coração *soffreram* muito com o que vi aqui na Capital onde uma população esquálida, maltrapilha, esfomeada, fendida como fantasmas, dormia nas calçadas” (Lima e Moura, 1985, p. 103).

Ao narrar as imagens da cidade, evoca cenas que ficaram marcadas em sua memória infantil, como o recolhimento dos mortos pelo poder público nas madrugadas e o sepultamento coletivo em covas rasas e promíscuas. A descrição de um coveiro embriagado zombando do corpo de uma criança morta “põe este *ahi* como travesseiro”, jogando-a em uma vala comum revela o impacto profundo dessa experiência sensível: “o que me escandalizou profundamente”, escreve ele. A narrativa segue com a descrição das epidemias que se alastraram “com a fedentina exalada das *immundicies*”, agravadas pela falta de saneamento básico, água potável e fossas regulares (Lima e Moura, 1985, p. 103).

O relato de Lima e Moura, ainda que escrito décadas após os acontecimentos e marcada por um evidente tom dramático e subjetivo, próprio do gênero memorialístico, oferece uma leitura importante sobre o cotidiano da capital durante a crise. Embora não possa ser tomada como retrato exato da realidade, apresenta impressões de marcas profundas do sofrimento coletivo e das cenas de abandono que o impactaram naquele contexto (Lima e Moura, 1985, p. 103).

Em *Brejo de Areia: Memórias de um Município* (1958), Horácio de Almeida²⁵ dedica uma seção ao que denomina de *Flagelos*, e nela centra sua atenção nos efeitos causados pelas secas sobre a população sertaneja paraibana e na negligência do governo imperial diante do problema. Mesmo sendo natural de Areia, seu foco recai, à semelhança de Irineu Joffily, a imagens já consolidadas sobre o sertão: lugar da fome, miséria, abandono, sofrimento e da degradação humana, em contraste com a fartura e estabilidade do Brejo.

²⁵ Horácio de Almeida (1896-1983), natural de Areia (PB), formado em Direito pela Faculdade de Recife, exerceu atividades como promotor público, jornalista, historiador e biógrafo. Colaborou com diversos jornais e publicou obras voltadas à valorização do passado parahybano, entre as quais se destaca *História da Paraíba* (1966; 1978). Membro ativo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) e da Academia Paraibana de Letras (APL), sua produção esteve fortemente ligada à construção de uma identidade regional e à formação de uma memória coletiva marcada pela bravura e singularidade do povo paraibano (Nascimento, G., 2010). Para uma análise crítica de sua trajetória intelectual e dos sentidos atribuídos à sua escrita histórica, ver: NASCIMENTO, George Silva do. **Pátrio-biografia**: Horácio de Almeida e a sua História da Paraíba. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João Pessoa, 2010.

Assim, sua análise oscila entre a crítica à negligência estatal e a reiteração de uma representação do sertão como espaço marcado pela catástrofe, o que se insere, até os dias de hoje, em uma longa tradição discursiva sobre a seca e o interior nordestino.

Logo no início, Horácio associa o período monárquico à instabilidade administrativa, denunciando a rotatividade de presidentes da província da Parahyba como um dos fatores que impediam o planejamento e a execução de medidas duradouras. A falta de planejamento, segundo ele, fazia com que o auxílio só viesse em momentos de calamidade, na forma de “esmola”, sem qualquer ação preventiva ou investimento em obras estruturais. Sua crítica se dirige também ao poder central, que, segundo afirma, só se lembrava das províncias do norte quando “graves comoções” perturbavam o centro do país, restringindo-se a ações simbólicas ou assistencialistas, como “palavras generosas e dos auxílios saídos do bolsinho particular do monarca no momento da dor e da desolação” (Almeida, H., 1958, p. 125).

Além disso, a Seca de 1877-79, é retratada com forte carga emocional: “O sertanejo, tão cioso da honra e do pundonor de sua família, já não repara que a esposa ou a filha ande seminua, com as carnes à mostra” (Almeida, H., 1958, p. 132). Diante desse quadro de degradação, o autor contrapõe à realidade do sertão à fartura do Brejo, revelando as profundas assimetrias entre o litoral e o interior.

Embora adote um tom de denúncia à negligência estatal, Horácio também evidencia a ambivalência de sua narrativa: ao mesmo tempo em que condena o abandono político, contribui para a manutenção de representações que naturalizam o sofrimento sertanejo. Já ao abordar as secas do século XX, transfere o tom crítico da monarquia para um enaltecimento da República, destacando os esforços de Epitácio Pessoa e José Américo de Almeida como marcos de uma nova postura estatal frente ao “problema secular” das secas (Almeida, H., 1958, p. 135).

Ainda assim, reconhece que a reincidência do fenômeno continua a ameaçar o Nordeste, sendo, “ainda hoje”, o mais grave dos problemas regionais. Sua visão, portanto, combina crítica política, memorialismo e idealização republicana, compondo um quadro em que a seca é tratada como catástrofe histórica, já o sertão, como espaço vulnerável, cuja “salvação” dependeria da ação enérgica e centralizadora do Estado (Almeida, H., 1958, p. 135).

Na extensa obra *História de Campina Grande* (1962), Elpídio de Almeida²⁶, no tópico dedicado à *Sêca de 1877*, constrói uma narrativa que combina elementos da história local relacionada à memória cívica e ao papel desempenhado pela Câmara Municipal.

O autor recorre a fontes como notícias de jornais da época e, também, aos relatos de Irineu Joffily, então deputado estadual na época e natural de Campina Grande, figura destacada pelos esforços de melhorias de auxílios e condições estruturais para a cidade – representada como um ponto de passagem e acolhimento dos migrantes que vinham do sertão e da Borborema em direção à Capital da Província, e, apesar de todas as circunstâncias ruins que a seca proporcionou, o autor reserva a ela um lugar de destaque na superação da crise (Almeida, E., 1962, p. 159-160).

Ao final do tópico, afirma que a seca não produziu em Campina Grande os “quadros angustiantes” observados em outras localidades, graças às providências do poder público, e conclui que a catástrofe teria, de certo modo, impulsionado o progresso urbano e institucional do município. Essa perspectiva mostra a preocupação de Elpídio com uma escrita voltada à valorização da cidade onde nasceu, colocando-a como símbolo de crescimento: “após o triênio de sofrimentos, consolava-se em ver aumentado o seu patrimônio com o levantamento de dois edifícios públicos, marcando a sua primeira fase de *desempêrr*o e crescimento. Lucrou com a desgraça” (Almeida, E., 1962, p. 163).

Elpídio ainda direciona sua narrativa sob a perspectiva da elite que compôs a legislatura de 1877-1879. No tópico dedicado às *Câmaras Municipais*, há um destaque reiterado às iniciativas dos vereadores de Campina Grande, mais uma vez, o destaque é para a atuação de Irineu Joffily, ao conseguir a solicitação de recursos para a construção de uma cadeia pública. O enfoque de Elpídio recai, portanto, sobre os feitos dessa elite política local, representando-a como ativa e eficaz. Tal representação alinha-se à construção de uma memória cívica voltada à exaltação das virtudes e do protagonismo das autoridades campinenses.

Na década de 1980, novos estudos e abordagens teórico-metodológicas sobre o tema emergiram, destacando-se a dissertação de mestrado *Falas de astúcia e de angústia: A seca*

²⁶ Elpídio de Almeida (1892–1970) foi médico, político, memorialista e um dos principais nomes ligados à construção da história de Campina Grande. Atuou como prefeito do município duas vezes: 1947-1951 e 1955-1959; publicou, em 1962, a obra *História de Campina Grande*, na qual reuniu documentos, depoimentos e memórias sobre a cidade, articulando uma narrativa que associa progresso urbano, identidade local e civismo. Participou do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) e foi membro da Academia Paraibana de Letras (APL). Sua produção busca enaltecer os feitos das elites campinenses, especialmente em momentos de crise, como nas secas e revoltas populares, contribuindo para consolidar uma memória oficial da cidade. Para essas e outras informações sobre sua vida e obra, ver: SILVEIRA, Regina P. S. **(Re)lendo “História de Campina Grande” de Elpídio de Almeida: uma construção histórica da “grande” campina.** 2014. 121f. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.

no imaginário nordestino de problema a solução (1877-1922), de Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1988). O autor explora a construção sociocultural do imaginário e do discurso sobre a seca, formulado pelas elites regionais para legitimar o controle político sobre as classes mais pobres, com base na exploração da mão de obra livre e em iniciativas de assistência particular.

É nesse contexto que se formam duas vertentes discursivas: uma, de caráter científico, voltada à elaboração de estudos para entender as causas e propor soluções para o problema; e outra, de natureza oligárquica, centrada no fenômeno da seca como instrumento de poder e expressão de uma *cultura política* de grupos que “conhecem o problema, e tem por obrigação defender os “flagelados”, reivindicar junto ao poder público providências para que o espaço e o povo do qual são porta-vozes não continuem sofrendo” (Albuquerque Jr., 1988a, p. 271).

Em sua outra obra *A Invenção do Nordeste e Outras Artes* (2011 [1999]) derivada da tese de doutorado defendida em 1994, Albuquerque Jr. argumenta que a “Grande Seca” de 1877 passou a ser representada como um “problema nacional”, o que impactou profundamente as relações políticas, econômicas e até mesmo religiosas, ecoando ainda na literatura regionalista dos anos 1930. Autores como José Lins do Rego, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos contribuíram para a consolidação de um imaginário popular do que viria a ser o Nordeste, retratando seus habitantes e paisagens marcadas pela luta e sofrimento frente às adversidades climáticas e sociais.

Esses discursos não apenas moldaram a forma como a seca era vista, mas também construíram um imaginário de atraso e carência em torno dessa região, uma vez que “o Nordeste nasce onde se encontram poder e linguagem” (Albuquerque Jr., 2011b, p. 33), visão que persiste até os dias atuais e continua a influenciar as representações contemporâneas sobre o Nordeste como uma região distinta no Brasil.

Essas transformações historiográficas também podem ser observadas na historiografia paraibana, com a obra *Raízes da Indústria da Seca: O caso da Paraíba* (1993)²⁷ de Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, que investigou as atuações políticas e seus efeitos econômicos, as permanências provocadas pelas sucessivas estiagens que afetaram a Parahyba ao longo da história, com ênfase no período da Primeira República.

De acordo com a autora, a Seca de 1877-79 inaugurou as primeiras ações públicas de cunho assistencialista ou, na terminologia atual, marcou o início da chamada indústria da seca,

²⁷ O livro faz parte dos resultados da sua dissertação de mestrado, intitulada: FERREIRA, Lúcia de Fátima G. **Estrutura de poder e seca na Paraíba (1877-1922)**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, 1982.

que está relacionado a três fatores principais de ordem estrutural: a crise crônica da economia nordestina, agravada pelas estiagens prolongadas; a organização política voltada para atender interesses privados de certos segmentos da sociedade; e a articulação de um *lobby* para captar recursos federais (Ferreira, 1993, p. 72-73).

Além disso, outras situações passam a ganhar visibilidade quando se analisam as dinâmicas sociais e políticas envolvidas nos demais episódios de seca na região Nordeste – como os saques, os desvios de verbas, a exploração da mão de obra migrante, além das condições insalubres e das doenças que os acometiam (Ferreira, 1993, p. 65).

A autora ainda destaca que, após a seca de 1877-79, consolidou-se um padrão de apropriação indevida dos recursos públicos por parte das elites locais, configurando uma “simbiose” entre os poderes público e privado. A má aplicação e o desvio de verbas, a exploração do trabalho e as obras inacabadas passaram a compor um sistema duradouro que, nas palavras da autora, “confirma a persistência da indústria da seca no período da Primeira República” (Ferreira, 1993, p. 74).

Outro trabalho fundamental, que dialoga com algumas das questões desta dissertação, é *A multidão e a história: Saques e outras ações de massa no Ceará* (2000), de Frederico de Castro Neves. Nessa obra, o autor propõe uma inflexão importante no modo de interpretar as experiências coletivas associadas às secas no Nordeste, ao deslocar o foco das explicações centradas exclusivamente nas elites políticas, nas instituições estatais ou nas respostas técnicas para a observação das práticas, percepções e ações das camadas populares.

Inserido no campo da História Social, o autor busca compreender a multidão não como massa amorfa ou irracional, mas como sujeito histórico situado, cujas ações – como deslocamentos, aglomerações, protestos, saques ou ocupações do espaço urbano – devem ser analisadas em seus contextos sociais, econômicos e políticos específicos. Ao fazê-lo, Neves problematiza leituras que tendem a associar automaticamente essas populações à desordem ou à barbárie, mostrando como tais interpretações foram historicamente construídas por discursos oficiais interessados em legitimar práticas de controle e repressão.

Embora não tenha como eixo central a análise da saúde ou das doenças, sua abordagem contribui para ampliar a compreensão das secas como experiências sociais complexas, nas quais fome, migração, assistência e conflito se entrecruzam, abrindo caminho para leituras que considerem o cotidiano, o sofrimento e as estratégias de sobrevivência dos grupos populares para além das narrativas institucionais.

É a partir dessas contribuições – articuladas às interpretações de âmbito nacional e regional aqui discutidas – que se pode encerrar este percurso historiográfico, mostrando como

as leituras sobre a seca estiveram profundamente vinculadas às estruturas políticas, econômicas e institucionais que moldaram as respostas do governo em relação às crises climáticas.

Ao longo do tempo, a seca foi compreendida como fenômeno natural, problema técnico, instrumento de disputa política, produzindo narrativas que privilegiaram obras, recursos, elites dirigentes e projetos de modernização, ao mesmo tempo em que relegaram a segundo plano as experiências do adoecimento, da fome e da morte.

Assim, ainda que a historiografia tenha avançado ao denunciar práticas assistencialistas, desvios de verbas e mecanismos de exploração da mão de obra migrante, permanecem lacunas importantes no que se refere à análise sistemática das condições sanitárias, das doenças e das práticas de cuidado que atravessaram o cotidiano das populações atingidas pela seca.

É a partir desse ponto que se justifica o deslocamento do olhar para os diálogos historiográficos e literários sobre a saúde e as doenças, tema do próximo subtópico, no qual apresentamos inicialmente os principais debates e abordagens da historiografia da saúde e das doenças, para, em seguida, analisar como essas questões foram apresentadas, narradas, silenciadas ou instrumentalizadas no contexto específico da Seca de 1877-1879.

1.2 DIÁLOGOS LITERÁRIOS E HISTORIOGRÁFICOS SOBRE A SAÚDE E AS DOENÇAS

No intuito de delimitar os caminhos teóricos e metodológicos que embasam este trabalho, faz-se necessário situar, ainda que brevemente, algumas das produções historiográficas que consolidaram o campo da História da Saúde e das Doenças.

Para além da produção historiográfica propriamente dita, é fundamental considerar o papel da literatura na construção de sensibilidades, imagens e narrativas sobre a seca, o adoecimento e o sofrimento social. As obras literárias produzidas no contexto da “Grande Seca” de 1877-1879, ou em diálogo direto com ela, não apenas registraram experiências de fome, migração e doença, mas também contribuíram para fixar representações duradouras sobre os corpos sertanejos, a miséria e a morte. Nesse sentido, a literatura constitui um campo privilegiado de observação das percepções sociais sobre a saúde e a doença, permitindo acessar dimensões subjetivas, morais e políticas do adoecer que muitas vezes escapam aos registros administrativos e médicos.

Nesta abordagem, a seca é frequentemente representada por meio de um discurso de dramatização que tende a reduzir ou generalizar a complexidade das experiências vividas, especialmente no que diz respeito à dependência de auxílios, ao controle dos corpos e às estratégias de sobrevivência. Embora esses registros sejam fundamentais para a construção da memória sobre as secas, é preciso atentar para como certas representações, ao se tornarem recorrentes, acabam reforçando visões estigmatizadas e pouco sensíveis à diversidade das experiências. Ainda que contribuam para evidenciar o drama humano vivido em contextos de estiagem, impõe-se analisá-las de forma crítica, considerando seus limites e os contextos históricos e sociais de sua produção.

Cabe mencionar que diversos romances produzidos no contexto das secas enfatizam a miséria, a apatia e o fatalismo como traços recorrentes associados às regiões do Norte. Nessas obras, a saúde e as doenças aparecem frequentemente vinculadas a situações de sofrimento extremo, precariedade material e abandono. Diante disso, torna-se relevante observar de que modo essas experiências de adoecimento são construídas literariamente, tomando como referência duas das obras mais conhecidas sobre a Seca de 1877–1879.

Começamos por José do Patrocínio²⁸, cuja obra *Os Retirantes* (2014 [1879]) apresenta a saúde como um dos elementos centrais do drama vivido pelos retirantes da seca, ainda que de forma menos sistemática do que em Rodolfo Teófilo. Ao longo do texto, é possível identificar menções diretas a doenças como beribéri, cólera, lepra e febre intermitente, além de referências mais amplas a epidemias, que apontam para um cenário de colapso sanitário.

Ainda que poucas enfermidades sejam nomeadas de modo preciso, o autor revela intensa preocupação com o adoecimento físico e moral provocado pelas condições extremas de miséria. Os sintomas descritos – corpos esqueléticos, olhos injetados, febre, diarreia, prostração e debilidade muscular – expõem o esgotamento dos corpos e a degradação das condições de vida. Esses sinais aparecem associados à fome prolongada, à exposição ao

²⁸ Figura central na história intelectual e política do Brasil oitocentista. Filho de um padre com uma mulher escravizada, cresceu numa fazenda onde pôde observar, desde cedo, a realidade brutal da escravidão. Formado em Farmácia em 1874, envolveu-se desde jovem com o movimento republicano e com o jornalismo de combate. Ingressou no Clube Republicano e participou de publicações como *Os Ferrões*, antes de ser contratado pela *Gazeta de Notícias*, onde iniciou sua trajetória como correspondente. Segundo André Scoville, o romance publicado por José do Patrocínio em 1879 surgiu como resposta direta à experiência vivida pelo autor durante a seca de 1877-1879, após sua viagem ao Ceará em 1878 como correspondente da *Gazeta de Notícias*. A gravidade do cenário presenciado, segundo Scoville, marcado por fome e extrema miséria, levou Patrocínio a transformar aquelas impressões em uma narrativa ficcional ambientada naquele contexto histórico. A crítica aponta que o tom excessivamente dramático e as descrições carregadas presentes na obra refletem tanto a formação jornalística quanto o engajamento político do autor. Ainda assim, “é verdade que tais excessos são muitas vezes aceitos com certa condescendência em face da realidade em si assustadora” (Scoville, 2011, p. 106).

relento, à falta de abrigo, à insônia e ao abandono social, compondo um quadro de sofrimento físico e psicológico que ultrapassa a simples descrição naturalista.

O adoecimento, nesse contexto, assume dimensões políticas e morais, revelando como os corpos das populações pobres, sobretudo as do sertão, são os primeiros a sucumbir quando as autoridades públicas falham em proteger seus cidadãos. Patrocínio, ao retratar cenas como a de um menino “ferido por toda parte” ou a de um prisioneiro faminto que se arrasta como um animal, evidencia a íntima conexão entre miséria, abandono e doença. Assim, mesmo com um vocabulário médico limitado, *Os Retirantes* contribui para a compreensão das múltiplas formas de sofrimento dos retirantes do Ceará no final do século XIX, ressaltando o impacto da fome sobre a saúde coletiva e a brutalidade de um sistema que naturaliza a morte dos pobres (Patrocínio, 1879).

Já Rodolfo Teófilo²⁹, em *A Fome* (2015 [1890]a), acompanha o drama dos retirantes sertanejos que, obrigados a abandonar suas terras, migram para Fortaleza, capital do Ceará, em busca de socorros. Na cidade, enfrentam a fome, a sede, as doenças e a indiferença do poder público. O romance constitui, assim, uma narrativa densa e trágica dos impactos da seca de 1877–1879 sobre a saúde física e mental das populações sertanejas.

Ao longo da obra, são mencionadas mais de trinta doenças, como varíola, beribéri, anasarca, disenteria, febre amarela, tifo e tuberculose, além de inúmeros sintomas e estados clínicos, descritos em passagens como “corpo coberto de feridas”, “os membros torácicos... em uma rigidez tetânica”, “delírios”, “febres”, “inchaços”, “insônia”, “apetite de besta esfomeada” e “garganta, meio fechada pela inflamação das mucosas, crivadas de pústulas, quase não permitia a deglutição”, entre outros (Teófilo, 2015 [1890]a).

Esses sinais indicam um cenário de colapso sanitário, agravado pela fome, pela promiscuidade e pelas precárias condições de abrigo, higiene e cuidado, somadas à ausência de uma rede de assistência pública eficaz. A obra não apenas descreve enfermidades com precisão quase médica, mas constrói um retrato cru da degradação do corpo e da experiência humana dos retirantes, convertendo o sofrimento coletivo em denúncia social. Diante da extrema miséria, a saúde aparece não como um direito universal, mas como um privilégio inalcançável para grande parte da população sertaneja (Teófilo, 2015 [1890]a).

²⁹ Rodolfo Marcos Teófilo (1853–1932) farmacêutico, escritor e intelectual baiano radicado no Ceará. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, destacou-se como um dos primeiros sanitaristas do estado e como um dos maiores cronistas das tragédias provocadas pelas secas nordestinas. Sua atuação durante a Seca de 1877–1879 combinou prática farmacêutica, denúncia social e engajamento humanitário. Autor de obras como *História da Seca do Ceará* (1883) e *Os Brilhantes* (1895) buscou representar por meio de uma narrativa marcada pelo realismo os dilemas sociais e morais do sertão no contexto da Seca.

Desse modo, as obras de José do Patrocínio e Rodolfo Teófilo, embora distintas em estilo, vocabulário e grau de detalhamento no tratamento da saúde e das doenças, convergem na construção de uma imagem significativa da seca como experiência marcada por profundas desigualdades regionais.

Ao contraporem os espaços do interior assolados pela fome, pela escassez de auxílios, pelo desgaste extremo dos corpos e pela perda de vínculos familiares às cidades que vivenciavam processos de urbanização e “modernização”, esses romances evidenciam a assimetria das respostas à crise. Ao dramatizarem a fome, o adoecimento e a morte, contribuíram decisivamente para a fixação de sensibilidades e representações sobre a vida dessas populações atingidas pela seca, ressaltando como o sofrimento físico e social se distribuía de forma desigual no território e recaía de maneira mais severa sobre aqueles afastados dos circuitos de proteção e assistência.

A partir dessas representações literárias, torna-se possível compreender como a seca e o adoecimento foram sentidos, narrados e simbolizados no final do século XIX. No entanto, para avançar na análise das respostas institucionais, das práticas médicas e das formas de organização da assistência, faz-se necessário deslocar o olhar para a produção historiográfica.

Desde as últimas décadas do século XX, a História da Saúde e das Doenças vem se afirmando como uma vertente importante da historiografia, ao incorporar novos olhares sobre o adoecimento, compreendido não apenas como fenômeno biológico, mas como experiência atravessada por significados sociais, religiosos, políticos e simbólicos (Silveira, A.; Nascimento, D., 2004). É a partir desse enquadramento que se torna possível dialogar com autores e interpretações que sustentam as análises desenvolvidas ao longo desta dissertação.

Considerando o recorte desta pesquisa, o diálogo historiográfico sobre saúde e doenças tem início na produção paraibana, observando como essas questões foram incorporadas, ainda que de forma fragmentada ou secundária, pelos autores locais. A opção por iniciar pela historiografia da Paraíba permite acompanhar os primeiros registros sobre epidemias, práticas médicas e condições sanitárias, bem como os limites e silêncios que marcaram essas interpretações, antes de avançar para debates mais amplos produzidos em outros contextos historiográficos.

Na historiografia paraibana³⁰, a temática começa a ser introduzida, ainda que de forma superficial, em algumas seções e tópicos descritos por Irineu Pinto (1910), que oferece um

³⁰ Azemar Soares Jr. elaborou um levantamento sobre a historiografia da saúde e das doenças desde o período colonial até o tempo presente, ver: SOARES JR., A. S. História e historiografia da saúde e das doenças na

relato detalhado sobre os impactos da epidemia de cólera que assolou a Província da Parahyba em 1856 – sendo essa a primeira vez que a moléstia atingiu a região, motivo pelo qual ficou conhecida como “primeiro cólera”; por Flávio Maroja (1911), que, em tom denunciatório e elogioso, aponta a precariedade dos serviços públicos de saúde, a ausência de dados estatísticos sobre mortalidade e natalidade e a necessidade de modernização dos serviços de higiene urbana.

Heronides Alves Coelho Filho (1959), por sua vez, apresenta apontamentos sobre a epidemia de cólera de 1856, retomando aspectos já mencionados por seus predecessores. Todos esses trabalhos foram publicados na *Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba* (IHGP), indicando que as primeiras abordagens sobre a saúde e as doenças na província estiveram vinculadas ao ambiente intelectual do Instituto.

É com os trabalhos citados logo abaixo que a temática ganha novas discussões. Ainda que não constituíssem o foco central de suas obras, representam contribuições importantes da historiografia “clássica”, produzidas de acordo com o contexto e as transformações sociais da época em que estavam inseridos (Certeau, 2011).

Nesse movimento de ampliação do olhar, a saúde e as doenças passam a ser incorporadas de forma mais sistemática às interpretações sobre a seca, a pobreza e a organização social da província.

José Américo de Almeida (2012 [1923]), na obra já mencionada, desenvolve, em alguns de seus capítulos, reflexões importantes sobre essa temática, contribuindo para o entendimento do cenário em questão. Em *O Martírio*, elenca as secas que atingiram a Parahyba entre 1692 e 1915, apresenta índices de doenças, descreve a superlotação da capital e o cenário de fome, mobilizando ampla documentação, muitas vezes reproduzida integralmente ao longo da narrativa.

Já em *O Saneamento*, o autor detém-se na questão da salubridade pública, reunindo discursos proferidos por higienistas da época acerca dos costumes de higiene e das medidas impostas à população. Também realiza um mapeamento das endemias e epidemias, do século XVII ao início do XX, evidenciando a recorrência das crises sanitárias na província.

Paralelamente a essa leitura de caráter mais abrangente e interpretativo, outros autores dedicaram-se a registrar a atuação médica e as práticas de cura na província, como é o caso

de Oscar Oliveira de Castro.³¹ Em *Medicina na Paraíba: flagrantes de sua evolução* (1945), o autor apresenta importantes descrições sobre a biografia dos médicos que atuaram na Parahyba nos séculos XIX e XX. Epidemias e doenças da época, bem como os primeiros práticos – como homeopatas, curandeiros e sangradores, que utilizavam plantas, sangrias e outros métodos de cura frequentemente em confronto com o saber médico oficial – figuram entre os temas abordados ao longo dos dezessete capítulos da obra.

Essa atenção às práticas médicas e populares também aparece nos trabalhos de síntese histórica produzidos nas décadas seguintes. Horácio de Almeida, em *História da Paraíba*, vol. 2 (1978b), dedicou uma seção aos males epidêmicos – como a varíola, a febre amarela e o cólera – e outra intitulada *Medicina do povo*, na qual apresenta uma extensa lista de terapêuticas populares desenvolvidas no século XIX. Entre elas, destacam-se os chás de barata, o uso de excremento de cachorro e a flor de louro, aplicados no tratamento de doenças como bronquite, reumatismo e constipações, entre outras.

A partir do final do século XX, observa-se um deslocamento importante no modo como a saúde, as doenças e as práticas de cura passaram a ser tratadas no campo historiográfico. Se, na produção paraibana mais clássica, essas questões apareciam de forma descritiva, episódica ou subordinadas a narrativas mais amplas sobre progresso, calamidade ou administração pública, as décadas seguintes assistiram à incorporação de novas abordagens teóricas e metodológicas, especialmente aquelas vinculadas à História Cultural e Social.

Nesse movimento, a doença deixa de ser compreendida apenas como evento médico ou sanitário e passa a ser analisada como experiência histórica, atravessada por relações de poder, sensibilidades, representações e práticas cotidianas. É nesse contexto de renovação historiográfica – que extrapola os limites regionais e dialoga com debates internacionais – que se consolidam referências fundamentais para pensar o corpo, o adoecimento e as políticas de saúde como construções sociais e históricas, abrindo caminho para as discussões que emergem a partir da historiografia internacional.

Um dos marcos pioneiros dessa renovação historiográfica surge na década de 1970, com a coletânea *História: Novos Objetos* (1995 [1976]), organizada por Jacques Le Goff.

³¹ Oscar de Oliveira Castro (1899–1970) nasceu em Bananeiras, na Paraíba. Formou-se inicialmente em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e, posteriormente, em Medicina pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro, em 1923. Embora tenha recebido convites para clinicar no Rio de Janeiro, optou por retornar à Paraíba, onde exerceu na administração pública e na vida intelectual do estado. Além da atuação médica, destacou-se como professor, jornalista e escritor, lecionando em diversas instituições de ensino secundário e superior, entre elas o Lyceu Paraibano, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito da então Universidade da Paraíba. Membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e da Academia Carioca de Letras, presidiu a Academia Paraibana de Letras por 25 anos, consolidando-se como figura de relevo na produção intelectual e na organização do campo médico e cultural paraibano no século XX (Barbosa, S., 2009, p. 44-45).

Dentre os ensaios, destacamos *O Corpo: o homem doente e sua história*, de Jacques Revel e Jean-Pierre Peter (1976), enfatizam as doenças como processos de desorganização e reorganização social, moldadas conforme a imagem criada pela sociedade e pelas relações de poder nas quais estão inseridas.

Seguindo o debate historiográfico sobre a saúde e as doenças como objeto de investigação, encontramos nas reflexões de Susan Sontag em *A Doença como Metáfora* (1984 [1978]) um ponto de partida essencial para pensarmos nesta pesquisa. Sua crítica ao uso das doenças como metáforas, especialmente a tuberculose e o câncer, evidencia como a linguagem médica, ao ser transposta para o campo político, moral e social, produz sentidos que extrapolam o biológico e impõem julgamentos morais aos indivíduos doentes (Sontag, 1984, p. 46).

Para a autora, as metáforas e os mitos, por mais sofisticados que sejam, contribuem para a desumanização do doente. Esse alerta nos conduz a uma postura cautelosa ao lidar com os discursos médicos e políticos que recaíram sobre os migrantes atingidos pela seca de 1877-79, muitas vezes tratados como portadores de doenças contagiosas e degenerativas, associando a miséria física à degradação moral e social.

Sontag argumenta que as metáforas associadas à doença funcionam como formas de punição moral e social, e é nesse ponto que sua reflexão converge com a necessidade de compreendermos como, historicamente, o adoecimento dos pobres e migrantes foi interpretado à luz de padrões morais e políticos da época. A autora aponta que a tuberculose, no século XIX, foi associada como uma “doença ativa e condenável”, ao passo que o câncer passou a representar repressão e ressentimento (Sontag, 1984, p. 52).

Ambas, porém, serviram para reforçar visões sociais sobre o corpo, o sofrimento e o lugar do outro, e é nesse ponto que a reflexão de Sontag se aproxima da realidade abordada nesta pesquisa, em que os migrantes pobres, oriundos do sertão, vítimas da fome e da seca, foram historicamente construídos como esse outro: sujeitos marcados pelo estigma da doença, do perigo e da desordem (Sontag, 1984).

Ao analisar como a tuberculose impulsionava deslocamentos para regiões como o sul, o campo ou o isolamento (como se a geografia também tivesse um papel terapêutico), Sontag nos ajuda a perceber como o espaço e o deslocamento são atravessados por significados médicos e morais.

Isso se conecta com os fluxos migratórios provocados pela seca, nos quais os sertanejos que chegavam às cidades litorâneas eram vistos não apenas como “miseráveis”, mas como um risco à saúde coletiva, como um corpo estranho a ser contido. Portanto, a crítica

de Sontag se torna um instrumento teórico para pensarmos o modo como o discurso médico reforça desigualdades sociais e políticas, e como o adoecimento pode ser usado como marcador de alteridade e exclusão.

Ao deslocar o foco da doença como experiência individual para os sentidos morais, políticos e sociais que se constroem em torno do adoecer, as reflexões de Sontag também nos conduzem a pensar os vínculos entre saber médico e mecanismos de poder. É nesse movimento que se torna pertinente aproximar essa discussão das análises de Michel Foucault, que examinam a medicina não apenas como campo de saber, mas como prática histórica de intervenção e regulação social.

Em *O nascimento da medicina social*, Michel Foucault (1999 [1979]) analisa como, entre os séculos XVIII e XIX, a medicina se transformou em uma tecnologia de poder voltada não apenas para curar indivíduos, mas para organizar, vigiar e controlar populações inteiras (Foucault, 1999, p. 89). A partir de três experiências distintas discutidas por ele – a francesa, a alemã e a inglesa – demonstra como a medicina urbana passou a esquadrihar os espaços, normatizar os corpos e definir condutas em nome da salubridade e da prevenção de doenças.

No caso francês, a cidade foi mapeada em função dos riscos sanitários: cemitérios, rios, casas e até o subsolo foram reorganizados para garantir a circulação do ar e da água, sob a lógica de que o meio poderia adoecer o corpo (Foucault, 1999, p. 90-91). Na Inglaterra, com o crescimento do proletariado, a medicina passou a incidir sobre os pobres, que deixaram de ser vistos como parte funcional da cidade e passaram a ser percebidos como ameaça (Foucault, 1999, p. 94-95). Além disso, foram criadas leis e serviços médicos para controlar seus corpos, comportamentos e locais de moradia, como exemplificam a Lei dos Pobres e os sistemas de *health service*³² (Foucault, 1999, p. 95-96).

Ao evidenciar como a biopolítica operou como instrumento de regulação social, Foucault nos oferece ferramentas importantes para pensar as práticas médicas e higiênicas voltadas a população da seca de 1877-79, que, ao migrarem em massa para áreas urbanas, também passaram a ser vistos como ameaça à ordem, à saúde pública e ao espaço urbano, não apenas por sua condição física, mas por sua presença social e moral. Nesse sentido, a medicalização dos pobres descrita por Foucault contribui para compreender os modos pelos

³² Conforme explica Foucault (p. 94-96), o *health service* se diferenciava da chamada Lei dos Pobres (*Poor Law*), pois enquanto esta oferecia assistência médica direta ao pobre como indivíduo, o *health service* voltava-se à população como um todo. No entanto, suas medidas recaíam, na prática, principalmente sobre as classes mais pobres, como um instrumento de controle social.

quais a pobreza, a migração e a doença se entrecruzaram na atuação das autoridades públicas durante os períodos de crise.

As contribuições de Foucault relevam como a medicina se constituiu historicamente como instrumento de gestão dos corpos e das populações. Esse deslocamento do olhar – da doença enquanto dado natural para a doença como fenômeno socialmente produzido – também se reflete em abordagens historiográficas que passaram a interrogar o adoecer a partir de sua historicidade.

É nesse horizonte que se insere coletânea *As Doenças têm História* (1985), organizada por Jacques Le Goff, a qual os ensaios reunidos rompem com a compreensão da doença como mero fenômeno biológico. Segundo o autor, as doenças passam a ser compreendidas por sua historicidade e construção social, o que representa uma mudança significativa no modo de analisar os processos de adoecimento. A obra passa a entendê-las como construções históricas e sociais, relacionadas às formas de vida, às condições de propagação e aos impactos sobre o cotidiano das populações. Essa perspectiva amplia o olhar da historiografia da saúde e das doenças, deslocando-o do campo estritamente biológico para um campo interpretativo que envolve dimensões culturais, políticas e sociais da experiência do adoecer.

Essa abordagem também se expressa nas reflexões de Roy Porter (1992, p. 297) ao propor, em seu ensaio *História do corpo*, uma leitura da história da medicina que convida a “enxergar o corpo como ele tem sido vivenciado e expresso no interior de sistemas culturais particulares, tanto privados quanto públicos”. Ao deslocar o foco da análise tradicionalmente centrada nos médicos e nas instituições para as experiências subjetivas dos doentes, Porter oferece uma chave interpretativa valiosa para pensarmos as sensibilidades e percepções do sofrimento vivenciadas durante a chamada “Grande Seca” de 1877-1879.

Porter enfatiza que a doença deve ser compreendida, antes de tudo, como experiência vivida, atravessada por sentidos e interpretações que extrapolam o campo da medicina e da ação estatal. Essa perspectiva permite considerar que, no contexto da seca, o adoecimento esteve profundamente ligado às condições extremas de vida, à fome, à migração forçada e ao abandono.

Pensar historicamente as doenças implica, assim, atentar para as formas como o sofrimento foi experimentado, nomeado ou silenciado, bem como para as respostas sociais, religiosas e terapêuticas mobilizadas diante dele (Porter, 1992). Ao reposicionar o sujeito doente no centro da análise, a abordagem de Porter contribui para retirar essas experiências do anonimato, aspecto particularmente relevante em uma pesquisa que toma os migrantes como protagonistas de um processo coletivo de sofrimento físico e social.

As contribuições desses autores foram fundamentais para consolidar, no âmbito internacional, uma compreensão histórica do adoecer centrada nas experiências dos sujeitos, nas representações sociais e nas relações entre corpo, poder e sociedade. Essas abordagens exerceram forte influência sobre a historiografia brasileira, que, a partir das últimas décadas do século XX, passou a incorporar tais referenciais teóricos e metodológicos na análise das doenças, das práticas de cura e das políticas de saúde, deslocando o foco exclusivo das instituições médicas para os contextos sociais, culturais e políticos nos quais o adoecimento se produzia.

No Brasil, a temática da saúde e das doenças foi aprofundada por diversos historiadores. Sidney Chalhoub (1996) analisou como as epidemias de febre amarela e varíola impactaram a organização urbana e social do Rio de Janeiro no século XIX; Betânia Gonçalves Figueiredo (2002) examinou os diversos agentes e práticas de cura em Minas Gerais no mesmo período; e Tânia Salgado Pimenta (2004) discutiu as transformações no exercício das práticas de curar no Rio de Janeiro entre 1828 e 1855.

Também se destacam os estudos de Anne Jackeline Silveira (2005), que analisou os debates médicos em torno da gripe espanhola de 1918; Dilene do Nascimento (2005), que desenvolveu um estudo comparado sobre tuberculose e Aids no Brasil; e Diana Maul de Carvalho (2005), que investigou textos médicos impressos sobre a varíola entre os séculos XVI e XVIII. Esses trabalhos contribuíram para consolidar o campo da História da Saúde no Brasil, ampliando as possibilidades de análise sobre epidemias, práticas médicas e discursos científicos.

Outros trabalhos também contribuíram para esse campo, como os de Ana Karine Martins Garcia (2011b), sobre a atuação médica em Fortaleza; Serioja Mariano e Nayana Mariano (2012; 2022), que abordaram as epidemias e as práticas terapêuticas na Parahyba; Azemar dos Santos Soares Jr. (2015), sobre discursos médico-pedagógicos nas escolas paraibanas; Sebastião Pimentel Franco (2015), acerca do cólera no Espírito Santo; Alisson Eugênio (2016), sobre a saúde dos cativos; e Rafael Nóbrega Araújo (2020), que analisou os discursos médico-higienistas no combate à sífilis na Paraíba, entre vários outros historiadores.

Nesse sentido, dialogamos com as reflexões de Dilene do Nascimento, ao destacar que os estudos sobre as doenças não se limitam à análise de concepções médicas ou científicas, mas permitem compreender seus efeitos sobre as relações de poder, as práticas cotidianas e os processos históricos mais amplos. Para a autora, esse campo de investigação possibilita apreender dinâmicas fundamentais da vida social, ao iluminar aspectos como a estrutura e as transformações sociais, a dinâmica demográfica e os deslocamentos populacionais, elementos

centrais para a compreensão histórica das experiências de adoecimento (Nascimento, D., 2005, p. 29).

No âmbito da produção acadêmica da Paraíba, as novas abordagens sobre a História da Saúde e das Doenças passaram a ser desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH/UFPB)³³. Em um levantamento realizado no Repositório Institucional do referido Programa, identificamos, até o momento, dez dissertações de mestrado que dialogam com o tema em diferentes contextos e sujeitos históricos da província/estado da Paraíba.

Entre os trabalhos que abordam o século XIX, destacam-se: Juciêdo Alexandre (2010), que discutiu as representações sobre o cólera-morbo publicadas no jornal *O Araripe* (Crato-CE), entre 1855 e 1864; Gerlane Farias Alves (2018), sobre o tratamento dado aos alienados pela Santa Casa de Misericórdia da Parahyba entre 1858-1892; Janyne Barbosa (2018), que investigou as condições sanitárias nos campos de batalha e o tratamento médico dos doentes durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870; Wuendisy da Silva (2020), relacionado às diferentes artes de curar e as disputas entre curadores e médicos na Paraíba entre 1870 e 1880.

Somam-se a esses estudos as pesquisas de Elyonara Targino (2021), acerca da atuação dos médicos João José Inocêncio Poggi e Abdon Felinto Milanez na Parahyba na segunda metade do século XIX, e de Millena Dôso (2023), que investigou os impactos da epidemia de cólera de 1856 nos ritos da morte nas freguesias de Cabaceiras e São João do Cariri. Em conjunto, essas produções revelam a vitalidade das pesquisas sobre a saúde e as doenças no Oitocentos, ainda que não tenham se debruçado diretamente sobre a experiência da Seca de 1877-1879 na província.

Quanto aos estudos que abordam problemáticas relativas ao século XX, citamos: Azemar dos Santos Soares Jr. (2011), sobre os discursos de jornais sobre o corpo limpo e sujo na cidade da Parahyba entre 1912 e 1924; Júlio César Alves da Silva (2013), referente aos discursos eugênicos e higiênicos veiculados na imprensa paraibana entre 1914 e 1921; Fernando Domingos de Aguiar Jr. (2016), que focou nos discursos sobre a aids veiculados pela imprensa paraibana no ano de 1980; e Emanuel Calixto do Nascimento (2019), sobre os processos de construção do Hospital Colônia Getúlio Vargas na Paraíba e as políticas de isolamento de pessoas com hanseníase entre 1929 e 1941.

³³ Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5438?locale=pt_BR. Acesso em: 25 jun. 2024.

A partir dessas contribuições, torna-se possível avançar para estudos que articularam a História da Saúde e das Doenças às experiências das secas em diferentes espaços do Nordeste, que nos permite ampliar o horizonte comparativo e compreender como fome, adoecimento, migração e assistência foram vividos e administrados de maneiras distintas, conforme as condições locais, as respostas do poder público e os arranjos sociais específicos.

Sem perder de vista o recorte paraibano, o diálogo com essas produções contribui para identificar aproximações, contrastes e singularidades, além de oferecer referências analíticas importantes para pensar os impactos sanitários da Seca de 1877–1879 no contexto regional mais amplo.

Analisar como a seca em questão foi vivida e administrada no Ceará e no Rio Grande do Norte – duas províncias vizinhas e marcadas por intensos fluxos migratórios – permite traçar paralelos, contrastes e aproximações com o caso Paraíba. Esse exercício comparativo contribui para ampliar a compreensão das diferentes respostas adotadas diante da seca, tanto no plano social e político quanto no campo das medidas médico-sanitárias. Ao acompanhar a atuação das autoridades provinciais frente à crise, torna-se evidente que os impactos da seca não foram homogêneos e que as estratégias de enfrentamento variaram significativamente conforme os contextos locais.

Entre os trabalhos que melhor ilustram esse cenário comparativo – e que dialogam diretamente com as preocupações desta pesquisa – destaca-se a dissertação *A sombra da pobreza na Cidade do Sol* (2006a), de Ana Karine Martins Garcia. A autora oferece uma contribuição importante à historiografia da seca de 1877-1879 ao deslocar o foco tradicional das análises centradas nas ações governamentais ou nos efeitos econômicos da calamidade, voltando-se para um campo ainda pouco explorado: as dinâmicas urbanas e os discursos médico-higienistas construídos em torno da presença dos migrantes na capital cearense.

A partir de uma perspectiva social e inspirada nos estudos sobre o cotidiano, a autora investiga como a chegada massiva de migrantes de diversas regiões alterou o espaço urbano de Fortaleza, provocando tensões sociais, transformações no ordenamento da cidade e desencadeando intervenções de caráter sanitário e disciplinador. Sua análise se destaca por colocar em evidência os abarracamentos, alojamentos improvisados construídos pelo governo, como espaços centrais na experiência desta população e nos embates em torno da salubridade pública. A autora também articula as noções de exclusão espacial e temporal, ao mostrar como os migrantes foram silenciados enquanto sujeitos históricos e apagados da memória oficial urbana.

Ao abordar as doenças, as práticas médicas e as estratégias de sobrevivência nos abarracamentos, a autora ilumina um campo negligenciado pelos estudos sobre a seca, evidenciando como os ideais de progresso e civilização foram tensionados pela presença incômoda dos “indesejáveis” e pela propagação de epidemias como a varíola. Como ela observa, “as moradias dos emigrantes foram, diversas vezes, apontadas como nocivas à sociedade, devido a sua coletividade e, desse modo, assinaladas como focos de irradiação das epidemias” (Garcia, 2006a, p. 20).

Na tese *Alimentação, Saúde e Doenças Carenciais em Períodos de Seca nos Sertões do Rio Grande do Norte (1877-1935)*, Avohanne de Araújo oferece uma contribuição relevante à História da Saúde e das Doenças ao investigar as relações entre alimentação, doenças carenciais e políticas públicas em contextos de estiagem nos sertões potiguaros. O estudo adota um recorte temporal amplo, que se inicia com a seca de 1877-1879 e se estende até a construção do açude Itans, em 1935, momento em que passam a se consolidar medidas mais estruturadas voltadas à segurança hídrica e alimentar no estado.

Ao deslocar o foco tradicional das epidemias mais recorrentes – como o cólera e a varíola – para enfermidades de origem nutricional, como o beribéri e o escorbuto, a autora demonstra que essas doenças não podem ser compreendidas como resultado de carências individuais ou de uma suposta ignorância popular. Ao contrário, são analisadas como expressão de uma estrutura fundiária desigual, da precariedade do abastecimento alimentar e das fragilidades das políticas públicas diante das estiagens prolongadas (Araújo, 2022).

No que se refere à historiografia paraibana mais recente, a seca de 1877-1879 ainda aparece, em grande parte, de modo secundário, seja em obras de escopo mais amplo, seja em capítulos ou estudos específicos produzidos nas últimas décadas. Ainda assim, essas pesquisas oferecem contribuições importantes ao evidenciar como a estiagem atravessou diferentes dimensões da vida social, sanitária e cultural na Parahyba.

Entre esses trabalhos, destaca-se o estudo de Alarcon Agra do Ó (2005), que, ao analisar os modos de adoecer na Parahyba Imperial³⁴, menciona as secas ocorridas entre 1825

³⁴ Agra do Ó demonstra como diferentes enfermidades eram compreendidas e vividas a partir de explicações que combinavam fatores climáticos, ambientais, morais e sociais. O autor examina, por exemplo, a recorrência das epidemias de cólera, varíola, febre amarela e bexigas, frequentemente associadas à insalubridade dos espaços urbanos, à decomposição de matérias orgânicas, à qualidade da água e à circulação de pessoas e mercadorias. Discute ainda como práticas médicas baseadas na teoria miasmática, no controle dos hábitos cotidianos e na vigilância dos corpos conviviam com interpretações religiosas, medos coletivos e formas populares de lidar com a doença e a morte. Ao tratar de temas como o isolamento dos doentes, os enterramentos, o papel das câmaras municipais e a precariedade da assistência médica, o autor evidencia que o adoecimento constituía uma experiência social marcada por desigualdades, medos e tentativas de ordenamento da vida coletiva na província (Agra do Ó, 2005).

e 1898. No que se refere especificamente à estiagem de 1877-79, o autor aponta a falta de higiene e a escassez de água como fatores que contribuíram para a propagação de diversas doenças em Campina Grande e na Capital, ainda que o tema não constitua o eixo central de sua investigação.

Sob uma perspectiva sociocultural, Serioja Mariano (2020), ao estudar a sífilis na Parahyba entre 1860 e 1880, identificou um aumento significativo da doença e da prostituição no ano de 1877. Segundo a autora, médicos e inspetores de higiene associavam o avanço da sífilis às aglomerações de migrantes na Capital. Em trabalho posterior, dedicado à varíola nas décadas de 1870 a 1890, a autora encontrou resultados semelhantes, indicando que a maioria dos infectados era composta por migrantes não vacinados (Mariano, S., 2022).

Entre as produções que se aproximam de forma mais direta do recorte desta pesquisa, destaca-se a monografia *Morte e Seca: a cidade de São João do Rio do Peixe (PB) durante a estiagem de 1877/79*, de Rosimeire Silva (2012). Embora tenha como objeto central a morte, o estudo dialoga com o imaginário social sobre as doenças ao abordar as representações do medo e os rituais religiosos mobilizados diante da estiagem. A autora também elabora um quadro com as principais causas de morte entre 1870 e 1880, no qual diarreia, fome/desnutrição e febres figuram entre as enfermidades que mais afetaram a população do município.

Por fim, em sua tese *Doidos [as] e Doutores: A Medicalização da Loucura na Província/Estado da Parahyba do Norte (1830–1930)*, Helmara Junqueira (2016) dedica um capítulo à saúde da população atingida pela seca que se deslocava para a Capital. A autora evidencia como esses sujeitos tinham seus hábitos, costumes e comportamentos morais constantemente julgados pela população local, pelos médicos e pelo próprio governo. Além disso, aponta a estigmatização e negligência pública, em torno do estado de “loucura” e alienação, em que muitos se encontravam, os médicos desconheciam as formas de tratamento e cuidado com a saúde mental dessa minoria, vista como uma ameaça à segurança pública e ao desenvolvimento urbano.

Diante desse percurso, torna-se possível perceber como a seca de 1877-1879 foi narrada, interpretada e problematizada por diferentes registros discursivos e tradições historiográficas. As obras literárias contribuíram para a construção de sensibilidades, imagens e representações duradouras sobre a fome, o adoecimento e o sofrimento das populações sertanejas, ainda que operem sob lógicas narrativas próprias, marcadas pelo naturalismo.

Já a produção historiográfica – da escrita clássica paraibana às abordagens internacionais e nacionais da História da Saúde e das Doenças – permitiu deslocar o olhar para

as dimensões políticas, sociais e culturais do adoecer, mostrando como as doenças, longe de serem fenômenos exclusivamente biológicos, estiveram imbricadas em relações de poder, práticas de controle, estratégias de assistência e disputas em torno da ordem urbana e social.

Ao mesmo tempo, esse balanço evidencia que, no caso da historiografia paraibana, ainda persistem silêncios e abordagens fragmentadas no que se refere à articulação entre seca, saúde e doenças, especialmente quando se busca compreender a experiência para além das narrativas institucionais ou dos grandes eventos.

É a partir dessas lacunas, mas também dos diálogos já estabelecidos, que se justifica a opção por um enquadramento teórico-metodológico atento aos discursos, às práticas e às materialidades do adoecimento, bem como às formas pelas quais esses elementos foram registrados, classificados e administrados. Assim, passamos agora ao próximo subtópico, no qual explicitamos os conceitos operatórios, o *corpus* documental e os procedimentos analíticos que orientam esta pesquisa.

1.3 DA REFLEXÃO À CONSTRUÇÃO: CONCEITOS, FONTES E METODOLOGIAS

Como já destacamos, esta pesquisa dialoga com os novos conceitos, fontes e abordagens propostos pela Nova História Cultural³⁵, entre eles, as *representações sociais* de determinado grupo, indivíduo ou até mesmo de um local e seus possíveis conflitos. Quando olhamos para as representações sobre a imagem dos migrantes criada ao longo da história, podemos perceber o processo de construção desses sentidos e significados que são “os esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado [...] **são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam**” (Chartier, 1990, p. 17. Grifo nosso).

Nesta perspectiva, a noção de representação apresentada por Roger Chartier (1990) nos faculta a possibilidade de compreender como a imagem social dos migrantes e do restante da população afetada era construída, em diferentes recortes temporais, como o da Seca de 1877-79, e geográficos, como o da Parahyba do Norte, ao confrontarmos as fontes do século XIX, como relatórios médicos, cartas e ofícios.

³⁵ Consolidada na década de 1970, pela 3ª geração da *Escola dos Annales*, liderada por historiadores como Roger Chartier, Carlo Ginzburg, Jacques Revel, Peter Burke entre outros. Para a historiadora Sandra Pesavento (2004, p.118): “uma das características da História Cultural foi trazer à tona o indivíduo, como sujeito da História, recompondo histórias de vida, particularmente daqueles egressos das camadas populares”.

Tais representações constroem a realidade social por meio de classificações, sujeitos, divisões e delimitações. É comum encontrarmos, nessas fontes, informações que revelam a imagem atribuída aos migrantes que irá persistir ao longo do século XX, marcada por termos como “mendigos”, “desvalidos”, “indigentes”, “flagelados”, “preguiçosos”, ou ainda por referências à sua condição de saúde e higiene, como “desnutridos”, “famintos”, “bexiguentos”, “insalubres”, entre várias outras denominações que, como afirma Chartier: “são historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas figuras” (Chartier, 1990, p. 27).

Para melhor compreensão dos discursos médicos e das medidas higiênicas impostas à população, recorreremos ao conceito de *biopolítica*, desenvolvido por Michel Foucault (1979a, 1999c). O autor define o poder como uma forma de ordenar o saber sobre a vida, utilizando mecanismos de controle sobre os corpos de grupos sociais, conforme os interesses políticos vigentes. Segundo Nayana Mariano (2015, p. 52), a “população está intimamente ligada ao problema da gestão, do governo e da população, o que demandou investimentos em instituições variadas”.

Essa forma de poder, entendida como uma norma regulamentadora da vida, converge com as informações encontradas nas fontes utilizadas nesta pesquisa: relatórios da Santa Casa da Misericórdia, cartas enviadas pela Inspetoria de Saúde Pública ao presidente da Província, bem como os dados registrados pelos hospitais emergenciais destinados ao acolhimento dos migrantes.

Observamos nessas fontes diversas ordens impostas à população, como os artigos dos códigos de postura provisórios que tratavam de novas regras de enterramento, da inspeção e manutenção dos itens vendidos no matadouro público (considerados anti-higiênicos para a saúde coletiva), da situação da Cadeia Municipal (muitas vezes citada nos relatórios médicos como um dos principais focos de propagação de doenças epidêmicas), do ensino de práticas e costumes de higiene e dos projetos de urbanização.

Além disso, diversas medidas visavam à dispersão populacional como estratégia de controle demográfico. A mais conhecida delas foi a formação dos núcleos coloniais (ou colônias agrícolas), que tinham por objetivo conter o crescimento desordenado das áreas centrais e integrar os migrantes em zonas agrícolas, geralmente em troca de trabalho ou favores. Dessa forma, compreendemos que há uma forte relação entre:

[...] o conjunto constituído por medicina e higiene, vai ser no século XIX um elemento, não o mais importante, mas aquele cuja importância será considerável dado o vínculo que estabelece entre as influências científicas sobre os processos biológicos e orgânicos (isto é, sobre a população e sobre

o corpo) e, ao mesmo tempo, na medida em que a medicina vai ser uma técnica política de intervenção com efeitos de poder próprios (Foucault, 1999c, p.301-302).

Para melhor compreensão do papel das autoridades públicas da Parahyba no enfrentamento da seca, buscamos no conceito de *culturas políticas*, entendido como um

[...] conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhado por determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro (Motta, 2009, p.21).

Desse modo, é possível compreender o jogo de interesses e estratégias políticas a partir dos discursos e ações voltadas para o assistencialismo, bem como da forma como a população reagia a essas políticas.

Uma das fontes centrais para esta análise são os *Anais do Congresso Agrícola do Recife*³⁶, realizado em outubro de 1878 por iniciativa das elites nortistas – compostas por comerciantes, fazendeiros e políticos – que, diante da crise da agroindústria açucareira nas províncias do Norte, gravada pela escassez de mão de obra escravizada e pela expansão da economia cafeeira no Sudeste, se mobilizaram para discutir suas causas e propor soluções.

Observa-se, nesses registros, que a principal preocupação dessas elites era a preservação de seu poder econômico. Diante disso, cabe questionar: temas como saúde, condições de higiene ou o avanço de doenças entre a população afetada foram debatidos com a mesma ênfase? Houve alguma preocupação efetiva com os impactos sociais da seca, ou as discussões giraram em torno da reorganização do trabalho agrícola e da manutenção da produção?

Outra fonte essencial para observarmos a presença das culturas políticas são os *Anais da Câmara dos Deputados*³⁷, com os discursos proferidos pelos deputados gerais da Parahyba que integravam o parlamento entre 1877 e 1879. Nestes debates, observa-se a tentativa de legitimar certas ações assistenciais em nome da ordem pública e da estabilidade política, ao mesmo tempo em que se evidenciam as disputas de poder em torno da distribuição de recursos e da responsabilização pelo agravamento da crise. A atuação de figuras como Manoel Pedro Cardoso Vieira e João Florentino Meira de Vasconcellos, por exemplo, revela o esforço de setores da elite provincial em intervir no debate público e nas decisões administrativas, mobilizando argumentos ora humanitários, ora técnicos, para defender medidas como a criação de hospitais, distribuição de mantimentos e organização de colônias agrícolas.

³⁶ Disponível na Biblioteca do Google Books: <https://abrir.link/SaUsq>. Acesso em: 24 out. 2023.

³⁷ Disponível no Portal da Câmara dos Deputados: <https://bd.camara.leg.br/bd/collections/857759f3-6161-4633-b08c-512a52295cae>.

Os caminhos metodológicos desta pesquisa, além de se apoiarem na historiografia “clássica” e contemporânea discutida acima, incorporam os aportes da *Demografia Histórica*³⁸, que se dedica ao estudo da dinâmica populacional, ou seja, dos movimentos que afetam as populações humanas, como o natural (nascimentos e mortes) e as migrações (Cardoso; Brignoli, 2002, p. 109). Tal abordagem contribui para a compreensão da dimensão dos impactos causados pela seca sobre a saúde das populações afetadas em diferentes localidades da província.

Além disso, conforme argumenta José D’Assunção Barros (2004, p. 153), ao tratar da História Regional, “o interesse central do historiador regional é estudar especificamente este espaço, ou as relações sociais que se estabelecem dentro deste espaço, mesmo que eventualmente pretenda compará-lo com outros espaços similares”. Nesse sentido, buscamos estabelecer uma análise comparativa ao mapear os acontecimentos ocorridos na capital da Província e nas mesorregiões do Sertão, Borborema, Agreste e Litoral.

As fontes catalogadas e analisadas nesta pesquisa estão baseadas nos questionamentos discutidos até aqui.

Para a identificação das doenças e das causas de morte no contexto da chamada “grande seca”, foram utilizados os Registros Paroquiais de Óbitos reunidos no acervo digital *FamilySearch*³⁹. A presente análise se restringe ao Sertão paraibano, concentrando-se nos municípios de Cajazeiras, Pombal e Teixeira, cujos registros estavam disponíveis para consulta no momento da pesquisa. Esses documentos, datados entre 1877 e 1879, constituem a base empírica desta análise.

O que nos interessa, acima de tudo, não é a dimensão quantitativa dos dados, mas entender quais doenças mais atingiam essa população, que perfis estavam mais vulneráveis, quais grupos sociais eram mais afetados. Havia predominância de crianças entre os mortos? Os idosos resistiam mais ou menos? Morriam mais homens ou mulheres? Entre os óbitos, havia um número maior de pessoas escravizadas ou libertas? São essas perguntas que orientam o uso dos registros de óbitos nesta pesquisa.

³⁸ Para maiores discussões, ver: BURGUIÈRE, André. A demografia. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. **História**. Novas Abordagens. Tradução de Henrique Mesquita. Rio de Janeiro: F. Alves, 1995, p.59-82. CARDOSO, Ciro F. e BRIGNOLI, Héctor P. História demográfica. In: CARDOSO, Ciro F. e BRIGNOLI, Héctor P. **Os métodos da História**. Tradução João Maia. 6 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 107-203.

³⁹ Disponível em: <https://www.familysearch.org/pt/>. Os livros de óbitos digitalizados pela plataforma *FamilySearch* apresentam variações quanto à cobertura temporal. Enquanto alguns municípios contam com registros contínuos desde a década de 1870, outros possuem livros iniciados apenas em 1877, 1878 ou 1879. Há ainda casos em que os registros disponíveis abrangem apenas três ou quatro meses, de forma fragmentada. Essa incompletude se deve tanto à ausência de digitalização quanto à possível inexistência dos registros originais em determinados períodos como meses inteiros de um mesmo ano que não constam nos livros.

A partir dessas informações, tentamos recompor um quadro aproximado de quem eram essas pessoas que morreram durante a seca, o que nos ajuda não só a identificar as doenças mais letais, mas também a perceber as desigualdades de classe, raça, idade e gênero que atravessavam a experiência da morte nesse contexto. Como aponta também Sirinelli, o historiador deve estar atento às “solidariedades de origem, de idade ou de estudos”, que constituem a base dessas relações (Sirinelli, 1986, p. 250).

Para complementação desses dados, utilizamos o *Diccionario de medicina popular e das sciencias accessorios para uso das famílias* (1890), do médico Pedro Luiz Napoleão Chernoviz para compreensão das origens, causas, sintomas e tratamento de algumas doenças desconhecidas daquela época ou que possuem variações lexicais e ortográficas contidas nos Registros ou Mapas de Óbitos. Os escritos do Dr. Chernoviz também podem nos ajudar na identificação e em outras orientações importantes como o modo de preparação e administração, bem como a eficácia dos remédios homeopáticos e alopáticos utilizados por médicos, curandeiros e práticos.

Mesmo nos registros oficiais, marcados por silenciamentos e padronizações, é possível aplicar um olhar indiciário, buscando sinais do cotidiano coletivo desses sujeitos. Afinal, como lembra Iraci Del Nero da Costa, “não nos basta, aos demógrafos historiadores, o conhecimento do comportamento demográfico das populações pretéritas, pois, após estabelecê-lo, perguntamo-nos imediatamente: quais os condicionantes de tal comportamento, quais são suas causas e consequências?” (Costa, 2011, p. 214).

Entre as fontes disponíveis em acervos digitais, também utilizamos os Relatórios de Presidentes da Província da Parahyba⁴⁰, datados entre 1850 e 1880, por meio dos quais obtivemos informações fundamentais sobre a administração política e econômica da província. Esses relatórios trazem seções específicas sobre a seca, a saúde pública e anexos com os Relatórios da Inspeção de Saúde Pública, que tratam das enfermidades que acometiam a população e dos auxílios fornecidos pelo governo. Outros dados relevantes incluem as taxas de mortalidade da capital, extraídas dos obituários do Cemitério da Boa Sentença e da Cruz do Peixe.

Outra fonte imprescindível foram os jornais, pois, como observa Tania Regina de Luca, “trabalha com o que se tornou notícia, o que por si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta das motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma

⁴⁰ Disponível no Portal Center of Research Libraries – CRL – Edu: apps.crl.edu/brazil.

coisa” (Luca, 2008, p. 140). Dentre os periódicos⁴¹ que circulavam na década de 1870 na Parahyba, e que foram consultados para a análise de como os efeitos da seca eram representados, destacam-se: *Echo Escolástico* (1877-1878), *Jornal da Parahyba* (1862-1889), *O Publicador* (1864-1885), *O Despertador* (1866–1888), *A Opinião* (1877), e *O Liberal Parahybano* (1879–1889).

Além dos periódicos publicados na Parahyba, foi consultado também um jornal de outra província, o jornal *A Reforma*, editado no Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar o campo de observação e compreender como a seca, as doenças e a circulação de migrantes eram noticiadas em um centro político e administrativo do Império. A incorporação dessa fonte permitiu contextualizar o caso parahybano em uma escala mais ampla, evidenciando recorrências discursivas, diferenças de enfoque e a circulação de representações sobre a crise, a saúde e a atuação das autoridades públicas.

As fontes primordiais para esta pesquisa foram localizadas no Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD), com o qual o primeiro contato foi estabelecido ainda durante o período da graduação, quando realizamos a catalogação, leitura, transcrição paleográfica e análise dos documentos. A vasta documentação referente ao período de 1877 a 1880 encontra-se organizada em quatro caixas: 061-A e 061-B (1875–1878), 062 (1879) e 063 (1880). Entre as fontes consultadas, destacam-se:

1) Os Mapas Estatísticos e a Relação/Lista Nominal

Nos Mapas Estatísticos dos anos de 1877 a 1880 selecionados por nós – que registram o movimento de pacientes, constam informações como: número de homens e mulheres, menores e maiores de idade, os que morreram; pacientes que já se encontravam internados (“existiam”), os que entraram, total de entradas; os que saíram, discriminados entre curados, falecidos, removidos para o hospital de variolosos e total de saídas; além dos que passaram para o mês seguinte.

Esses mapas referem-se ao Anexo do Convento de São Francisco, à Enfermaria de Variolosos da Cruz do Peixe (na capital), a hospitais situados em Santa Rita e Mamanguape, bem como às instituições que atendiam às vítimas da seca, como Nossa Senhora das Neves, Santo Antônio e a Santa Casa de Misericórdia.

⁴¹Disponíveis na *Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional*: <https://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>. Outras edições como o jornal *O Liberal Parahybano* (1879-1889), podem ser encontradas no site *Jornais Folhetins da Paraíba do Século XIX* (CCHLA-UFPB). Disponível em: <https://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/acervo.html>.

Entre as Relações/Listas identificadas por nós, localizamos vários documentos extensos que registram as atividades desenvolvidas por turmas de trabalhadores migrantes envolvidos em obras públicas – como a construção de estradas e açudes, a limpeza e a arborização da cidade, além de listas elaboradas pelas Comissões de Socorros Públicos.

Estas últimas informam sobre as cargas de alimentos distribuídas (arroz, feijão, carne verde, milho e farinha), incluindo quantidade, estado de conservação (bom ou ruim), data de entrega, previsão de duração dos mantimentos, e os valores pagos por cada produto e pelo transporte. Outras listas mencionam a distribuição de roupas, itens de higiene e limpeza, bem como solicitações de ambulâncias para o fornecimento de medicamentos destinados aos núcleos coloniais, hospitais e municípios vizinhos.

Cabe destacar que parte dessa documentação inclui dados pessoais de pacientes internados e de trabalhadores alocados nas frentes de serviço, como: 1) nome; 2) sexo; 3) idade; 4) procedência – local de residência anterior à seca. Uma característica relevante desses registros é a possibilidade de observar o fluxo migratório para províncias vizinhas. Destacamos ainda uma fonte importante desse período: as listas nominais de crianças órfãs abandonadas por suas famílias, que passaram a viver em hospitais como o de São Pedro, em Mamanguape.

2) Relatórios Médicos

Produzidos pelos principais médicos que atuavam na Inspetoria de Higiene e Saúde Pública, na Santa Casa e em outros espaços médicos da Parahyba durante o século XIX como Abdon Felinto Milanez e Antônio da Cruz Cordeiro, esses relatórios trazem notícias sobre as teorias de contágio em circulação à época, os conflitos com curandeiros e sangradores, bem como críticas às suas práticas de cura, consideradas ineficazes ou prejudiciais.

Também relatam a situação precária dos hospitais, a escassez de equipamentos avançados e de pessoal qualificado, a insalubridade da capital e da Cadeia Pública. Além disso, os documentos oferecem recomendações médicas e higiênicas destinadas a conter a propagação de doenças de caráter endêmico e epidêmico. Uma característica recorrente desses relatórios é a preocupação com o número crescente de migrantes na cidade, considerados um risco à saúde dos demais habitantes.

3) Cartas e Correspondências

Com base nos documentos consultados por nós, que variam entre cartas e correspondências enviadas por médicos, juizes de direito, vigários e padres de vilas ou freguesias de diversas regiões como o *Sertão*: São João do Rio do Peixe, Cajazeiras, Conceição, Piancó, Sousa, Patos, Catolé do Rocha, Pombal e Teixeira; *Borborema*: São João

do Cariri, Cabaceiras, Santa Luzia e Monteiro; *Agreste*: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Campina Grande e Itabaiana; *Litoral*: Cidade da Parahyba (Capital), Livramento (Santa Rita), Mamanguape e Cabedelo – foi possível investigar os efeitos da seca em diferentes localidades.

Esses 23 municípios nos permitiram observar episódios como saques a armazéns e depósitos de comerciantes locais ou de reservas das Comissões, o atraso no envio de verbas e cargas, além de pedidos por água potável e por obras de saneamento básico. As cartas também relataram o intenso fluxo migratório rumo ao Agreste e à Mata Parahybana, bem como as doenças que mais afetavam a vida dos habitantes dessas regiões. Já as correspondências e os ofícios eram trocados entre os Chefes de Polícia, os Ministros dos Negócios do Império ou da Fazenda e o Presidente da Província, tratando de assuntos como a segurança pública, a criação de obras, o aumento dos recursos financeiros para os cofres provinciais e o planejamento da assistência à população.

São por meio dessas fontes que procuramos relacionar as *redes de sociabilidade*, definida por Jean-François Sirinelli como estruturas compostas por mecanismos de inclusão e exclusão, marcadas por solidariedades, fidelidades, mas também por rupturas e conflitos (Sirinelli, 1986, p. 248–249). No contexto da seca, considerar essas *redes* podem revelar as formas como sujeitos em situação de vulnerabilidade se apoiaram mutuamente ou foram isolados, ou dos vínculos que se criaram em torno de espaços como os hospitais, as frentes de trabalho e as áreas de acolhimento nas cidades.

Nesse sentido, o conceito de *experiência*, conforme formulado por E. P. Thompson (1981a), processo histórico envolve perceber como os sujeitos, dentro de contextos sociais específicos, experimentam e interpretam as condições em que vivem. Ou seja, trata-se de investigar como suas ações, sentimentos e percepções se desenvolvem a partir de situações concretas, atravessadas por relações sociais, culturais e materiais. Nesse sentido, é fundamental reconhecer que a experiência é construída historicamente e se manifesta tanto nas práticas quanto na consciência que os sujeitos desenvolvem sobre elas. Como afirma Thompson:

[...] estamos falando de homens e mulheres, em sua vida material, em suas relações determinadas, em sua experiência dessas relações, e em sua autoconsciência dessa experiência. Por “relações determinadas” indicamos relações estruturadas em termos de classe, dentro de formações sociais particulares (Thompson, 1981a, p. 111).

A experiência, portanto, não é uma vivência neutra ou abstrata, mas um terreno onde o ser social e a consciência social se encontram e se tensionam. Desse modo, entendemos que

os migrantes não aparecem apenas como vítimas passivas da calamidade, mas como sujeitos que compartilharam dores, buscaram meios de sobrevivência e produziram sentidos sobre sua condição.

Ao lado disso, as *redes de sociabilidade*, tal como propõe Sirinelli, fornecem um instrumental valioso para explorarmos essas relações interpessoais, os mecanismos de exclusão, os vínculos familiares preservados nos registros, ou repetições de locais de origem podem indicar laços prévios ou formados no percurso da migração. Nas palavras do autor, essas redes se constituem como “um lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e espaço de sociabilidade” (Sirinelli, 1996, p. 249), aplicáveis, com devida adaptação, a outros tipos de coletividades.

Concluídas as reflexões deste primeiro capítulo, *Os Percursos da Pesquisa*, apresentamos o tema, os objetivos, o percurso investigativo, o diálogo historiográfico sobre seca, saúde e doenças, bem como as escolhas teórico-metodológicas e o conjunto de fontes mobilizadas. Não se buscou responder a todas as questões levantadas, considerando os limites do acervo analisado, composto principalmente por uma documentação oficial, o que impõe restrições à apreensão das experiências e das vozes da população que vivenciou a seca de 1877-1879.

Portanto, nossa pretensão foi, por meio das *representações* e demais conceitos, lançar novos olhares sobre as interligações entre seca, saúde e doenças, e seus impactos sobre a vida das populações envolvidas. Le Goff já assinalava que cabe a nós, enquanto historiadores, o exercício de questionar os documentos, interpretá-los de forma crítica e reflexiva, articulando-os com a historiografia e indo além daquilo que as fontes não são capazes de expressar.

Embora não tenhamos a pretensão de oferecer respostas definitivas, esperamos que as análises iniciadas possam abrir caminhos e lançar inquietações pertinentes, pois, como ressaltou Sandra Pesavento (2006c, p. 20), “a história é sempre construção de uma experiência, que reconstrói uma temporalidade e a transpõe em narrativa”. E, como é comum nesse processo de escritas e reescritas, a própria pesquisa também nos devolveu tantas outras dúvidas.

É a partir desse balanço crítico, utilizando as fontes mencionadas, que o capítulo seguinte desloca o olhar da historiografia para o acontecimento histórico em si, examinando o início da seca na Parahyba do Norte e seus primeiros impactos sobre a população, as condições de vida, a saúde e a organização social, quando a crise começa a devastar o território e a ceifar milhares de vidas.

2 “DEVASTANDO A POPULAÇÃO E CEIFANDO MILHARES DE VIDA”: O INÍCIO DA SECA DE 1877-1879 NA PARAHYBA DO NORTE

Com a chegada da “Grande Seca” de 1877–1879, a Província da Parahyba, que já enfrentava transformações urbanas, crises econômicas, sociais e recorrentes episódios epidêmicos, viu seu cotidiano profundamente abalado por uma série de acontecimentos que desestruturaram diferentes grupos sociais e instâncias de poder. As cenas registradas ao longo das estradas e nos edifícios públicos tornaram-se palco das experiências de milhares de homens, mulheres e suas famílias, que migravam por diversas regiões da província em condições precárias de saúde, higiene, alimentação e convívio social.

Diante desse quadro, foram formuladas medidas voltadas ao enfrentamento dos efeitos da seca, entre elas a criação das colônias agrícolas ou núcleos coloniais. Essas iniciativas buscavam oferecer moradia e alimentação às famílias atingidas pela estiagem, e também àquelas já inseridas em situação de pobreza, condicionando o acesso à assistência à inserção dos beneficiários em obras públicas ou em atividades internas. Como será discutido ao longo do capítulo, o funcionamento dessas colônias implicava a organização da mão de obra e a constituição de mecanismos específicos de administração e controle. Nesse mesmo contexto, o Congresso Agrícola do Recife, realizado em 1878, tornou-se espaço de debate sobre questões relacionadas ao trabalho e à reorganização da produção, articulando interesses das elites agrárias diante da crise provocada pela seca.

Nesse contexto, a Comissão de Socorros Públicos ocupou posição central na organização da assistência, sendo responsável pela distribuição dos gêneros destinados aos municípios atingidos pela seca e pelo abastecimento dos hospitais e enfermarias. Entretanto, a atuação desse aparato foi marcada por falhas administrativas, irregularidade nas remessas e disputas internas, o que contribuiu para o agravamento da crise sanitária e social. Essas tensões extrapolaram o âmbito provincial e alcançaram o cenário político nacional, passando a integrar os debates parlamentares sobre a condução dos socorros públicos durante a seca.

Portanto, este capítulo tem por objetivo analisar as formas pelas quais a Província da Parahyba respondeu à crise desencadeada pela seca de 1877–1879, articulando as políticas de assistência, a reorganização do trabalho e os discursos produzidos em torno da população migrante. Busca-se compreender como núcleos coloniais, comissões de socorros públicos e debates políticos nacionais operaram simultaneamente como estratégias de enfrentamento da calamidade e como instrumentos de controle, disciplinamento e gestão social, revelando as tensões entre assistência, trabalho e saúde.

2.1 “TÊM ENTRADO CADÁVERES AMBULANTES QUE SÓ TÊM A PELE E OS OSSOS”: A PROVÍNCIA DA PARAHYBA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

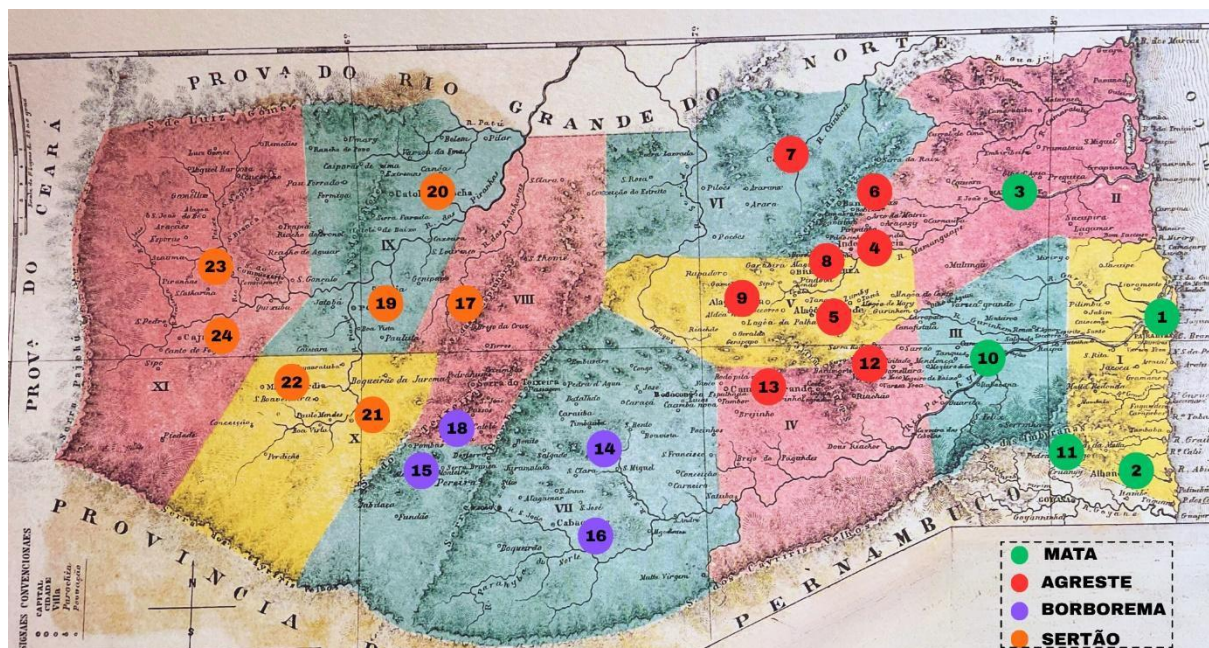
A Cidade da Paraíba era no início da segunda metade do século XIX um aglomerado urbano acanhado; pequeno e pobre [...]. Ainda não era tempo para uma definição de progresso ininterrupto. A população era reduzida, a educação pouco penetrante, o trabalho rudimentar e a economia primária (Almeida, M., 1982, p. 39).

Em 1859, ano da visita do imperador D. Pedro II à Cidade da Parahyba, então capital da província, o que se via era um núcleo urbano ainda modesto, marcado por limitações estruturais e por um desenvolvimento desigual que refletia os desafios enfrentados por grande parte das capitais do Norte do Império. Conforme descreveu Maurílio de Almeida, tratava-se de um “aglomerado urbano acanhado, pequeno e pobre”. Além disso, a preocupação com a urbe ia mais além: nem todas as ruas eram calçadas, a cidade não possuía saneamento adequado por não atender “aos requisitos da higiene desejável”, e ainda carecia de iluminação pública de qualidade, o que só viria a melhorar com a recepção do imperador. Já a medicina não dispunha de recursos suficientes para lidar com esses “atrasos”, o que contribuía para a ocorrência de mortes por “febre tifóide – infecção endêmica – em grande parte decorrente da falta de cuidados higiênicos; de febre amarela, implaudismo, câmaras de sangue, sífilis, cólera, etc.” (Almeida, M., 1982, p. 47).

Em relação ao espaço urbano, a capital da Parahyba apresentava uma organização marcada pela divisão entre Cidade Alta e Baixa, esta última também conhecida como Varadouro. Essa separação geográfica expressa, de certo modo, uma hierarquia funcional: enquanto a parte baixa, mais próxima do porto e das áreas de circulação de mercadorias, concentrava a atividade comercial, a alfândega, a estação da estrada de ferro e a cadeia pública; a parte alta, mais extensa, reunia os principais edifícios administrativos e institucionais, como os palácios do governo e da câmara municipal, a tesouraria da fazenda, o mercado público e o hospital da Santa Casa de Misericórdia (Joffily, 1892, p. 169).

A fim de ampliarmos a compreensão sobre a organização territorial da Província, apresentamos, a seguir, o mapa da Parahyba do Norte, adaptado a partir do original elaborado por Candido Mendes de Almeida (1868). Nele, é possível visualizar a divisão da Parahyba em mesorregiões. Como os nomes dos municípios não estão legíveis na imagem original, foi inserida uma numeração que é detalhada no Quadro 1, mais adiante, facilitando a identificação e a localização de cada município.

Figura 1 – Mapa da Província da Parahyba do Norte (1868), com destaque para as mesorregiões



Fonte: ALMEIDA, Candido Mendes de. Atlas do Império do Brasil. Instituto Philomathico, 1868, p. 9. Adaptado por nós para destacar as mesorregiões da Parahyba do Norte.

Conforme identificado por Solange Rocha⁴², em 1856, a Cidade da Parahyba possuía 9.033 habitantes, dos quais 7.646 eram livres e 1.387 escravizados (as). Em um intervalo de seis anos, expandiu para 3.600 novos moradores, um salto até expressivo se compararmos à estimativa de 5.420 habitantes em 1850. Já com o Censo de 1872, esse crescimento continua: a capital já somava 11.887 pessoas, sendo 10.855 livres e 1.032 escravizadas (Rocha, 2007a, p. 140). No que se refere à população geral da Província, no recenseamento feito pelo governo provincial de 1851⁴³, obteve uma aproximação em torno de 212.466, sendo 183.920 de condição livre, enquanto 28.546 eram escravizados (as). Vinte e um anos depois, com o primeiro Censo publicado em 1872⁴⁴, esses números sobem para 376.226 no total, sendo 354.700 livres e 21.526 escravizados (as).

⁴² A autora utilizou as informações contidas no “*Quadro demonstrativo da divisão civil, judiciária da província da Parahyba do Norte*”, produzido em 1857, disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cujos dados se referem ao ano anterior.

⁴³ Elaborado pelo Secretário do Governo Lindolfo José Correia das Neves no “*Mappa Estatístico da População Livre, e Escrava da Província da Parahyba do Norte, organizado por Municípios, e Freguezias; e de conformidade com o Aviso Imperial de 17 de janeiro de 1850*”, consta no anexo do apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo excellentíssimo presidente da província, o Dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, em 2 de agosto de 1851, p. 27. Tipografia de José Rodrigues da Costa, 1851.

⁴⁴ IBGE, Recenseamento do Brasil em 1872, Rio de Janeiro: Typographia G. Leuzinger, s.d. [prov. 1874]. Ver seção sobre a Parahyba, p. 115. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=225477>. Acesso em: 2 jul. 2025.

O Quadro 1 apresenta os municípios numerados no Mapa da Figura 1, acompanhados de suas respectivas populações (livres e escravizadas) e das mesorregiões às quais pertencem.

Quadro 1 – População dos Municípios da Parahyba do Norte (1872) identificados no Mapa 1 por numeração

Nº no Mapa	Município	População livre	População escravizada	Total
1	Cidade da Parahyba	22.258	2.456	24.714
2	Alhandra	4.656	228	4.884
3	Mamanguape	16.661	802	17.463
4	Independência	26.857	1.334	28.191
5	Alagoa Grande	10.765	642	11.407
6	Bananeiras	21.993	689	22.682
7	Cuité	11.729	611	12.340
8	Areia	24.125	1.424	25.549
9	Alagoa Nova	10.322	419	10.741
10	Pilar	9.358	1.191	10.549
11	Pedras de Fogo	16.654	1.145	17.799
12	Ingá	20.173	1.308	21.481
13	Campina Grande	13.999	1.105	15.104
14	São João	14.471	642	15.113
15	Alagoa do Monteiro	9.891	611	10.502
16	Cabaceiras	7.557	587	8.144
17	Patos	13.265	880	14.145
18	Santa Luzia	3.964	335	4.299
19	Pombal	11.800	1.182	12.982
20	Catolé do Rocha	16.005	1.016	17.021
21	Piancó	13.057	612	13.669
22	Misericórdia	14.018	628	14.646
23	Souza	28.350	1.376	29.726
24	Cajazeiras	12.572	408	12.980
População Total		354.700	21.526	376.226

Fonte: Quadro adaptado por nós com base nos dados extraídos do Censo Geral de 1872. IBGE⁴⁵, 1872.

Quanto à economia da Parahyba, sua organização agroexportadora e latifundiária, estruturada na produção de açúcar no litoral e de algodão no agreste, aliada às relações de trabalho escravista, enfrentou, ao longo da segunda metade do século XIX, períodos de crise relacionados às altas tarifas de exportação, à precarização do trabalho agrícola, às longas estiagens e, principalmente, à falta de mão de obra livre. Ainda que o açúcar e o algodão tenham sido os produtos de maior peso econômico, outras mercadorias também compunham

⁴⁵ Utilizamos os dados contidos nos *Quadro Geral da Província da Parahyba do Norte, da população livre considerada em relação aos sexos, estados civis, raças, religião, nacionalidades e grão de instrução, com indicação dos números de casas e fogos*; e o *Quadro de Recapitulação da Província da Parahyba do Norte*. In: IBGE, Recenseamento do Brasil em 1872, Rio de Janeiro: Typographia G. Leuzinger, s.d. [prov. 1874]. Ver seção sobre a Parahyba, p. 115. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=225477>. Acesso em: 2 jul. 2025.

o rol de exportações do período, como couro, carne, rapadura, borracha, entre outros⁴⁶. Para Irene Fernandes (1999, p. 32), a ausência de inovações técnicas e a instabilidade dos preços decorrentes do mercado externo resultaram na queda produtiva do açúcar, que perdurou até as duas primeiras décadas do século XX.

De acordo com Diana Galliza, os entraves à economia da Parahyba extrapolavam as dificuldades impostas pela crise. A precariedade das vias de acesso entre a capital e os municípios mais distantes, como os do Brejo e do Sertão, agravava ainda mais o cenário, pois o transporte de cargas era realizado, em grande parte, por tração animal, o que implicava lentidão e altos custos (Galliza, 1979, p.32-33). Além disso, a limitada infraestrutura portuária constituía outro obstáculo relevante: com frequência, as mercadorias precisavam ser escoadas pelo porto de Mamanguape ou da própria Capital, ambos com pouca estrutura e custos operacionais elevados.

Já o Porto de Cabedelo, por sua vez, não possuía condições adequadas para operações transoceânicas, o que exigia o envio de produtos via porto de Recife. Esse deslocamento elevava ainda mais os custos, devido à cobrança de impostos adicionais e à morosidade no transporte, abastecimento e embarque. Tal dependência da Parahyba em relação às praças comerciais de Pernambuco impediu o desenvolvimento de um comércio mais autônomo, o que, segundo documentos oficiais da época, limitou significativamente os lucros que poderiam ter sido obtidos com produtos como o algodão (Galliza, 1979, p. 49).

Para Ariane Norma de Menezes Sá (2009, p. 37), o período entre 1850 e 1888, na Parahyba, foi marcado por uma crise social causada não apenas pela concentração de terras que impedia o acesso aos mais pobres, mas também pela queda nas exportações de algodão⁴⁷ e açúcar⁴⁸, o que impactou diretamente as finanças da província. A esse cenário somavam-se

⁴⁶ Lucian Souza da Silva (2021b, p. 37) observou que, embora o couro já não tivesse a mesma expressividade econômica em termos de produção e exportação, ele continuava sendo comercializado juntamente com outros produtos que, embora secundários diante do açúcar e do algodão, também integravam as atividades voltadas ao mercado externo, como bebidas, alimentos, derivados da pecuária e matérias-primas diversas.

⁴⁷ Diana Galliza classifica o setor açucareiro, nesse período: “imerso em um marasmo secular”, agravado pela crescente concorrência do açúcar de beterraba europeu: francês e alemão, cujas produções passaram a contar com avanços técnicos modernos, além de oferecerem qualidade superior a preços mais baixos. Soma-se a isso a ascensão do açúcar cubano, favorecido por sua localização estratégica, que passou a dominar a preferência dos mercados consumidores (Galliza, 1979, p. 28).

⁴⁸ Os períodos de baixa produção coincidiram com os anos de secas parciais e/ou prolongadas, o fim do tráfico de escravizados em 1850, além dos momentos de crise epidêmica, como o cólera, em 1856 (Mariz, 1978a, p. 18). Como ressalta Celso Mariz, apesar da boa recuperação econômica no início da década de 1860, os investimentos em infraestrutura e as consequências da Guerra do Paraguai intensificaram o crescimento das dívidas públicas. Em relação aos anos de 1864 a 1866, a arrecadação provincial era de dois milhões de cruzeiros, enquanto, no triênio de 1872 a 1874, esse valor caiu para pouco mais de um milhão (Mariz, 1978a, p. 21-22).

as longas secas, que agravavam ainda mais a situação das populações rurais, resultando em fome, doenças e mortes.

Até aqui vimos um cenário marcado por instabilidade econômica, concentração fundiária, crises produtivas e recorrentes estiagens, as condições de vida da população tornaram-se progressivamente mais precárias, principalmente entre os grupos mais pobres e residentes nas áreas rurais.

É nesse contexto de instabilidade econômica, seca e adoecimento que se intensificam, na Parahyba, as preocupações com a higiene, o ordenamento urbano e o controle da população, especialmente diante da recorrência de epidemias e do crescimento de práticas médicas e normativas voltadas à salubridade da cidade.

Em relação às questões ligadas à higiene, como as medidas de saneamento, embelezamento da urbe e as mudanças nos modos de vida da população, passaram a ser temas constantes no cotidiano administrativo e médico da Parahyba. Isso pode ser observado nos relatórios, nos documentos da Inspetoria de Saúde Pública e nas discussões da Assembleia Legislativa. No entanto, essas preocupações não se restringiam apenas à Parahyba: estavam presentes em várias regiões do Império, revelando uma tendência mais ampla nas formas de disciplinamento e medicalização da vida pública (Pesavento, 1999a).

Segundo Doralice Sátyro Maia (2014), foi a partir da década de 1830 que se consolidou uma preocupação explícita do governo imperial com o ordenamento e a estética das cidades, como parte de um projeto mais amplo de disciplinamento social. Essa inquietação foi difundida por meio de leis, decretos e normativas que passaram a compor o repertório dos poderes locais. No caso da Parahyba, esse conjunto normativo expressava não apenas os interesses do governo, mas também valores e ideais de “civilização” e “progresso” inspirados nas reformas urbanas em curso nas cidades europeias do século XIX (Maia, D., 2014, p. 7).

A autora observa que, nos artigos que compõem os Códigos de Posturas Municipais, normas como a obrigatoriedade de caiar muros e cercas, manter as fachadas limpas e demolir construções desalinhadas revelavam uma tentativa de transformar a cidade em um espaço visualmente “ordenado” e socialmente controlado (Maia, D., 2014, p. 8). A sujeira, a desorganização e os modos populares de ocupação do espaço eram percebidos como sinais de atraso.

Desse modo, limpar as ruas, remover o lixo e padronizar fachadas tornaram-se práticas regulamentadas que associavam diretamente a boa aparência urbana à higiene pública. Ainda segundo a autora, o objetivo não era apenas melhorar a infraestrutura urbana, mas também intervir nos comportamentos e modos de vida dos habitantes (Maia, D., 2014, p. 8-9).

Nesse contexto, a Parahyba também passou por transformações urbanas significativas, por exemplo, o alargamento e o alinhamento de ruas, a substituição de igrejas por praças e jardins e a instalação de trilhos para circulação de bondes. Na concepção da autora, tais reformas expressam a imposição de um novo modelo de cidade, mais moderna, higienizada e funcional, que atendia aos interesses das elites locais e ao projeto civilizatório do império (Maia, D., 2014, p. 13).

Nesse sentido, Nayana Mariano (2015) pontua que a educação primária era vista como instrumento de moralização social dentro de uma estrutura normativa que também impunha regras sobre lazer, comércio e circulação urbana, evidenciando o controle sobre os espaços e comportamentos na cidade. A solicitação da remoção do matadouro, em 1855, quando o cólera já se alastrava pela província, da rua das Trincheiras para as margens do rio Sanhauá é um exemplo claro de como certas medidas de higiene começaram a aparecer nos discursos e ações das autoridades provinciais.

A justificativa era a melhoria da salubridade da capital, já que o antigo local era visto como impróprio e até perigoso por conta dos “miasmas” e da falta d’água. Ainda que o novo espaço também tivesse seus problemas, ele foi defendido como o “mais apropriado”, mostrando que, naquele momento, a preocupação com a saúde pública começava a ganhar espaço nas decisões administrativas (Pinto, 1977, p. 239).

Como destacou Doralice Maia, esse controle se dava tanto sobre o espaço físico quanto sobre os corpos que nele transitavam. Assim, a cidade se tornava, ao mesmo tempo, objeto de intervenção técnica e cenário de imposição moral, na medida em que práticas tidas como “fora da normalidade” como a presença de bêbados, loucos ou pessoas pobres em determinados espaços era considerada indesejável e reprimida por meio de normas e penalidades (Maia, D., 2014, p. 13).

No entanto, essas transformações no espaço urbano da Parahyba, se articulavam a um contexto mais amplo. À medida que os casos de doenças infectocontagiosas e a presença de epidemias de febre amarela e *cholera morbus*, os surtos de varíola, entre outras enfermidades, atingiam a província, reforçava-se a necessidade de manter a cidade limpa, arejada e “higiênica”, argumento defendido pelos médicos da época. A crença na teoria dos miasmas, que associava a propagação das doenças aos maus odores, à umidade e ao acúmulo de sujeira, servia como base para legitimar as condutas de higiene a serem adotadas.

Considerando a frequência com que doenças e epidemias atingiam a província, convém retomar de forma mais detalhada as enfermidades mencionadas acima, dado o impacto que tiveram na organização da cidade e nas práticas de higiene pública. A começar

pela epidemia de febre amarela, que teve início no final de 1849, com pico em março de 1850. De acordo com Kaori Kodama (2009), no Rio de Janeiro, a média era de mais de 80 casos por dia. Assim como aconteceu com o cólera, os médicos⁴⁹ buscavam explicações para a origem da doença: uns atribuíam a fatores locais (teoria da infecção), outros a fatores externos (teoria do contágio).

Na Parahyba, conforme analisou Serioja Mariano e Nayana Mariano (2012, p. 2), as notícias sobre o avanço da febre e do cólera eram espalhadas por “jornais, panfletos e do boca a boca”. Uma das principais preocupações das autoridades públicas era também com os navios que atracavam no porto do Varadouro, na Capital, e que podiam trazer a transmissão de diversas doenças. Com isso, o presidente da província organizou comissões de inspeção compostas por autoridades locais e representantes da saúde, que atuavam em articulação com a Inspetoria de Saúde dos Portos, já existente desde 1828 (Mariano; Mariano, 2012, p. 8).

As autoras também citam outras iniciativas: a construção de um lazareto, espaço destinado ao isolamento de pessoas doentes ou suspeitas, na ilha do Tiriry⁵⁰, o que reforça como o isolamento era visto como uma solução preventiva diante da ameaça do contágio⁵¹, ainda que os próprios espaços de quarentena fossem precários e muitas vezes acelerassem o adoecimento dos internados.

Já a de *cholera morbus* foi, sem dúvida, uma das mais temidas do século XIX, tanto pela rapidez com que se espalhava quanto pelo número de mortos e infectados. Ao mapear o trajeto da doença, Laércio Souza Júnior (2023, p. 197-198) identificou, a partir das estimativas de óbitos, uma expressiva variação da mortalidade entre os municípios da Parahyba, alcançando índices superiores a 30% da população em locais como Pilar e Independência, enquanto outros, como Patos, Pombal e Piancó, registraram taxas inferiores a 0,3%. O autor evidencia que essas diferenças, visualizadas em tabelas e mapas, revelam um impacto

⁴⁹ Também se difundia, entre eles, a tese do médico francês Mathieu François Maxime Audouard, segundo a qual o problema não residia no clima do Brasil, mas nas condições degradantes dos navios negreiros. A proposta teve ampla aceitação por preservar a imagem do território nacional como salubre: algo fundamental para incentivar a imigração europeia e afastar as representações negativas que circulavam no exterior sobre o país. Além disso, as ideias defendidas por Audouard se alinhavam ao discurso antiescravista ao associar o tráfico à origem da doença (Kodama, 2009, p. 519).

⁵⁰ O local foi pouco utilizado, sendo substituído por outro espaço na Ilha da Restinga, ambos distantes da capital (Mariano; Mariano, 2012, p. 8).

⁵¹ O medo provocado pela febre amarela também afetou o cotidiano da população parahybana. As autoras identificaram que as procissões religiosas chegaram a ser suspensas com o argumento de evitar a aglomeração de fiéis, e também como forma de barrar o avanço da doença. Além disso, por precaução, as reuniões da Assembleia Provincial foram suspensas por um longo período, já que havia receio de contaminação entre os parlamentares e demais pessoas no mesmo ambiente (Mariano; Mariano, 2012, p. 10).

territorialmente desigual, mais severo nas áreas litorâneas e agrestinas e sem graves ocorrências em partes do sertão (Souza Jr., 2023, p. 199).

A atuação das Juntas de Higiene, como apontado por Juciello Alexandre, consolidou-se nesse período como uma estratégia para afirmar o espaço político dos médicos e garantir a execução de projetos sanitários nas cidades. No entanto, esse processo não ocorreu de forma homogênea ou sem conflitos. A epidemia de cólera de 1855, e também outras doenças epidêmicas que circularam no período, acabam por revelar as fragilidades desses setores, marcadas por disputas internas entre os próprios médicos quanto à natureza da doença e às medidas adequadas de contenção (Alexandre, 2010a, p. 36).

No caso da varíola, uma das enfermidades que mais mobilizou as autoridades provinciais da Parahyba⁵², Serioja Mariano (2019, p. 3) mostra que, já em 1805, se registravam tentativas de introdução da vacina por iniciativa do então governador Luiz da Mota Feo. A autora argumenta que, no relatório provincial de 1839, a resistência da população à vacinação passou a ser vista como um entrave à erradicação da doença, o que levou os gestores a propor gratificações para os vacinadores e a investir⁵³, ainda que de modo tímido, em campanhas de inoculação (Mariano, S., 2019, p. 3).

Se a década de 1850 foi marcada por duas grandes epidemias, o cólera e a febre amarela, os anos finais da década de 1860 revelavam não só a permanência de doenças como a varíola, febres diversas e disenteria, mas também a fragilidade estrutural da província frente às secas, principalmente nos sertões da Parahyba. Ainda que a conjuntura da Seca de 1877-1879 tenha mobilizado as autoridades nacionais de forma mais ampla, é importante destacar que, em 1870, o sertão enfrentava uma estiagem severa, que se estendia desde 1867.

Diante desse quadro, torna-se necessário recuar alguns anos no tempo para observar como a província já vinha enfrentando situações recorrentes de estiagem, adoecimento e respostas governamentais limitadas antes da chamada “Grande Seca”. Ao longo dos anos finais da década de 1860, especialmente nos sertões da Parahyba, a combinação entre seca, fome e doenças expôs fragilidades estruturais que seriam novamente acionadas, e agravadas, a partir de 1877.

⁵² A autora constatou que os impactos da varíola na Parahyba revelaram as tensões entre ciência, fé, pobreza e poder político, bem como os limites concretos da saúde pública num contexto marcado por desigualdades sociais, disputas institucionais e contradições entre o discurso médico-higienista e sua aplicação prática (Mariano, S., 2019a, p. 10).

⁵³ Apesar de o discurso oficial enfatizar a importância da vacinação e da saúde pública, os gastos efetivos eram ínfimos, como demonstrado no orçamento de 1844, quando a verba destinada à saúde foi de apenas 600\$000, muito inferior aos recursos aplicados na força policial (Mariano, S., 2019, p. 3).

A análise da estiagem de 1867-1870 permite, portanto, compreender permanências administrativas, práticas de socorro e discursos oficiais que antecederam e ajudaram a moldar a experiência da seca de 1877-1879.

Apesar de as notícias sobre o primeiro ano de seca no sertão nos relatórios provinciais sejam escassas⁵⁴, ela foi divulgada pelo jornal *O Publicador (PB)*⁵⁵, em 30 de setembro de 1867, dentro de um debate travado na Assembleia Provincial, motivado por interesses de ordem econômica. Discutia-se a concessão de moratórias a devedores que enfrentavam dificuldades financeiras, e a argumentação partia do reconhecimento de uma crise que atingia não apenas o tesouro público, mas também as rendas particulares, de credores que não recebiam pagamentos há mais de dois ou três anos.

O autor da proposta, o deputado Manoel Carlos, defendia que a prorrogação dos prazos para o pagamento das dívidas seria benéfica tanto para a fazenda provincial, que evitaria o prejuízo total, quanto para os próprios peticionários, muitos dos quais sequer possuíam bens suficientes para quitar metade do débito. Ao final, ele reforça que muitos desses devedores do sertão foram duramente atingidos pela “seca devoradora”, o que justificaria o amparo governamental (*O Publicador (PB)*, n.º 1511, 30/09/1867, p. 3).

As notícias mais direcionadas a essa seca ocorrem apenas em abril de 1869⁵⁶, na exposição proferida pelo 2º vice-presidente, Dr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva⁵⁷. Em seu pronunciamento, ele demonstrava preocupação com a situação crítica de algumas regiões da província, principalmente os sertões de São João, Teixeira e Patos, onde a fome já se fazia sentir, e “a gente pobre alimenta-se com raízes silvestres” (Parahyba do Norte, Exposição, 1869, p. 6). O relato indica que a seca já se prolongava por dois anos, sem perspectiva imediata de melhora, uma vez que as chuvas que caíram em fevereiro haviam sido torrenciais, prejudicando o litoral e sendo insuficientes para o interior. Diante disso, o 2º vice-

⁵⁴ No relatório enviado à Assembleia Legislativa, em maio de 1862, o então presidente da província, Dr. Francisco d’Araújo Lima, já reconhecia que a população do sertão buscava soluções por conta própria, como a construção de açudes públicos e particulares, com a finalidade de amenizar os efeitos das estiagens que impactavam a produção agropecuária (Parahyba do Norte, Relatório, 1862, p. 67). Por mais que algumas iniciativas tenham sido tomadas, elas não foram suficientes para conter os efeitos das secas, talvez pela pequena proporção dessas obras diante da extensão do problema.

⁵⁵ Foi o primeiro jornal de circulação diária na Paraíba, fundado em 1862 e publicado até 1886. De propriedade do tipógrafo José Rodrigues da Costa e, mais tarde, de seus herdeiros (Peixoto, 2017a).

⁵⁶ Exposição com que o Exm. Sr. presidente Dr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, passou a administração da província da Parahyba do Norte ao 2.º vice-presidente padre Francisco Pinto Pessoa em 9 de abril de 1869. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º 20, 1869.

⁵⁷ Foi bacharel em Direito pela Faculdade de Recife, formado em 1852. Antes de assumir a presidência da Província da Parahyba do Norte, desempenhou funções de destaque na administração imperial, presidindo as províncias do Rio de Janeiro e da Bahia, além de ter exercido o cargo de Ministro da Agricultura (Mariano, N., 2015, p. 293).

presidente afirmou ter assumido a criação de uma comissão de socorro com o envio de alimentos para as localidades mais atingidas (Parahyba do Norte, Exposição, 1869, p. 6).

Em junho, um novo relato⁵⁸ sobre a seca de 1867 foi apresentado pelo 1º vice-presidente, Dr. Silvino Elvídio Carneiro da Cunha.⁵⁹ Ele informa que assumiu o governo em 16 de abril e imediatamente se deparou com ofícios dos municípios de Misericórdia e Piancó, que descreviam o estado de fome e miséria da população, atingindo inclusive aqueles que possuíam melhores recursos. Diante da urgência, Silvino abriu um crédito de cinco contos de réis na Tesouraria da Fazenda. Mesmo assim, antes mesmo de concluir esse primeiro socorro, chegaram novas solicitações das vilas de Catolé do Rocha e Pombal (Parahyba do Norte, Relatório, 1869, p. 3-4).

Como não havia tempo nem condições de adquirir mantimentos dentro da província, o governo precisou comprá-los no Recife. Os gêneros seguiram de vapor⁶⁰ até Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de lá seriam remetidos aos municípios paraibanos pelo agente fiscal. Para organizar a distribuição, Silvino nomeou comissões locais compostas por vigários, juízes municipais e delegados de polícia.

Ele informa ainda que apenas São João, Patos e Teixeira – que já haviam recebido socorros anteriormente, por iniciativa de seu antecessor – confirmaram oficialmente a chegada e a boa distribuição dos produtos. Nos demais municípios, como Misericórdia, Piancó, Pombal e Catolé do Rocha, o governo ainda aguardava respostas, atribuindo a demora à distância (Parahyba do Norte, Relatório, 1869, p. 4). De todo modo, o relato revela que somente em 1869 o governo provincial passou a registrar com maior atenção a situação dos sertões, ainda restrito a medidas emergenciais e fragmentadas, sem qualquer indício de planejamento mais amplo.

⁵⁸ Relatório com que S. Exc. o Sr. Dr. Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, 1º. vice-presidente, passou a administração da província da Parahyba do Norte ao Exm. Sr. Dr. Venancio José de Oliveira Lisboa em 11 de junho de 1869. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º20, 1869.

⁵⁹ Ocupou inicialmente a vice-presidência e assumiu o governo provincial pela primeira vez entre abril e junho de 1869. Posteriormente, voltou a exercer a presidência da província em um segundo mandato mais prolongado, entre 1873 e 1876. Já no final do Império, reassumiu o comando provincial pela terceira vez em 1889, novamente na condição de vice-presidente (Mariano, N., p. 296, 299).

⁶⁰ Essa logística se tornou, em 1877, um dos grandes entraves no socorro à população sertaneja, devido à falta de estradas de ferro que encurtassem as distâncias e tornassem mais ágil o envio dos mantimentos, além do alto custo do transporte de víveres e medicamentos (Rebouças, 1877).

No balanço de sua administração, apresentado em 24 de outubro de 1870⁶¹, o presidente da província, Venancio José d'Oliveira Lisboa⁶², destacou a seca como uma das maiores calamidades daquele ano. Ao relatar os impactos da crise, afirmou que “não foi tão horroroso como proclamaram os profetas de desgraça, mas foi suficiente para amargurar a minha administração”. Apesar disso, nega que tenham ocorrido mortes por fome. Em sua narrativa, Lisboa se defende das críticas, atribuindo a lentidão dos socorros não à omissão do governo, mas à falta de gêneros e às dificuldades de transporte. Reivindica ainda o mérito de haver combatido a especulação ao vender farinha a preço controlado na Capital e afirma ter socorrido todos os locais que solicitaram ajuda (Parahyba do Norte, Exposição, 1870, p. 7-8).

No quadro⁶³ de distribuição de alimentos apresentado pelo presidente, observa-se que, embora o Sertão concentrasse os pedidos de socorro, regiões do Brejo também foram contempladas, indicando que os recursos não foram destinados exclusivamente às áreas mais afetadas. Apesar do volume expressivo de gêneros adquiridos pela província, apenas uma pequena parte foi efetivamente distribuída às populações atingidas, enquanto a maior parcela, em especial a farinha, foi destinada para a venda com o argumento de conter a especulação e regular o mercado da Capital.⁶⁴

Essa estratégia, porém, revela outras contradições. Mesmo alegando que tais medidas buscavam garantir preços acessíveis, os dados revelam que o montante vendido superou o doado, e que a comercialização beneficiou prioritariamente o município de Lucena⁶⁵ (Parahyba do Norte, Exposição, 1870, p. 20). Assim, ao afirmar que não houve mortes por fome e que todos os pedidos foram atendidos, o presidente procurou suavizar os efeitos da crise, mas os próprios registros oficiais evidenciam os limites dos socorros públicos (Parahyba do Norte, Exposição, 1870, p. 7).

Considerando o panorama reconstruído, a seca de 1867-70 poderia ter servido de alerta: naquele momento já era possível identificar suas causas, mapear as áreas mais afetadas

⁶¹ Exposição feita pelo Exm. Sr. presidente da província da Parahyba do Norte Dr. Venancio José d'Oliveira Lisboa ao passar a administração da mesma ao Exm. Senhor senador Frederico de Almeida e Albuquerque em 24 de outubro de 1870. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1870.

⁶² Foi presidente da província da Parahyba entre junho de 1869 e outubro de 1870. Antes, havia presidido outras províncias, como as do Pará, Minas Gerais e Bahia (Mariano, N., 2015, p. 294).

⁶³ As informações foram retiradas com base no “*Quadro demonstrativo dos gêneros alimentícios comprados para socorros públicos, remetidos à diversas localidades desta Província, ou vendidos de ordem do Exmº Sr. Presidente da Província à população desta Capital*”. In: Exposição feita pelo Exm. Sr. presidente da província da Parahyba do Norte Dr. Venancio José d'Oliveira Lisboa ao passar a administração da mesma ao Exm. Senhor senador Frederico de Almeida e Albuquerque em 24 de outubro de 1870, p. 19. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1870.

⁶⁴ A província adquiriu 2.667 sacas de farinha, 131 de milho e 73 de arroz. Foram distribuídas 485 sacas de farinha, 131 de milho, 73 de arroz e 4 arrobas de carne (Parahyba do Norte, Exposição, 1870, p. 20).

⁶⁵ Ao todo, foram direcionadas 2.182 sacas de farinha para venda (Parahyba do Norte, Exposição, 1870, p. 20).

e produzir um balanço capaz de orientar ações mais eficazes. No entanto, a ausência de planejamento e a repetição dos mesmos erros impediram qualquer mudança estrutural, e os efeitos da estiagem se agravaram ano após ano, com perdas agrícolas, fome e saques, enquanto as respostas governamentais permaneciam pontuais.

Medidas como o envio de remédios, alimentos ou a abertura de créditos foram adotadas, mas não constituíram uma política contínua e articulada de enfrentamento da seca. Na prática, o que se observou foi o prolongamento do sofrimento da população diante dos limites da ação governamental.

Essas respostas pontuais, ainda que recorrentes ao longo da década de 1860, não foram acompanhadas por mudanças estruturais na organização da assistência, da saúde pública ou do enfrentamento das estiagens. Ao contrário, revelam a permanência de um padrão de atuação marcado pela improvisação, pela reação tardia e pela ausência de planejamento contínuo. Esse modo de administrar a crise contribuiu para a manutenção de um quadro instável que se prolongou nos anos seguintes, criando as condições para que a seca de 1877 encontrasse uma província já fragilizada. É nesse cenário que se inscrevem as doenças, as tensões sociais e os conflitos políticos que marcaram a Parahyba às vésperas da chamada “Grande Seca”.

Nos anos que a antecederam, a Parahyba já enfrentava a combinação de doenças recorrentes, crises sociais e instabilidade política. Em 1869, a Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba⁶⁶ apresentou um balanço detalhado do panorama sanitário da província, com base nos óbitos registrados desde 1850. O relatório, assinado pelo médico João José Innocencio Poggi⁶⁷, destacava que, em média, a mortalidade anual da freguesia⁶⁸ girava entre 370 a 450 pessoas, com exceção do ano de 1856, quando o número de mortos subiu para 1.993 em razão da epidemia de *cholera morbus* (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo H, 1869, p. 3).

⁶⁶ Relatório da Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo H, 12 de agosto de 1869. In: Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte no dia 2 de outubro de 1869 pelo Exmo. Presidente Dr. Venancio José de Oliveira Lisbôa. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º20, 1869.

⁶⁷ Era natural de Pernambuco e atuava como prático, sem formação acadêmica formal. Exerceu cargos importantes na administração provincial, como 1º vice-presidente, juiz de paz, inspetor de saúde pública e provedor da Santa Casa de Misericórdia. Em agosto de 1866, assumiu interinamente a presidência da Província da Parahyba, ocasião em que escreveu relatórios sobre a situação sanitária. Foi agraciado com comendas da Ordem de Cristo e da Rosa (Mariano, N., 2015, p. 90).

⁶⁸ O médico não especifica a qual freguesia se refere ao mencionar os dados de mortalidade, limitando-se a usar a expressão “n’esta freguezia”. Considerando que o relatório foi apresentado pela Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba do Norte e que Poggi atuava na capital, é provável que os dados refiram à freguesia da cidade da Parahyba.

Outro pico de mortalidade ocorreu em 1866, com 540 óbitos atribuídos à desintéria, que, segundo Poggi, persistia devido ao “descuido no tratamento e falta de regime dietético”. Do mesmo modo, ao examinar a década de 1860, Poggi identificou a presença de outras doenças, como “tétano dos recém-nascidos, as febres intermitentes simples, algumas perniciosas, as remittentes”, além de enfermidades “infectuosas, como a typhoide”, e afecções crônicas como “hyperemias e inflamações das vísceras abdominaes, “hydropesias symptomaticas, anemia, congestões e hemorragias cerebraes, phthisica pulmonar e a própria dysenteria” (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo H, 1869, p. 3).

Em 1871, o novo inspetor de saúde, Dr. Abdon Felinto Milanez⁶⁹, afirmou que não havia epidemias em larga escala no interior da província⁷⁰. Ainda assim, relatava que, há pelo menos dois anos, uma febre de caráter maligno atingia de forma recorrente os municípios de Pombal, Piancó, Misericórdia e, mais recentemente, a vila de São João, para onde foi enviada uma ambulância com medicamentos. A enfermidade já causava algumas mortes e, segundo ele, exigia maior atenção do governo. Milanez admitia, porém, que não tivera tempo para investigar⁷¹ suas causas e demonstrava surpresa diante da presença de uma febre tão agressiva nos sertões, então considerados de “clima salubre” (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1871, p. 9-10).

Nos anos seguintes, observamos uma frequência maior do aumento da gravidade do quadro nosológico da província. Na fala apresentada à Assembleia Legislativa Provincial no dia 7 de junho de 1872⁷², o então 3.º vice-presidente José Evaristo da Cruz Gouvêa⁷³ destacou

⁶⁹ Natural de Areia (PB) e formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, atuou como clínico em sua cidade natal e na Capital da Parahyba. Foi inspetor de Saúde Pública, jornalista, deputado provincial e senador (Mariano, N., 2015, p. 92).

⁷⁰ Relatório da Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo II, 13 de junho de 1871. In: Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. 3o. vice-presidente da provincia, Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 16 de outubro de 1871. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1871.

⁷¹ Em junho de 1871, Abdon Felinto Milanez foi nomeado para assumir interinamente o cargo de Inspetor da Saúde Pública da província da Parahyba do Norte, em substituição a João José Innocencio Poggi, que havia solicitado exoneração por motivos de saúde. Em seu primeiro relatório, Milanez reconhece a brevidade do tempo no cargo e a impossibilidade de apresentar um balanço completo da situação sanitária, destacando os méritos e a experiência de seu antecessor, cujo trabalho deixara “um vácuo que [...] não poderei preenchê-lo” (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1871, p. 1).

⁷² Falla dirigida à Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. 3o. vice-presidente da provincia, Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 7 de junho de 1872. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1872.

⁷³ Foi médico, natural de Areia (PB), formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atuando como clínico e cirurgião em Areia e na cidade da Parahyba. Exerceu também funções administrativas ligadas à saúde e à instrução pública, como inspetor de Saúde Pública e diretor da Instrução Pública. No campo político, integrou o Partido Conservador, foi deputado provincial e geral, e assumiu a presidência da Província da Parahyba por três vezes na condição de vice-presidente, entre 1871 e 1873, sendo figura recorrente na administração provincial do período (Mariano, N., 2015, p. 294).

com preocupação o estado sanitário da Capital, que, seguia enfrentando surtos de febres de diferentes naturezas, além da varíola e de outras enfermidades, atribuídas à poluição do ar. A explicação sobre a origem das doenças como resultante da decomposição de corpos, vegetais e demais matérias orgânicas revela o fortalecimento de interpretações e estratégias baseadas na teoria dos miasmas (Parahyba do Norte, Falla, 1872, p. 14).

Em meio a esse cenário de precariedade, o vice-presidente relata a ocorrência de vários surtos de febre amarela, iniciados em dezembro do ano anterior com a chegada dos navios estrangeiros ao porto da Capital, estendendo-se à população local. Sem nenhum hospital disponível próximo ao Porto, a solução encontrada foi instalar um lazareto improvisado na ilha da Restinga⁷⁴, sob a responsabilidade do Dr. João Cândio Nunes de Mattos⁷⁵, posteriormente transferido para os subúrbios da cidade.

Também foram relatados os mesmos surtos em Campina Grande e de varíola na povoação de Preguiça, no termo de Mamanguape, “fazendo numerosas *victimias*, pois quasi toda a população d'aquellas paragens é pobre, ignorante e privada de recursos” (Parahyba do Norte, Falla, 1872, p. 14). As providências tomadas, como o envio de ambulâncias e alimentos, mostram o esforço da administração diante das emergências, mas também expõem a fragilidade das estruturas públicas de saúde e a contínua dependência de medidas paliativas e improvisadas.

Segundo o médico Abdon Felinto Milanez⁷⁶, a cidade da Parahyba parecia viver sob “a pressão de serios cataclismas epidemicos”, o que exigia vigilância e ações contínuas. Não apenas as doenças febris chamavam atenção: a sífilis já se apresentava em “escala progressiva”, além das “diversas affecções dos aparêlhos inspiratório e digestivo, as lesões orgânicas do coração, a varíola e o sarampo” (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1873, p. 6-7). A referência à sífilis nesse contexto revela não apenas a diversidade do quadro patológico enfrentado, mas também o silêncio do poder público diante de questões sensíveis, como as doenças venéreas e seus impactos sociais (Mariano, S., 2020).

Apesar de não haver registro de uma grande epidemia no primeiro semestre de 1873, Milanez reconhece que o estado sanitário da capital não foi satisfatório. A febre amarela,

⁷⁴ A opção pela ilha da Restinga relaciona-se às características geográficas e estratégicas do local, situado na foz do Rio Paraíba do Norte, no município de Cabedelo.

⁷⁵ Médico natural de Camaçari, município da Bahia, formado em 1870 pela Faculdade de Medicina da Bahia, autor da tese *Influença da syphilis sobre a marcha da prenhez* (Mattos, 1870).

⁷⁶ Relatório da Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo II, 1 de agosto de 1873. In: Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. presidente da provincia, Dr. Francisco Teixeira de Sá, em 6 de setembro de 1873. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1873.

embora não tenha se alastrado como em outros anos, reapareceu em sua “visita anual”, atingindo os tripulantes dos navios que desembarcavam no Porto, principalmente aqueles que vinham de Pernambuco, onde a moléstia grassava em estado epidêmico. A observação de que a população da cidade teria permanecido “incólume”, ou seja, sem perigo, diante da doença, contrastando com a contaminação dos estrangeiros, reforça um certo otimismo, ou talvez um desejo de autopreservação, por parte do médico, que credita à “divina providência” o controle da situação (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1873, p. 6).

Ao comentar a recorrência de febres intermitentes, contínuas e remitentes, de caráter menos alarmante, o inspetor reconhece que essas enfermidades afetavam uma parcela significativa da população. Ainda que consideradas “benignas” em muitos casos, não deixavam de causar mortes, entre adultos e crianças em condição de maior vulnerabilidade. A descrição das formas⁷⁷ “ataxica” e “adnamica”, que terminavam frequentemente em óbito, revela a gravidade desses quadros clínicos, agravados por fatores como a dificuldade de acesso ao tratamento contínuo (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1873, p. 6-7).

Fica evidente que, para os setores mais pobres, a assistência era tardia ou inexistente, e o hospital da Santa Casa acabava por receber doentes em estado terminal, como atesta o próprio médico ao afirmar que muitos “exhalão o último suspiro antes de receberem qualquer socorro médico; elles sabem que não vão encontrar allivio para os males physicos, mas tem a convicção de que encontrarão o conforto para a alma e um enterramento decente” (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1873, p. 9).

Com relação às ocorrências sanitárias do interior da província, as notícias vindas de Pombal, por exemplo, informam o surgimento, ainda em janeiro, de uma febre de “mau caráter”, associada aos surtos de sarampo e diarreia. O médico registra que houve resposta rápida por parte do governo, com o envio de uma ambulância de medicamentos em 6 de fevereiro. Já a situação registrada em Bananeiras, no mês de abril, repete esse padrão: a febre amarela, mencionada como de grande intensidade, causava medo, desânimo e vários casos de morte. Mais uma vez, a solução foi o envio de remédios e de uma comissão liderada pelo médico João Nepomuceno Dias Fernandes, que foi elogiado pela forma como desempenhou sua função (Parahyba do Norte, Inspetoria de Saúde Pública, Anexo II, 1873, p. 13).

⁷⁷ As expressões “ataxica” e “adnamica” (grafadas assim no relatório médico da época) não se referem a tipos específicos de febre, mas sim a manifestações clínicas associadas ao agravamento do estado do paciente. A ataxia (perda da coordenação motora) e a adinamia (fraqueza muscular intensa ou perda generalizada de força física) podem surgir como complicações decorrentes de enfermidades infecciosas ou do estado de debilidade orgânica.

Entre as solicitações⁷⁸ feitas por Abdon Felinto Milanez, chama atenção a situação de diferentes espaços de tratamento na Capital, revelando um quadro sanitário ainda marcado por limitações. Na enfermaria da Cadeia Pública, a febre era apontada como a moléstia mais comum entre os detentos, representando cerca de um terço dos casos. O mesmo ocorria entre os aprendizes marinheiros, acometidos por febre intermitente, que deixaram de ser internados na Santa Casa e passaram a ser tratados no próprio quartel, onde as instalações também não ofereciam condições adequadas de higiene.

Mais uma vez, o médico reforçou a urgência da criação de um hospital específico para o tratamento de moléstias contagiosas, dada a insuficiência das estruturas existentes para lidar com os casos mais graves. Em relação ao Porto da Capital, o excesso de lama acumulada e a falta de drenagem eram apontados como um sério empecilho à salubridade do local, sendo vistos por Milanez como uma das principais causas da instalação e propagação das febres (Parahyba do Norte, Inspetoria da Saúde Pública, Anexo B, 1875, p. 7-8).

Nesse caminho percorrido acerca do quadro nosológico da província da Parahyba entre as décadas de 1850 ao início da de 1870, convém apresentarmos um balanço geral entre 1870 e 1876. Com base no levantamento feito por nós a partir dos dados contidos nos relatórios provinciais e da Inspetoria de Saúde Pública, vemos que o período ficou marcado pela reincidência de doenças infecciosas e respiratórias, revelando uma situação sanitária precária que antecedeu a crise de 1877-79.

Dentre as enfermidades mais recorrentes, como já foi discutido anteriormente, destacam-se as diversas formas de febres – amarelas, contínuas, intermitentes e remitentes, que aparecem com frequência nas documentações, afetando tanto a Capital quanto o interior. Também foram diagnosticados casos de varíola, sífilis, sarampo, diarreias, afecções do aparelho respiratório (como pneumonias, bronquites, anginas, pleurisias e tísica), além de doenças associadas à desnutrição e à debilidade física, como anemias, hidropisias, ascite e anasarca.

Também é importante justificarmos que o cálculo total do número de mortes, ao longo desses sete anos, é inconcluso, pois nem sempre os relatórios especificam a quantidade de óbitos correspondente a cada mês, ano ou local. Em muitos casos, encontramos informações relativas ao “ano próximo findo” em relatórios produzidos já na metade ou no final do ano seguinte, o que compromete a obtenção do número real. Ainda assim, podemos afirmar, com

⁷⁸ Inspetoria da Saúde Pública da Parahyba, Anexo B, 1 de Setembro de 1875. In: Relatório apresentado à Assembléa Legislativa da província da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 9 de outubro de 1875. Typ. do Jornal da Parahyba - Rua da Matriz, n. 4, 1875.

base no nosso levantamento, uma estimativa de 2.500 a 3.000 mortes⁷⁹. Essa constatação reforça que a seca de 1877 atingiu uma população já fragilizada por doenças, abandono e por estruturas de saúde ainda incipientes.

Mas o início da década de 1870 não se restringiu à seca e às doenças: foi marcado, também, com o fim da Guerra do Paraguai (1864-1870). Nesse contexto, o Império brasileiro enfrentou uma série de desdobramentos complexos, como o elevado número de emissões de papel-moeda e a inflação provocada pelos empréstimos externos contraídos junto à Inglaterra para custear o conflito⁸⁰. Segundo Maria Regina de Souza (2018, p. 6), o Norte do Império, por ter sido o maior fornecedor de soldados⁸¹ para a Guerra do Paraguai (1864-1870), ainda enfrentava os impactos sociais deixados pelo conflito, como o aumento da violência, da orfandade e da pobreza. A autora destaca que, nesse contexto, surgiu até uma nova categoria social: os chamados “pobres da guerra”.

Essa dimensão social da guerra também se revela na experiência dos soldados que participaram do conflito, como constatou Janyne Barbosa (2018), ao abordar aspectos pouco explorados sobre a realidade vivida por aqueles que eram enviados à linha de frente, muitos dos quais alistados à força. Além dos que morriam nos combates ou eram abandonados já que “era tido como incapaz e representava atraso para os generais responsáveis pelos pelotões do exército”, havia os que retornavam para casa em condições precárias - traumatizados, doentes e esquecidos pelo governo (Barbosa, J., 2018, p. 120).

No centro da investigação⁸² da autora está a relação entre o saber médico e os espaços de cura, por meio dos discursos produzidos pelas instituições médicas imperiais, sustentados por regulamentos, relatórios e práticas terapêuticas, se concretizavam na rotina dos hospitais improvisados e nas experiências de médicos, enfermos e práticos durante o conflito. A guerra é apresentada não apenas como uma sucessão de batalhas, mas como uma realidade atravessada por doenças, abandono e precariedade.

⁷⁹ Se considerarmos o primeiro valor, temos uma média anual estimada em 356 óbitos, já o segundo indicaria uma média aproximada de 429 mortes por ano.

⁸⁰ Como forma de driblar essas consequências e o cenário de crise econômica, as desvalorizações cambiais contribuíram para a investida no mercado privado e nas exportações, o que acarretou um desempenho favorável, com superávits na balança comercial nos anos seguintes (Pereira, 2017).

⁸¹ Ariane Sá (2009, p. 51) chama atenção para o fato de que, durante a guerra contra o Paraguai, muitos dos soldados enviados às frentes de batalha eram homens escravizados, aos quais, pela legislação imperial de 1866, seria concedida a carta de alforria caso se alistassem no serviço militar.

⁸² A autora parte da premissa de que a guerra foi não só sangrenta, mas também epidêmica e doente, e busca compreender como as instituições médicas militares foram organizadas (ou desorganizadas) durante o conflito, e de que forma os sujeitos envolvidos lidaram com esse cenário extremo (Barbosa, 2018).

Os espaços de cura eram, em geral, insalubres, improvisados e violentos, tanto pela precariedade material quanto pela escassez de medicamentos e alimentos. Não eram espaços de cuidado, mas, muitas vezes, de exclusão e abandono, ou, como denominou a autora “laboratórios a céu aberto” (Barbosa, J., 2018, p. 40).

Nesse cenário de agravamento das tensões sociais e econômicas, não tardaram para emergir manifestações de resistência popular que evidenciavam o descontentamento com as transformações em curso⁸³. Um dos episódios mais expressivos desse período foi a chamada Revolta do Quebra-Quilos⁸⁴, em 1874, que teve forte presença na Parahyba e em outras províncias do norte – Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A indignação popular foi impulsionada pela interferência nos modos de vida locais. Comerciantes, agricultores e consumidores protestavam contra o chamado “imposto de chão”, já que “o chão simplesmente não era de ninguém, melhor dizendo, era do povo” (Lima, L., 2011, p. 470). Além disso, a revolta coincidiu com a implementação de leis e regulamentos de repressão à vadiagem, os quais visavam “impor formas compulsórias de trabalho aos homens pobres da região, que vivia a crise da escravidão” (Lima, L., 2011, p. 471).

Nesse mesmo cenário, a nova Lei de Recrutamento Militar n.º 2.556 também se destacou entre os fatores que alimentaram a insatisfação popular durante a Revolta do Quebra-Quilos. Conhecida como “Lei da Cumbuca”, amplamente rejeitada pela população, a norma estabelecia o sorteio como forma obrigatória de seleção para o serviço militar, além de retirar o benefício de isenção dos homens casados.

De acordo com Ariane Norma de Menezes Sá (2009, p. 102), o recrutamento compulsório, também chamado de “imposto de sangue”, era temido⁸⁵ pelos trabalhadores

⁸³ Segundo Luciano Mendonça de Lima, a crise do algodão e a consequente reorientação da produção agrícola representaram um fator adicional na escalada das tensões sociais descritas. Na tentativa de preservar seus lucros, os grandes proprietários de terras ampliaram as lavouras voltadas à exportação sobre áreas antes destinadas à subsistência, decisão que comprometeu o abastecimento local e contribuiu para a elevação dos preços dos alimentos. Como consequência, esse conjunto de mudanças resultou na expulsão de pequenos produtores e moradores tradicionais, na concentração fundiária e na redução das roças de subsistência. A escassez de alimentos agravou ainda mais a situação das camadas populares, já pressionadas pelo aumento de tributos sobre itens básicos de consumo, como carne e farinha, decorrente dos desdobramentos de 1874 (Lima, L., 2011, p. 456-455).

⁸⁴ A eclosão da revolta foi a reação contra a imposição da Lei Imperial n.º 1157, de 26 de junho de 1862, que só entrou em vigor em 1872, quando implantou o sistema métrico-decimal francês, com novas taxas sobre o peso e a medida dos produtos. Apesar de marcar um avanço na modernização, a lei propunha o abandono de antigas práticas cotidianas utilizadas pelos comerciantes, como os equipamentos de medição linear, de capacidade e de volume, substituídos pelo metro, o litro e o quilograma. No entanto, as consequências em torno da “criação e majoração de impostos elevavam o custo de vida, atingindo principalmente os homens livres pobres que já vinham com o desemprego e baixos salários” (Sá, 2009, p. 99).

⁸⁵ Segundo a autora, a má recepção da nova lei também se relacionava à sua divulgação precária e à percepção de que ela submetia os cidadãos livres e pobres a um regime semelhante à escravidão, intensificando o sentimento de exclusão desses grupos em relação ao projeto nacional (Sá, 2009, p. 103).

rurais, pois funcionava como uma forma de punição arbitrária imposta pelos grandes proprietários. Em caso de desentendimentos, o trabalhador podia ser indicado para servir nas forças armadas ou na polícia, restando-lhe como única saída a clandestinidade.⁸⁶

É válido pontuar que antes de 1877 a Parahyba já enfrentava sérias dificuldades econômicas⁸⁷, como demonstra a elevação constante do déficit orçamentário entre 1872 e 1875. Após um aumento de 126:129\$019 (cento e vinte e seis contos, cento e vinte e nove mil e dezenove réis) em 1872-1873 para 132:933\$913 (cento e trinta e dois contos, novecentos e trinta e três mil e novecentos e treze réis) em 1873-1874, o salto registrado em 1874-1875: quando o déficit atingiu 297:023\$842 (duzentos e noventa e sete contos, vinte e três mil e oitocentos e quarenta e dois réis) (Parahyba do Norte, Relatório, 1875, p. 30-31).

Observamos até o presente momento, uma série de inconstância nas condições de vida e saúde da população parahybana, e também nos acontecimentos sócio-políticos da província. Ainda no ano de 1876⁸⁸, podemos perceber que a situação não seria diferente nos anos seguintes. Isso porque o 2º vice-presidente da província, Dr. João da Matta Correia Lima⁸⁹, resumiu o quadro nosológico daquele ano afirmando que se “luctou-se com extensas e mortíferas epidemias” (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 19).

Além disso, a febre amarela voltou a provocar novos surtos após a chegada do navio inglês *Titania* ao Porto da Capital. A varíola, por sua vez, afetava de forma mais intensa os habitantes do interior, em localidades como Alagoa Grande, Alagoa Nova, Independência, Bananeiras, Pilar, São João, Piancó, Souza, Misericórdia e Taquara (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 19).

⁸⁶ Além disso, apesar das promessas de isenções, persistia a desconfiança de que os únicos convocados seriam justamente os que não possuíam influência ou recursos. A possibilidade de um recrutamento mais igualitário ainda gerava temor entre as elites rurais, que viam na nova legislação uma ameaça à sua autoridade, já que ela impedia o uso de substitutos e favorecidos, revelando um cenário de tensão social que contribuiu diretamente para o levante (Sá, 2009, p.103).

⁸⁷ Outra medida voltada ao aumento da produtividade e à redução de custos foi a implementação dos engenhos centrais. A proposta foi aprovada em 1875, com o objetivo de modernizar a indústria açucareira em larga escala (Fernandes, 1999, p. 34). No entanto, os primeiros engenhos centrais só foram instalados em 1885, com a inauguração do Engenho São João, no município de Santa Rita. Mesmo assim, a iniciativa não surtiu os efeitos esperados, pois “enquanto a direção da empresa considera onerosos os contratos para a compra de cana-de-açúcar, os fornecedores desistem de contratos já firmados, por achá-los pouco compensadores” (Fernandes, 1999, p. 35).

⁸⁸ Relatório com o que o Exm. Sr. Dr. José Paulino Gomes de Figueiredo, 1º Vice-presidente, passou a administração da província da Parahyba ao Exm. Sr. Dr. Esmerino Gomes Parente no dia 24 de abril de 1877. Typ. do Jornal da Parahyba,- Rua Visconde de Pelotas n. 10, 1877.

⁸⁹ Exerceu a administração interinamente entre janeiro e março de 1877. Também atuou como deputado provincial nos períodos de 1854-1855 e 1856-1857 (Mariano, N., 2015, p. 296).

Apesar desse quadro, em 1877⁹⁰, o presidente Flávio Clementino da Silva Freire⁹¹ fez questão de ressaltar que “a população desta capital acha-se em sua totalidade vaccinada, o que é devido ao zelo e actividade do digno commissario vaccinator” (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 19). Tal afirmação antecipa um discurso que se tornará recorrente nos anos seguintes: a valorização da profilaxia urbana como símbolo de ordem e civilização, em contraste com a vulnerabilidade sanitária das regiões do interior.

Na prática, esse tipo de enunciado servirá também para reforçar uma imagem negativa em torno dos migrantes que se dirigiram à capital durante a seca, frequentemente associados à propagação de doenças (Brasil, R.; Mariano, S., 2025). No caso específico da varíola, a questão não estava exatamente na mobilidade dessas populações, mas na ausência de cobertura vacinal nas zonas mais distantes. Ainda na seção sobre a *salubridade pública*, o presidente mencionou casos de sarampo e beribéri, que, embora tenham causado apreensão foram controlados por meio da “aplicação dos remédios aconselhados pela sciencia” (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 19).

Diante desse acúmulo de crises – sanitárias, sociais, políticas e econômicas –, a província ingressou em 1877 com uma população já marcada por vários acontecimentos preocupantes e por uma rede de assistência ainda limitada, frequentemente acionada apenas em caráter emergencial. A recorrência de febres, surtos de varíola e episódios epidêmicos, somada ao déficit orçamentário, às tensões sociais do pós-guerra e às medidas de controle que recaíam sobre os pobres, compunha um cenário de instabilidade permanente.

Assim, quando os primeiros sinais de estiagem se tornaram mais evidentes e a crise hídrica avançou sobre o interior, seus efeitos não incidiram sobre um cotidiano “regular”, mas sobre uma realidade já pressionada por precariedades acumuladas. É nesse ponto que a seca de 1877-79 deixa de ser apenas uma possibilidade climática e passa a se impor como ruptura concreta, desencadeando migrações, agravando o adoecimento e inaugurando uma nova fase de colapso social na Parahyba.

À medida que epidemias se sucediam, que a pobreza se aprofundava e que o cotidiano se tornava mais instável, a Parahyba parecia caminhar para um limite. Esse limite começou a

⁹⁰ Relatório... Barão de Mamanguape – 9 de janeiro de 1877. 1877. Relatório anual apresentado à Assembleia Legislativa da Província da Parahyba do Norte. Typ. do Jornal da Parahyba, – Rua Visconde de Pelotas n. 10, 1877.

⁹¹ Detentor do título de Barão de Mamanguape, foi uma das figuras de maior projeção política da Província da Parahyba ao longo do século XIX. Bacharel em Direito, construiu uma trajetória marcada pela atuação parlamentar contínua e pelo prestígio junto ao Imperador D. Pedro II. Exerceu sucessivos mandatos como deputado geral e senador do Império, além de ter administrado a Província da Parahyba em três ocasiões distintas, entre 1853 e 1877 (Revista do IHGB, n.º 262, p. 18-19).

se romper em 1877. Não podemos afirmar ao certo uma data exata de quando começaram os primeiros efeitos do que ficaria conhecido como “Grande Seca”.

Pelas documentações disponíveis, é possível levantarmos a hipótese de que já havia, no início dos primeiros meses de 1877, alguns indícios ainda pontuais de uma possível estiagem. Mas, de acordo com José Américo de Almeida (2012 [1923], p. 150): “a situação exasperou-se de repente”. Logo, as primeiras ações realizadas pelo governo foram apresentadas à Assembleia Legislativa no dia 24 de abril de 1877⁹², pelo 1º vice-presidente, Dr. José Paulino de Figueiredo, ao passar a administração da província para o novo presidente, Dr. Esmerino Gomes Parente.

Nesse momento, expressam-se as primeiras consequências da seca: “A falta de chuvas vai reduzindo os sertões da província ao mais deplorável estado. Os criadores têm soffrido immenso prejuizo em seus gados”. Relata também ter recebido representantes do alto sertão pedindo auxílio para socorrer a população atingida pela fome, o que o levou a abrir um crédito de 5:000\$000 (cinco contos de réis) “na Thesouraria da Fazenda, por sua própria responsabilidade, destinado à compra de gêneros alimentícios” (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 10-11).

Ele explica que, como ainda havia a possibilidade de chegar o inverno, o que mudaria completamente o cenário de seca, não seria prudente, naquele momento, comprometer as finanças da província com grandes despesas em ajuda emergencial, uma vez que tais socorros “poderiam ainda ser dispensados” caso chovesse.

Apesar disso, reconhece que a seca se agravou e que a esperança de inverno praticamente se perdeu, o que exigiria agora medidas concretas e imediatas por parte do próximo administrador. Ao afirmar que caberia a V. Ex. “tomar as medidas que em sua sabedoria julgar mais acertadas”, o presidente sinaliza que, apesar de já ter feito alguma intervenção, como descrito anteriormente, a responsabilidade pelo enfrentamento mais efetivo da calamidade estava sendo transferida ao sucessor, com destaque para a urgência da situação enfrentada especialmente pela população pobre do interior da província (Parahyba do Norte, Relatório, 1877, p. 10-11).

A partir desse momento, os efeitos sociais da seca passaram a se manifestar de forma mais visível e contínua, sendo o intenso fluxo migratório em direção à Capital e a regiões vizinhas um de seus primeiros desdobramentos. Já nos primeiros meses de 1877, jornais locais

⁹² Relatório com o que o Exm. Sr. Dr. José Paulino de Figueiredo, 1º. Vice-presidente, passou a administração da província da Parahyba ao Exm. Sr. Dr. Esmerino Gomes Parente no dia 24 de abril de 1877. Typ. do Jornal da Parahyba, – Rua Visconde de Pelotas n. 10, 1877.

passaram a noticiar a chegada crescente de migrantes vindos do interior, antecipando cenas que se tornariam recorrentes ao longo de toda a Seca de 1877-1879. Nesse sentido, a edição de 6 de maio de 1877 do jornal *A Opinião* descrevia que “[...] a seca vai se tornando cada vez mais devoradora e que os emigrantes dos sertões afluem quase diariamente nos brejos em número considerável” (*A Opinião* (1877), 06/05/1877, *apud* Almeida, J., 2012 [1923], p. 152).

Em períodos de secas intensas, a baixa umidade e o clima quente favorecem o aumento de doenças respiratórias (pneumonia, tuberculose), carenciais (anemia, desnutrição, opilação), infectocontagiosas e parasitárias (diarreia, sífilis, chagas), além dos surtos epidêmicos de febre amarela e varíola.

Segundo José Américo de Almeida (2012 [1923]), a Seca de 1877-1879, na Parahyba, ficou marcada pela alta taxa de mortalidade e por uma “conjunção de influências funestas”, males como “as afecções palustres, o beribéri, a anasarca, as febres perniciosas, o escorbuto, a varíola [...]” ameaçavam a vida da população que já se encontravam expostas a uma série de condições precárias de higiene e segurança (Almeida, J., 2012 [1923], p. 161).

Para além do quadro clínico das doenças, o aspecto físico dos atingidos pela seca denunciava uma tragédia ainda mais profunda. Os relatos descrevem corpos consumidos, em extrema magreza, além dos olhares aflitos, eram denunciados em toda as localidades, no sertão, a situação era ainda mais alarmante, em 1º de novembro de 1877, no município de Cajazeiras⁹³

A miséria vai invadindo todas as classes da sociedade. Dizem-me que já têm morrido à fome algumas pessoas; em nossa casa **têm entrado cadáveres ambulantes que só têm a pele e os ossos. Há pais que por sua miséria têm abandonado seus filhos, de sorte que as ruas vivem cheias de meninos e meninas no estado mais pungente que se pode imaginar. Há mulheres que vivem nuas e morrendo à fome.** Deus se compareça desta terra, certo de que o futuro de Cajazeiras está cheio de horrores e de desgraças (Comarca de Cajazeiras, AHWBD, 01/11/1877. Grifos nossos).

A menção à invasão da miséria “em todas as classes da sociedade” sugere a dimensão do colapso social, reforçando a ideia de que a seca afetava a todos, ainda que de formas desiguais. Outra consequência que se tornaria “comum” é o abandono de crianças pelas ruas, que passaram a ser abrigadas tanto em hospitais quanto em casas de caridade. Vemos também que o apelo “Deus se compareça desta terra” aponta para o limite das esperanças diante da seca, enquanto o anúncio de um futuro “cheio de horrores e de desgraças” revela uma

⁹³ Comarca de Cajazeiras em 01 de Novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

percepção de que o pior ainda estava por vir. Trata-se de um relato que não apenas narra, mas interpreta a própria catástrofe.

O relato também representa um ponto de inflexão na vida social da província da Parahyba, com a chegada da seca, marcando uma ruptura violenta com a estrutura de eventos até então comuns do cotidiano. Como propõe Agnes Heller, a vida cotidiana nada mais é do que o campo onde os indivíduos se orientam no mundo a partir de esquemas práticos, juízos provisórios e formas espontâneas de ação, num equilíbrio precário entre repetição e criatividade, entre rotina e possibilidade (Heller, 2016). No entanto, essa estrutura da vida cotidiana, pode tornar-se altamente vulnerável à alienação quando submetida a condições extremas, como as provocadas por catástrofes sociais e naturais.

No contexto da seca, o colapso das condições materiais de existência como a perda das colheitas, morte dos rebanhos, fome generalizada, deslocamentos forçados, desorganizou profundamente os vínculos, papéis e referências que sustentavam a vida ordinária. Como destaca Agnes Heller (2016), é no cotidiano que os indivíduos constroem sentidos estáveis para a vida prática e afetiva. Quando esse campo de orientações se desfaz, surgem o imprevisto, o desamparo e a ruptura com normas previamente estabelecidas.

Tal desestruturação se fez visível também nas tensões urbanas geradas pela chegada em massa dos migrantes. Os jornais relatavam: “Vemos o mais horrível dos males devastando a população e ceifando milhares de vidas necessárias [...] – a fome!” (*Echo Escolastico*, 19/09/1877, p.1).

Posteriormente, em 11 de dezembro de 1877, o chefe de polícia da Capital⁹⁴ relatava o aumento de tentativas de roubo no Varadouro e em outras partes da cidade, pois “todo o dia crece o numero de retirantes, que a secca tem feito descer dos sertões da Província; é de supor que se vão tornando mais frequentes as tentativas de rôbos distúrbios e mesmo outros crimes” (Delegacia de Polícia da Capital, AHWBD, 11/12/1877).

Nesses termos, pode-se dizer que a seca de 1877 instaurou um processo de alienação da vida cotidiana, no qual a separação entre o ser e sua essência, entre a individualidade e sua autorrealização, tornou-se mais aguda.

Ainda assim, como lembra Heller, mesmo sob tais condições, não se extingue a possibilidade de ação moral: ao contrário, a tentativa de restituir algum sentido à existência, de proteger os filhos, de migrar em busca de recursos, de pedir ajuda ou de resistir ao desespero, pode transformar-se em uma condução representativa da vida, que,

⁹⁴ Delegacia de Polícia da Capital em 11 de Dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

excepcionalmente, “transforma a própria ordenação da cotidianidade numa ação moral e política” (Heller, 2016, p. 53). Ao iluminar essas experiências, é possível reconhecer nos gestos mais elementares de sobrevivência não apenas estratégias de adaptação, mas também formas de agência histórica e resistência subjetiva.

Esse processo de desagregação da vida cotidiana e das formas tradicionais de sociabilidade não se limitou às experiências individuais ou aos conflitos urbanos gerados pela migração. A seca de 1877-1879 também atingiu as estruturas econômicas e sociais que sustentavam a ordem vigente na província, entre elas o próprio sistema escravista.

O sistema escravista, em particular, entrou em um processo acelerado de desgaste, ao mesmo tempo em que se intensificavam as pressões emancipacionistas. Esse movimento articulava-se a fatores já em curso, como a proibição do tráfico internacional de escravizados e a ampliação do tráfico interprovincial direcionado à zona cafeeira do Centro-Sul (Rocha, 2007; Silva, 2021). Nessa conjuntura, a lógica do comércio inter-regional de cativos passou a tensionar a estabilidade do regime escravista, uma vez que

“[...] estava colocando em risco a estabilidade do regime escravista, pois de um lado encontramos o Norte descapitalizado que cada vez mais vendia seus escravos na tentativa de minimizar suas perdas, e de outro, o Sul que aumentava a compra de escravos para garantir sua produção. No entender dos sulistas, este desequilíbrio numérico entre as regiões podia levar os nortistas a se solidarizar com a causa emancipacionista. Para prolongar a escravidão, só aprovando uma lei antitráfico” (Sá, 2009, p. 32).

A Parahyba, por exemplo, impôs inicialmente um imposto de 100\$000 (cem mil réis) por cada escravizado(a) exportado(a), mas foi reduzido para 25\$000 (vinte e cinco mil réis) em 1860 – sem, contudo, impedir a compra de cativos pelas províncias cafeeiras (Galliza, 1979, p. 116-117). Documentos da época registram a atuação recorrente de firmas comerciais nesse tipo de transação, chegando a contabilizar o envio de aproximadamente 83 cativos naquele ano (Galliza, 1979, p. 121).

A continuidade do mercado interno de escravizados, mesmo diante da crise, é encontrada também nos anúncios de jornais, como o publicado no *Jornal da Parahyba*, em 17 de abril de 1879: “Compra-se escravos próprios para embarque: à tratar com Melo & Cia. à rua Conde d’Eu nos 50 e 52” (*apud* Aguiar, 1999, p. 161).

Esse quadro se agravou de forma significativa, quando muitos agricultores parahybanos passaram a não conseguir sustentar seus cativos, o que resultou na paralisação da produção e da exportação. Enquanto isso, as elites cafeeiras do Centro-Sul se beneficiaram da maior oferta de escravizados no mercado.

Por outro lado, como bem destacou Lucian Silva (2021, p. 66), também “colocou em xeque o controle social e suas várias formas de dominação, que garantiam a manutenção da ordem e das hierarquias sociais em um momento em que as elites nortistas estavam paulatinamente perdendo os espaços de poder na política nacional”. Esse abalo nas estruturas de poder revela como a crise climática impactou as formas de dominação social na província, antecipando transformações que enfraqueceram o modelo escravista vigente.

Diante desse cenário de desorganização social, crise econômica e enfraquecimento dos mecanismos tradicionais de controle, as respostas formuladas não se limitaram às iniciativas individuais de sobrevivência, mas passaram a assumir formas institucionais. Entre as experiências e estratégias de adaptação, muito há a ser dito.

Durante a Seca de 1877-1879, três mecanismos foram criados com o intuito de prestar assistência à população migrante. O primeiro deles foi a formação dos núcleos ou colônias agrícolas, que não funcionavam apenas como um simples sistema de troca de moradia por trabalho, mas iam muito além disso, como veremos a seguir. Em um segundo momento, destacam-se a criação dos hospitais e das comissões de socorros públicos, encarregadas de distribuir alimentos, roupas, remédios e oferecer atendimento médico-hospitalar, mecanismos que se sobressaíram pelas consequências mais graves e persistentes.

2.2 “SEJA LIVRE SUA INCLUSÃO, SE NÃO FOREM ACTIVOS, E BEM COMPORTADOS”: AS RELAÇÕES DE TRABALHO NOS NÚCLEOS COLONIAIS DA PARAHYBA EM 1877-1879

Logo nos primeiros meses em que os efeitos da seca começaram a desorganizar o cotidiano de diversas famílias, especialmente no sertão, verificou-se um fluxo migratório intenso e descontrolado em direção às regiões do Agreste e do Litoral Parahybano. A concentração de migrantes nos centros administrativos da Capital passou a ser percebida pelas autoridades não apenas como um problema assistencial, mas também como um risco sanitário e social, frequentemente associado à disseminação de doenças, à ausência de vacinação contra a varíola e a comportamentos considerados incompatíveis com a ordem urbana. Nesse contexto, o trabalho emergiu como um eixo central das estratégias de controle e reorganização da população migrante.

Ao comunicar-se com a Assembleia Legislativa⁹⁵, o presidente da província, Dr. Esmerino Gomes Parente⁹⁶, expressou o temor quanto ao aumento dos “crimes, que a aglomeração de tanta gente ociosa poderia ocasionar”, defendendo, ao mesmo tempo, a necessidade de “utilizar os seus serviços para compensação”. Como medida inicial, recomendou que as comissões de socorros empregassem os assistidos em trabalhos públicos, como a construção de açudes, cadeias e estradas, inaugurando uma lógica na qual a assistência passava a ser condicionada à disciplina do trabalho (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 30).

Apesar do discurso em combater a ociosidade se tornar uma causa constante durante os três anos de seca, houve também um incentivo explícito para que “aconselhassem á buscar o littoral e proximidades d’esta Capital, onde achariam, por seo trabalho, meios de subsistencia, ou receberiam mais facilmente os socorros do Governo” (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 30).

Encontramos, ainda, diversos relatos denunciando a chegada contínua de migrantes e suas famílias, muitas das quais não recebiam uma recepção amigável. Em alguns casos, a hostilidade se manifestava por ações violentas, como ocorreu no dia 06 de outubro de 1877, à chegada de determinado grupo, quando, segundo o jornal *A Opinião* (1877), “os soldados espancarão, no meio das ruas, turmas de matutos que atulhavam-se debaixo dos sabres” (*A Opinião* 1877, n.º 60, 25/11/1877, p. 4)⁹⁷.

Esse episódio evidencia que, para além da falta de acolhimento, a presença de migrantes era tratada como um problema de ordem pública, sendo reprimida por meio de violência física e humilhação. O uso do termo “matutos” para descrevê-los não denunciava apenas sua origem rural, comumente associada ao sertão, mas carregava um forte peso estigmatizante, ao representá-los como sujeitos socialmente marginalizados. Tal representação reforçava estereótipos e servia, aos olhos das autoridades e de parte da

⁹⁵ Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província da Parahyba do Norte pelo presidente Exm. Sr. Doutor Esmerino Gomes Parente, em 12 de agosto de 1877. Typ. Liberal Parahybana.- Rua Visconde de Inhaúma n. 12. 1878.

⁹⁶ Formou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife em 1858. Entre os cargos ocupados estão o de promotor, juiz de direito, chefe de polícia, deputado provincial e vice-presidente da província do Ceará (Mariano, N., 2015, p. 296-297). Exerceu a presidência da província da Parahyba do Norte entre abril de 1877 e março de 1878.

⁹⁷ Tanto a edição dos jornais *A Opinião* (25 nov. 1877) quanto a de *O Publicador* (11 jun. 1879) foram identificadas e catalogadas pela Profa. Maria da Vitória Barbosa Lima a partir de pesquisas realizadas nos acervos do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR), da Fundação Casa de José Américo (FCJA) e do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP). Agradeço a Lucian Silva, que, com autorização da Profa. Maria Vitória, gentilmente disponibilizou as referidas documentações.

população, como justificativa para práticas de exclusão, vigilância e controle nos espaços urbanos.

Fica, assim, a contradição: se o próprio governo declarava que poderiam “buscar o littoral e proximidades d’esta Capital”, por que depois voltaria atrás, tratando esse deslocamento como um problema?

Apesar dessa orientação, o próprio presidente reconheceu que tal medida só obteve êxito em Campina Grande, onde, “não sem dificuldade”, o juiz de direito conseguiu reunir alguns trabalhadores e aplicá-los aos reparos e limpeza dos açudes; “em geral recusam-se a aproximar-se d’esta Capital” (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 30). Isso indica que uma parte da população optava por permanecer em localidades intermediárias ou, possivelmente, era encaminhada para os núcleos coloniais – hipótese que pode estar relacionada ao receio do que encontrariam na Capital, à incerteza quanto às condições de acolhimento ou ao desejo de evitar um deslocamento mais longo e arriscado.

Além disso, o direcionamento para o interior e para os núcleos não era apenas uma medida assistencial: também havia o interesse econômico de aproveitar a mão de obra migrante em obras públicas e na produção agrícola, reduzindo a pressão demográfica e social sobre a capital. Pouco tempo depois, Esmerino afirmou ter tomado providências “a fim de obviar a emigração” em maior escala, revelando uma mudança de postura. Nesse contexto, “emigração” não significava deixar a província, mas deslocar-se internamente para áreas que o governo queria evitar sobrecarregar (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 30).

Assim, se no início o incentivo para “buscar o littoral” visava suprir a mão de obra e facilitar o acesso aos socorros, quando o fluxo se tornou numeroso e descontrolado, passou a representar um problema logístico e sanitário, levando o governo a tentar fixar parte dessa população em pontos estratégicos do interior e nos núcleos coloniais.

Diante dessa conjuntura de deslocamentos intensos, tensões urbanas e do receio crescente quanto à presença de uma população considerada “ociosa” e potencialmente perigosa à ordem pública, o governo provincial passou a buscar alternativas que permitissem, ao mesmo tempo, dispersar os migrantes, aproveitar sua força de trabalho e reduzir os riscos sociais e sanitários associados à sua permanência na Capital.

É partir dessas circunstâncias que se insere a criação dos núcleos coloniais, concebidos como espaços capazes de fixar essa população em áreas específicas, submetendo-a à disciplina do trabalho e a formas sistemáticas de vigilância e controle.

Esses núcleos, mais do que espaços de combate emergencial à fome e aos efeitos da estiagem, funcionavam também como instrumentos de administração e controle social. É

nesse sentido que podemos compreendê-los como dispositivos de *biopolítica*: mecanismos de gestão da vida “que compreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto” (Foucault, 1988, p. 128).

Organizados em turmas de trabalho, os migrantes recebiam assistência, mas, ao mesmo tempo, eram vigiados, regulados e disciplinados, numa dinâmica em que, segundo Foucault (1988), as relações estabelecidas em espaços estruturados, como locais de trabalho e assistência, funcionam como formas permanentes de vigilância e controle sobre populações vulneráveis.

Antes de adentrarmos a análise das condições de vida e saúde, bem como das relações de trabalho estabelecidas nos núcleos coloniais, é importante situar esse processo no contexto mais amplo das transformações provocadas pela Seca de 1877-1879.

Como aponta Ariane Sá (2009, p. 77), a estiagem “estimulou o mercado interprovincial de escravos, desorganizou a produção onde eles eram utilizados e contribuiu para um maior aproveitamento da mão de obra livre”. Desse modo, a criação dos núcleos coloniais na Parahyba não se restringiu a uma resposta emergencial à crise, mas integrou um projeto mais amplo de reorganização do trabalho, voltado tanto à absorção dos migrantes quanto à adaptação dos proprietários rurais à progressiva transição do trabalho escravizado para o livre.

Segundo a autora, essas colônias foram implantadas, em sua maioria, em áreas estratégicas, próximas às ferrovias, ao litoral e às zonas de engenho, o que revela sua articulação direta com os interesses da economia agroexportadora (Sá, 2009, p. 68). Assim, os núcleos coloniais combinavam funções assistenciais e produtivas, ao mesmo tempo em que operavam como mecanismos de controle social, ao disciplinar os corpos e integrar os trabalhadores pobres a um regime de trabalho regulado pelo governo local.

Mesmo quando os proprietários aparentavam “ceder” terrenos sem cobrança direta, havia ganhos indiretos evidentes. Ariane Sá (2009, p. 70) lembra que o sistema de trabalho mais difundido entre os grandes proprietários rurais era o de morador-agregado. Nessa modalidade, o trabalhador recebia um lote de terra para garantir sua subsistência, mas ficava obrigado a prestar serviços regulares ao engenho, como “o trato e o corte de uma tarefa” – equivalente a 625 braças de cana, cerca de 1.375 metros. O morador-condiceiro devia trabalhar dois ou três dias por semana, recebendo pagamento apenas pelo excedente, enquanto o morador-foreiro, detentor de uma área maior, pagava foro e fornecia o chamado cambão, isto é, de “20 a 30 dias de trabalho gratuito por ano nas terras do senhor” (Sá, 2009, p. 70).

No caso dos núcleos coloniais, o governo provincial, por meio das comissões de socorro, assumia tarefas fundamentais para a viabilização dessas áreas: limpeza do terreno, derrubada do mato, abertura de estradas, construção de açudes e preparação das terras para o cultivo. Do ponto de vista da economia política, contudo, esse modelo apresentava contradições importantes.

Embora garantisse uma oferta relativamente estável de mão de obra nos períodos de safra, a adoção do trabalho assalariado entrava em choque com a lógica de uma economia “escassamente monetarizada” (Sá, 2009, p. 68–69). Além disso, ao permitir que trabalhadores e suas famílias tivessem acesso à terra para a própria subsistência, os núcleos enfraqueciam os vínculos tradicionais de dependência com os grandes proprietários, afetando as bases do poder local.

Dessa forma, a terra permanecia como instrumento central de dominação e controle da mão de obra livre. O que estava em jogo, como destaca Ariane Sá (2009, p. 69), não era apenas a assistência aos migrantes, mas a condução, sob os interesses das elites agrárias, do processo de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre.

Essas intervenções, feitas com recursos públicos, acabavam valorizando as propriedades e ampliando seu potencial produtivo ou de acesso. Além disso, a cessão de terras se inseria em práticas de assistencialismo e de troca de favores que caracterizavam as relações políticas do período. Ao oferecer suas terras para iniciativas ligadas ao combate à seca, o proprietário local se posicionava como aliado do governo provincial, fortalecendo sua influência e garantindo possíveis benefícios futuros.

Ainda conforme a autora, alguns núcleos, estavam instalados em engenhos, como é o caso do Mussuré⁹⁸, de propriedade do padre Lindolfo Correia das Neves⁹⁹. Nesse núcleo viviam 1.677 pessoas divididas em 366 famílias, sendo o maior entre os 31 formados no período da seca. Houve diversos episódios envolvendo a conduta moral e as precárias condições de higiene e saúde dos trabalhadores.

Em ofício enviado pelo próprio padre ao presidente da província, informa que uma parte da colônia “recebeu todos os generos pedidos para sua ração”, enquanto a 2ª seção recebeu apenas “a carne, faltando a farinha” (Offício, AHWBD, 23/07/1879). O documento

⁹⁸ Ofício enviado pelo padre Lindolfo Correia das Neves. 23 de Julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

⁹⁹ Integrou o grupo de deputados provinciais parahybanos formados na Faculdade de Direito de Olinda, concluindo o curso em 1847, ano em que apenas ele representava a província da Paraíba entre os 26 bacharéis. Antes disso, havia estudado no Seminário de Olinda, onde foi ordenado sacerdote em 1843. Entre seus bens, figurava o engenho Mussuré, citado em seu testamento (Segal, 2017, p. 113-114).

também expõe as dificuldades para repassar os mantimentos aos colonos, ainda que houvesse “os colvéis para conduzi-la, mas a Repartição de Socorros não existe, na Alfandega não existe ordem para entregar, e estão os colonos, que já perderam dois dias, sem receber a comida” (Offício, AHWBD, 23/07/1879).

Ao final do ofício, o padre cobra com urgência que “logo a V. Ex^a que se digne providenciar em ordem a que seja fornecida hoje a farinha, pois ainda devem perder um dia, o da distribuição, que só pode ir amanhã”. Apesar do atraso e do não cumprimento da carga total a ser recebida, é possível perceber a frustração do padre, e também o seu arrependimento ao expor o descaso ao presidente de província “desculpe V. Ex^a a impertinencia, porque sou também obrigado a importuna-lo”, mas ainda ressalta outras falhas no pedido das cargas de feijão e milho para sementes, “apenas a ordem da 1^a secção recebeu quatro sacas de feijão” (Offício, AHWBD, 23/07/1879).

Ou seja, a população do núcleo estava há dois dias sem acesso aos gêneros de subsistência, situação que não apenas agravava o quadro de fome e desnutrição, como também evidenciava o descaso das autoridades. Essa carência enfraquecia fisicamente os trabalhadores, aumentava a vulnerabilidade à doenças e reduzia a capacidade de cumprir as tarefas laborais impostas. Dessa forma, as interrupções no abastecimento comprometiam tanto a sobrevivência imediata quanto o rendimento produtivo esperado pelo governo e pelos administradores dos núcleos.

Mas não era apenas a falta de alimentação diária e de reservas de roupas que afetava os colonos. Na *Lista de Relação*¹⁰⁰ da 2^a Turma dos trabalhadores empregados nos serviços da estrada de Várzea Nova a São Bento, dos 106 ocupados, 15 constavam como doentes, conforme registrado nas “observações” da lista. Entre eles, 10 estavam anotados como “doentes racionados ½”, o que indica que já se encontravam em processo de recuperação – possivelmente de sezões ou de feridas (Relação dos Trabalhadores, AHWBD, 20/07/1879).

Essa condição (racionados ½) sugere que poderiam ser aproveitados em outras frentes de trabalho, prática comum à época, como no caso da turma empregada na estrada de Tambaú e Cabedelo, cujo administrador geral das obras foi orientado a “fazer apresentar ao capitão Affonso de Almeida e Albuquerque para racional-os, afim de serem destinados à algum dos nucleos coloniaes que pretendo estabelecer, [...]” (*O Liberal Parahybano*, 05/08/1879, n.º 38, p. 2). Além deles, 3 estavam acometidos por sezões e 2 apresentavam feridas.

¹⁰⁰ Relação dos Trabalhadores restantes empregados nas divisas da entrada de Várzea Nova a S. Bento, a contar de 20 a 27 julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Como é possível observar na lista, havia colonos acometidos por sezões. Cremos, inclusive, que se tratava de uma pequena epidemia, hipótese sustentada pelo relato de João Antonio Gomes¹⁰¹ ao presidente da província, no qual ressalta que, em Gramame, “não tem por ora havido no dito lugar pessoas acometidas de sezões, ou outra qualquer epidemia, que infelizmente tem grassado em outros lugares” (Villa de Pedras de Fogo, AHWBD, 22/08/1879). Não foi possível identificar, nas documentações, dados precisos sobre o número de enfermos ou mortos. Mas sabemos que o tratamento utilizado foi a homeopatia e que os casos de sezões ocorreram em mais de um núcleo já construído ou que ainda iriam ser.

Conforme consta na seção oficial do governo, reproduzida pelo jornal *O Liberal Parahybano* (PB, 1879-1889), a Tesouraria da Fazenda forneceu ao tenente-coronel Francisco Ignácio Pereira de Castro, para implementação do núcleo – composto por 78 famílias e 405 pessoas – ferramentas como enxadas, martelo, balança, além de “xas de pílulas de contra sezões, 6 garrafas de óleo de rícino e 4 ditas amarga, objectos esses necessarios para a colonia que vai estabelecer no Engenho Puxi de Baixo de sua propriedade” (*O Liberal Parahybano*, 05/08/1879, n.º 38, p. 1).

De forma semelhante, outro núcleo recebeu “4 garrafas de óleo de rícino, 2 ditas d’água amarga e 5 caixas de pílulas contra sezões” para atender aos migrantes destinados à colônia que seria criada na propriedade Jagaraú, pertencente ao tenente-coronel José Fernandes de Carvalho, sob a direção do capitão Antônio Cabral de Vasconcellos (*O Liberal Parahybano*, 09/08/1879, n. 39, p. 1), e no Engenho Amparo, de propriedade de Primo Pacheco Borges & Filho, sob a direção de Porfírio Venâncio da Costa Bahia (*O Liberal Parahybano*, 26/08/1879, n. 45, p. 3).

Em relação à enfermidade chamada “sezões”, trata-se de um termo usado no século XIX para designar febres intermitentes caracterizadas por episódios ou crises cíclicas de calafrios, febre e sudorese, que podiam decorrer tanto da malária quanto de outras afecções febris de padrão intermitente.

O médico Chernoviz¹⁰² (1890), em seu *Dicionário de medicina popular*, descreve diversos tipos de febres, entre elas a tifoide (também chamada mucosa, perniciososa, maligna,

¹⁰¹ Villa de Pedras de Fogo. 22 de agosto de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁰² Pedro Luiz Napoleão Chernoviz (1812–1881) foi médico e farmacêutico de origem polonesa, radicado no Brasil a partir da década de 1840. Tornou-se amplamente conhecido pela publicação de manuais médicos e farmacêuticos, especialmente o *Formulário e Guia Médico* e o *Dicionário de Medicina Popular*, obras que circularam intensamente ao longo do século XIX e tiveram grande impacto na difusão de saberes médicos entre profissionais da saúde, boticários e leigos, sendo frequentemente utilizadas em contextos de escassez de médicos e de atendimento formal.

nervosa, lenta nervosa ou pútrida), a remitente (conhecida como febre dos mangues ou palustre), a intermitente (identificada como sezões ou maleitas) e a intermitente perniciosa. Nesse caso, trata-se de uma febre intermitente semelhante às que já vinham sendo registradas na província na década de 1870, como apontado pelo médico Inspetor de Saúde Pública.

Segundo José Américo de Almeida, a estrutura e as condições de moradia dos núcleos coloniais assemelhavam-se a “um sítio insalubre, de forma que as febres intermitentes e de outros caracteres deram cabo, em pouco tempo, dos infelizes que haviam sido removidos para esse foco letal” (Almeida, J., 2012 [1923], p. 160). Relatos da época também mencionam que as habitações eram semelhantes a “choupanas de ramos” (Joffily, 1982, p. 95), evidenciando a precariedade desses espaços. Nessas condições, o risco à saúde era elevado, agravado pela falta de itens básicos de higiene, como a distribuição regular de roupas, e pela insuficiência de alimentação e de medicamentos, o que contribuía para a propagação de doenças e a deterioração física dos colonos.

Essa fragilidade estrutural também se revela no ofício enviado pelo administrador José Francisco de Albuquerque, da Colônia Rio do Meio¹⁰³, ao presidente da província José Roiz Pereira Júnior, em 26 de setembro de 1879, no qual solicita autorização para desmontar duas palhoças abandonadas às margens da estrada de rodagem, nos lugares Barreira e Boa Vista, a fim de aproveitar suas palhas e madeiras na construção de casas para famílias de colonos sob sua administração (Colônia Rio do Meio, AHWBD, 26/09/1879).

Descobrimos também, em outro ofício datado de 15 de maio de 1879, enviado pelo padre ao vice-presidente da província, Pe. Felipe Benício da Fonseca Galvão¹⁰⁴, que, embora a maior parte dos colonos solteiros e das famílias fosse composta por migrantes, ainda era possível admitir novos integrantes na colônia.

Esse ingresso, porém, não ocorria de forma simples: era necessário apresentar um requerimento, como fez Policarpo da Luz Tavares, “que pede a V. Ex^a para ser admittido a colonia d’esta propriedade de Mussuré”. O padre, entretanto, declarou não ter “conhecimento do supplicante” e considerou “talvez conveniente, que os que houvessem de requerer para entrar na colonia juntassem atestado de conducta” (Offício, AHWBD, 15/05/1879).

¹⁰³ Colônia Rio do Meio. 26 de setembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁰⁴ Exerceu mandato como deputado provincial em diferentes legislaturas, presidindo a Assembleia Legislativa da Parahyba em 1864-1865. Foi nomeado 1º vice-presidente da província, função que assumiu interinamente durante as ausências dos titulares entre 20 de fevereiro e 12 de junho de 1879 e, novamente, de 30 de abril a 15 de maio de 1880 (Revista IHGB, v. 249, jul/set. 1960, p. 65).

Nesse caso, o atestado de conduta servia para comprovar os “bons modos” do requerente, provavelmente emitido por alguma autoridade local, como um juiz de direito, pároco ou mesmo um administrador do núcleo. A justificativa apresentada pelo padre baseava-se no fato de que, poucos dias antes, havia sido “preso um pretendente a colono como indiciado em furtos de cavallos”. Assim, o documento deveria atestar que o interessado possuía bom comportamento moral, não estava envolvido em crimes, dívidas ou conflitos e era considerado “apto” e “trabalhador” (Offício, AHWBD, 15/05/1879).

Em novo ofício¹⁰⁵, o padre faz questão de afirmar que aqueles que quisessem entrar em seu núcleo deveriam, além do atestado, possuir “aptidão ao trabalho e conduta; mas como seja livre sua inclusão, se não forem activos, e bem comportados, unico meio de repressão que tenho, e os suplicantes estejam com más circunstancias podem merecer a mesma graça concedida a outros”. O trecho evidencia que a admissão no núcleo estava vinculada a critérios morais e produtivos, o que refletia uma preocupação com a disciplina e a utilidade econômica dos beneficiários (Colônia do Mussuré, AHWBD, 16/05/1879).

Ao mesmo tempo, a ressalva final demonstra certa flexibilidade, permitindo que pessoas em condições extremas “do estado de pernuria em que se achão”; ou como o requerimento¹⁰⁶ feito por Maria Cândida de Jesus e Maria Theresa da Annuniação, as quais “me foram entregues, ninformando, que me parecerem dignas dos socorros do governo” (Colônia do Mussuré, AHWBD, 15/05/1879). Mesmo que não preenchessem plenamente os requisitos desejados, tais casos revelam a tensão entre o ideal de um corpo de trabalhadores disciplinados e a necessidade de atender a situações de vulnerabilidade social.

No entanto, nem todos os admitidos no núcleo mantinham a conduta esperada pelo administrador. O caso¹⁰⁷ de Manoel Bandeira de Lima ilustra como comportamentos considerados indisciplinados eram tratados como ameaças à ordem e à moral da colônia. Acusado de embriaguez, desordem, agressão física a outro colono e resistência à prisão, além de portar arma de fogo em ocasião anterior, Manoel acabou sendo expulso por decisão direta do padre Lindolfo, que justificou a medida com base nas condições que havia imposto para a cessão das terras.

Além disso, o administrador relata que, “fora de si, ia lavar-se de dia no rio onde as mulheres vão lavar roupa, e ultimamente deu uma bofetada em um colono, puxando-o por

¹⁰⁵ Colônia do Mussuré. 16 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁰⁶ Colônia do Mussuré. 15 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁰⁷ Colônia do Mussuré. 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

uma faca, e resistindo à prisão que outros colonos quiseram fazer n'ele por esse motivo” (Colônia do Mussurú, AHWBD, 1879). Acrescenta ainda que o colono “abandonou” a mãe viúva, a qual continuava vivendo na colônia com seus filhos e filhas órfãs. O documento não apenas reforça a autoridade do administrador na manutenção da disciplina interna, mas também revela que a má conduta podia ser entendida como um risco coletivo, capaz de comprometer a segurança e a funcionalidade do núcleo (Colônia do Mussurú, AHWBD, 1879).

Também havia outros casos em que, além da expulsão da colônia, os migrantes eram submetidos a diferentes formas de punição e humilhação. Um exemplo é o registrado no jornal *A Opinião* (1877), a seção intitulada *Palmatoadas* denunciou que o agricultor Manoel José da Silva estava recolhido à cadeia da cidade com as mãos inchadas em decorrência das palmatoadas (castigo físico aplicado com golpes nas palmas das mãos), que sofrera no engenho Viração, de propriedade de Flávio Clementino da Silva Freire (Barão de Mamanguape). Segundo o periódico, a ordem para aplicar a punição partiu do filho do proprietário, e Manoel ali trabalhava quando foi agredido (*A Opinião* (1877), n.º 65, 13/12/1877, p. 2).

Pela transcrição e análise das 27 *Relações de Trabalhadores Retirantes Empregadas em Obras Públicas* (1879)¹⁰⁸, feita por nós, foi possível identificar, por meio de microanálise, que Manoel integrava a 1ª turma da Estrada de Tambaú, registrada em 8 de janeiro de 1879. Natural da Parahyba e procedente da mesma província, Manoel tinha 38 anos, era pardo, casado e trabalhava como agricultor. A presença de seu nome nas relações oficiais e o relato do jornal revelam não apenas o envolvimento de migrantes ou não, visto que ele já morava na capital, nas frentes de trabalho, mas também as formas de violência a que estavam sujeitos, inclusive quando empregados em propriedades privadas.

Sob a ótica da biopolítica, esse conjunto de medidas evidencia como governo e agentes privados exerciam controle direto sobre a vida e o corpo dos indivíduos, disciplinando-os, punindo-os e explorando sua força de trabalho, integrando práticas de assistência e repressão que visavam simultaneamente governar e utilizar essa população vulnerável. Como observa Nayana Mariano, esse mecanismo de biopoder também se estendia à interferência nos costumes do cotidiano, sendo necessário “higienizar” e “medicalizar” a sociedade, num projeto fazia parte de uma “ciência a serviço do progresso” (Mariano, N., 2015, p. 83).

¹⁰⁸ Relação dos Trabalhadores Retirantes Empregados em Obras Públicas – Estrada de Tambaú – 1ª Turma, 8 de Janeiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Para Tyrone Apollo Pontes Cândido, ao investigar as relações de trabalho estabelecidas durante a seca de 1877-79 no Ceará, além de estarem sob constante supervisão, os trabalhadores podiam enfrentar a falta de auxílios, atrasos no pagamento e até a suspensão das obras caso as turmas não comparecessem aos serviços.

Os núcleos coloniais, segundo o autor, constituíam “um espaço de concentração de expectativas contraditórias, ao mesmo tempo em que um campo propício para a tessitura de laços de reciprocidades solidárias” (Cândido, 2014, p. 206). Ele também observa que as doenças eram recorrentes e se manifestavam em larga escala: “Febres, erupções cutâneas, afecções respiratórias, desconfortos abdominais, inchaços, dores de diversos tipos e intensidades denunciavam a presença de casos de malária, beribéri, varíola, sarampo, catapora, tuberculose” (Cândido, 2014, p. 224).

Em relação às atividades laborais deviam “fazer por conta da verba socorros publicos e com os serviços dos retirantes existentes n’esta capital as obras que são necessarias nessa Repartição”, ou seja, o objetivo central era utilizar a mão de obra dos migrantes já presentes na capital, evitando gastos adicionais com contratações externas. Também era fundamental que no “trabalho seja observada a economia que é por desejo”. A ordem, expedida pelo Palácio da Presidência em 17 de maio de 1879¹⁰⁹, explicita que as obras deveriam atender ao funcionamento da Repartição, mas sempre com o mínimo de despesas possíveis, dentro de um rígido controle orçamentário e administrativo (Officio n.º 1358, AHWBD, 17/05/1879).

Cada turma de trabalhadores era acompanhada por um apontador, responsável pelo registro da frequência, controle das tarefas e repasse das informações ao administrador. A organização geral ficava a cargo de um administrador, que supervisionava as turmas, distribuía as atividades, fiscalizava as obras e mantinha comunicação com o inspetor – em alguns casos, proprietário do sítio ou engenho onde funcionava o núcleo – e com as comissões de socorros. O administrador contava com o auxílio de um ajudante, encarregado da organização dos trabalhos e do controle de materiais e ferramentas, além de um ajudante geral, responsável pelo apoio operacional.

Nos vários cargos públicos criados no período da seca, encontramos, na Comissão de Pagadoria de Trabalhadores¹¹⁰, informações sobre os contratos e pagamentos daqueles que compunham as turmas empregadas em obras públicas. Entre os dados repassados pelo pagador

¹⁰⁹ Officio n.º 1358. 17 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹¹⁰ Pagadoria dos Trabalhadores Retirantes na Capital da Parahyba. 24 de setembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Manoel Coelho Bandeira de Mello a dois deputados provinciais e também membros da Comissão Central de Socorros, Antonio Manoel de Aragão e Mello e Manoel Pedro Cardoso Vieira, que mais tarde levaria essas discussões às sessões do Legislativo Geral, voltadas especialmente às quantias orçamentárias recebidas pela Parahyba, consta que as folhas dos trabalhadores “não forão pagas em virtude de Vossa Excelência” (Pagadoria dos Trabalhadores, AHWBD, 24/09/1878).

Ele também esclarece que os gastos com a obra da estrada do Gramame somaram 155\$000 (cento e cinquenta e cinco mil réis), referentes à compra de areia e cal. O que chama atenção, no entanto, é o fato de o pagador deixar claro que “estas quantias porem não estão documentadas”. Essa ausência de registros formais abre margem para questionamentos sobre como se davam os pagamentos, com que regularidade e em que valores, além de levantar dúvidas sobre os motivos pelos quais essas lacunas aparecem justamente em um setor responsável pelo repasse direto dos recursos aos trabalhadores (Pagadoria dos Trabalhadores, AHWBD, 24/09/1878).

Já a experiência coletiva dos trabalhadores revela que, além do penoso trabalho desenvolvido no “serviço de lavoura dos retirantes agasalhados”, questões relacionadas aos cuidados pessoais e ao desempenho das tarefas foram expostas no ofício¹¹¹ enviado pelo inspetor do Sítio Alagoas ao presidente da província, Dr. Ulysses Vianna.¹¹²

Localizado na zona rural de Mamanguape, o inspetor reclama da má qualidade das ferramentas fornecidas pelo governo, muitas “de sobremodo insuficiente para o trabalho, em relação ao numero de individuos, soffrendo muito com esta deficiencia e andamento do trabalho, acha-se a mór parte d’ella estragada e outra já inutilizada, de maneira a prestar-se com pouco resultado” (Officio do Sítio Alagoa, AHWBD, 22/10/1878).

Entre as solicitações, estão novos instrumentos para a execução de serviços de limpeza e preparo da terra, que incluíam a derrubada e a roçagem do mato para implantação de lavouras, indicando tratar-se de um trabalho urgente, realizado para aproveitar o período agrícola favorável, provavelmente pela expectativa de algum indício de chuvas, evitando atrasos que pudessem comprometer a colheita. O inspetor também solicita, com urgência,

¹¹¹ Ofício do Sítio Alagoa, 22/10/1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹¹² Natural de Pernambuco, integrou o quadro de bacharéis em Direito formados pela Faculdade do Recife, concluindo seus estudos em 1870. Antes de chegar à presidência da Província da Parahyba do Norte, construiu uma trajetória política vinculada à sua província de origem, exercendo mandatos como deputado provincial e deputado geral, além de atuar na imprensa, espaço a partir do qual também interveio nos debates públicos do período. Sua nomeação para a presidência da Parahyba ocorreu em 1878, no contexto da ascensão dos liberais ao poder, inserindo-o entre os administradores imperiais responsáveis pela condução da província em um momento de fortes tensões políticas e sociais (Silva, L., 2021, p. 66, *apud A Província*, 12 set. 1911).

roupas para as 375 pessoas ocupadas no sítio, afirmando que é “muito escasso o suprimento” feito pela comissão de socorros e que, quando chegam, são insuficientes: 50 fardos para os homens e 100 para as mulheres.

Segundo ele, a justificativa para essa distribuição foi “preferidos os mais necessitados na ocasião”, mas, ainda assim, muitos continuam “carecidas instantemente deste auxílio do governo”. Ao encerrar o pedido, agradece ao presidente, reconhecendo que ele “tem demonstrado pela acomodação e conforto destes infelizes flagelados pela seca, se designará de providenciar com urgência” (Offício do Sítio Alagoa, AHWBD, 22/10/1878).

Esse quadro de tensões não era exclusivo da Parahyba, como mostra Ana Karine Martins Garcia ao analisar a seca de 1877-1879 no Ceará. Segundo a autora, a entrega de alimentos e o pagamento dos salários aos trabalhadores ocorriam em um ambiente marcado por vigilância e tensão. O descontentamento com alguns comissários, motivado por atrasos na remuneração e na distribuição de mantimentos, “acirrava as relações entre emigrantes e governo”, o que levou o poder provincial a adotar medidas de fiscalização para evitar manifestações e conflitos (Garcia, 2006a, p. 97-98).

O medo de reações dos colonos fazia com que os administradores estivessem “sempre [...] cercados por proteção policial, principalmente no momento em que era realizado o pagamento e a entrega de alimentos” (Garcia, 2006a, p. 98). Essas medidas visavam conter motins e episódios de violência, frequentemente desencadeados por demissões motivadas por má conduta no trabalho, mas também revelam o clima de desconfiança e controle que permeava a relação entre as autoridades com os trabalhadores.

Como já discutido, grande parte da população alocada nos núcleos coloniais trabalhava em obras públicas, especialmente na construção de estradas, mas também podia desempenhar outras funções, como os que estavam “ocupados no aterro do Cemiterio da Cruz do Peixe”¹¹³ ou aqueles encarregados da “condução de cadáveres para os cemitérios” e do transporte de enfermos para os hospitais emergenciais da época (*O Liberal Parahybano*, 02/08/1879, n.º 37, p. 2). Também recebiam salários para atuarem na carga e descarga de gêneros alimentícios (Gabinete da Comissão Central de Socorros, AHWBD, 30/11/1877).

Para além das atividades desempenhadas pelos trabalhadores nos núcleos coloniais e nas obras públicas, torna-se fundamental observar quem eram esses sujeitos afetados pela seca e pela política de socorros. Dessa forma, o deslocamento do olhar para os perfis dos trabalhadores permite compreender de forma mais precisa a composição social dessa mão de

¹¹³ Repartição de Socorros Públicos Parahyba. 15 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

obra: suas origens, os fluxos migratórios acionados pela crise e as características gerais dessa população. A análise das listas e relações de trabalhadores possibilita, ainda que de modo parcial, identificar padrões de procedência e circulação, evidenciando como a seca de 1877–1879 reorganizou mobilidades internas e concentrou contingentes populacionais em determinados espaços da província.

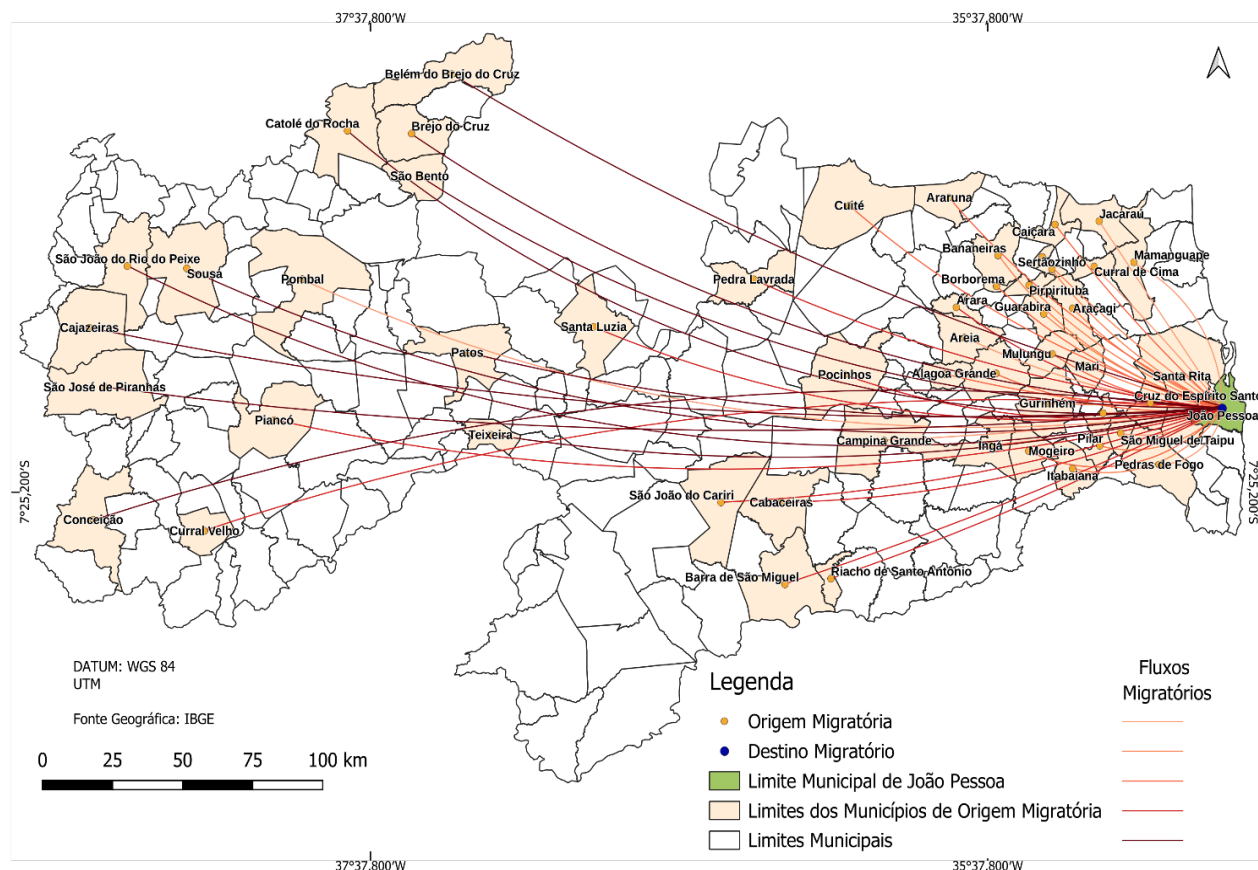
Das listas ou relações de turmas de trabalhadores catalogadas por nós, dez contêm informações relevantes sobre a identidade desses migrantes, ao menos parte deles, já que alguns não estavam ocupando nenhum posto de trabalho.

Ao todo, foram identificados 50 municípios de origem, entre eles: Alagoa Grande, Alagoa Nova, Arara, Araruna, Araçagi, Bananeiras, Barra de São Miguel, Belém do Brejo do Cruz, Borborema, Brejo do Cruz, Cabaceiras, Caiçara, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Conceição, Cruz do Espírito Santo, Curral de Cima, Curral Velho, Cuité, Guarabira, Guirinhém, Ingá, Itabaiana, Jacaraú, Mamanguape, Mari, Mogeiro, Mulungu, Patos, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Pilar, Pirpirituba, Pocinhos, Pombal, Riacho de Santo Antônio, Santa Luzia, Santa Rita, São Bento, São João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, São Miguel de Taipu, Serra da Raiz, Sertãozinho, Sobrado, Sousa e Teixeira.

Para melhor compreender a distância percorrida por essas famílias e a dimensão de seus deslocamentos, elaboramos um mapa que ilustra a amplitude dos fluxos migratórios registrados nas documentações, permitindo vislumbrar os desafios enfrentados por esses grupos durante o trajeto, marcado por longas distâncias, condições precárias de transporte e escassez de recursos.

O mapa abaixo evidencia os fluxos migratórios internos na província da Parahyba do Norte em 1879, mostrando a concentração de deslocamentos de trabalhadores empregados em obras públicas rumo à Cidade da Parahyba. As linhas vermelhas indicam a trajetória de migrantes oriundos de diferentes municípios, já citados, que convergiam para a Capital. A concentração das setas na região litorânea, sugere a centralização das oportunidades de trabalho e auxílio nas frentes de obras públicas ali instaladas, bem como o papel da Cidade da Parahyba (Capital) como polo de atração para a população migrante em situação de vulnerabilidade.

Figura 2 – Mapa dos Fluxos Migratórios dos Trabalhadores Empregados em Obras Públicas na Parahyba (1879)



Autores: ANDRADE, Iris Laryssa S.; BRASIL, Rayane.

Fonte: Mapa elaborado por Iris Laryssa S. Andrade e Rayane Brasil, a partir de dados extraídos de 10 *Relações de Trabalhadores Retirantes Empregados em Obras Públicas na Parahyba do Norte (1879)*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062, utilizando o *software QGIS*¹¹⁴.

Da mesma forma que existiam o fluxo de pessoas vindas do Ceará para a Parahyba, também ocorria o movimento inverso e, de modo semelhante, deslocamentos para outras províncias vizinhas. Márcio Douglas de Carvalho e Silva, em sua investigação sobre as relações entre deslocamentos populacionais, doenças e estratégias de sobrevivência no contexto da seca de 1877-1879, tem como foco os registros de internados na Santa Casa de Misericórdia de Teresina. Pela análise da lista de internados no ano de 1879, “identificou-se

¹¹⁴ O mapa foi elaborado no *software QGIS*, utilizando como base cartográfica os limites municipais fornecidos pelo IBGE (projeção *WGS 84 – UTM*). Foram inseridos os pontos correspondentes às origens migratórias a partir da tabulação dos dados extraídos das listas de trabalhadores. As linhas de fluxo foram traçadas para representar a ligação entre cada município de origem e o destino migratório, que no período correspondia à Cidade da Parahyba – denominação histórica da atual João Pessoa. Considerando que o *shapefile* (formato de base de dados geoespaciais) reflete a divisão político-administrativa contemporânea, a representação cartográfica é aproximada e não reproduz fielmente os limites municipais existentes em 1879.

uma grande presença de cearenses, contabilizando os dados expostos” (Silva, M., 2024a, p. 17).

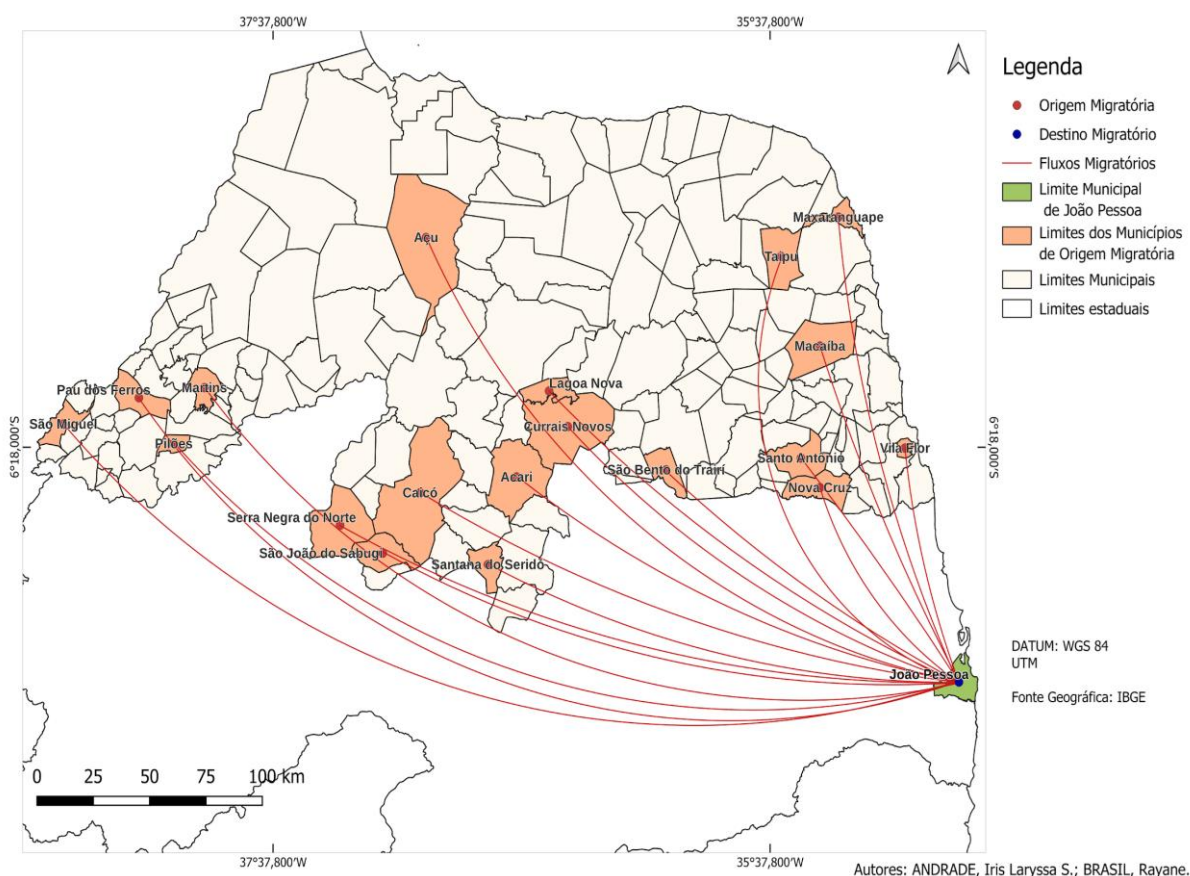
Embora a migração para o Piauí tenha sido numericamente pouco expressiva, “houve a internação: dos paraibanos João Antonio Liandro e Luís Ribeiro de Sousa, ambos com 20 anos, diagnosticados com febre intermitente, ficando o primeiro sob os cuidados da instituição por 23 dias e o segundo por 20 dias” (Silva, M., 2024a, p. 21), evidenciando que, mesmo em menor escala, uma parte da população da Parahyba também buscou assistência médica e alimentar no Piauí.

No caso das documentações analisadas, observa-se que, parte dos migrantes também realizou migração inter-regional, com registros em municípios como Trairi, no Ceará; Água Doce, no Maranhão; Maraú, na Bahia; e Timbaúba, em Pernambuco. Esses casos, embora pontuais, indicam que o deslocamento não se restringiu apenas às áreas mais próximas.

Mas, boa parte era oriunda de diferentes municípios do Rio Grande do Norte, totalizando 19 localidades: São Miguel, Pau dos Ferros, Pilões, Martins, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Caicó, Açú, Santana do Seridó, Acari, Currais Novos, Lagoa Nova, São Bento do Trairi, Taipú, Maxaranguape, Maíca, Santo Antônio, Nova Cruz e Vila Flor.

O mapa abaixo exemplifica os fluxos migratórios provenientes do Rio Grande do Norte com destino à Capital da Parahyba em 1879, destacando-se como parte das migrações interprovinciais registradas durante a seca de 1877-1879. As setas mostram a chegada de trabalhadores de diferentes municípios potiguares, desde o Alto Oeste, como São Miguel e Pau dos Ferros, passando pelo Seridó, com localidades como Caicó, Acari e Currais Novos, até áreas próximas ao litoral, como Vila Flor, Nova Cruz e Maxaranguape. A variedade espacial dessas origens indica que a crise afetou amplamente o território potiguar, impulsionando deslocamentos de longa distância, como podemos ver abaixo.

Figura 3 – Mapa dos Fluxos Migratórios dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte Empregados em Obras Públicas na Parahyba do Norte (1879)



Fonte: Mapa elaborado por Iris Laryssa S. Andrade e Rayane Brasil, a partir de dados extraídos de 10 *Relações de Trabalhadores Retirantes Empregados em Obras Públicas na Parahyba do Norte (1879)*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062, utilizando o *software QGIS*¹¹⁵.

Vemos, portanto, que as colônias agrícolas desempenhavam um papel muito mais amplo do que o de simples espaços de assistência destinados a abrigar milhares de famílias migrantes. Sua complexa funcionalidade envolvia a constituição de redes de sociabilidade marcadas pela convivência entre indivíduos de diferentes localidades, pela reorganização das relações familiares e comunitárias e pela produção de experiências comuns de trabalho, vigilância e disciplina. Esses espaços articulavam uma política voltada ao controle das

¹¹⁵ O mapa foi elaborado no *software QGIS*, utilizando como base cartográfica os limites municipais fornecidos pelo IBGE (projeção *WGS 84 – UTM*). Foram inseridos os pontos correspondentes às origens migratórias a partir da tabulação dos dados extraídos das listas de trabalhadores. As linhas de fluxo foram traçadas para representar a ligação entre cada município de origem e o destino migratório, que no período correspondia à Cidade da Parahyba denominação histórica da atual João Pessoa. Considerando que o *shapefile* reflete a divisão político-administrativa contemporânea, a representação cartográfica é aproximada e não reproduz fielmente os limites municipais existentes em 1879.

condutas morais, à normatização dos modos de vida e à defesa de interesses econômicos específicos, entre eles, o objetivo explícito de “ocupar os braços ociosos”.

Não se tratava apenas de oferecer abrigo, moradia ou alimentos, mas de instaurar uma lógica de troca: em contrapartida ao socorro, esperava-se disciplina, submissão às regras, adesão ao trabalho e adaptação a um modo de vida considerado adequado pelas autoridades. A experiência cotidiana nesses núcleos era, assim, atravessada por tensões, aprendizagens forçadas e estratégias de sobrevivência, nas quais o trabalho assumia centralidade não apenas como meio de subsistência, mas como critério de distinção moral e social.

Nesse sentido, a vivência entre as turmas de trabalhadores remete ao que E. P. Thompson identificou como parte de um processo mais amplo de reestruturação disciplinadora das relações de trabalho, baseado na criação de “novos estímulos e de uma nova natureza humana em que esses estímulos atuassem efetivamente” (Thompson, 2005, p. 269). É partir desses desdobramentos que se inserem os debates sobre a mão de obra livre e o ensino agrícola, difundidos pelo Congresso Agrícola do Recife, em 1878, apresentados como soluções para a crise do trabalho, para a reorganização da produção e para a formação de trabalhadores considerados úteis, disciplinados e adaptados às exigências de uma economia em transformação.

2.2.1 “FAÇA-SE DESAPARECER A FEBRE-AMARELLA, A BÉRI-BÉRI”: OS CONGRESSOS AGRÍCOLAS DE 1878 E O ENSINO AGRÍCOLA NA PARAHYBA DO NORTE

No ano de 1878, em meio à crise provocada seca no Norte do Império e às crescentes tensões em torno da substituição do trabalho escravizado (intensificadas após a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871), dois congressos agrícolas foram realizados no Brasil. O primeiro ocorreu em junho, na Corte, promovido pelo governo imperial sob liderança do ministro João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu¹¹⁶, e concentrou-se nas demandas da cafeicultura das províncias do Sul e Sudeste, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas

¹¹⁶ Mais conhecido como Visconde de Sinimbu. Além de político, magistrado e diplomata brasileiro, foi presidente do Clube da Reforma. Sobre ele recaía a responsabilidade de implementar as reformas preconizadas pelo Partido Liberal e esvaziar a propaganda da república (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, VI). Natural de Alagoas, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e teve destacada carreira no Império, ocupando cargos como presidente de província, ministro de Estado e senador do Império (Ribeiro, 2018, p. 248-249).

Gerais e Espírito Santo. As discussões giraram em torno da transição da mão de obra escravizada para o trabalho livre, da educação agrícola e da imigração europeia.

A introdução de José Murilo de Carvalho à edição *fac-similar* dos Anais do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro de 1878¹¹⁷ destaca que o evento reuniu, pela primeira vez, grandes proprietários em diálogo direto com o governo imperial, sem mediação parlamentar. Realizado num momento de impasse para o setor agrário, o congresso refletia as incertezas causadas pela crise da mão de obra escravizada, intensificada após a Lei do Ventre Livre (1871), e a falta de alternativas viáveis para sua substituição. Nem o regime escravista, nem o trabalho livre — nacional ou imigrante¹¹⁸ — apresentavam, naquele momento, soluções imediatas (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, V).

Existia uma série de dúvidas sobre o custo e a autonomia que os trabalhadores europeus teriam; também havia a desconfiança e o discurso formado em torno dos trabalhadores nacionais, vistos como instáveis, pouco afeitos à disciplina do trabalho permanente e propensos à mobilidade; por fim, havia ainda a rejeição política e cultural aos imigrantes asiáticos. Soma-se a isso a fragilidade financeira da agricultura, marcada por dívidas internas e externas, agravadas pela seca de 1877 no Norte e pelas consequências da Guerra do Paraguai.

Desde 1873, o governo tentava oferecer crédito agrícola via Banco do Brasil, com apoio de uma lei de 1875 que previa a criação de bancos rurais e subsídios a juros, mas as medidas fracassaram no meio cafeeiro (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, V). No plano político, a monarquia enfrentava desgaste, e o Partido Republicano ganhava força no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O retorno dos liberais ao poder em 1878, após uma década de domínio conservador, reforçou a pressão para agradar à elite rural. Sinimbu, enquanto ministro da Agricultura, convocou o congresso como estratégia para esvaziar a propaganda republicana, consultando diretamente os grandes lavradores do Sul. A convocação restringiu-se às províncias do Rio de

¹¹⁷ CARVALHO, José Murilo de. Introdução. In: Congresso Agrícola do Rio de Janeiro (1878). **Anais do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878. p. v-ix.

¹¹⁸ A maioria dos congressistas defendia a imigração europeia como alternativa “civilizada” e mais próxima dos valores defendidos pelas elites escravistas, embora temessem que esses trabalhadores buscassem a posse da terra posteriormente. Já a proposta do ministro Sinimbu de utilizar trabalhadores asiáticos como solução provisória enfrentou forte resistência, sendo rejeitada com base nos preconceitos raciais, culturais e morais. Muitos delegados e políticos alegavam que “Nem como machinas de trabalho e esgotados que sejam todos os recursos [...], podemos admittir a aquisição do homem asiatico conhecido com o nome de *Coolies*. Fracos e indolentes por natureza, alquebrados pela depravação dos costumes e hábitos que desde o berço adquirem, narcotizados physica e moralmente pelo ópio, não poderão nunca no Brazil supportar o arduo e penoso trabalho da cultura do café” (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, p. 39).

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, sob justificativa “prática”, mas refletindo a exclusão deliberada do Norte (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, VI).

Composto em sua maioria por cafeicultores do Vale do Paraíba, Zona da Mata mineira e Oeste Paulista. Poucos senhores de engenho do Norte Fluminense participaram, mas sem possuir grande peso político. O discurso de abertura de Sinimbu enfatizou a lavoura como base do progresso nacional e a necessidade de reconstruí-la com trabalho livre, livre também do “predomínio do Estado, ao crescimento da autoridade em detrimento da liberdade” (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, VII).

A convocatória e a composição do evento, no entanto, deliberadamente excluíram as províncias do Norte, o que gerou protestos e levou à realização de um segundo congresso, em outubro do mesmo ano, no Recife (PE), articulado pelas elites agrárias nordestinas. Esse segundo encontro teve como objetivo não apenas reagir à exclusão política e econômica da região nos debates nacionais, mas também discutir alternativas para enfrentar a crise da lavoura açucareira, agravada pelos efeitos da estiagem e pela escassez de mão de obra.

Para José Murilo de Carvalho, o Congresso Agrícola do Recife pode ser definido através de duas características: a primeira, é o descontentamento com o Governo Imperial, acusado de favorecer os interesses dos grandes proprietários do Sul, especialmente do Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), em detrimento do Norte. Esse ressentimento se manifesta em falas inflamadas durante o congresso, nas quais alguns oradores chegam a comparar a exclusão do Norte da convocatória do Congresso do Rio a episódios históricos de revoltas na província de Pernambuco (como as de 1817, 1824 e 1848). Já a segunda, escancara as limitações estruturais da economia agroexportadora nortista no final do século XIX, pressionada pela crise do trabalho escravizado e pela dificuldade de financiamento.

A demanda por repressão à “vadiagem” revela ainda o caráter coercitivo das propostas de reorganização do trabalho rural, que visavam substituir a escravidão por novas formas de controle da força de trabalho (Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, 1878, p. VIII). É a partir dos registros desse congresso que se torna possível examinar as estratégias discursivas e os interesses econômicos mobilizados diante da calamidade, além de compreendermos até que ponto questões como saúde, higiene e bem-estar da população afetada foram efetivamente consideradas, ou pelo menos citadas, nos discursos das elites envolvidas.

Na mesma linha de pensamento, Maria Gareis (1993) identificou nos discursos proferidos no Congresso do Recife que o Nordeste (ou “Norte”, na linguagem da época) é representado como isolado geográfica, econômica e politicamente, o que constitui um dos eixos centrais da retórica regionalista. Essa percepção de isolamento serve como justificativa

política para demandar medidas de apoio estatal e reforçar a ideia de que o progresso da região depende da integração ao modelo sulista.

Ao observarmos como as questões relativas à saúde dos trabalhadores foram incorporadas às pautas do Congresso¹¹⁹, percebe-se uma tentativa de disciplinar e moralizar a população livre pobre, associando a pobreza à ociosidade e à ameaça social, como já apontado anteriormente. Essa perspectiva aparece de forma explícita no parecer do cônego pernambucano Augusto Adolpho Soares Kuswetter¹²⁰, que defende uma concepção pragmática de saúde e higiene, subordinada à lógica do trabalho e da regeneração moral. Além disso, o autor sustenta que o enfrentamento da escassez de mão de obra dependia fundamentalmente da ação do governo, que deveria estimular os lavradores e trabalhadores considerados “de mérito”, ao mesmo tempo em que combatia a ociosidade, os vícios e a vadiagem.

Dentro desse raciocínio, a saúde aparece como um elemento secundário: “Faça-se desaparecer a febre-amarella, a béri-béri, etc., por meio de arborização e limpeza. Plante-se em grande quantidade o eucaliptus e o gyrasol”. Também afirma que é necessário que “Melhore-se a edificação relativamente à hygiene. Façam-se estradas. Haja maior garantia de vida e propriedade e moralise-se o povo, que virá espontaneamente a emigração e o país prosperará” (Congresso Agrícola do Recife, 1879, p. 240).

Essas afirmações revelam com clareza que, para o cônego Kuswetter, a saúde e a higiene eram úteis à construção de um ambiente moralmente regrado, economicamente produtivo e apto a atrair imigrantes. O bem-estar físico aparece vinculado à ideia de “civilização e progresso”, e não como uma preocupação humanitária com os efeitos da seca ou da miséria sobre a população afetada.

Outra proposta bastante discutida no Congresso, que também está relacionada com a saúde, foi a implementação do ensino agrícola e primário obrigatório, que aparece como uma forma de moldar sujeitos úteis ao trabalho, mais do que uma preocupação com a formação intelectual ou desenvolvimento profissional. Ou seja, o projeto analisado a seguir, revela que uma das soluções defendidas por alguns congressistas foi a criação de colônias destinadas a abrigar ingênuos – filhos de mulheres escravizadas nascidos após a Lei do Ventre Livre –,

¹¹⁹ KUSWETTER, A.A.S. Parecer sobre a agricultura de Pernambuco oferecido ao Congresso pelo Revmº Cônego Augusto Adolpho Soares Kuswetter. In: **Trabalhos do Congresso Agrícola do Recife**, 1878. Edição *Fac-Similar* reproduzida do original publicado em 1879 pela Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco. p. 237-243.

¹²⁰ A única informação encontrada por nós sobre o cônego era que fazia parte da Sociedade Auxiliadora de Agricultura da Província de Pernambuco.

órfãos e libertos. Na realidade, seriam espaços de controle e disciplinamento social, nos quais se buscava educar e formar futuros trabalhadores livre para atender às demandas da lavoura.

Com o título um tanto chamativo: *Projeto Colônia Agrícola Industrial – Auxílio Mútuo – Entre Proletários, Seus Filhos e os da Mulher Escrava*, apresentado pelo engenheiro geometra, Joaquim Alvares dos Santos Souza¹²¹ (Congresso Agrícola do Recife, 1879, p. 294), a colônia é representada como uma “missão especial” de aproveitar e tornar produtores todos os indivíduos ociosos, incluindo proletários e filhos de mulheres escravizadas. Além de enquadrar a mão de obra para ser “corrigida” e inserida na lógica do trabalho agrícola, industrial e artesanal, vemos uma forte insistência na ideia de “aproveitamento”, na tentativa de esvaziar qualquer direito e assistência social, já que o maior objetivo é de transformar o “ocioso” em trabalhador útil.¹²²

Já a saúde aparece, mais uma vez, como instrumento para manter a força de trabalho, é o que expõe a seção sobre o *médico* (capítulo 3), com sua função principal de dirigir o serviço médico da colônia, com foco nas enfermarias e em casos de necessidade. Suas obrigações incluem cumprimento de ordens, registro de entradas e saídas de doentes, distribuição de remédios e produção de estatísticas sobre a situação das colônias. Não há qualquer proposta mais ampla de medidas de higiene, saneamento, alimentação adequada ou atenção à saúde como direito. O cuidado médico se restringe aos limites da colônia e aos indivíduos selecionados como aptos para o trabalho. Trata-se de uma saúde funcionalizada.

Antes mesmo de ganharem força nas discussões do Congresso, propostas como essa apresentada, já apareciam em momentos anteriores. Na Parahyba, antes mesmo da seca de 1877, houve tentativas semelhantes, como a introdução de um sistema educacional agrícola, em resposta à intensificação do envio de pessoas escravizadas para as províncias cafeeiras. Já em meados da década de 1850, surgiram iniciativas voltadas à introdução do trabalho livre e assalariado.

Durante a administração de Henrique de Beaurepaire Rohan, em 1857, foi apresentado à Assembleia Legislativa um plano para suprir a crescente escassez de trabalhadores nas atividades agrícolas e pecuárias (Galliza, 1979, p. 126). A proposta incluía a criação de colônias e o incentivo ao ensino agrícola, como forma de enfrentar os entraves da lavoura, marcados pela baixa mecanização e pelo uso de instrumentos rudimentares.¹²³ O projeto

¹²¹ Também era membro da Sociedade Auxiliadora de Agricultura da Província de Pernambuco.

¹²² O projeto também menciona que ser cego, aleijado, mudo ou surdo não inabilita o indivíduo a participar da colônia (Congresso Agrícola do Recife, 1879, p. 294).

¹²³ Em 1852, a Parahyba registrou algumas tentativas de modernização das atividades agrícolas, como a introdução do arado de ferro – mais durável e de uso mais simples. Também trouxe “de Pernambuco um

começou a ser implementado com a inauguração do Jardim Botânico, na Capital, pensado como espaço de formação técnica.

Apesar disso, a iniciativa não avançou como previsto, e o jardim passou a exercer a função que mantém até hoje, sem se consolidar como uma escola agrícola.¹²⁴ Buscava-se também integrar a população pobre e livre ao mercado de trabalho, diante da diminuição da mão de obra cativa provocada pela Lei do Ventre Livre e pelo tráfico interprovincial.

Nesse contexto, tornava-se, segundo Lima (2011, p. 456), “necessário transformá-los em mãos de obra diligente. [...] combinando-se a propagação de uma nova pedagogia em torno do trabalho, a ser internalizada pelo trabalhador, e a repressão àqueles que não moldassem a essa nova moral”. Essas medidas mostram que, mesmo antes da abolição, já se articulavam estratégias de disciplinamento do trabalho livre, revelando uma preocupação das elites em manter a ordem social diante da transição gradual do modelo escravista.

A proposta foi retomada em 13 de novembro de 1878, quando a Comissão de Socorros da comarca de Sousa, composta pelo juiz de direito Manuel Barata de Oliveira Mello, pelo médico encarregado Dr. Fausto Nominando Meira de Vasconcellos e pelo vigário José Antônio da Silva Genuíno Ramos encaminhou ao presidente da província, Dr. Ulysses Vianna, um detalhado relato sobre a situação da população sertaneja diante da seca de 1877-1879. Primeiro, o documento¹²⁵ evidencia o esgotamento dos recursos locais e a intensificação da miséria, apontando as múltiplas dimensões da crise.

Segundo o relato da Comissão, “a frota da população, que tirava a sua subsistência da ração de gados e da produção da sua indústria agrícola, atônita e desorientada pela seca emigrou em sua maioria procurando o litoral, Cariri-Novo e margem dos grandes rios”, mas as esperanças foram frustradas, pois “dali tem sido repelida pela peste, pela escassez de

escravo pratico na plantação da canna”, e contratou engenheiros para aprimorar o desempenho das máquinas movidas à roda d’água. Embora essas medidas indicassem esforços pontuais de inovação, nenhuma delas se consolidou como uma política de continuidade, muito menos produziu resultados expressivos, revelando, assim, um quadro de estagnação tecnológica e de permanência das condições precárias no trabalho agrícola (Parahyba do Norte, Relatório, 1852, p. 25).

¹²⁴ Apesar da tentativa frustrada de se implantar o ensino agrícola, a criação da Escola de Educandos Artífices, em 1868, evidencia outra iniciativa voltada à formação para o trabalho. A proposta tinha como finalidade afastar crianças e adolescentes órfãos da marginalidade, inserindo-os no mercado por meio da profissionalização. No entanto, o projeto não teve continuidade, sendo extinto já em 1870. Além disso, durante o século XIX, foram criadas na Paraíba nove Casas de Caridade, entre elas a comandada pelo Padre Ibiapina, com o intuito de ajudar a população afetada pela epidemia de cólera *morbus* em 1860 (Sá, 2009, p. 75). Tais iniciativas reforçam o papel das instituições religiosas e do Estado na tentativa de moldar comportamentos sociais por meio do trabalho e da assistência. Para mais informações sobre a Escola de Educandos Artífices, consultar: LIMA, Guaraciane Mendonça de. **O Collegio de Educandos Artífices 1865-1874: a infância desvalida da Parahyba do Norte**. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.

¹²⁵ Comarca de Souza. 13 de novembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

recursos, quando não ceifada na grande maioria pela morte” (Comarca de Souza, AHWBD, 13/11/1878). O registro revela que a migração, vista inicialmente como uma saída, expôs a população migrante a novas ameaças, epidemias, fome e violência, comprometendo a sobrevivência e levando muitos a retornarem para o sertão.

Esse retorno, de “muitas famílias horrivelmente dizimadas e no mais lamentável estado”, entretanto, não representou melhora nas condições de vida. Pelo contrário, “[...], a confiança no governo e mil e outras relações a atraíam, têm não agradado amargas decepções e outras encontrado a morte depois de haverem percorrido toda escala da dor e descido até o último degrau da objeção” (Comarca de Souza, AHWBD, 13/11/1878). A fala da Comissão articula um diagnóstico de frustração e perda, em que tanto a confiança depositada no governo quanto às expectativas climáticas não se concretizaram, deixando a população sem alternativas.

O documento também aponta para um quadro de degradação social: o sertão, “pela algidez da morte e pela contaminação dos muitos vícios, de que só a miséria tem o segredo, se estorce nas convulsões da depredação da fome, da peste e da morte” (Comarca de Souza, AHWBD, 13/11/1878). Essa descrição sugere que, além das doenças e da carência alimentar, havia uma concepção moralizante sobre os comportamentos resultantes da penúria, associando a miséria ao crescimento da criminalidade e da mendicância.

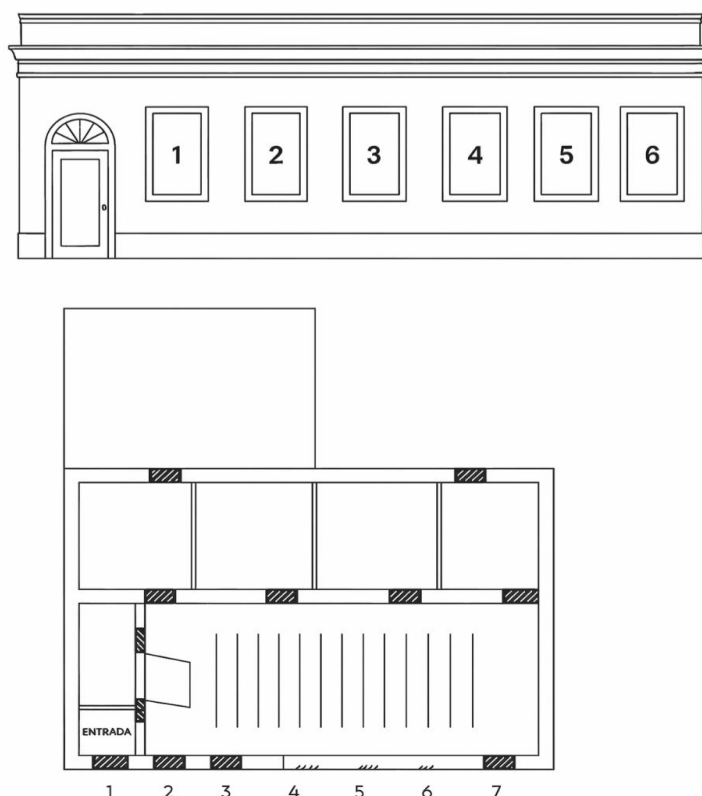
Ao final dessa diagnose sobre a situação enfrentada pela Comarca de Sousa, a Comissão faz um apelo ao presidente para “empregar a população válida em alguma obra de utilidade pública [...], sendo para isto necessário algum dinheiro, além de gêneros, para a compra de materiais”. No entendimento da comissão, a obra mais urgente era a construção de uma escola pública para o sexo masculino, visto que a atual se encontrava em condições “miseráveis” e “em ruína”. Para tal, chegou-se a contratar a compra de um terreno pelo valor de 400\$000 (quatrocentos mil-réis) (Comarca de Souza, AHWBD, 13/11/1878).

Não há, no documento, menção explícita de que essa escola teria finalidade agrícola. Contudo, a proposta se insere em um contexto mais amplo, já discutido anteriormente, de incentivo ao ensino agrícola como estratégia de disciplinamento e formação de mão de obra, especialmente durante e após a seca¹²⁶, como também em meio às discussões do Congresso Agrícola do Recife. Assim, ainda que não seja possível afirmar categoricamente que a planta

¹²⁶ Segundo Irineu Joffily, nos municípios do Sertão, como Cajazeiras e Sousa, conhecidos pelo desempenho em papéis relevantes na economia e pela presença de instituições de ensino que atraíam estudantes de outras províncias vizinhas, entraram em retração e deixaram de ocupar a posição de destaque que mantinham até então (Joffily, 1892, p. 192-193).

enviada visava a criação de uma escola agrícola, sua concepção dialoga com práticas e projetos semelhantes adotados em outros momentos e localidades, nos quais a instrução formal e a aprendizagem agrícola se articulavam como instrumentos de reorganização social e econômica. Vejamos, a seguir, a planta desenhada e enviada pela comissão.

Figura 4 – Planta da Escola Pública Proposta pela Comissão de Socorros de Sousa (1878)



Fonte: A imagem, adaptada por nós, corresponde à planta presente no documento original da Comarca de Sousa (AHWBD, 13/11/1878)¹²⁷.

Desse modo, a proposta da Comissão de Sousa de erguer um edifício para a instrução, acompanhada da planta detalhada, revela a intenção de estruturar um espaço formal para o ensino do município. Ainda que o documento não explicita o tipo de educação a ser oferecida, o contexto do período, também faz parte de uma estratégia para regenerar as populações afetadas pela seca e integrá-las a um projeto de desenvolvimento econômico, principalmente com o avanço das causas abolicionistas permite situar essa iniciativa entre as práticas de auxílio que buscavam combinar socorro imediato e formação produtiva.

¹²⁷ A digitalização foi realizada a partir de fotografia do documento original. As correções e complementações visuais, como o acréscimo de números incompletos e a indicação da entrada, foram feitas com o auxílio da ferramenta *ChatGPT*, a partir de coordenadas e orientações fornecidas **por nós**, responsáveis pela definição dos elementos inseridos na imagem final.

Encontramos ainda outra iniciativa mais direcionada, encaminhada¹²⁸ ao governo provincial por João Antônio Gomes, morador no termo de Pedras de Fogo. Ele oferece “a propriedade Gramame de Baixo, ou Gramame de Bulhões distante da Villa de Pedras de Fogo duas legoas, a qual tem proporção para uma Colonia de cinquenta familias” (Villa de Pedras de Fogo, AHWBD, 22/08/1879). É possível identificar que a proposta é bastante parecida com as que foram apresentadas no Congresso Agrícola do Recife (1878), como a de Pernambuco, que trouxemos à análise.

Entre as condições apresentadas, destaca-se que, “findo o tempo, que o governo indicar terão os colonos mais quatro anos de moradia gratis em seos lugares, sem pagarem renda em ano algum”. A proposta também previa a presença de “duas pessoas habilitadas para lecionar primeiras letras, uma do sexo masculino e outra do feminino”, encarregadas de “ensinar a ler, escrever, contar e a doutrina christã” e de apresentar mensalmente ao administrador um relatório do estado do ensino (Villa de Pedras de Fogo, AHWBD, 22/08/1879).

Além disso, o plano incluía “uma pequena ambulancia de medicamentos homeopathicos” (Villa de Pedras de Fogo, AHWBD, 22/08/1879), a ser administrada pelo próprio responsável pela colônia e abastecida pelo governo, que poderia fiscalizar o local “por quem lhe aprover”. A proposta, datada de 22 de agosto de 1879, evidencia como os projetos coloniais combinavam objetivos de fixação da mão de obra, instrução básica, assistência médica e vigilância socio-administrativa, articulando dimensões produtivas, educativas e de controle social em um mesmo espaço.

2.3 “NUNCA CHEGOU [...] RELAÇÃO ALGUMA DAS PESSOAS QUE TEM RECEBIDO SOCORROS”: AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO NO CONTEXTO DA SECA

Para Lúcia de Fátima Guerra Ferreira (1993, p. 15), a problemática da seca pode ser interpretada por várias vertentes, entre elas, a da *estrutura de poder*, que permite compreender a “permanência das secas como calamidade pública”. Ao analisar os mecanismos elaborados para enfrentar esse quadro, a autora identifica cinco sistematizações presentes na historiografia, responsáveis por definir as fases e as principais soluções propostas para o combate à seca.

¹²⁸ Villa de Pedras de Fogo. 22 de agosto de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

A primeira fase, de *caráter humanitário*, correspondeu às medidas emergenciais de socorro, enquanto sua solução privilegiava a dimensão *hidráulica*. Em seguida veio a fase de *reconhecimento*, marcada pela abertura de estradas como estratégia de ocupação e integração territorial. A terceira fase, denominada *intervenção*, relacionou-se a propostas de caráter *ecológico*. Já a fase de *diferenciação* esteve associada às práticas do *dry-farming* (cultura seca). Por fim, a quinta fase, de *integração*, articulava-se a uma solução *composta*, que buscava reunir diferentes iniciativas em um mesmo plano de ação (Guerra, 1993, p. 15–16).

Segundo a autora, as duas primeiras fases foram as mais utilizadas entre 1877 e 1922, seja nas iniciativas de construção de açudes ou na abertura de vias de comunicação. Para a análise deste trabalho, constatamos que a fase *humanitária* foi marcada por disputas, saques e desvios, aspectos que serão discutidos neste subtópico, enquanto a solução *hidráulica* será retomada no último capítulo.

Além disso, as políticas de assistência criadas para combater os males causados pela seca revelam-se complexas em todas as suas dimensões, inclusive no que se refere às fontes e às abordagens. Por isso, dividimos esta análise em três momentos. Essa opção metodológica se justifica pela necessidade de compreender como diferentes instâncias se articulavam no enfrentamento da crise. Não é possível tratar do principal órgão de assistência criado, a Comissão Central de Socorros Públicos, sem mencionar também as comissões locais que a ela estavam subordinadas.

Da mesma forma, não se pode ignorar a atuação política dos presidentes de província, nem tampouco a conjuntura política em nível nacional, em que se destacaram as deliberações dos deputados eleitos para representar a Parahyba no Parlamento. Esses representantes, ao levarem ao centro do Império as demandas da província, atuavam como mediadores entre o governo central e as realidades locais, influenciando debates e buscando recursos para fortalecer sua base política. Veremos a seguir como a seca foi utilizada como instrumento de poder, regido por interesses e estratégias políticas.

A intensificação da crise provocada pela seca de 1877-1879 exigiu do poder público a formulação de estratégias emergenciais para lidar com a fome, a miséria e a disseminação de doenças. No âmbito político-administrativo, destacou-se a atuação das comissões de socorros, responsáveis por coordenar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à assistência, e ainda pelo envio de verbas para os hospitais e enfermarias provisórias criados para atender os migrantes e a população local em situação de vulnerabilidade

Entre as instituições criadas ou reorganizadas nesse contexto, destacaram-se: o Hospital de Santo Antônio, instalado no convento de São Francisco; o de Nossa Senhora das

Neves, próximo ao Tesouro Provincial; a enfermaria dos Variolosos, situada na Cruz do Peixe¹²⁹; o de São Pedro, em Mamanguape; o da Guia, em Lucena, e os hospitais de Areia, Bananeiras e Santa Rita, que atendiam às vítimas de varíola. Para compreender o alcance dessa rede assistencial, é fundamental observar as condições de funcionamento, frequentemente afetadas pela escassez de medicamentos, vestimentas e suprimentos básicos.

A dependência desses hospitais em relação à Comissão de Socorros pode ser percebida em diversos registros, como no caso do Hospital de Nossa Senhora das Neves. Em correspondência¹³⁰ enviada à administração provincial no final de 1878, registrou-se que, embora houvesse autorização para o fornecimento de roupas destinadas às mulheres e meninas internadas, o envio não se concretizou. A gravidade da situação tornava-se ainda mais evidente quando se observava que “à falta até de camisas, estão [as mulheres] mais sobre os leitos, envolvidas em cobertas somente” (Hospital de Nossa Senhora das Neves, AHWBD, 24/12/1878).

No ano seguinte¹³¹, as dificuldades persistiam. Dois homens receberam alta pelo Dr. Antônio da Cruz Cordeiro, mas não podiam deixar a instituição por não possuírem roupas. Diante disso, o administrador, Dr. José Pereira Maia, solicitou dois pares de vestimentas (duas camisetas e dois calções) e, pouco depois, apresentou novo pedido, solicitando o envio regular de roupas, “visto não poderem sahir pelo estado de nudes em que se achão” (Hospital de Nossa Senhora das Neves, AHWBD, 12/06/1879, 12/07/1879).

Outro caso parecido pode ser observado no Hospital de São Pedro, em Mamanguape, onde a precariedade das condições materiais se apresentava de forma recorrente. Em junho de 1878, a Comissão de Socorros local encaminhou¹³² ao presidente da província uma representação baseada no ofício do administrador do hospital, informando que o estabelecimento mantinha cerca de 260 enfermos, número que se conservava relativamente estável ao longo dos meses. Além disso, parte das camas encontrava-se inutilizada em razão do desgaste das coberturas de lona, apesar de suas armações ainda estarem em bom estado, o que levou a Comissão a sugerir, como medida paliativa, o envio de novas lonas para

¹²⁹ Ocupava o prédio que antes era o Colégio dos Educandos Artificies. Tinha como administrador o Sr. Major Carlos Ribeiro; e como médico, o Dr. Abdon Felinto Milanez (*O Liberal Parahybano*, 14/08/1879, n.º 41, p. 1).

¹³⁰ Hospital de Nossa Senhora das Neves, 24 de dezembro de 1878. N.º93. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

¹³¹ Hospital de Nossa Senhora das Neves em 12 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹³² Comissão da Villa de Mamanguape em 28 de junho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

reaproveitamento da estrutura existente (Comissão da Villa de Mamanguape, AHWBD, 28/06/1878).

Um ano depois, em junho de 1879, a situação não apenas persistia como se agravava. Em novo ofício¹³³ enviado à Comissão de Socorros, a Secretaria do Hospital de São Pedro relatava que as enfermarias estavam completamente lotadas, impossibilitando o acolhimento de novos doentes, e reiterava a falta de camas, lençóis, travesseiros e roupas. Também descreve cenas de extrema precariedade, de alguns enfermos deitados “sobre folhas de bananeiras”, enquanto outros se encontravam “quase que núz e sem uma cobertura”. Na tentativa de amenizar o problema, foi solicitado com urgência tanto a construção de uma palhoça para ampliar o espaço de atendimento quanto o reparo estrutural da enfermaria destinada aos variolosos (Secretaria do Hospital de São Pedro em Mamanguape, AHWBD, 28/06/1879).

Esses registros revelam que, além da falta de itens básicos, parte dos recursos disponíveis encontrava-se deteriorada ou imprópria para uso, ampliando os riscos sanitários em um contexto marcado pela disseminação da varíola, de outras doenças e pela superlotação dos hospitais.

Essas situações são retratadas, mais uma vez, no relato¹³⁴ feito pela Repartição acerca do estado dos objetos e medicamentos provenientes da Colônia e do Hospital da Guia, informando a necessidade urgente de examinar o caixão “a fim de ver-se ha remedios aproveitados”. Outras dúvidas surgiam quanto às condições da carne existente, afirmando que ela “não pode ser distribuida pelo seu mau estado”, sugerindo a realização de uma vistoria para avaliar sua utilização (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 26/12/1878).

Nesse cenário de escassez contínua e dependência direta da Comissão de Socorros, os problemas no abastecimento dos hospitais não se limitaram apenas à falta de recursos, mas passaram a gerar conflitos entre as próprias repartições responsáveis pela assistência. Em março de 1879¹³⁵, o Hospital dos Variolosos tornou-se o centro de uma controvérsia envolvendo a Repartição de Socorros Públicos e a administração provincial. A origem do impasse foi uma representação encaminhada pelo chefe do hospital, na qual se questionava a regularidade dos gêneros alimentícios recebidos pela instituição.

¹³³ Secretaria do Hospital de São Pedro em Mamanguape, 28 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹³⁴ Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 26 de dezembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

¹³⁵ Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 24 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Em resposta, o administrador da Repartição, Manoel Coelho Bandeira de Mello, procurou afastar qualquer responsabilidade sobre eventuais irregularidades. No ofício enviado ao vice-presidente de província, Padre Felipe Benício da Fonseca Galvão¹³⁶ afirma ter acompanhado pessoalmente a entrega das sacas de farinha e arroz, garantindo que se encontravam “perfeitamente regulares” e que o funcionário encarregado do recebimento não apresentara reclamações no momento da entrega. Ao mesmo tempo, ele desloca a possibilidade de extravio ou roubo para a etapa do transporte, sustentando que, caso as sacas tivessem sido subtraídas durante o trajeto, tal ocorrência não poderia ser atribuída à Repartição (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 24/03/1879).

Além disso, ele admite que não era possível medir individualmente todas as sacas recolhidas aos armazéns, recorrendo a um sistema de aferição por amostragem, no qual apenas parte dos volumes era medida, tomando-se uma média para o restante. Essa prática, justificada pela sobrecarga de trabalho e pela urgência das remessas, evidencia o caráter improvisado da logística de abastecimento em meio à crise, abrindo margem para divergências, desconfianças e acusações entre os agentes envolvidos (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 24/03/1879).

Vemos ainda as tensões pessoais e institucionais que emergem quando o chefe da Repartição busca desqualificar as reclamações apresentadas pelo responsável pelo hospital dos variolosos. Ele sustenta que outros estabelecimentos hospitalares da Capital, como o de Nossa Senhora das Neves e o de Santo Antônio, jamais teriam formulado queixas semelhantes, sugerindo que as denúncias partiriam exclusivamente daquele serviço e que tampouco seriam “inéditas” (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 24/03/1879).

Nesse mesmo contexto, ao registrar as requisições frequentes do Hospital de Santo Antônio, o administrador da Repartição¹³⁷ não apenas informa o fluxo de gêneros, mas constrói um argumento destinado a deslegitimar eventuais reclamações futuras da instituição. Ao afirmar que tais remessas “fornecem para aviltar qualquer reclamação”, sugere que o problema não residiria na escassez estrutural, mas no consumo considerado excessivo por

¹³⁶ Foi um político atuante na Província da Parahyba do Norte na segunda metade do século XIX. Exerceu o cargo de vice-presidente da província em diferentes momentos, assumindo interinamente a administração provincial entre fevereiro e junho de 1879 e novamente entre abril e maio de 1880. Além disso, teve longa trajetória como deputado provincial, com mandatos sucessivos desde a década de 1840, o que lhe conferiu papel relevante na condução administrativa e política da província, especialmente nos anos que sucederam a Grande Seca de 1877-1879 (Mariano, N., 2015, p. 297).

¹³⁷ Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 10 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

parte do hospital, ao qual atribui um comportamento “gastador” (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 10/10/1879).

Desse modo, a proposta de limitar as remessas diárias revela uma lógica de contenção e disciplinamento dos gastos, em que a assistência hospitalar passa a ser regulada por critérios administrativos, mesmo diante do avanço de diversas doenças e do alto número de pacientes que necessitavam de tratamento médico (Repartição de Socorros Públicos, AHWBD, 10/10/1879).

Vemos até o presente momento que, a assistência hospitalar, no período da seca, encontrava-se atravessada não apenas pela falta de itens de subsistência, mas também por disputas internas quanto à responsabilidade pelas falhas do sistema. Como por exemplo, o hospital dos variolosos, destinado ao atendimento de uma das doenças mais temidas do período, tornava-se palco de embates administrativos que revelam o esgotamento da rede de socorros públicos e a dificuldade do governo provincial em manter uma atuação coordenada e eficaz diante da persistência dos surtos de varíola e da própria crise social.

Além dos hospitais, as comissões também atuaram nos municípios, coordenando o envio e a distribuição de socorros, um processo que, apesar de planejado, mostrou-se repleto de atrasos e irregularidades. Ao assumir o cargo de presidente de província, em agosto de 1877, o Dr. Esmerino Gomes Parente relatou que “o mal, porém, estendera-se a todo o interior, donde eu recebia instantes reclamações de socorros” (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 39).

Mesmo com as providências já tomadas pelo seu antecessor para o envio de mantimentos a algumas comarcas, como Sousa, Pombal e Piancó, a demanda crescia rapidamente, acompanhada por um expressivo aumento nos preços¹³⁸, o que tornou necessária a adoção de um sistema mais estratégico, tanto em termos de viabilidade geográfica quanto de organização administrativa (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 39).

Como forma de enfrentamento da crise, foram estabelecidos pontos de armazenamento e distribuição em locais considerados estratégicos: a comarca de Pombal, responsável por

¹³⁸ Os comerciantes da Parahyba também foram impactados com dois artigos impostos pela Câmara Municipal da Capital, que estabelecem uma proibição econômica para tentar conter a saída de alimentos básicos (farinha, feijão, milho e arroz) dos municípios em plena seca. Ou seja, quem exportasse esses gêneros pagaria não apenas o imposto normal, mas também uma multa de 5 mil réis por saca (podendo dobrar em caso de reincidência). A intenção era impedir o desabastecimento local e segurar a comida para a população da região. O segundo artigo, proíbe a compra e venda por atacado (em grandes quantidades) dos mesmos produtos listados. Além disso, determina que, se a venda ocorresse, deveria ser feita em locais públicos e fiscalizados, evitando comércio clandestino. Quem descumprisse pagaria multa de 20 mil réis (mais alta do que no artigo 1º), dobrada se fosse reincidente (Sala das Sessões da Câmara Municipal da Capital da Parahyba em 18 de dezembro de 1877).

abastecer a própria região, além das vilas de Cajazeiras, Souza e Piancó; e a comarca de Campina Grande, encarregada de suprir sua área e também as vilas de Patos, São João e Alagoa do Monteiro. À medida que crescia a necessidade de socorros, o presidente nomeou, para cada cidade-depósito, uma comissão formada pelo juiz de direito, o vigário e o coletor das rendas gerais, encarregados de administrar e distribuir os alimentos e demais itens¹³⁹ (Almeida, J., 2012 [1923], p. 155).

Ainda sobre os administradores e chefes das comissões, observa-se que eram, em sua maioria, homens dotados de prestígio social nas localidades. De acordo com Márcio de Carvalho e Silva (2025b, p. 434-435), ainda que analisando o caso do Piauí, essa composição conferia legitimidade formal às comissões, mas também favorecia a articulação entre autoridade pública, interesses privados e filiação partidária.

Em muitos casos, os comissários eram correligionários do partido no poder provincial, o que alimentava suspeitas recorrentes quanto ao uso político dos recursos destinados aos socorros. Assim, as comissões não operavam como instâncias técnicas neutras, mas como espaços profundamente imbricados nas dinâmicas do poder local.

Na Parahyba, também se observaram essas características. Em uma lista¹⁴⁰ datada de 15 de outubro de 1877, que reúne as pessoas residentes na Capital da Província que atenderam ao chamado da Comissão Central de Socorros para prestar serviços “para minorar os rigores da fome e da nudez de que se acham presos milhares de infelizes no interior da Província, em consequência da desgraçada seca que a flagela”, é possível identificar a mobilização de indivíduos vinculados às elites políticas, religiosas e diplomáticas locais.

Entre os nomes registrados constam figuras socialmente reconhecidas, como o próprio presidente da província à época, o Dr. Esmerino Gomes Parente; o Cônego Dr. Leonardo Antunes Meira Henriques (Padre Meira); o vice-cônsul inglês Robert James Shalders; e o então futuro vice-presidente da província, Pe. Felipe Benício da Fonseca Galvão, entre outros (Relação das pessoas residentes n’esta Capital..., AHWBD, 15/10/1877).

Outros nomes, como advogados, médicos, deputados provinciais, tenentes, delegados e capitães, ocupavam funções de colaboradores, administradores, escrivãos e comerciantes

¹³⁹ No caso do alto sertão, uma das regiões mais afetadas e de difícil acesso, os gêneros deveriam ser enviados via porto de Mossoró (RN), sob responsabilidade de um agente fiscal incumbido de garantir que chegassem ao destino (Parahyba do Norte, Relatório, 1878, p. 30).

¹⁴⁰ Relação das pessoas residentes n’esta Capital, que se dignaram, accendendo ao pedido da Comissão Central de Socorros as victimas da secca, subscrever para de alguma forma minorar os rigores da fome e da nudez de que se acham presos milhares de infelizes no interior da Província, em consequência da desgraçada secca que a flagela. 15 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

particulares responsáveis pelo fornecimento de carne ou farinha, além de “encarregados no tratamento de indigentes” em determinados municípios do sertão, muitos deles sem qualquer formação médica. Ao analisar a atuação dessas autoridades durante a epidemia do cólera no Ceará, Juciêdo Alexandre (2024b, p. 114) observa que tais situações podiam representar tanto uma “oportunidade de demonstrar grandeza” quanto, em sentido oposto, revelar “a inconveniência de ver uma pessoa despreparada em postos estratégicos, trazendo prejuízo às localidades e vergonha ao nome da autoridade”.

Em relação à distribuição de gêneros alimentícios e de outros socorros na Capital, as entregas eram realizadas, inicialmente, às quintas-feiras e aos sábados, em prédios públicos como o quartel de polícia e os conventos de São Francisco e de São Bento – este último funcionando também como abrigo para parte da população migrante (Almeida, J., 2012 [1923], p. 159–160). Posteriormente, no pátio da Tesouraria Provincial, a partir de outubro de 1877, a distribuição passou a ocorrer às quartas-feiras e aos sábados, no horário das 9 horas da manhã às 3 da tarde (*Jornal da Parahyba*, 25/10/1877 *apud* Aguiar, 1999, p. 160).

Também eram fornecidos tecidos, como indica um dos poucos registros disponíveis: “seguiram [...] algumas peças de algodão de cor e de algodãozinho branco [...]” (*Jornal da Parahyba*, 20/10/1877 *apud* Aguiar, 1999, p. 160). Trata-se de uma documentação esparsa, o que sugere que o envio desses materiais, possivelmente destinados à confecção de roupas e lençóis, não correspondia a uma prática contínua ou estruturada, diferentemente do que ocorria com os gêneros alimentícios. Ainda que fornecidos de maneira irregular, esses itens buscavam oferecer algum alívio às famílias que haviam perdido tudo, revelando os limites da assistência prestada.

Como mencionado anteriormente, não é possível estabelecer uma data precisa para o início da seca, mas já no começo de abril de 1877 os municípios do Sertão encaminhavam pedidos formais de socorros.

Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Cajazeiras¹⁴¹, os vereadores dirigiram um apelo ao presidente da província, descrito como um “ato de humanidade e patriotismo”, diante da demora no envio dos primeiros gêneros. A ata informava que a Câmara não havia solicitado auxílio antes porque persistia entre a população a esperança de que as chuvas ainda chegassem; mas com o prolongamento da estiagem e o avanço da fome, os vereadores alertavam que “a multidão de vítimas [...] aparecerá”, caso o governo não intervisse de imediato (Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras, AHWBD, 10/04/1877).

¹⁴¹ Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras em Sessão Ordinária, 10 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

A persistência desse quadro pode ser observada meses depois, quando em outubro de 1877 a Câmara Municipal de Cajazeiras¹⁴² voltou a registrar a extrema dificuldade no acesso aos socorros. Em novo ofício enviado, afirma que, embora alguns carregamentos de gêneros tivessem chegado anteriormente e sido distribuídos à população, já faziam três meses que “nem mais um caroco de farinha” alcançava a localidade. O documento atribuía essa interrupção à precariedade das estradas que ligavam a região a Mossoró (RN), as quais se tornaram intransitáveis não apenas pelas condições do caminho, mas também pela ausência de pastos para alimentar os animais de carga, então o único meio de transporte disponível na região (Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras, AHWBD, 30/11/1877).

O mesmo cenário ocorria na Vila de Patos, como descrito pela Câmara Municipal¹⁴³ acerca do avanço da fome entre a população. Relatam que a escassez de chuvas “não permitiu lucrarem-se as plantas, e nem mesmo criar pastos”, o que levou ao enfraquecimento e morte do gado, retirando das famílias pobres um dos poucos recursos de subsistência que ainda dispunham. A Câmara observa que, se não fosse a caridade exercida por alguns particulares, eles próprios já ameaçados pela fome, o número de vítimas seria ainda maior (Paço da Câmara Municipal da Villa de Patos, AHWBD, 28/04/1877).

No entanto, esses auxílios tornavam-se inviáveis por um conjunto de fatores que atravessavam a política de socorros como um todo: desvios e mau uso de verbas, falta de organização e de uma estratégia coordenada, dificuldades logísticas no transporte e armazenamento dos gêneros, além dos problemas relacionados à própria conservação dos alimentos. A esses entraves somava-se a impossibilidade de circulação dos socorros, pois a ausência de pastos tornara inviável o transporte por animais de carga, reproduzindo a mesma dificuldade já registrada em Cajazeiras.

Nesse contexto, Patos enfrentava não apenas a escassez de recursos para atender à população local, mas também a pressão gerada pelo intenso fluxo de migrantes que atravessavam a vila – “os que por aqui passam dos sertões de cima com direção aos brejos”. Ao funcionar como ponto de passagem desses deslocamentos, a vila passou a lidar com tensões crescentes na administração local e no abastecimento disponível (Paço da Câmara Municipal da Villa de Patos, AHWBD, 28/04/1877).

¹⁴² Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras em Sessão Ordinária, 30 de Outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹⁴³ Paço da Câmara Municipal da Villa de Patos em Sessão Extraordinária, 28 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Esse conjunto de demandas alimentava a construção de discursos que associavam a presença dos migrantes ao descontrole dos socorros e à intensificação da fome, reforçando representações negativas sobre a população oriunda do Sertão, mesmo quando ela própria era vítima direta da calamidade (Paço da Câmara Municipal da Villa de Patos, AHWBD, 28/04/1877).

O quadro de desorganização administrativa e colapso do abastecimento de gêneros no Sertão era agravado ainda por episódios recorrentes de violências e saques, que interferiam na chegada dos gêneros enviados pelo governo provincial.

Em outubro de 1877, o Gabinete da Comissão Central¹⁴⁴ comunicou ao presidente da província que parte dos víveres destinados às comarcas de Pombal, Cajazeiras, Piancó e Sousa havia sido roubada “por um grupo de homens armados”, durante o trajeto da lancha *Time* entre a barra¹⁴⁵ e o porto de Mossoró. Além do assalto que retirou 32 sacas de farinha da carga original, a correspondência também denunciava o desvio de remessas por encarregados locais, que não entregaram às comissões parte dos gêneros sob sua responsabilidade (Gabinete da Comissão Central de Socorros, AHWBD, 08/10/1877).

Ao solicitar uma investigação imediata e a responsabilização dos envolvidos, a Comissão Central reconhecia que a escassez causada pela seca não era produzida apenas pela falta das chuvas ou pela precariedade das estradas, mas também pela ação de grupos armados e pela apropriação irregular dos socorros (Gabinete da Comissão Central de Socorros, AHWBD, 08/10/1877). Esses episódios mostram que, no Sertão, a política assistencial era atravessada por múltiplos vetores de instabilidade: fome, migrações, insegurança pública e desvio de recursos, criando um ambiente no qual garantir que os alimentos chegassem ao destino final era tão desafiador quanto obtê-los.

Nesse contexto de instabilidade, os saques não podem ser compreendidos apenas como efeitos imediatos da falta de recursos e da perda das condições mínimas de subsistência. A esse respeito, Frederico de Castro Neves (2000, p. 14-15) argumenta que os episódios de violência ocorridos durante períodos de seca extrema não se reduzem a uma resposta mecânica à carência alimentar, mas emergem de um quadro mais amplo de conflitos sociais intensificados pela calamidade, carregando sentidos políticos próprios, ainda que não enquadrados nas formas clássicas de mobilização coletiva.

¹⁴⁴ Gabinete da Comissão Central de Socorros às Vítimas da Seca na Parahyba, 8 de Outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹⁴⁵ A barra mencionada no documento não se refere ao litoral parahybano, mas sim à Barra do Apodi, no Rio Grande do Norte. Era por esse ponto que as embarcações ingressavam no Rio Apodi para alcançar o Porto de Mossoró, rota utilizada no século XIX para o envio de gêneros destinados ao Sertão da Parahyba..

Dessa forma, mesmo quando provocados por condições extremas – como a fome, o deslocamento forçado e a desassistência –, esses saques não devem ser interpretados como atos desorganizados ou irracionais, mas como estratégias sociais de sobrevivência, moldadas por pressões estruturais que organizavam a experiência sertaneja nos anos de seca (Neves, 2000, p. 15).

Se as notícias e relatos provenientes do Sertão já evidenciavam o colapso da assistência e a incapacidade do governo provincial de suprir minimamente as necessidades da população em movimento, o cenário observado no Agreste confirma a expansão e o agravamento da crise.

O ofício da Câmara Municipal da Vila de Bananeiras¹⁴⁶ expõe de maneira contundente o impacto da migração interna sobre as localidades que recebiam grande número de famílias vindas do Sertão. A cena descrita, uma sala da Câmara tomada por “imensidade de povo”, muitos em “estado de nudês”, tentando forçar a entrada para garantir uma refeição antes que os gêneros se esgotassem, revela a ruptura completa das formas habituais de sociabilidade e de organização administrativa (Paço da Câmara Municipal da Villa de Bananeiras, AHWBD, 26/04/1877).

Mesmo com a Comissão distribuindo alimentos com extrema parcimônia, o volume de migrantes crescia diariamente, tornando inviável o atendimento de todos e levando muitos a percorrer portas particulares em busca de ajuda, quase sempre sem sucesso. Em Bananeiras, como em outras áreas do Agreste, a fome não se expressava apenas na falta de gêneros, mas no esgotamento das instâncias assistenciais, incapazes de lidar com uma demanda que ultrapassava qualquer previsão administrativa.

Além disso, o relato enviado pela Câmara torna-se ainda mais significativo quando passa a explicar por que parte da população migrante estariam vivendo na ociosidade. A justificativa apresentada seria o alto número de pessoas, a falta de trabalho disponível e a impossibilidade de cultivar a terra por falta de sementes e alimento, é imediatamente seguida por uma interpretação moralizante: segundo os vereadores, a permanência desse quadro levaria esses indivíduos a “pedir e furtar”, caso não encontrassem ocupação remunerada (Paço da Câmara Municipal da Villa de Bananeiras, AHWBD, 26/04/1877).

Ao enquadrar parte dos migrantes como potenciais enganadores ou aproveitadores dos socorros, o relato contribui para legitimar um discurso que condicionava o acesso à assistência

¹⁴⁶ Paço da Câmara Municipal da Villa de Bananeiras em Sessão Ordinária de 26 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

pública à incapacidade para o trabalho. Nessa lógica, os considerados “válidos” deveriam ser afastados dos auxílios gratuitos e direcionados a atividades laborais, vistas como a única forma legítima de socorro, capaz de conter a ociosidade e preservar a ordem local. O pedido da Câmara por verbas para novas obras insere-se, assim, num projeto de disciplinamento social, no qual o trabalho operava como critério de moralidade e vigilância.

A mesma lógica de discurso aparece na vila do Pilar¹⁴⁷, reforçando que a representação dos migrantes como sujeitos “ociosos” ou propensos ao desvio não era um caso isolado. Em relatório semelhante, a Comissão de Socorros afirma que, no início das distribuições, observou “a má aplicação” dos gêneros por parte da população pobre e que, uma vez alimentados, muitos se entregariam a “uma indolência completa”, aguardando novas remessas; afirma ainda que, no intervalo entre uma distribuição e outra, “furtaram tudo quanto encontravam” (Comissão de Socorros da Villa de Pilar, AHWBD, 04/04/1877).

Assim como em Bananeiras, a Comissão converte a experiência extrema da fome em argumento moral, atribuindo aos próprios migrantes a responsabilidade pela desordem, ao invés de considerar a falha estrutural na oferta regular de alimentos. Desse modo, a representação construída pela autoridade local opera novamente como mecanismo de distinção entre os que “merecem” assistência e aqueles vistos como ameaça à ordem pública (Comissão de Socorros da Villa de Pilar, AHWBD, 04/04/1877).

Tal percepção não era exclusiva de Bananeiras e Pilar. Outras vilas do Agreste também registraram dificuldades semelhantes, como Areia, onde a pressão demográfica provocada pelos fluxos migratórios do Sertão rapidamente ultrapassou a capacidade administrativa das câmaras e comissões locais.

Em junho de 1877, a Câmara Municipal¹⁴⁸ descrevia que os socorros enviados pelo governo eram “minguados” diante da chegada maciça de famílias procedentes de Patos, Sousa, Catolé, Pombal e Piancó, a ponto de parecer que “toda a população daquelas localidades se achao aqui aglomeradas”. A distribuição, realizada apenas uma vez por semana para “economizar os gêneros”, deixava grande parte da população com fome, criando tensões entre proprietários rurais e migrantes, já que aqueles afirmavam não poder sustentar trabalhadores debilitados e famintos, o que resultava em demissões e maior precarização das condições de vida (Paço da Câmara Municipal da Cidade de Areia, AHWBD, 07/06/1877).

¹⁴⁷ Comissão de Socorros da Villa de Pilar em 04 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹⁴⁸ Paço da Câmara Municipal da Cidade de Areia em 07 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Por sua vez, a correspondência¹⁴⁹ oriunda de Campina Grande expõe outro aspecto do fracasso estrutural da assistência: a ausência de controle, articulação e comunicação entre as diferentes comissões encarregadas. Em setembro de 1877, a Comissão de Campina informa à Presidência da Província que “nunca chegou [...] relação alguma das pessoas que tem recebido socorros das diversas comissões do interior”, declarando-se, por isso, incapaz de prestar qualquer esclarecimento à Comissão de Santa Luzia, que já havia recorrido a “correios particulares” para enviar suas listas (Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 21/09/1877).

A realidade ali registrada escancara o imprevisto administrativo que marcava toda a rede de assistência: listas que não chegavam, informações desencontradas, ausência de padronização e dependência de mensageiros privados em plena calamidade. Em Bodocongó¹⁵⁰, por exemplo, onde a subdelegacia de polícia informava, em 1879, não dispor de “recurso de porte algum” para socorrer a população local e os migrantes que há três anos não dispunha de recursos para enfrentar a fome os assolava, recorrendo ao presidente da província para o envio de alimentos (Subdelegacia de Polícia de Bodocongó, AHWBD, 29/04/1879).

Em meio às diversas reclamações e discussões já apresentadas, cabe abrir um breve parêntese para dimensionar a migração com a qual as comissões de socorros precisaram lidar – e que, em muitos casos, foi enfrentada de forma desproporcional e marcada por omissões.

Ao evidenciar a quantidade de migrantes distribuídos pelas diferentes mesorregiões da Parahyba, torna-se possível compreender tanto o volume de pessoas concentradas em distintos espaços quanto o despreparo das comissões diante da demanda por alimentos, medicamentos e vestimentas. Essa análise também se mostra fundamental para interpretar a expressiva presença de migrantes nos hospitais, enfermarias e casas de caridade, bem como para contextualizar o mapeamento das doenças que será abordado no próximo capítulo.

Até aqui, observamos as recorrentes reclamações relativas ao envio de gêneros alimentícios. No entanto, é necessário também mencionar as volumosas listas de remessas que eram – ou ao menos deveriam ser – distribuídas às instituições de caridade, aos estabelecimentos hospitalares e aos municípios afetados pela seca. Apesar da existência desses registros, é inegável que, mesmo quando os gêneros eram efetivamente enviados, os

¹⁴⁹ Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande em 21 de setembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹⁵⁰ Subdelegacia de Polícia do Distrito da Povoação de Bodocongó em 29 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

problemas persistiam, muitas vezes em proporções ainda mais graves. Isso porque diversas remessas não eram distribuídas de forma adequada, seja em razão dos atrasos, das más condições dos alimentos ou, ainda, da quantidade insuficiente frente à demanda crescente.

No que diz respeito aos componentes que integravam a chamada “ração” ou “dieta” destinada à alimentação da população, observa-se pouca variação ao longo do período. Os gêneros mais recorrentes eram arroz, feijão, milho, farinha, carne e bacalhau. Para os hospitais, além desses alimentos, eram também encaminhados itens específicos, como bolachas, café e alguns utensílios de cozinha, a exemplo de bules, xícaras e pratos, o que indica uma tentativa de suprir minimamente as necessidades do funcionamento dessas instituições.

A maior lista de envios registrada, correspondente ao período entre 14 de março e 3 de abril de 1878, insere-se no segundo ano da estiagem, quando a população já se encontrava profundamente exaurida após meses de espera por algum tipo de amparo iniciado ainda em 1877.

Após esse momento, observa-se uma redução progressiva na liberação de novas remessas por parte do governo, ainda que as solicitações e reclamações locais permanecessem constantes. Como será discutido adiante, ao longo de 1878 os envios tornam-se cada vez mais limitados, culminando, em 1879, em uma diminuição quase completa da assistência, mesmo com os efeitos da seca ainda fortemente presentes.

No Quadro 2, apresentado a seguir, encontram-se discriminadas as cargas destinadas aos municípios que solicitaram auxílio, permitindo observar não apenas o tipo de gêneros enviados, mas também as assimetrias entre as remessas e as necessidades locais. Chama a atenção, nesse sentido, o envio de apenas seis barricas de bolachas para a Villa de São João, quantitativo insuficiente quando comparado com uma população estimada em cerca de 15 mil habitantes, número que, muito provavelmente, não contempla o contingente adicional de migrantes concentrados no local em razão da seca.

Situação semelhante pode ser observada no caso das peças de madapolão, tecido de algodão que aparece apenas uma vez em toda a lista, com o envio de oito unidades igualmente destinadas à Villa de São João. A documentação não esclarece a finalidade desse material, não sendo possível determinar se se destinava ao vestuário dos migrantes, ao uso hospitalar ou a outras necessidades institucionais.

Quadro 2 – Lista dos gêneros alimentícios enviados para as comarcas e vilas da Parahyba (1878)

Localidades	Madapolão	Bolachas	Farinha	Milho	Feijão	Arroz	Carne	Bacalhau
Borborema	-	-	70	6	6	-	300	6
Cabaceiras	-	-	40	4	4	4	300	4
Patos	-	-	68	8	8	-	300	4
Alagoa do Monteiro	-	-	60	10	10	-	300	6
Alagoa Grande	-	-	60	8	4	4	300	4
Ingá	-	-	50	8	8	-	300	6
São João	-	-	60	10	10	-	300	6
Independência	-	-	70	8	8	4	300	4
Mamanguape	-	-	50	6	6	4	300	6
Campina Grande	-	-	280	40	40	8	1.050	14
Serra da Raiz	-	-	40	8	116	4	150	4
Areia	-	-	54	10	10	-	150	4
Santa Luzia do Sabugy	-	-	68	8	8	2	150	4
Patos	-	-	50	12	10	-	300	4
Belém	-	-	12	2	2	2	-	2
Areia	-	-	212	-	22	14	900	20
Araruna	-	-	40	8	6	4	150	4
Bananeiras	-	-	70	8	8	4	300	4
Teixeira	-	-	68	-	12	8	150	4
Borborema	-	-	56	-	10	8	150	4
S. João	8	6	50	-	8	4	150	4
Alagoa Nova	-	-	48	-	6	2	150	2
Santa Luzia do Sabugy	-	-	50	-	12	10	300	4
Mamanguape	-	-	40	-	12	12	450	8
Areia	-	-	120	-	18	-	600	14
Mamanguape	-	-	80	-	10	-	450	10
Soma Total	8	6	1.866	164	374	98	8.250	156

Fonte: Quadro elaborado por nós com base na *Lista dos gêneros alimentícios remetidos às diversas comissões de socorros do interior de 14 de março á 3 de abril*. 05 de Abril de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Conforme exposto no Quadro 2, a distribuição dos gêneros alimentícios ocorreu de forma desigual entre as comarcas e vilas da Parahyba, com variações significativas tanto nos tipos quanto nas quantidades remetidas a cada localidade. Alguns municípios receberam volumes mais expressivos, enquanto outros foram contemplados com remessas bastante reduzidas, o que indica a ausência de um critério uniforme de distribuição.

Outro aspecto relevante diz respeito à recorrência de alguns municípios na lista, como Campina Grande, Areia, Mamanguape e Santa Luzia do Sabugy, que receberam mais de uma remessa no período analisado. Essa repetição pode ser compreendida a partir de diferentes fatores, entre eles a concentração de um número expressivo de pessoas nessas localidades, o intenso fluxo de migrantes e a incidência de doenças e situações de abandono em larga escala, amplamente registradas pela documentação do período. Apesar disso, a repetição das remessas não elimina as críticas e reclamações constantes sobre a insuficiência e a irregularidade dos socorros.

Mas o que também chama nossa atenção é que, apesar das reclamações e das negligências registradas, o quadro não se limita a quantificar os gêneros enviados; ele evidencia, as desigualdades regionais na distribuição dos socorros, a falta de justificativas ou dos critérios adotados, além dos silêncios que marcaram a experiência da seca para grande parte das localidades sertanejas.

Acerca dos alimentos que constam no quadro, os expressivos quantitativos de farinha e de carne – vermelha ou salgada, em alguns casos – em relação aos demais gêneros indicam uma escolha de caráter estratégico. Tratava-se de alimentos socialmente reconhecidos como capazes de “sustentar” ou “saciar” a fome por períodos mais prolongados, ao mesmo tempo em que facilitavam o armazenamento e a conservação, como no caso da carne salgada. Além disso, essa opção revela uma lógica de socorro econômica voltada à redução da frequência das distribuições, sem assegurar as condições adequadas de alimentação ou a recuperação dos corpos de crianças, adultos e idosos desgastados pela seca.

Quando comparamos a experiência da Parahyba com a de outras províncias, como o Rio Grande do Norte, observa-se que havia pouca variação na escolha dos gêneros destinados aos socorros, sendo o bacalhau o único item que não figurava com regularidade nas listas (Araújo, A., 2022, p. 160). Conforme analisa Avohanne de Araújo, a repetição de determinados gêneros alimentícios resultava de escolhas condicionadas tanto pelos hábitos alimentares regionais quanto por preocupações médicas e práticas, o que contribuiu para a padronização parcial das remessas durante o período da seca (Araújo, A., 2022, p. 160).

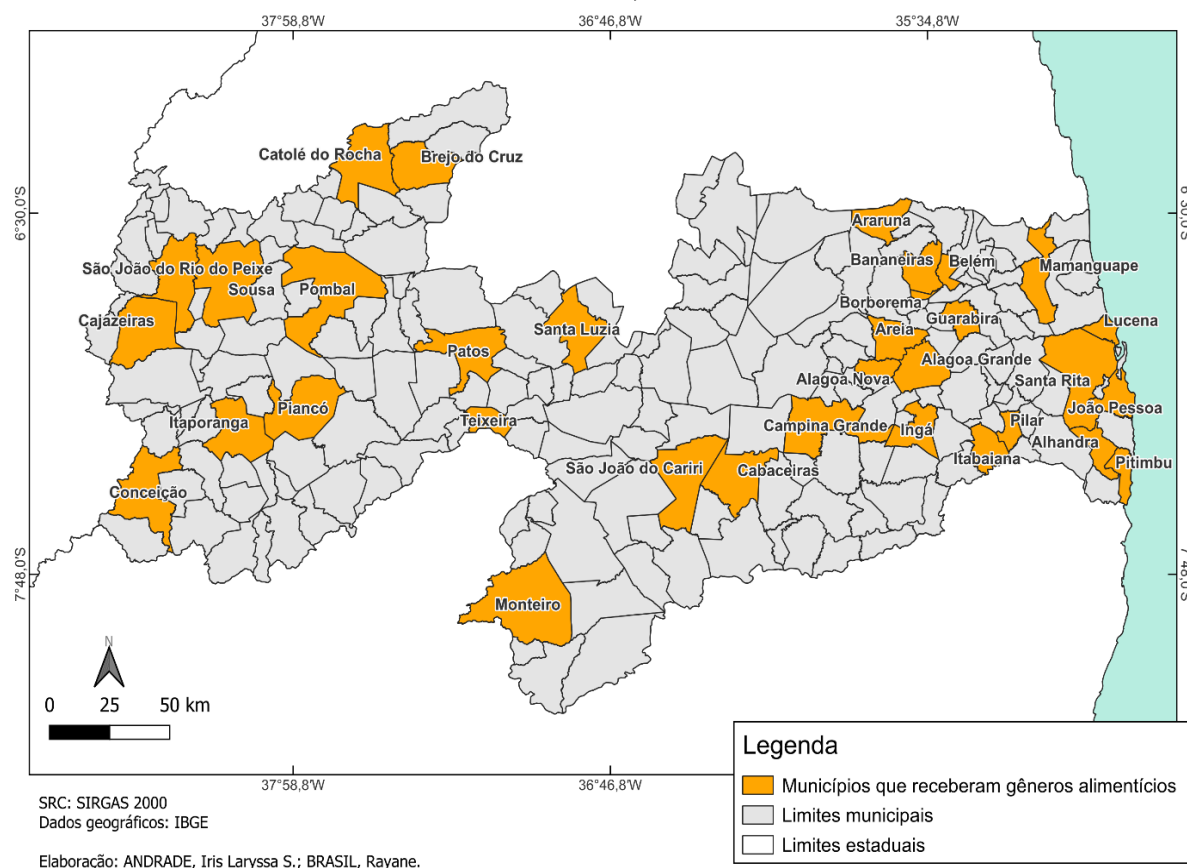
Ainda de acordo com a autora, no caso do arroz, parte da medicina oitocentista demonstrava reservas quanto ao seu consumo isolado, em razão das perdas nutricionais decorrentes do beneficiamento do grão, o que o associava ao surgimento de enfermidades como o beribéri. Essa limitação, podia ser atenuada quando o arroz era consumido em conjunto com outros alimentos comuns à dieta sertaneja. Já a farinha ocupava lugar central na alimentação do sertão, por derivar da mandioca, planta resistente à seca. Em contextos

extremos de fome, a ingestão inadequada da mandioca, sem os devidos processos de preparo, podia ocasionar adoecimentos e até mortes (Araújo, A., 2022, p. 162).

Assim como no quadro referente à alimentação dos migrantes, a análise das cartas, relações e correspondências permitiu mapear os municípios que receberam, ao menos uma vez, alguma remessa de gêneros alimentícios. Esse levantamento torna-se ainda mais significativo diante das recorrentes reclamações registradas na documentação, que apontam atrasos nos envios, por vezes prolongados por meses e até anos.

Desse modo, identificam-se 33 municípios contemplados, sendo 11 localizados no Sertão – Catolé do Rocha, São João do Rio do Peixe, Sousa, Cajazeiras, Pombal, Vila da Misericórdia (atual Itaporanga), Conceição, Piancó, Patos, Teixeira e Brejo do Cruz; 4 na Borborema – Santa Luzia, São João do Cariri, Monteiro e Cabaceiras; 11 no Agreste – Campina Grande, Alagoa Nova, Areia, Belém, Bananeiras, Araruna, Borborema, Serra da Raiz, Itabaiana, Ingá e Guarabira; e, por fim, 7 na Mata – Mamanguape, Lucena, Santa Rita, Capital (atual João Pessoa), Alhandra, Pitimbu e Pilar. Abaixo consta o mapa da Figura 5 com essas distribuições.

Figura 5 – Mapa de Distribuição dos Gêneros Alimentícios na Província da Parahyba (1877-1879)



Fonte: Mapa elaborado por Iris Laryssa S. Andrade e Rayane Brasil, a partir de dados extraídos de 22 documentações sobre envios de alimentos para várias comarcas/vilas e freguesias da Província da Parahyba do Norte. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877-79, Caixas: 61 (A e B) e 62, utilizando o *software QGIS*¹⁵¹.

Muitos dos relatos visualizados até aqui mostram que os migrantes eram frequentemente retratados pelas fontes como uma massa populacional aglomerada e desesperada por alguma refeição. Raramente aparecem como “sujeitos sociais participativos e possuidores de vontade e desejo próprios”, mesmo que, em alguns casos, tenham ocorrido protestos ou reclamações, os quais pouco eram levados a sério ou considerados pelas autoridades. Pelo contrário, esse estado de sofrimento coletivo, marcado por angústias, mortes e desespero, fornecia conteúdos e provas importantes “com finalidade políticas de angariar recursos materiais para a Província” (Garcia, 2006a, p. 59).

Além de se tornarem palco de discussões médicas e higienistas, os migrantes passaram a ser representados como uma “ameaça” ao ideal de civilização e como corpos situados fora dos modelos adequados de higiene. Quanto mais as histórias e os relatos eram construídos a partir do coletivo, maior era seu potencial de chamar atenção e sensibilizar, permitindo que muitos políticos locais levassem essas questões ao nível nacional. Descrições de migrantes sem vestimenta, sem alimentação ou obrigados a se alimentar de comidas podres e restos de animais eram empregadas como elementos de comoção, reforçando a gravidade do quadro apresentado (Garcia, 2006a, p. 59-60).

Nesse movimento de busca por maiores recursos e posições de destaque, a exposição da miséria também se inseria em um jogo de interesses entre os políticos das províncias do Norte. Enquanto algumas procuravam afirmar-se como menos afetadas e melhor administradas, outras enfatizavam o cenário de calamidade vivido por sua população, recorrendo de forma frequente à descrição da pobreza extrema, aos números elevados de atingidos e, sobretudo, aos pedidos sucessivos de novas aberturas de crédito e verbas destinadas aos socorros, na tentativa de privilegiar sua província no interior das disputas políticas do período.

Feitas essas considerações, passamos agora à análise da atuação dos deputados provinciais João Florentino Meira de Vasconcellos e Manoel Pedro Cardoso Vieira, representantes da Parahyba, com o objetivo de examinar como suas falas no Parlamento

¹⁵¹ O mapa foi elaborado no *software QGIS*, utilizando como base cartográfica os limites municipais fornecidos pelo IBGE (projeção *WGS 84 – UTM*).

expressaram disputas políticas, estratégias discursivas e projetos de intervenção, ou a ausência deles, diante da crise provocada pela seca.

2.3.1 “OS RECURSOS FORAM TAMBÉM ESCASSEANDO EM TODAS AS LOCALIDADES”: A REPRESENTAÇÃO DOS DEPUTADOS PARAHYBANOS NO PARLAMENTO BRASILEIRO

A distribuição de gêneros alimentícios e de verbas orçamentárias, discutida anteriormente, também passou a ser mobilizada como instrumento de construção de discursos políticos. Nos debates parlamentares, especialmente aqueles protagonizados por deputados das províncias do Norte, os socorros públicos converteram-se em eixos de articulação de demandas regionais e de cobrança ao governo imperial.

Essas intervenções não se limitavam à denúncia da gravidade da seca ou à defesa da assistência às populações migrantes, mas expressavam projetos políticos mais amplos e tentativas de reposicionamento no cenário nacional. Antes de analisar as atuações de João Florentino Meira de Vasconcellos e Manoel Pedro Cardoso Vieira, faz-se necessário compreender o contexto político nacional e a dinâmica da política na Parahyba nesse período.

A política brasileira no Período Imperial foi marcada por disputas entre diferentes grupos, que se consolidaram, ao longo do tempo, em dois grandes agrupamentos: o Partido Conservador, defensor da centralização do poder e da manutenção da ordem, e o Partido Liberal, que advogava maior autonomia provincial e reformas de caráter moderado (Carvalho, 2008, p. 206). Apesar dessas diferenças, José Murilo de Carvalho (2008, p. 212) ressalta que ambos eram formados por proprietários de terra, associados, no caso dos conservadores, a burocratas, e, entre os liberais, a profissionais liberais.¹⁵²

Na Parahyba, como observa Myraí Segal (2017), a vida política seguia a lógica nacional de alternância entre conservadores e liberais, em que a composição da chefia do gabinete no centro influenciava diretamente a organização das assembleias e os arranjos de poder locais. Na década de 1850, consolidou-se uma hegemonia conservadora, a partir da 8ª Legislatura (1850-1851), mantida até a 12ª (1858-1859), quando começou a perder força. Essa configuração esteve associada à liderança do senador Frederico de Almeida e Albuquerque,

¹⁵² Além disso, o Poder Legislativo adotava um sistema bicameral, formado pela Câmara dos Deputados, composta por representantes eleitos pelas províncias com mandatos temporários, e pelo Senado, de caráter vitalício, embora também eletivo (Carvalho, 2008, p. 57). As duas casas legislativas reuniam-se sob a denominação de Assembleia Geral.

que estabeleceu alianças¹⁵³ com o grupo liberal¹⁵⁴ chefiado por Felizardo Toscano de Brito entre 1840 e 1876 (Silva, 2016a, p. 91; Segal, 2017, p. 114).

Enquanto isso, entre 1877 e 1879, os debates parlamentares revelaram não apenas a gravidade da seca, mas também como ela foi instrumentalizada politicamente por representantes das províncias afetadas. Nas 16^a (1876-1877) e 17^a (1878-1881) legislaturas, a Parahyba contou com cinco deputados gerais em cada uma. Durante a 17^a legislatura, destacou-se a atuação do suplente Dr. Abdon Felinto Milanez, que, em 1880, assumiu as vagas deixadas por Manoel Pedro Cardoso Vieira, que falecera, e por João Florentino Meira de Vasconcellos, que se transferiu para o Senado (Silva, 2021b, p. 333-334). Com esse panorama delineado, passamos à análise dos discursos proferidos no Parlamento durante o auge da crise.

Nas discussões sobre os desdobramentos da seca, a atuação dos presidentes de província tornou-se objeto de elogios, críticas e comparações, como as diferentes formas de administrar a crise. Um exemplo disso ocorreu na sessão parlamentar da Câmara dos Deputados de 10 de agosto de 1877¹⁵⁵, quando o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, Antônio da Costa Pinto e Silva¹⁵⁶, destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas pelas províncias do Norte, em Pernambuco “não tem aparecido queixas por falta de recursos” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1877, t. II, p. 76).

Para o ministro, o êxito pernambucano devia-se à atuação do presidente da província e à nomeação de uma comissão de socorros públicos composta por juizes com conhecimento sobre as zonas sertanejas. Essa eficiência permitiu, inclusive, que “as sobras” fossem utilizadas para socorrer a Parahyba e o Ceará (Brasil, Câmara dos Deputados, 1877, t. II, p. 76).

De fato, as Comissões de Socorros do Recife, das quais a Parahyba já vinha sendo beneficiada, enviaram significativa quantidade de gêneros alimentícios. Essa remessa identificada como parte das “sobras” mencionadas pelo ministro, motivou, dois meses depois,

¹⁵³ Celso Mariz define esse momento da seguinte forma: “os conservadores que, subindo Felizardo, ficaram com este, ficaram liberais” (Mariz, 1980, p. 157).

¹⁵⁴ Segundo Lucian Silva (2016a, p. 93), a ascensão liberal em 1878, com João Lins Vieira Cansanção Sinimbu na chefia do gabinete ministerial, coincidiu com a liderança provincial de João Leite Ferreira Júnior, político experiente e genro de Toscano de Brito, que passou a conduzir as articulações do grupo no cenário local.

¹⁵⁵ BRASIL. **Annaes do Parlamento Brasileiro**: Câmara dos Srs. Deputados. Segundo anno da décima-sexta legislatura. Sessão de 1877. Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. de Villeneuve & C., 1877.

¹⁵⁶ Exerceu mandatos como deputado provincial por Niterói e deputado geral por São Paulo. Ao longo de sua trajetória, ocupou o cargo de Ministro do Império e presidiu as províncias da Parahyba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro (Mariano, N., 2015, p. 290).

um ofício do gabinete da Comissão da Parahyba¹⁵⁷ agradecendo não apenas a doação, mas também o pagamento do transporte dos “dois mil volumes contendo generos alimentícios [...], com destino do socorro dos indigentes oprimidos pela sêcca” (Gabinete da Comissão Central de Socorros da Parahyba, AHWBD, 08/10/1877).

O episódio revela que a assistência não se restringia a um gesto humanitário, funcionando também como instrumento de construção de prestígio político e de fortalecimento de redes de cooperação e influência entre as províncias.¹⁵⁸ Além de Pernambuco, a Parahyba recebeu recursos provenientes das festas de caridade promovidas na capital do Império, contribuições de estudantes da Escola Politécnica e donativos oriundos de outras províncias, como o Pará, bem como de associações maçônicas do Espírito Santo e do Paraná (Almeida, J., 2012 [1923], p. 155).

Apesar dessas expressivas remessas provenientes do Império e de outras províncias, a dinâmica da assistência na Parahyba mostra que a sobrevivência cotidiana da população afetada pela seca dependia igualmente de iniciativas individuais, muitas vezes motivadas pela constatação de que o governo não conseguia atender às necessidades mais urgentes. Um caso¹⁵⁹ emblemático é o do professor Graciano Fontino Lordão¹⁶⁰, da povoação de Pedra Lavrada, que ofereceu 100\$000 (cem mil réis) de seus próprios vencimentos, atrasados desde 1875, para auxiliar na compra de gêneros alimentícios destinados à população local (Gabinete da Comissão Central de Socorros, AHWBD, 12/09/1877).

Essa insuficiência do aparato governamental também transparecia no debate parlamentar. Na sessão da Câmara dos Deputados de 21 de janeiro de 1879¹⁶¹, o deputado pela Parahyba, João Florentino Meira de Vasconcellos¹⁶², construiu um discurso voltado a

¹⁵⁷ Gabinete da Comissão Central de Socorros as victimas da sêcca na Parahyba, 8 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877, caixa 061 (A).

¹⁵⁸ Mesmo com o envio das chamadas “sobras”, a Parahyba continuava a recorrer ao mercado pernambucano para adquirir gêneros alimentícios. Os telegramas trocados com negociantes recifenses, acompanhados de uma carta de comerciantes da mesma praça, evidenciam que o abastecimento dependia de transações comerciais regulares. A Tesouraria da Fazenda da Parahyba, por sua vez, demonstrava preocupação em justificar ao presidente da província que os valores pagos refletiam apenas “a alta dos preços correntes da farinha, feijão e milho” (Parahyba do Norte – Tesouraria da Fazenda, AHWBD, 05/04/1878).

¹⁵⁹ Gabinete da Comissão Central de Socorros às victimas da Seca na Parahyba, 12 de setembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877, caixa 061 (A)

¹⁶⁰ Foi um intelectual e homem público atuante na Paraíba oitocentista. Identificado nas fontes como “pardo” ou “de cor”, conforme o informante, era filho de uma mulher negra com um clérigo católico. Destacou-se como professor de latim, área em que se diplomou, além de ter estudado filosofia e retórica no Liceu Paraibano. Atuou também como deputado, colaborador da imprensa local e funcionário da administração pública, circulando por espaços centrais da vida intelectual e política provincial (Barros, S., 2018, p. 2 e 9).

¹⁶¹ BRASIL. **Anais do Parlamento Brasileiro**: Câmara dos Srs. Deputados. Primeiro anno da décima-sétima legislatura: sessão de 1878. Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879.

¹⁶² Ainda que de forma discreta, acreditamos que os discursos proferidos pelo deputado demonstravam atenção a temas de cunho social e à saúde pública, interesse possivelmente relacionado à sua formação em Farmácia. Nascido em 1865 na cidade do Pilar, diplomou-se em Farmácia em 1886 pela Faculdade de Medicina do Rio

questionar a atuação do governo e dos demais parlamentares. Segundo ele, havia um distanciamento entre o centro político do Império e a experiência concreta daqueles afetados pela seca, pois apenas quem vivia o desastre poderia “calcular com verdadeira exatidão a grandeza da dor” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 59).

O deputado descreveu a intensificação da fome, a degradação das condições de sobrevivência e a ausência de estrutura mínima para lidar com os mortos, elementos que, segundo ele, evidenciavam a incapacidade do governo de responder à calamidade de forma eficaz. Sustentou ainda que a execução dos socorros esteve longe de atender às necessidades mais urgentes, sendo marcada por desigualdades e falhas administrativas que agravaram ainda mais o sofrimento das populações atingidas. Como parte do seu discurso relatava que

[...], os recursos foram também escasseando em todas as localidades. A fome recrudesceu fortemente e tornou-se tão intensa e voraz que momentos houve em que **a carne humana serviu de alimento àquelles que sobreviveram. A mortandade por sua vez foi vasta e geral**, e tal era o abandono do povo, que **os cadáveres, insepultos pelas estradas, pelas ruas das cidades e logares públicos, eram pasto dos abutres**. [...] **É cada provincia formando um vasto cemiterio!** Nestas condições, quando a população reclamava socorros e auxílios, é certo que o governo imperial resolveu proteger os indigentes e necessitados perseguidos da sêcca; mas **o serviço da distribuição de socorros foi a princípio feito com grande desigualdade, muita imprevidencia e com graves e fataes erros** (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 60. Grifos nossos).

Ao analisar esse colapso, observa-se que a crítica do deputado não se restringe aos efeitos da seca enquanto fenômeno natural, mas incide diretamente sobre a incapacidade política e administrativa de enfrentá-la. A assistência pública aparece como resultado da má gestão, ausência de planejamento e centralização ineficiente, o que permite compreender as comissões de socorros não apenas como instâncias neutras de ajuda, mas como parte de uma lógica marcada por controle, disputas e abandono.

Ao mencionar o município de Sousa, Meira de Vasconcellos afirmou ter lido no jornal *A Reforma (RJ)*¹⁶³ um ofício da comissão local, dirigido ao Ministro do Império, no qual se descreviam “os horrores da fome e da miséria nos sertões da Parahyba” e se denunciava a falta

de Janeiro. Em 1896, fundou a Sociedade Farmacêutica, que presidiu com destaque e, dois anos depois, participou da criação da Escola Livre de Farmácia, instituição que deu origem à Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo (Academia Nacional de Farmácia, 2017). Formado também em Direito, foi membro do Partido Liberal, deputado provincial e geral pela Parahyba, promotor da comarca do Pilar, juiz de direito, diretor da instrução pública, presidente da província de Minas Gerais, senador, ministro da Marinha e do Império, além de Cavaleiro da Ordem da Rosa e da Ordem de Cristo (Segal, 2016, p. 79, 216).

¹⁶³ *A Reforma* foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, em circulação entre 1869 e 1879, com sede na rua Sete de Setembro. O jornal mantinha vínculo com o Partido Democrático, atuando como espaço de divulgação de suas posições políticas.

de distribuição de mantimentos aos municípios do interior entre os meses de maio e outubro (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 61). Embora reconhece que interrupção pudesse ser atribuída às dificuldades de transporte, em razão da falta de ferrovias, estradas de rodagem e vias de comunicação, mas assegurava a veracidade da denúncia pois consta de um documento oficial assinado por cidadãos de reconhecida probidade.¹⁶⁴

Não localizamos a matéria mencionada pelo deputado, mas as cartas enviadas pelos membros da comissão de Sousa permitem reconstruir parte dos acontecimentos. Em uma delas, o juiz de direito informa ao presidente José Paulino de Figueiredo, em 11 de abril de 1877¹⁶⁵, que os víveres e “o recurso de um conto e duzentos mil réis” destinados a “socorrer as necessidades dos indigentes flagelados” já estavam “quase concluídos, apesar de [...], ter sido distribuído com a maior economia” (Juiz Municipal do Termo de Souza, AHWBD, 11/04/1877).

Em correspondência posterior¹⁶⁶, o juiz municipal de Sousa evidencia a precariedade da assistência médica durante a seca. Ele relata a celebração, em fevereiro, de um contrato com o médico Fausto Nominando Meira de Vasconcelos para o “tratamento dos desvalidos”, mas informa que, até abril, não havia obtido confirmação oficial do acordo. Segundo o documento, o médico chegou a custear parte dos remédios, mas solicitou nova remessa com urgência, uma vez que muitos doentes permaneciam “sem o devido tratamento”. A carta revela que, mesmo em 1878, a burocracia e a falta de recursos continuavam a comprometer a eficácia dos socorros (Juiz Municipal do Termo de Souza, AHWBD, 17/07/1878).

Voltando para a leitura do ofício publicado no jornal *A Reforma*, o parlamentar procura blindar sua denúncia contra acusações de parcialidade, sugerindo que a gravidade da situação ultrapassaria qualquer fronteira partidária. Optando por não ler o ofício na íntegra por ser muito extenso, apresenta à Câmara apenas alguns trechos que descrevia o “miserável estado do centro de nossa província, cuja mortandade já excede de vinte mil pessoas”. Além disso, estavam

[...] presa ao mesmo tempo da fome, da nudez, da peste e da prostituição; homens, mulheres e crianças nus, desfigurados, meio loucos, estúpidos, insensíveis a tudo, vagueam atônitos de uns para

¹⁶⁴ O documento mencionado pelo deputado teria sido assinado pelo juiz de direito Manuel Barata de Oliveira Mello, pelo médico encarregado Dr. Fausto Nominando Meira de Vasconcelos e pelo vigário José Antônio da Silva Genuíno Ramos, integrantes da Comissão de Socorros da comarca de Sousa, já analisados anteriormente no contexto da solicitação de criação de uma escola pública no município.

¹⁶⁵ Juiz Municipal do Termo de Souza em 11 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875-1878, caixa 061 (B).

¹⁶⁶ Juiz Municipal do Termo de Souza em 17 de julho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875-1878, caixa 061 (B).

outros logares, semi-mortos, enchendo as estradas de cadaveres, que têm dado largo pasto aos corvos, aos quaes disputam a carniça dos cavallos! (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 61. Grifos nossos).

Após a leitura, o deputado retira da província qualquer expectativa de recuperação autônoma, ao afirmar que “a Parahyba acha-se em tal estado de decadência e de indigência, que nem agora nem de futuro poderá encontrar salvação em seus próprios recursos”. A declaração sustenta a defesa pela ampliação dos socorros públicos, apresentados como a única possibilidade de sobrevivência diante do desequilíbrio entre receita e despesa provincial e da necessidade de recorrer a empréstimos junto ao Banco do Brasil (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 62).

Ao inserir a Parahyba nesse quadro de ruína, Meira de Vasconcellos assume para si o papel de articulador das demandas e do sofrimento da província, mas ao mesmo tempo, naturaliza uma leitura da província como espaço incapaz, atrasada e “indigente”. Trata-se de uma posição contraditória: ao reivindicar recursos, reforça estigmas que hierarquizam regionalmente o país, ancorando seu discurso em uma cultura política que associa o sertão à miséria e à dependência estrutural (Guerra, 1993; Albuquerque Jr., 2011b).

Ao encerrar sua fala, Meira de Vasconcellos apresenta um requerimento que contrasta com a contundência do discurso. De caráter genérico, dirigido a todas as províncias atingidas pela seca, o pedido não formula questionamentos diretos sobre a situação específica da Parahyba, limitando-se à solicitação de informações administrativas e financeiras, entre elas dados sobre as despesas com socorros públicos, a aplicação de uma circular governamental, os gastos com obras públicas e os valores destinados ao Pará para o atendimento de migrantes cearenses (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. II, p. 63).

Outra linha de argumentação mobilizada pelo deputado foi a comparação entre a seca na Parahyba e a do Ceará, província que concentrava maior visibilidade no cenário nacional.¹⁶⁷ Segundo ele, a imprensa parahybana silenciava sobre os sofrimentos enfrentados pela população, de modo que temas centrais da crise “foram abafados pelo silencio”. Para Meira de Vasconcellos, o exemplo a ser seguido era o da imprensa cearense, que, independentemente das posições políticas, conseguiu projetar a gravidade da seca, fazendo com que as notícias alcançassem repercussão “do extremo norte até o extremo sul” do Império (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. I, p. 177).

¹⁶⁷ BRASIL. *Annaes do Parlamento Brasileiro: Câmara dos Srs. Deputados*. Primeiro anno da décima-sétima legislatura. Sessões de 1878. Tomo IV. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879.

Ainda insatisfeito com a disparidade na distribuição de verbas e com o destaque concedido ao Ceará tanto na Câmara dos Deputados quanto em outros espaços de alcance nacional, o parlamentar insistiu que a Parahyba sofria em igual intensidade, embora permanecesse à margem da atenção pública, como expressa no seguinte trecho:

[...] o Ceará de preferencia attrahia a attenção de todos, até do estrangeiro, dentro e fóra do Imperio sómente se fallava na sêcca do Ceará, **de maneira que parecia naquelle tempo que o Ceará era a unica provincia que soffria; mas, a minha provincia no silencio da dor soffria igualmente tanto quanto o Ceará. a fome e a peste lhe devastavam igualmente a população** (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. I, p. 177. Grifos nossos).

O contraste entre o discurso inflamado de Meira de Vasconcellos e o conteúdo final de seu requerimento evidencia os limites institucionais do Parlamento, no qual a dramatização do sofrimento funcionava como recurso político para ampliar os socorros, sem questionar de forma efetiva os critérios que orientavam a política de assistência imperial. Seu apelo combinava a busca por reconhecimento regional com a afirmação da incapacidade da Parahyba de enfrentar a crise sem o auxílio direto do governo central.

Passamos agora à atuação de outro deputado parahybano, Manoel Pedro Cardoso Vieira¹⁶⁸, em março de 1879¹⁶⁹. Sua intervenção ocorreu em um cenário de tensões acumuladas, alimentadas pela omissão e má gestão dos socorros públicos, das quais ele próprio havia participado em instâncias administrativas e políticas anteriores à sua atuação na Assembleia Geral, por parte do governo central e, em especial, pela circular de 14 de outubro do ano anterior, que, segundo o parlamentar, teria suspendido as remessas de gêneros às províncias do Norte.

Manoel Pedro¹⁷⁰ inicia sua intervenção denunciando o agravamento da situação na Parahyba, apoiando-se em relatos sobre a fome, taxa de mortalidade e o colapso social enfrentado pela população. Em seguida, apresenta uma interpelação formal ao governo, estruturada em seis quesitos, voltados a esclarecer as medidas adotadas pelo governo, as instruções aos delegados locais, os resultados da distribuição de gêneros, os fundamentos da

¹⁶⁸ Natural da freguesia de Jacoca (atual Conde, PB). A presença no espaço legislativo geral, no final da década de 1870, segundo Rocha (2012), revela a importância que alcançou na política imperial. Com atuação multifacetada, foi advogado, professor de Retórica no Lyceu Provincial, fundador e colaborador de jornais, poeta e orador com reconhecida habilidade, envolvido em frequentes embates e polêmicas políticas. Apesar de ter vivido apenas 32 anos, construiu uma trajetória marcante. Faleceu no início de 1880, na capital do Império, enquanto exercia o mandato de deputado geral, vítima da chamada “febre perniciosa” (Rocha, 2012).

¹⁶⁹ BRASIL. **Anais do Parlamento Brasileiro**: Câmara dos Srs. Deputados. Primeiro anno da décima-sétima legislatura, sessão de 1878. Tomo IV. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879.

¹⁷⁰ No Anais do Parlamento Brasileiro, Manoel Pedro Cardoso Vieira é frequentemente identificado apenas como “Manoel Pedro”. Também adotaremos essa forma de referência ao mencioná-lo nas sessões parlamentares.

circular de outubro, a quantidade de mantimentos remetidos e as responsabilidades pela condução da crise (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. IV, p. 43).

Nesse sentido, enfatiza que sua intenção não é criar polêmica, mas cumprir o dever político de representar sua província: “Não tenho pretensões a ser amável. Pode fazer isto o deputado que deixa atrás de si amigos que sacrificaram tempo, dinheiro, para mandá-lo a esta casa?” (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. IV, p. 43).

A interpelação de Manoel Pedro foi incluída na ordem do dia após aprovação de urgência pela Câmara. Em resposta, o ministro Leôncio de Carvalho afirmou que os pedidos da Parahyba se restringiam ao envio de gêneros, supostamente atendidos com regularidade e orientados pelo princípio de evitar a dependência, a ociosidade e a mendicância. Acrescentou ainda que os delegados buscavam empregar a população em trabalhos considerados úteis, como a fundação de colônias, a abertura de estradas e a construção de escolas. Manoel Pedro contestou essa leitura, apontando insuficiências e atribuindo a irregularidade dos socorros ao próprio sistema adotado, ao passo que o ministro reconheceu dificuldades persistentes, explicando-as como herança de práticas administrativas anteriores (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. IV, p. 51).

Por último, o deputado questionou se o decreto que autorizava a construção de linhas férreas no Ceará e em Alagoas não poderia ser estendido para substituir o auxílio pago aos trabalhadores de estradas na Parahyba. O ministro respondeu que não havia impedimento e que o governo já fazia esforços para compatibilizar os socorros com as obras públicas. Ao longo da discussão, Manoel Pedro interveio diversas vezes, contestando as justificativas do ministro e insistindo que o quadro na província permanecia grave. Ele destacou que, segundo informações recebidas, a mortalidade era elevada e que o governo subestimou a crise (Brasil, Câmara dos Deputados, 1879, t. IV, p. 52).

Para Júlio César Santos e Lucian Silva (2020), a preocupação de Manoel Pedro Cardoso Vieira ao interpelar o governo imperial não se limitava apenas aos flagelos causados pela seca. Mesmo com o discurso permeado por imagens dramáticas da situação no sertão e da província em si, é possível perceber que sua atuação também atendia a outros setores políticos. Como apontam os autores, “mas pelo que tudo indicava, sua insistência no assunto dava-se pela possível pressão que estava recebendo de seus correligionários locais e grupos dos dominantes que desejavam investimentos do governo e maiores quantias para a província” (Santos; Silva, 2020, p. 490).

Essa leitura é reforçada pelas próprias palavras do deputado, que evocou na tribuna o esforço dos “amigos que sacrificaram tempo, dinheiro” para garantir sua presença no

Parlamento. Nesse contexto, a defesa enérgica de socorros à Parahyba também funcionava como uma forma de prestar contas a essas elites locais, dentro de um cenário político marcado por práticas clientelistas e relações de troca, nas quais a lealdade entre representantes e seus grupos de apoio era essencial para a manutenção de influência e da projeção política tanto em âmbito regional quanto nacional (Santos; Silva, 2020, p. 490).

Vemos, portanto, que essas discussões revelam um deslocamento analítico que ultrapasse a compreensão da política como mero reflexo institucional ou administrativo. Como têm apontado os estudos sobre culturas políticas, o espaço parlamentar constitui também um campo de produção de sentidos, no qual discursos, valores, linguagens e estratégias de legitimação são continuamente mobilizados e disputados. Nesse enquadramento, a seca não aparece apenas como calamidade natural ou problema econômico, mas como objeto de elaboração política, acionado pelos deputados em consonância com projetos, expectativas e formas específicas de representação do poder no Império.

Desse modo, a análise das intervenções de João Florentino Meira de Vasconcellos e Manoel Pedro Cardoso Vieira permite compreender como a seca de 1877-1879 foi convertida em objeto de disputa política no Parlamento imperial, articulando denúncia, reivindicação e negociação dos socorros públicos. Ambos os deputados mobilizaram informações oriundas da província: inclusive os mesmos relatos que estimavam a mortandade em mais de 20 mil pessoas, para confrontar o discurso oficial e pressionar o governo central por recursos. As diferenças entre suas atuações não residem no diagnóstico da crise, mas nas estratégias adotadas no espaço parlamentar.

Enquanto Meira de Vasconcellos privilegiou uma narrativa fortemente dramática, voltada à sensibilização da Câmara e à ampliação dos auxílios, Manoel Pedro recorreu a uma interpelação formal, estruturada em quesitos, que buscava responsabilizar diretamente o governo geral pela condução dos socorros. Em ambos os casos, a representação da Parahyba como província arruinada e incapaz de enfrentar a calamidade sem a intervenção do governo geral funcionou como elemento central de legitimação das demandas, revelando como a política de assistência se constituiu não apenas como resposta humanitária à seca, mas como campo de negociação, hierarquização regional e afirmação de projetos políticos no interior do governo imperial.

Ao longo deste extenso capítulo, percebemos que o migrante não aparece apenas como alguém que se desloca em busca de sobrevivência, mas como uma figura social produzida pela própria dinâmica da seca e pelas respostas institucionais a ela. Desde os primeiros fluxos

oriundos do Sertão em direção ao Agreste e ao Litoral, observa-se que esses deslocamentos não foram percebidos de forma neutra pelas autoridades.

Ao contrário, o migrante foi rapidamente associado à ociosidade, ao risco sanitário, à desordem urbana e à pressão sobre os cofres públicos. Sua presença nos espaços da Capital e das vilas do interior desencadeou políticas que combinavam assistência e controle, socorro e disciplina, trabalho compulsório e vigilância constante.

Nos núcleos coloniais e nas obras públicas, o migrante foi enquadrado como força de trabalho a ser aproveitada, mas também como corpo a ser regulado. Sua admissão dependia de atestados de conduta e de comprovação de “aptidão ao trabalho”; sua permanência estava condicionada à obediência, à produtividade e à submissão às normas impostas pelos administradores.

Nos hospitais, figurava como paciente desassistido, muitas vezes sem roupas e sem tratamento adequado; nos discursos parlamentares, transformava-se em argumento político, mobilizado para reivindicar recursos ou denunciar omissões do governo imperial. Entre a caridade, o disciplinamento e a instrumentalização política, o migrante foi simultaneamente vítima da calamidade e objeto de administração.

Destacamos ainda que o mapeamento das enfermidades, das causas de morte e das práticas terapêuticas, que será desenvolvido no próximo capítulo, encontra suas bases nesses fluxos iniciais, que reorganizaram espaços, intensificaram a circulação de pessoas e redefiniram as relações entre poder, assistência e vida. Assim, compreender o migrante como categoria histórica, construída no cruzamento entre deslocamento, vulnerabilidade e controle, é fundamental para entender como a seca não apenas moveu corpos pelo território, mas produziu novas formas de governá-los.

Diante desse cenário, torna-se necessário deslocar o olhar para as condições de saúde da população migrante e atingida pela seca, observando os espaços que passou a ocupar e as dificuldades enfrentadas para garantir a própria sobrevivência. A análise das doenças e das diferentes formas de tratamento então mobilizadas permitirá compreender como esses corpos deslocados, já marcados pela fome e pela disciplina do trabalho, também se tornaram alvo de intervenções médicas e higienistas no contexto da crise.

3 “EXTENUADOS DE FOME, CANSAÇO E MISÉRIA”: ASPECTOS SOBRE A SAÚDE, AS DOENÇAS E A MEDICINA

A partir das migrações ocorridas no contexto da seca de 1877-1879, identificamos registros que evidenciam as trajetórias de famílias, homens, mulheres, crianças e idosos que, ao migrarem, enfrentaram rupturas no cotidiano e incertezas constantes, tanto ao longo do processo migratório quanto nos destinos de chegada. Em um primeiro momento, este capítulo se dedica a compreender como esses grupos foram classificados e descritos pela documentação como “desvalidos”, “indigentes” e “flagelados” – e de que maneira tais representações se articularam às políticas de socorro e às formas de assistência médico-hospitalar então disponíveis.

Na sequência, analisamos as principais doenças e causas de morte registradas nos livros de óbitos do Sertão (Pombal, Cajazeiras e Teixeira), região que foi a mais atingida pela seca. Os dados permitem observar que a fome, as febres diversas, as disenterias, as hidropisias e a varíola estiveram entre as enfermidades que mais vitimaram a população. Os registros também revelam situações extremas de privação alimentar, que atingiram de forma particularmente grave recém-nascidos, crianças e pessoas idosas, além de episódios-limite associados à fome prolongada, como práticas de canibalismo.

O capítulo contempla ainda a análise da atuação dos médicos durante a seca, assim como a presença de práticos como boticários, farmacêuticos e curandeiros – que exerceram suas atividades por meio de boticas e serviços prestados tanto nos hospitais quanto em diferentes municípios da província. Buscamos compreender quais métodos terapêuticos foram empregados, destacando a coexistência de práticas alopáticas e homeopáticas, além das teorias miasmáticas então vigentes. Observamos que a homeopatia apareceu com frequência significativa na documentação, sendo possível mapear os hospitais e municípios que receberam medicamentos, ao passo que outros registraram reiteradas queixas quanto à sua escassez.

Desse modo, o objetivo deste capítulo consiste em analisar as condições de vida e saúde da população atingida pela seca, com ênfase nos migrantes, nas doenças que os acometeram e no papel desempenhado por médicos e práticos no âmbito das práticas terapêuticas. Para tanto, mobilizamos um conjunto diversificado de fontes: mapas das casas de caridade, hospitais e enfermarias, registros de óbitos, listas de medicamentos e funcionários, cartas e correspondências locais, ofícios administrativos e notícias publicadas em jornais da Parahyba e de outras províncias.

3.1 “ERAM DESVALIDOS, INDIGENTES E FLAGELADOS”: AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO PARAIBANA

Nesta data **acabam de morrer dois pais de família, além de outros, deixando os abrigos da orphandade e da miseria numero crescido de filhos menores por falta** (um dos principais motivos) de remediar; cujo fato causou tal sensibilidade nos habitantes, que tacharam de negligentes e indiferentes os membros desta comissão. E como estes dois infelizes, se acham muitas á morrer do destino, esperando a hora fatal. É clamorosa e humilhante urgência! (Comissão de Socorros Públicos na Povoação de Pitimbu, AHWBD, 15/05/1879. Grifos nossos¹⁷¹).

Cada história relatada no período da “Grande Seca” revela trajetórias de famílias, homens, mulheres, crianças e idosos tentando sobreviver às circunstâncias da fome, da miséria, das doenças e das epidemias. As migrações evidenciam que, ao deixar o ponto de partida, ocorria uma ruptura profunda do cotidiano, enquanto, até alcançar o destino, persistiam as incertezas sobre o que lhes aguardava, tanto ao longo do caminho percorrido a pé, sob o “sol abrasador”, quanto nos locais de chegada. Muitos seguiam carregando crianças pequenas, sacolas com algumas roupas e poucos pertences, enfrentando um percurso marcado pelo desgaste físico, pela insegurança e pela privação contínua de alimento e abrigo.

Nesse contexto, o adoecimento não pode ser compreendido como algo que acompanha o migrante de forma inerente, mas como uma condição produzida e agravada pelas circunstâncias da própria migração. A presença recorrente de migrantes nos hospitais e enfermarias deve ser lida não apenas como mero indicador de doença, mas como evidência de trajetórias atravessadas pela circulação constante entre espaços de trabalho, acolhimento precário e exclusão, nas quais a fome, a exposição às intempéries, a concentração populacional e a falta de assistência médica adequada transformavam o percurso migratório em um espaço de produção da enfermidade. O adoecimento, portanto, integrava a própria experiência migratória, sendo resultado das condições materiais e sociais que estruturavam esses percursos.

Nas palavras de Rodolfo Teófilo (2015 [1890]a, p. 47), as estradas, de um lado, eram tomadas por milhares de caravanas de pessoas famintas, “de todas as idades”, muitas delas já em estado esquelético; de outro, encontravam-se “ossos humanos, cuja pele seca e colada os conservava articulados”. Para poupar os filhos da visão dessas cenas, Manuel de Freitas¹⁷²

¹⁷¹ Comissão de Socorros públicos na Povoação de Pitimbu em 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁷² Na obra, o personagem central é Manuel de Freitas, sertanejo ligado a uma das famílias tradicionais do interior cearense. Herdeiro de uma pequena fortuna e detentor de boa formação, ele vê sua vida ser reorganizada pela

optava por seguir caminho pelas matas. Carregava pouco mantimento, levando apenas algumas borrachas de água¹⁷³ para beber, mas, ainda assim, não conseguia escapar daqueles que, “com o instinto de animal esfomeado, pressentiam que levava alimento e cercavam-no, pedindo de joelhos uma migalha pelo amor de Deus” (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 47).

Na Parahyba, apesar de não dispormos de um número exato sobre o total de migrantes deslocados pela seca, estima-se que apenas a Capital e seus arredores tenham recebido entre 30 e 35 mil pessoas nos anos de 1877 e 1878, conforme informado pelo presidente da província, Dr. Ulysses Vianna, em relatório apresentado em 1º de janeiro de 1879¹⁷⁴. Esse dado aparece de forma pontual, sem que o relatório apresente os critérios utilizados para chegar a essa estimativa. Além disso, esse número não é retomado em outras fontes administrativas, como nos registros da Comissão Central ou local.

Isso não invalida a informação apresentada pelo presidente, mas indica que se trata de uma estimativa produzida em um contexto de dificuldades administrativas e de falta de registros mais precisos. Não podemos esquecer que a menção aos números elevados também cumpria a função de mobilizar recursos e de chamar atenção para o papel desempenhado pelo governo geral na prestação de assistência às populações afetadas.

Nesse mesmo contexto, outras fontes também registraram a presença de contingentes expressivos de migrantes na província. As informações publicadas pelo jornal *A Reforma* (RJ), na seção do *Diário Oficial*, reforçam a dimensão das migrações durante a seca ao mencionar a existência de mais de 20 mil pessoas concentradas na Parahyba.¹⁷⁵

Esses registros também relatam as dificuldades em promover a chamada “emigração espontânea”, apresentada como uma alternativa para aliviar a sobrecarga populacional, já que, em um intervalo de dez dias, cerca de 400 migrantes, “na maior parte achados de várias moléstias”, aceitaram embarcar, mesmo de forma relutante, com destino à província de Alagoas, com outros 400 migrantes de Pernambuco (*A Reforma* (RJ), n.º 199, 01/09/1878, p. 2).

Essa redistribuição de migrantes já ocorria desde o primeiro ano da seca e estendia-se também à província do Amazonas, que passou a receber famílias vindas dos sertões do Rio

irrupção da seca de 1877, que força a família a abrir mão dos bens e seguir, a pé, em direção a Fortaleza. Ao longo desse deslocamento, o grupo enfrenta sucessivos obstáculos.

¹⁷³ Segundo Teófilo (2015 [1890], p. 13), eram bolsas de couro utilizadas pelos sertanejos para as longas viagens.

¹⁷⁴ PARAHYBA DO NORTE, Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial da provincia da Parahyba do Norte pelo presidente, Exm. Sr. Doutor Ulysses Machado Pereira Vianna, em 1º. de janeiro de 1879.

¹⁷⁵ Também envolvia a província do Pará, uma vez que a operação de transporte marítimo de migrantes estava vinculada à rota dos navios que partiam ou eram coordenados a partir dessa província (*A Reforma* (RJ), n.º 199, 01/09/1878, p. 2).

Grande do Norte e da Parahyba (*A Reforma (RJ)*, n.º 122, 15/08/1877, p. 3). As fontes, no entanto, pouco informam sobre como esse deslocamento ocorria na prática. Não há referências sobre as condições de chegada, sobre a existência de alojamentos ou das formas de inserção dessa população no local de destino. Supõe-se que boa parte tenha sido encaminhada para as frentes de trabalho ou obras públicas, mas essa informação não pode ser confirmada pela documentação consultada. Também não é possível identificar por quanto tempo essas famílias permaneceram nesses espaços nem se houve retorno para seus locais de origem.

Já no agreste parahybano, municípios como Araçagy presenciavam a chegada de “3.000 e tantas pessoas para socorrer”, enquanto, em Independência (Guarabira), a seca “tem feito emigrar para esta comarca talvez mais de duas mil pessoas”.¹⁷⁶ Na comarca de Bananeiras, a situação mostrava-se ainda mais grave, com a existência de “uma população desvalida de cerca de 10 mil pessoas”, quantitativo semelhante ao registrado em Campina Grande¹⁷⁷. Na cidade de Areia, segundo Horácio de Almeida (1958a, p. 132), o brejo, “que já não comporta tantos flagelados”, recebeu cerca de 25 mil migrantes, “dos quais morriam de fome pelas calçadas”.

Esses grupos eram formados por pessoas provenientes de diferentes localidades da Parahyba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará¹⁷⁸. Se somarmos os números já mencionados, chega-se a uma estimativa de cerca de 50 mil migrantes apenas na região do agreste. No entanto, quando o olhar se volta para o brejo, os números apresentados pela imprensa tornam-se ainda mais expressivos.

Em novembro de 1877, o jornal *O Despertador* – em notícia posteriormente reproduzida pelo jornal *A Reforma (RJ)* – apontava que “são talvez 100 mil retirantes acumulados nos brejos, vivendo da esmola insuficiente que lhe distribue o governo, [...], habituando-se á mendicidade, essa escola de todos os vícios”. Segundo o periódico, o brejo havia se tornado, assim como a Capital, uma das regiões mais procuradas pelos migrantes, mas não possuía condições de abrigar nem de alimentar “a quase toda a população pobre dos sertões” (*A Reforma (RJ)*, n.º 264, 21/11/1877, p. 2).

¹⁷⁶ Comissão de Socorros de Araçagy, 24 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.; Juizado de Direito da Comarca da Independência em 23 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

¹⁷⁷ Ofício da Comarca de Bananeiras, em 6 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).; Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

¹⁷⁸ Gabinete da Comissão Central de Socorros, AHWBD, 30/11/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Como vimos no capítulo anterior, enquanto uns ficavam alojados nas colônias agrícolas ou dispersados em obras públicas, outros permaneciam ao relento nas ruas e calçadas. Já outra parte daqueles classificados como “desvalidos”, “indigentes” e “flagelados” encontrava abrigo nas Casas de Caridade de Santa Fé, Pocinhos e Cabaceiras, além da Santa Casa da Misericórdia, na Capital – quando necessitavam de atendimento médico e ali permaneciam mesmo após curados –, bem como nos hospitais de São Pedro, em Mamanguape, e de Areia, que funcionaram como importantes polos de acolhimento de órfãos e de pessoas vindas de regiões muito distantes, fugindo da seca e sem redes de apoio locais.

É nesse contexto que se insere o caso de Maria Francisca da Conceição, migrante viúva, natural de Patos, que se encontrava na Capital desde 1878, acompanhada de seus três filhos.¹⁷⁹ Segundo declaração datada de 22 de maio de 1879, a sobrevivência da família dependia do auxílio prestado por terceiros, uma vez que “viveu a suas expensas”, expressão que indica que foram mantidos pelo próprio declarante, Antônio de Paula Carvalho de Albuquerque¹⁸⁰. Ainda assim, a carta relata que a falta de alimentação e a provável desnutrição, contrastada pela “nudez em que se achão, e isto torna-se patente a olhos nuz”, impediam o retorno à sua terra natal (Parahyba, AHWBD, 22/05/1879).

No trecho que abre esta seção, três gestores da Comissão de Socorros de Pitimbu, no litoral do extremo Sul da Parahyba, comunicam à administração provincial que a população migrante não possuía mais nenhum recurso, sendo o principal deles o “pão da caridade”. Para piorar a situação, esses indivíduos vinham sendo ceifados não apenas pelo “abandono às vistas da administração de V. Exa.”, mas também pelas epidemias de febres e de varíola, as mais recorrentes do período, o que tornava urgente o recebimento dos 24 remédios homeopáticos necessários para iniciar o tratamento, solicitados há cerca de dois meses (Comissão na Povoação de Pitimbu, AHWBD, 15/05/1879).

Como está registrado no trecho, as doenças epidêmicas vitimavam também os pais de família, o que acarretava a desestruturação dos núcleos familiares, uma vez que esses homens eram socialmente reconhecidos como responsáveis pelo sustento doméstico. Com a morte desses provedores, muitas crianças acabavam lançados à orfandade e à miséria, intensificando

¹⁷⁹ Parahyba, 22 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁸⁰ Não encontramos informações adicionais a respeito de Antônio de Paula Carvalho de Albuquerque nas fontes consultadas. Ainda assim, a própria declaração permite supor que o declarante possuía reconhecimento social suficiente para que sua palavra tivesse validade administrativa, já que foi enviada ao vice-presidente da Província, dispunha de recursos mínimos para sustentar, ainda que provisoriamente, uma mulher viúva e seus três filhos, e atuava como intermediador entre a população pobre e as instâncias de socorro, papel comum a indivíduos que, mesmo fora das estruturas formais do governo, mediavam o acesso aos auxílios durante a seca.

os efeitos sociais da seca para além do adoecimento individual. O documento destaca, ainda, que tais mortes causaram forte comoção entre os habitantes da localidade, que passaram a atribuir aos membros da Comissão de Socorros a responsabilidade pelo agravamento da situação, taxando-os de “negligentes e indiferentes” (Comissão na Povoação de Pitimbu, AHWBD, 15/05/1879).

Diante desse cenário, a ameaça de exoneração dos administradores da Comissão não expressava abandono da função, mas antes uma reação à impossibilidade de cumprir suas atribuições frente à ausência de medicamentos e outros recursos, além do avanço das epidemias. É possível ainda, a partir da menção a um pedido de renúncia coletiva, levantar a hipótese de que a comissão buscava deslocar para a administração provincial a responsabilidade pelas mortes, proteger-se das acusações e pressionar o governo a responder às requisições ignoradas, fatores que, mais uma vez, expressam as tensões e os limites das políticas de socorro no interior da província.

Em consequência da insuficiência da ação governamental, outras formas de assistências foram essenciais para amparar os grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes de lançados à orfandade, além de pessoas de diversas idades que também recebiam acolhimento e cuidados básicos. É a partir desses cenários que se inserem os casos das Casas de Caridade, integrantes de um conjunto mais amplo de 22 instituições criadas entre os anos de 1860 e 1872, das quais dez foram fundadas na província da Parahyba¹⁸¹, sob a administração do Padre Ibiapina¹⁸². Vejamos, a seguir, três redes de assistência mantidas pelo padre, no contexto da seca.

Em carta enviada ao presidente da província, ainda no primeiro ano da seca, o Pe. Ibiapina faz um comovente pedido de socorro em favor da Casa de Caridade de Santa Fé, em Solânea, que abrigava um elevado número de crianças órfãs menores de sete anos. Segundo o

¹⁸¹ De acordo com Gilson Lopes da Silva (2022, p. 5), após retornar à Parahyba, o Pe. Ibiapina construiu hospitais de emergência nas localidades de Areia e Alagoa Nova, devido à epidemia do cólera. Posteriormente, esses espaços foram convertidos em Casas de Caridade, ampliando suas funções e passando a oferecer assistência social permanente, configurando-se como os primeiros recolhimentos fundados na província. Segundo o autor, as instituições parahybanas destacaram-se por seu maior desenvolvimento, em razão da presença do Pe. Ibiapina, exercendo maior controle sobre seu funcionamento. Na Parahyba, foi responsável pela fundação de dez Casas de Caridade – Areia, Alagoa Nova, Santa Luzia do Sabugi, Pocinhos, Parari (Pombas), Santa Fé, Souza, Cajazeiras, Cabaceiras e Campina Grande.

¹⁸² José Antônio de Maria Ibiapina (1806-1883), conhecido como Padre Ibiapina, nasceu em Sobral, no Ceará. Antes de ingressar na vida religiosa, exerceu funções como advogado, juiz de direito e deputado. Aos 47 anos, optou por abandonar a carreira pública e dedicar-se ao sacerdócio, passando a percorrer os sertões do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. Destacou-se pela evangelização associada a ações de caráter social e educativo, contribuindo para o desenvolvimento local por meio “da construção de açudes, cemitérios, capelas, cacimbas, igrejas e as Casas de Caridade, que figuram entre suas principais obras” (Silva, G., 2022, p. 1-2).

sacerdote, essas crianças encontravam-se sem alimentação adequada e com o abastecimento de água prestes a se esgotar (Lima, D., 2009, p. 74).

Para Danielle de Lima (2009, p. 74), as cartas do Pe. Ibiapina revelam um contraste entre as expectativas depositadas nas migrações para localidades consideradas, naquele momento, menos atingidas pela seca, frequentemente entendidas como uma espécie de “terra prometida”, capaz de suprir as necessidades por meio de uma ampla rede de auxílios. Contudo, o conteúdo dessas correspondências mostra uma realidade distinta, marcada por preocupações e angústias do padre diante da fome e das mortes que assolavam a população assistida.

Como única alternativa, o padre mobilizava uma retórica fortemente ancorada na moral cristã, recorrendo a passagens bíblicas associadas ao juízo final e reforçando a ideia de salvação dos “bons”, ao mesmo tempo em que advertia sobre a condenação dos que não praticassem a caridade, estratégia que buscava sensibilizar a comunidade e estimular a partilha como dever religioso.

No caso da povoação de Pocinhos, o relato de Irineu Joffily expõe que a casa local abrigava mais de 70 órfãos, mas, após a perda de seu patrimônio, passou a enfrentar uma situação extrema de escassez alimentar. Diante desse quadro, as meninas órfãs não encontravam outra alternativa a não ser o consumo de “carne putrefata das reses que morrião inanidas pelas estradas”. Como consequência, registrou-se a disseminação de enfermidades epidêmicas, que reduziram drasticamente o número de internos da instituição, além de afetarem o restante dos moradores da povoação (Joffily, 1892, p. 95-96).

Em Cabaceiras também foram registradas cenas semelhantes às anteriores, como descrito na carta¹⁸³ enviada em 16 de dezembro de 1879 pela regente Veneranda Maria de São José Ibiapina ao presidente da província. Logo no início de seu relato, ela revela não saber se poderia contar com a remessa de auxílios prevista para o fim de janeiro, uma vez que havia sido informada anteriormente de que a vila poderia estar excluída da distribuição, o que preocupava a manutenção das atividades da casa, que contava com o trabalho de um grupo composto por 18 mulheres e 1 beato, além do acolhimento de 38 meninas órfãs (Casa de Caridade da Villa de Cabaceiras, AHWBD, 16/12/1879).

Diante da ausência de alternativas institucionais e sem ter a quem recorrer, a regente apelava diretamente à autoridade provincial, solicitando o reconhecimento de que, “nestas condições miseráveis por via da crise dolorosa, somos dignos da caridade do governo. Por Deus espero do coração bem fasejo de V. Exa. que serei atendida por muito justa [serem]

¹⁸³ Casa de Caridade da Villa de Cabaceiras aos 16 de dezembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

minhas súplicas à crise dolorosa” (Casa de Caridade da Villa de Cabaceiras, AHWBD, 16/12/1879).

Quando essas crianças não eram abandonadas nas Casas de Caridade, muitas famílias recorriam à distribuição de seus filhos (as) entre casas consideradas menos expostas à pobreza, inserindo essas crianças em relações precoces de trabalho doméstico (Almeida, J., 2012 [1923], p. 162). Longe de representar uma forma de proteção adequada, essa prática implicava a submissão a uma condição servil, marcada pela dependência, pela ausência de remuneração e pela perda do convívio familiar. A presença dessas crianças nos serviços domésticos em várias localidades do interior revela, assim, uma estratégia de sobrevivência acionada diante da fome e da desagregação social provocadas pela seca.

A Capital da Parahyba também presenciou um elevado número de órfãos (as). De acordo com Nereida Martins (2019, p. 201), o provedor da Santa Casa, Lindolfo José Correia das Neves, exprimia preocupações que ultrapassavam suas possibilidades de atuação ao presenciar cenas que se tornavam recorrentes: muitas mães buscavam tratamento no hospital, enquanto a instituição ficava encarregada de abrigar seus filhos, que acabavam lançados à orfandade quando ocorria o falecimento materno.

Essas situações também geravam outra inquietação, relacionada ao aumento das despesas públicas necessárias para cuidar e alimentar um contingente cada vez maior de pessoas. Ainda assim, chamavam-lhe atenção as cenas de abandono infantil: “crianças famintas, que andavam mendigando na rua, e apanhando para comer matérias nocivas”.¹⁸⁴

Ainda na Santa Casa¹⁸⁵, muitos migrantes internados, nas palavras do provedor Benjamin Franklin de Oliveira, encontravam-se “estragados por uma vida irregular, sem commodos, sem agasalho”, o que evidencia que a própria Casa de Caridade não dispunha de condições para acolher a totalidade dos necessitados, diante da escassez de camas e vestimentas – situação já discutida no capítulo anterior e que, infelizmente, se repetia com frequência (Relatório do Provedor da SCM, SCMPB, 1879, p. 44).

Não por acaso, a população migrante era atribuída como uma das causas para os entraves da Santa Casa. É o que justifica o médico e cirurgião mor da Província, Antônio da Cruz Cordeiro¹⁸⁶, ao classificar os doentes internados de “proletários”, no sentido depreciativo, ou seja, pobres, desprovidos de bens e de recursos materiais. Além disso, associa

¹⁸⁴ Relatório de Mordomia do Hospital da Caridade, 21 de junho de 1879, fl. 1f., *apud* Martins, 2019, p. 201.

¹⁸⁵ Relatório do Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Parahyba em 1879. Santa Casa da Misericórdia da Paraíba (SCMPB), p. 44.

¹⁸⁶ Offício n.º 674, da Santa Casa da Misericórdia enviado ao presidente da província Dr. Esmerino Gomes Parente, 10/07/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

a pobreza à ausência de hábitos de higiene e de civilidade, ao acusar os doentes de serem “sem hábitos de asseio e de cerimônia, que não emporcalham como destroem os objetos de seu uso, que não poucas vezes ficam inutilizados” (Offício nº674, AHWBD, 10/07/1877).

No entanto, é importante lembrar que, em décadas anteriores à seca de 1877, já existiam reclamações recorrentes sobre a falta de estrutura da Santa Casa, as quais não resultaram em melhorias efetivas. Essas queixas continuavam a ocupar as páginas de relatórios médicos e administrativos, ao mesmo tempo em que as verbas destinadas à instituição não apenas deixavam de aumentar, como sofriam reduções sucessivas ao longo dos anos.

Para o ano de 1877, inclusive, essas dificuldades foram alvo de críticas do presidente da Câmara Municipal da Capital¹⁸⁷ que, em sessão extraordinária, constatava a inexistência de um orçamento adequado e, mais grave ainda, a ausência de “crédito para pagamento de um médico” (Offício n.º57, Paço da Camara Municipal da Capital da Parahyba, AHWBD, 19/01/1877). O próprio presidente da província reconhecia que, além de a instituição se encontrar “fora de todas as condições de hygiene”, os recursos financeiros eram insuficientes para suprir suas necessidades (Parahyba do Norte, Relatório, 12/08/1877, p. 38).

Nessa conjuntura desproporcional de acolhimento e tratamento, além da fome, esses indivíduos estavam acometidos por enfermidades diversas, como vírus, ulcerações *phagedênicas*, decorrentes do clima quente, que produziam feridas do tipo “roídas”, com maior incidência nos membros inferiores, possivelmente associadas ao prolongado tempo de exposição ao sol e às condições precárias de vida (Relatório do Provedor da Santa Casa da Misericórdia, SCMPB, 1879, p. 44).

Como a contenção e a redistribuição da população migrante constituíam um objetivo recorrente da administração provincial, outros espaços passaram a ser criados com a finalidade de abrigar essa população e prestar assistência médica. O presidente da província, Dr. Ulysses Vianna, ao constatar que os alojamentos e edifícios públicos da Capital já enfrentavam a presença de febres reinantes e “quaisquer outras moléstias”, com “para mais de 5.000 pessoas aglomeradas”, decidiu ampliar a rede de atendimento, autorizando a criação de novas enfermarias. Esse processo culminou na instalação do chamado Hospital da *Guia*¹⁸⁸, localizado na área rural do Convento do Carmo, como parte das medidas adotadas para

¹⁸⁷ Offício n.º57, Paço da Camara Municipal da Capital da Parahyba, em sessão extraordinária de 19 de janeiro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

¹⁸⁸ Apesar de se tratar de um hospital de caráter emergencial, não foram localizadas fontes que indiquem o movimento de entrada e saída de pacientes, nem registros de contratação de médicos ou práticos.

“desafogar” a concentração na Capital e isolar os doentes (*A Reforma (RJ)*, n.º 98, 02/05/1878, p. 2).

Enquanto isso, em Mamanguape, o Hospital de São Pedro¹⁸⁹ destacou-se como uma das instituições mais ativas, exercendo uma função dupla ao acolher os “desvalidos” e também aqueles acometidos de varíola ou outras doenças. Para se ter uma ideia da composição do Hospital, é possível recorrer ao cruzamento de duas listas que relacionam órfãos e pessoas de diferentes idades que recebiam assistência da instituição.

Cabe destacar, que as fontes não informam idades precisas: os indivíduos são identificados apenas como “menor” ou, na ausência dessa indicação, inferidos como adultos. Ainda assim, esse levantamento permite identificar o perfil geral dos sujeitos atendidos e compreender a diversidade dos grupos amparados pelo hospital durante a seca.

Na primeira lista, acerca *dos órfãos e outras pessoas válidas*¹⁹⁰, registra-se um total de 33 indivíduos, dos quais 11 eram adultos, sendo 3 homens e 8 mulheres, enquanto 22 eram órfãos, 10 meninos e 12 meninas. A designação de “pessoas válidas” não deve ser compreendida como indicativo de ausência de necessidades básicas, tampouco como exclusão do acesso à alimentação, mas como uma classificação administrativa que sugeria capacidade física para o trabalho, ainda que esses indivíduos permanecessem sob amparo institucional (Secretaria do Hospital de S. Pedro, AHWBD, 7/04/1879). Como esclarece o secretário do hospital¹⁹¹, tratava-se de pessoas que, “por terem perdido ali seus pais ou maridos, se conservão na casa às expensas do estado” (Sala das reuniões das comissões de socorros de Mamanguape, AHWBD, 26/04/1879).

Já a segunda lista, *das pessoas desamparadas, que comem no Hospital*¹⁹², composta por 14 pessoas, evidencia a predominância de menores, muitos deles identificados apenas pelo prenome. Desse conjunto, 7 eram órfãos, sendo 4 meninas e 3 meninos. A relação é completada por 4 viúvos (as), entre os quais 3 mulheres e 1 homem, indicando a presença de adultos marcados pela perda do provedor familiar e pela dependência direta da assistência

¹⁸⁹ Cidade de Mamanguape, 20 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁹⁰ Secretaria do Hospital de S. Pedro - Relação dos órfãos e outras pessoas válidas no Hospital da Cidade de Mamanguape, no dia 7 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁹¹ Sala das reuniões das comissões de socorros de Mamanguape, 26 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁹² Secretaria do Hospital de S. Pedro, em Mamanguape, 23 de abril de 1879 – Lista das pessoas desamparadas, que comem no Hospital S. Pedro na Cidade de Mamanguape. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

institucional para a subsistência cotidiana (Secretaria do Hospital de S. Pedro, AHWBD, 23/04/1879).

Consideradas em conjunto, as duas relações evidenciam que a identificação incompleta, especificamente entre os menores, era recorrente, ao passo que os adultos apareciam com maior frequência plenamente nomeados. A comparação entre as listas demonstra que o Hospital de São Pedro não se limitava ao tratamento de enfermidades, mas funcionava como um espaço permanente de amparo a órfãos, viúvos e outros indivíduos desprovidos de redes familiares, mesmo quando classificados como “aptos ao trabalho”.

Após delinear os perfis da população assistida, passamos agora à análise do Quadro 3 com os 100 pacientes internados no mesmo hospital. Importa destacar que se trata de outros indivíduos, distintos daqueles registrados nas listas analisadas anteriormente, o que permite ampliar a compreensão sobre as enfermidades tratadas no Hospital de São Pedro e sobre a atuação médica no contexto da seca.

Quadro 3 – Distribuição das doenças tratadas no Hospital de São Pedro em Mamanguape (1879)

Grupo de Doenças	Enfermidades registradas	Masc.	Fem.	Total
Afecções cutâneas, ferimentos e lesões corporais	Úlceras; Ferimentos; Abscesso; Cobreiro; Cranco	34	20	54
Infecciosas e epidêmicas	Febre intermitente; Coqueluche; Sarampo; Tosse; Sífilis; Chagas; Sarnas	10	12	22
Aparelho digestivo e quadros nutricionais	Diarreia/Câmaras de sangue; Vermes; Embaraço gástrico; Anasarca	4	3	7
Crônicas, reumáticas e neurológicas	Reumatismo; Paralisia; Alienação	5	2	7
Afecções oculares e sensoriais	Oftalmia; Cegueira	-	6	6
Afecções específicas do corpo feminino	Metrite	-	2	2
Casos sem diagnóstico especificado	N/i	1	1	2
Soma Total		54	46	100

Fonte: Quando elaborado e adaptado por nós com base na *Relação dos doentes encontrados no Hospital da Cidade de Mamanguape* no dia 7 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Conforme consta no quadro acima, para fins de melhor compreensão analítica, as enfermidades registradas foram organizadas em grupos de doenças com características semelhantes. Entre elas, destacam-se as úlceras, que figuram como as lesões mais recorrentes, atingindo 47 pessoas (30 homens e 17 mulheres).

Nos termos médicos do século XIX, as úlceras abrangiam diferentes tipos de lesões, muitas delas de caráter cutâneo, associadas a ferimentos crônicos e infecções. No contexto da

seca, é plausível supor que essas úlceras estivessem relacionadas a quadros de desnutrição, higiene precária, ferimentos não tratados e infecções bacterianas, fúngicas ou virais, sendo agravadas pela longa exposição ao sol, pelo desgaste físico e pelas condições adversas de vida enfrentadas pelos migrantes.

A segunda enfermidade com maior número de registros foi a febre intermitente, totalizando 14 enfermos, sendo 1 homem e 11 mulheres. A recorrência desse diagnóstico reforça a centralidade das febres no quadro nosológico observado durante a seca, tema que será aprofundado na próxima seção, na qual se analisam as principais causas *mortis* do período. Segundo Chernoviz (1890, p. 1093), as febres intermitentes eram atribuídas às emanções provenientes de águas estagnadas e lodosas, bem como a fatores como o frio úmido prolongado e a habitação em locais baixos.

Embora Chernoviz não relacione diretamente essas moléstias aos episódios de seca, suas observações permitem um diálogo fecundo com o contexto em questão. A redução dos volumes de água, a formação de poças residuais, a precariedade das moradias improvisadas e a sobrecarga das localidades que receberam grandes contingentes de migrantes podia contribuir para a criação de ambientes insalubres, ampliando a exposição coletiva às febres entre indivíduos já fragilizados pela fome e pela subnutrição.

No que se refere à distribuição por sexo, os dados indicam um relativo equilíbrio entre homens e mulheres entre os doentes registrados, com 54 homens e 46 mulheres, totalizando 100 pacientes. Ainda que algumas enfermidades apresentem variações pontuais, o conjunto revela que o adoecimento atingia ambos os sexos de forma generalizada.

No geral, a distribuição das enfermidades registradas no Hospital da Cidade de Mamanguape demonstra um padrão de adoecimento relacionado às condições impostas pela seca. As afecções cutâneas, ferimentos e lesões corporais constituíram o grupo mais numeroso, indicando corpos marcados por feridas abertas, infecções e lesões mal cicatrizadas, compatíveis com longos deslocamentos a pé, exposição contínua ao ambiente e ausência de cuidados básicos.

Em seguida, as doenças infecciosas e epidêmicas aparecem de forma expressiva, podendo ser causada pela circulação de moléstias em contextos de aglomeração e ambientes insalubres. Já os quadros ligados ao aparelho digestivo e à nutrição, assim como as enfermidades crônicas, reumáticas e neurológicas, mesmo que em menor número, reforçam os efeitos prolongados da falta de assistência eficaz sobre os indivíduos assistidos.

Em síntese, a situação do Hospital de São Pedro em abril¹⁹³ indica que atendiam 292 pessoas, sendo 100 pacientes em tratamento regular e 192 indivíduos acometidos de varíola, estes últimos mantidos em ala separada das demais. Trata-se de um número elevado, se considerado o quadro reduzido de pessoal disponível. Os esforços exigidos eram extremos, a ponto de 3 enfermeiros serem responsáveis por 97 enfermos – um cuidando de 48, outro de 39 e o terceiro de 10 pacientes –, enquanto 4 enfermeiras assistiam 95 doentes, distribuídos entre 30, 24, 21 e 20 pacientes para cada uma. Esses dados evidenciam a sobrecarga do trabalho hospitalar e as condições precárias em que se dava a assistência aos enfermos no contexto da seca (Secretaria do Hospital S. Pedro, AHWBD, 23/04/1879).

Passamos agora à região do Brejo, onde o município de Areia¹⁹⁴ registrou um expressivo número de migrantes que, diante da “perspectiva da miséria e da moléstia”, buscavam atendimento no hospital local para o tratamento de diferentes enfermidades.

A instituição contava com 22 funcionários, entre serventes, enfermeiras e lavadeiras, além de um farmacêutico da Capital da Província, responsável pelo envio dos medicamentos, contingente considerado insuficiente para atender à demanda crescente, o que levou à necessidade de recorrer ao auxílio de 22 freiras da Casa de Caridade (Comissão de Socorros da Cidade de Areia, AHWBD, 26/05/1879).

Além disso, a Comissão de Areia informou ao presidente da província que as remessas de alimentos destinadas ao hospital eram escassas, a ponto de não atenderem a todos os enfermos, que permaneciam em situação de fome. Diante disso, solicitou-se o envio de novas cargas de feijão e milho, consideradas essenciais para a composição das refeições dos doentes (Comissão de Socorros da Cidade de Areia, AHWBD, 26/05/1879). Nesse contexto, marcado por limitações estruturais e pela escassez de recursos, a distribuição¹⁹⁵ das enfermidades entre os sexos masculino e feminino no Hospital de Areia pode ser observada no Quadro 4.

¹⁹³ Secretaria do Hospital S. Pedro, em Mamanguape 23 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁹⁴ Comissão de Socorros da Cidade de Areia, em 26 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

¹⁹⁵ Mappa dos enfermos existentes no hospital desta cidade Areia, 22 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Quadro 4 – Distribuição das doenças tratadas no Hospital de Areia (1879)

Grupo de Doenças	Enfermidades registradas	Masc.	Fem.	Total
Afecções cutâneas, ferimentos e lesões corporais	Úlceras; Abscessos; Ferimento; Escrófulas	29	13	42
Aparelho digestivo, quadros nutricionais e metabólicos	Anemia; Inanição; Marasmo; Cachexia; Beribéri; Opilação; Câmaras de Sangue; Oftalmia; Vermes; Gastralgia; Hepatite Crônica	26	10	36
Infecciosas, febris e epidêmicas	Sezões; Sífilis; Bronquite; Epilepsia	9	6	15
Crônicas, reumáticas e do aparelho locomotor	Reumatismo; Alejada (condição)	2	4	6
Outras	Hydropesia; Metrorragia; Moléstia	2	2	4
Soma Total		68	35	103

Fonte: Quando elaborado e adaptado por nós com base no *Mappa dos enfermos existentes no hospital desta cidade. Areia, 22 de abril de 1879*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Conforme apresentado no Quadro acima, as enfermidades tratadas no Hospital de Areia, em 1879, foram organizadas em grupos de doenças com características semelhantes, o que permite uma leitura mais clara dos padrões de adoecimento observados no contexto da seca. No total, foram identificados 101 pacientes, sendo 68 homens e 33 mulheres. O número de 103 registros que aparece no quadro, decorre do fato de que alguns indivíduos apresentavam mais de uma moléstia simultaneamente, como José, migrante de São João do Rio do Peixe, acometido por opilação e úlcera, e Francisco, procedente de Catolé do Rocha, que se encontrava em tratamento das mesmas enfermidades (Mappa ..., Areia, AHWBD, 22/04/1879).

Em relação aos tipos de doenças, o grupo mais numeroso correspondeu às afecções cutâneas, ferimentos e lesões corporais, que somaram 42 casos, dos quais 29 homens e 13 mulheres. Esse predomínio masculino pode estar relacionado aos corpos submetidos a maior desgaste físico, feridas abertas, abscessos e lesões decorrentes de trabalhos pesados, longas caminhadas, exposição ao sol e ausência de cuidados médicos contínuos.

Em seguida, destacam-se as enfermidades relacionadas ao aparelho digestivo, aos quadros nutricionais e metabólicos, com 36 registros (26 homens e 10 mulheres). Doenças como anemia (associada à debilidade geral do organismo e à carência prolongada de alimentos), inanição (estado extremo de privação alimentar), marasmo (forma grave de desnutrição caracterizada pelo emagrecimento acentuado e enfraquecimento do corpo), caquexia (condição de desgaste profundo do organismo, marcada por perda de peso, fraqueza e prostração) e beribéri (ligada à carência de nutrientes essenciais e da vitamina B1) reforçam o impacto direto da fome e da escassez alimentar sobre os corpos.

No grupo das doenças infecciosas, febris e epidêmicas, foram registrados 15 casos, sendo 9 homens e 6 mulheres. A diferença numérica é reduzida, o que indica um padrão de adoecimento relativamente equilibrado entre os sexos, especialmente em enfermidades como as febres e a bronquite. Esse dado sugere que, diferentemente das lesões físicas e dos quadros nutricionais mais graves, as doenças infecciosas tendiam a atingir homens e mulheres de forma mais homogênea, em razão das condições coletivas de insalubridade, aglomeração e circulação de agentes patogênicos no contexto da seca.

Já entre as doenças crônicas, reumáticas e do aparelho locomotor, observa-se uma inversão na distribuição por sexo: dos 6 casos registrados, 4 correspondiam a mulheres e apenas 2 a homens. Ainda que se trate de um universo reduzido, essa predominância feminina aponta para a maior incidência de enfermidades associadas a dores persistentes, limitações físicas e quadros prolongados.

A presença de casos classificados como “outras enfermidades”, que incluem hidropisia e metrorragia – hemorragia uterina anormal, caracterizada por sangramentos fora do período regular – indica como determinadas condições de saúde só passavam a ser registradas no ambiente hospitalar quando atingiam um grau de gravidade que tornava impossível sua manutenção fora desse espaço, exigindo internação.

Quando comparados aos dados do Hospital de Mamanguape, analisados anteriormente, os registros do Hospital de Areia revelam padrões semelhantes de adoecimento, como no predomínio das afecções cutâneas, das doenças ligadas à fome e do impacto das condições impostas pela seca. Em ambos os casos, as lesões, feridas e quadros de debilidade nutricional aparecem como marcas recorrentes de uma população submetida a deslocamentos forçados, más condições de higiene e assistência limitada.

No entanto, diferentemente de Mamanguape – onde se observava um relativo equilíbrio entre homens e mulheres entre os internados –, em Areia o adoecimento masculino se mostrou mais expressivo, especialmente nos grupos associados ao esforço físico, à desnutrição e aos ferimentos.

O hospital contava ainda com um “rancho dos variolosos”, destinado ao isolamento dos acometidos por varíola. No mês de março de 1879, essa ala atendia 11 pessoas; ao longo do período, recebeu mais 17 enfermos, dos quais 2 faleceram, 10 foram considerados curados e 16 permaneceram internados (Movimento do Hospital da Cidade de Areia, AHWBD, 03/1879). No mês seguinte, em abril, o número de pacientes variolosos em tratamento elevou-se para 25 pessoas, conforme registrado no *Mappa estatístico de movimento*.

Quanto à procedência dos pacientes internados no Hospital de Areia, homens e mulheres provinham em sua maioria de diferentes regiões do interior da própria província da Parahyba. Do Agreste, região onde se localiza Areia, foram identificados 51 pacientes, com destaque para o próprio município de Areia (27), seguido por Alagoa Grande (6), Alagoa Nova (4), Bananeiras (4), Guarabira (3), Campina Grande (2), Araruna (2), além de registros pontuais de Soledade, Serra da Raiz e Cuité (1 cada).

Da região da Borborema, contabilizaram-se 6 pacientes, oriundos de Picuí (5) e Seridó (1). A maior concentração, vinha do Sertão, com 33 internos, especialmente de Pombal e Catolé do Rocha (11 cada), seguidos por São João do Rio do Peixe e Sousa (2 cada), Patos (2), e, em menor número, São José de Piranhas, Conceição, Cajazeiras, Serra Grande e Piancó (1 cada). Chama atenção a ausência de pacientes provenientes do litoral da província.

Além dos casos internos à Parahyba, foram registrados 11 pacientes oriundos de províncias vizinhas, o que indica a ampliação da área de influência do hospital no contexto da seca. Do Ceará, destacam-se Serra do Pereiro (2); do Piauí, a região do Pajeú (1); de Pernambuco, o município de Gameleira (1); e do Rio Grande do Norte, Acari (5), Caicó (1) e Serra do Mel (1). Esses deslocamentos interprovinciais reforçam o papel do Hospital de Areia como espaço de acolhimento regional em um cenário marcado pela intensificação das migrações forçadas pela estiagem.

Vemos, até aqui, grupos diversificados tentando, de algum modo, sobreviver às consequências da intempérie. No entanto, quando se trata das pessoas idosas, as documentações são escassas. Para além das referências às Casas de Caridade já citadas, são raras as menções que permitem apreender, ainda que de forma fragmentada, as experiências desse grupo, indicando os limites das fontes produzidas durante a seca em registrar o envelhecimento e a velhice em contextos de crise.

Ainda assim, é possível identificar algumas menções pontuais às pessoas idosas em duas fontes específicas, que permitem lançar luz, ainda que de forma limitada, sobre suas condições de saúde.

A primeira delas refere-se a Patos¹⁹⁶, onde o vigário descrevia os horrores provocados pela migração: “todos os dias chegam-me motins de pessoas velhas e crianças, caídas de fraqueza e fome”, muitas das quais já se encontravam “na lista dos mortos”. Diante da gravidade, o religioso apelava pela intervenção do governo local como forma de evitar o prolongamento dessas listas de óbitos e de conter a fome ali existente, uma vez que, ao mesmo

¹⁹⁶ Villa de Patos, abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

tempo em que novas pessoas chegavam à localidade, outras famílias seguiam “para os Brejos, onde acharão recursos” (Villa de Patos, AHWBD, 04/1877).

O mesmo ocorria na Comarca da Independência¹⁹⁷, atual Guarabira, onde o juiz de direito informava que eram pessoas “de todas as idades e condições”, se encontravam famintas e em “estado de vergonhosa nudez”, dependendo das “esmolas” dos habitantes locais. Os “pobres e desvalidos”, do pouco que recebiam – quando recebiam –, ainda precisavam disputar esses recursos com “a chegada de novos emigrantes” (Juizado de Direito da Comarca da Independência, AHWBD, 23/06/1877).

Nesse contexto, é possível supor que muitas das mortes não decorreram apenas da fome, mas também do desgaste físico provocado pelos trajetos percorridos sob o sol intenso, sem acesso regular à água, descanso ou abrigo – condições extremamente penosas para pessoas idosas e fisicamente fragilizadas. Por essa razão, muitos migrantes interrompiam seus percursos em localidades onde era possível parar e obter algum tipo de auxílio, ainda que esses destinos não correspondessem aos lugares inicialmente almejados, o que contribuiu para a concentração de inúmeras pessoas e para a sobrecarga das estruturas locais de assistência.

Como se pode observar nessas e em outras descrições já discutidas, a fome e a nudez constituíam duas características recorrentes nas representações do estado físico desses migrantes. A fome, que os fazia depender da caridade do governo, vinha acompanhada de sentimentos de vergonha, tristeza e constrangimento, associados às condições que os levavam a implorar por uma refeição.

É nesse sentido que se insere o relato da Comissão de Socorros da povoação de Água Doce, na Comarca de Ingá¹⁹⁸, no terceiro ano de seca, ao solicitar auxílios para os “doentes e famintos”, descrevendo que, diante dos horrores da fome, “faz dó ver-se tantos de nossos irmãos esmolando pelas portas o pão da caridade”, situação agravada pelo fato de que os próprios habitantes “não podem sofrer, porque não têm mais o que dar, e não há recurso de comidas” (Offício N.º 467, Palácio da Presidência, AHWBD, 01/03/1879).

Por outro lado, a recorrência da categoria “nudez” não expressa apenas a falta de roupas mínimas para cobrir o corpo, mas também a degradação física, social e moral atribuída a esses sujeitos, bem como a perda da dignidade e dos bens materiais deixados para trás.

¹⁹⁷ Juizado de Direito da Comarca da Independência em 23 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

¹⁹⁸ Offício N.º 467- Informe a Repartição de Socorros. Palácio da Presidência 1º de Março de 1879. Comissão de Socorros Públicos da povoação de Água Doce da Comarca de Ingá 1º de Março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Nessas representações, os migrantes aproximavam-se de um “estado selvagem”, marcados por vestimentas rasgadas ou inexistentes, o que os expunha a múltiplas doenças e a situações precárias de higiene. Restava-lhes, assim, a humilhação de serem descritos como “famélicos, maltrapilhos, imundos e doentes” (Barbalho, 2005, p. 140).

Para além da fome e da nudez, as fontes também registram cenas atravessadas por sensibilidades, revelando experiências de dor, sofrimento psíquico e aflição. Reconstruir as histórias da população migrante na Parahyba constitui um desafio significativo; ainda assim, nas pesquisas por nós realizadas, encontramos duas menções diretas relacionadas aos estados de sofrimento mental e emocional dessa população, marcada pela dor, pela exaustão e pela ausência de perspectivas de vida.

A primeira consta no relatório enviado pelo Dr. Antônio da Cruz Cordeiro ao presidente da província, Dr. Esmerino Gomes, documento que deveria ser lido e apresentado à Assembleia Legislativa. Nele, o médico informava que “no pavimento térreo são tratados os loucos por haver maior segurança”, ao mesmo tempo em que expunha o descaso público com o acolhimento e a assistência a esses indivíduos, ao afirmar que “os quartos destinados aos loucos não oferecem cômodos para seu regular tratamento”. Além das condições materiais precárias, esses sujeitos encontravam-se submetidos à humilhação e ao abandono, uma vez que os espaços a eles destinados eram considerados “inferiores relativamente aos preceitos e leis da higiene” (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

A segunda menção diz respeito à ocorrência encaminhada pelo subdelegado do 2º distrito da Capital ao presidente da província, na qual se registra o relato do farmacêutico Luiz Baptista Silva Júnior acerca do caso de André Sobreira de Mello, migrante de localidade não mencionada, que teria atentado contra a própria vida na residência daquele.¹⁹⁹

A comunicação revela não apenas o episódio em si, mas também o clima de apreensão que o cercava, uma vez que o farmacêutico buscava resguardar-se de qualquer responsabilidade legal, solicitando a verificação oficial do ocorrido. Ao chegar ao local, as autoridades encontraram Sobreira em estado de intenso sofrimento, o que motivou a intervenção imediata da subdelegacia (Subdelegacia do 2º distrito da Capital da Parahyba, AHWBD, 20/12/1877).

Casos como esse, ainda que raros e fragmentados na documentação, indicam que a experiência da seca também incidia sobre a mente da população, levando a situações de esgotamento pouco visíveis nas estatísticas, mas registradas nas ocorrências policiais.

¹⁹⁹ Subdelegacia do 2º distrito da Capital da Parahyba, 20 de dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Como revelam os relatórios da Santa Casa e da Provedoria analisados pela autora, os indivíduos classificados como “loucos” ou “alienados” eram, com frequência, enquadrados menos a partir de uma compreensão clínica dos transtornos mentais e mais como sujeitos incômodos à ordem social. Nessas representações, apareciam associados à desordem moral, à ociosidade ou à ameaça à salubridade pública, o que justificava seu deslocamento entre hospitais, cadeias e enfermarias provisórias (Junqueira, 2016, p. 243).

Entre os diferentes grupos sociais alcançados pela seca, a saúde e as condições de vida das mulheres emergem nas fontes de forma recorrente, ainda que marcadas por representações específicas, associadas aos papéis que lhes eram atribuídos quando abandonadas pelos maridos ou diante da viuvez, situações em que assumiam a responsabilidade pelo cuidado e pela sobrevivência dos filhos. Muitas aparecem também como mulheres desempregadas ou inseridas nos núcleos de socorro, onde permaneciam encarregadas da manutenção da família e das tarefas domésticas, enquanto os homens se deslocavam para o trabalho nas obras ou nos próprios núcleos.

No cruzamento de dados realizado a partir da lista²⁰⁰ de pessoas contratadas para exercer funções de trabalho em diferentes espaços públicos, observa-se que a identificação das mulheres nem sempre era feita de maneira explícita quanto à sua condição de migrantes. Em diversas relações de pagamento, elas aparecem registradas apenas sob a denominação genérica de “cidadãs”, sem qualquer referência à procedência.

Ainda assim, esses registros não excluem a presença de mulheres migrantes nesses quadros, uma vez que, em uma das listas de contratação, constam os nomes de 32 mulheres atuando ao lado de homens identificados como migrantes nas turmas de obras públicas. Nessas atividades, desempenhavam funções como serventes, ajudantes, enfermeiras, cozinheiras, dispenseiras e lavadeiras, vinculadas aos hospitais e enfermarias, indicando sua inserção no trabalho assistencial e de apoio aos serviços de saúde (Thesouraria da Fazenda da Parahyba, AHWBD, 20/06/1879).

Ainda no que se refere ao trabalho feminino no contexto da seca, a documentação permite avançar na identificação direta de mulheres migrantes contratadas para serviços específicos. No Hospital dos Variolosos, localizado em Santa Rita²⁰¹, foram registradas a contratação da enfermeira Joana Baptista de Albuquerque e da servente Delfina Maria da

²⁰⁰ Thesouraria da Fazenda da Parahyba, 20 de junho de 1879 - Relação das pessoas que percebem gratificação pela verba Socorros Públicos. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²⁰¹ Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, em 2 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Conceição, ambas qualificadas no documento como “retirantes e habilitadas para este serviço” (Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, AHWBD, 02/06/1879).

No caso da servente, cabia-lhe também a lavagem das roupas dos doentes, mediante o pagamento de uma diária de 800 réis. A documentação indica ainda que essas contratações ocorreram em substituição a uma trabalhadora anteriormente vinculada à instituição e residente na capital, o que sugere uma reorganização da mão de obra hospitalar diante das dinâmicas impostas pela seca e pela presença de migrantes.

As limitações dessas formas de inserção laboral, ajudam a compreender outras estratégias de sobrevivência acionadas por mulheres em contextos de plena escassez material. Para Maria Mafalda de Araújo (1994, p. 75), ao investigar a atuação feminina durante a seca de 1877–1879 no Piauí, a documentação revelou histórias de “mulheres pobres, sofridas, desempregadas, buscando a prostituição, [...], [que] complementavam com o meretrício os baixos ganhos do trabalho”. A autora constatou ainda que a pobreza extrema fazia da prostituição uma alternativa recorrente, inclusive para mulheres casadas e menores de idade.

Na Parahyba, essas práticas passaram a ser enquadradas por um discurso médico-higienista que deslocava o foco da pobreza estrutural para a moralização dos corpos. Conforme identificou Serioja Mariano (2020), no contexto da seca, a sífilis e outras doenças venéreas passaram a ser associadas aos espaços de prostituição e aos sujeitos (homens e mulheres) que os frequentavam, compreendidos como focos de disseminação da enfermidade e de degeneração física e moral. Nesse sentido, a preocupação médica voltava-se menos para as condições sociais que produziam essas práticas e mais para o controle sanitário das doenças e o tratamento dos enfermos vinculados a esses circuitos (Mariano, S., 2020, p. 273).

No interior desse discurso médico-higienista, o relatório²⁰² elaborado pelo Dr. Antônio da Cruz Cordeiro traz informações sobre as mulheres que buscavam tratamento na Santa Casa da Misericórdia. Ao detalhar as doenças que mais as acometiam, o médico destacou a recorrência das febres contínuas, remitentes e intermitentes, como já identificado em outros hospitais da província, e descreveu casos de sífilis associados a afecções uterinas e a comprometimentos do aparelho geniturinário, indicando quadros de inflamações persistentes e lesões nos órgãos reprodutivos e urinários (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877). Essas complicações reforçavam a percepção médica de uma doença crônica e debilitante, que tornava o organismo mais vulnerável a infecções secundárias e a outras moléstias graves.

²⁰² Offício n.º674, da Santa Casa da Misericórdia enviado ao presidente da província Dr. Esmerino Gomes Parente, 10/07/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Esses quadros clínicos tiveram reflexos diretos no movimento de entrada e saída dos pacientes. De acordo com o mapa anual do hospital, entre julho de 1876 e junho de 1877, ao todo, 32 “mulheres desvalidas” passaram pela instituição. Deste conjunto, 11 mulheres faleceram, 14 receberam alta e 7 permaneciam internadas ao final do período (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

A aparente diferença no número de pacientes registrados na Santa Casa, quando comparada aos hospitais de Mamanguape e de Areia, não deve ser interpretada como indicativo de menor impacto da seca na Capital. O próprio médico responsável expõe, em seus relatórios, a falta de recursos financeiros, de equipamentos médico-hospitalares e de estrutura adequada da instituição para acomodar os pacientes e realizar procedimentos mais complexos, como cirurgias.

Ele também deixa claro que “o movimento dos doentes recolhidos [...] já foi muito maior do que nestes últimos meses”, explicando que essa redução não decorria da “repugnância da parte dos desvalidos a procurarem neste abrigo e aliviar as suas dores”, mas da incapacidade do hospital em absorver uma demanda crescente, sendo obrigado, “na contingência de receber menos doentes, de conformidade com as forças do estabelecimento” (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Como se pode imaginar, diante de uma crise como a seca – cuja duração ainda não se sabia que se estenderia por mais dois anos –, não houve planejamento orçamentário capaz de responder às exigências da saúde pública. Isso se agravou quando “a Assembleia Provincial entendeu conveniente diminuir a subvenção que dá anualmente à Santa Casa e com a qual sustenta o seu hospital, [...], o que dá lugar a muitas faltas que não se podem remediar” (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Somam-se a esses limites estruturais e orçamentários a forma como os próprios relatórios médicos foram produzidos. É provável que tais documentos se refiram apenas a enfermarias específicas sob responsabilidade direta dos médicos signatários, Dr. Antônio da Cruz Cordeiro e Dr. Abdon Felinto Milanez, o que contribui para a fragmentação dos dados. Essa hipótese se fortalece ao observar que, no mesmo documento, o médico discrimina separadamente o movimento da enfermaria da cadeia pública, indicando que os números apresentados não correspondiam ao conjunto da instituição, mas a setores distintos da Santa Casa.

Ao lado das mulheres, dos órfãos, dos idosos e dos migrantes pobres, os indivíduos recolhidos à cadeia pública também compunham o conjunto de grupos sociais afetados pela

seca, figurando nas fontes como um segmento específico do atendimento médico e assistencial.

Segundo as descrições do Dr. Antônio da Cruz Cordeiro, a enfermaria da Cadeia Pública, composta por uma ou duas salas destinadas ao atendimento dos presos, apresentava condições higiênicas precárias. A proximidade com um pântano, a aglomeração de indivíduos ocupando mais do que o espaço permitido, a ausência de colchões e a falta de vestimentas adequadas contribuíam para um ambiente considerado insalubre, tornando, nas palavras do médico, “repugnante o aspecto desses presos maltrapilhos e de feições doentias” (Offício n.º 674, AHWBD, 10/07/1877).

Os dados referentes à movimentação dessa enfermaria, entre julho de 1876 e junho de 1877, indicam que foram tratados 585 indivíduos, dos quais 531 receberam alta, 31 faleceram e 23 permaneciam internados ao final do período. As causas de morte registradas revelam um quadro de adoecimento marcado por enfermidades infecciosas, inflamatórias e por comprometimentos orgânicos graves, entre as quais se destacam: tísica, gastro-hepatites, gastroenterite, gastro-hepato-enterite, gastroduodenite, broncopneumonia, pleuro-pneumonia, febre hética, febre maligna, hidropisia, hydropericardite e lesão orgânica do coração, além de um caso de ferimento grave (Offício n.º 674, AHWBD, 10/07/1877).

Observa-se que muitas dessas doenças apresentavam relações entre si. As afecções do aparelho digestivo, frequentemente associadas à má alimentação, à ingestão de água contaminada e às condições de confinamento, contribuíam para o enfraquecimento geral do organismo, tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções respiratórias graves, como a tísica e as pneumonias.

Já os quadros de hidropisia, hydropericardite e lesões cardíacas indicam estágios avançados de comprometimento orgânico, relacionados a infecções prolongadas e à desnutrição. Entre as causas mais recorrentes de morte, destacaram-se a tuberculose pulmonar, responsável por 9 óbitos, e a varíola, com 8 registros, seguidas pela congestão cerebral, com 2 casos (Offício n.º 674, AHWBD, 10/07/1877).

Na Cadeia Pública de Campina Grande, a situação também era alarmante. Segundo as informações da Comissão de Socorros²⁰³ daquela localidade, solicitava-se com urgência cerca de 90 pares de roupas “para os referidos presos poderem mudar a roupa e desinfetar-se desta cadeia”. É nesse cenário de insalubridade que a varíola surge como um novo fator de agravamento do quadro sanitário, sendo associada, segundo a Comissão, à chegada de um

²⁰³ Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande em 26 de janeiro de 1879 Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

preso transferido da Cadeia da Vila de Ingá, a partir do qual passaram a ser registrados casos da enfermidade “com intensidade” (Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 26/01/1879).

Desde janeiro de 1879, cerca de 12 presos foram afetados pela varíola, dos quais quatro vieram a óbito. No mês seguinte, o lazareto dos bexiguentos já abrigava cerca de 30 presos em tratamento, revelando condições estruturais e higiênicas semelhantes às da enfermaria da Cadeia da Capital (Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 08/02/1879)²⁰⁴. Esses dados reforçam que a Cadeia Pública não operava apenas como espaço de punição, mas também como um ambiente marcado pelo adoecimento coletivo e por condições precárias de confinamento.

No que se refere à saúde da população escravizada durante a seca de 1877-1879, as fontes consultadas oferecem poucas informações, sendo mais frequentes apenas anúncios de fuga, nos quais se destacam as características físicas, sem qualquer referência a doenças ou condições de higiene. Essa ausência documental não indica a inexistência de adoecimento ou sofrimento, mas revela os limites e silêncios das fontes produzidas no período. Nesse sentido, a análise de outras manchetes de jornais, e o diálogo com a própria historiografia tornam-se fundamentais, uma vez que permitem apreender como a seca, a fome e as doenças afetaram a população escravizada.

É necessário destacar, nesse período, que os migrantes livres foram amplamente retratados pela documentação oficial e pela imprensa como sujeitos perigosos, propagadores de doenças e alvos de políticas de controle e disciplinamento pelo trabalho, como já vimos. Enquanto isso, os escravizados aparecem sob outra lógica discursiva. Suas experiências durante a seca raramente emergem como objeto de preocupação social ou administrativa do governo.

Um exemplo disso, está na notícia intitulada “*Situação de miséria da Província*”, publicado pelo jornal *O Publicador* em 11 de junho de 1879²⁰⁵, a população escravizada aparece associada a epidemias das décadas anteriores, particularmente à “primeira invasão do cholera”, em 1856, que teria “destruído muito a classe escrava”. A referência não se detém nas condições de vida, no adoecimento ou na morte desses sujeitos, mas surge como um dado para discutir os efeitos econômicos da crise. O jornal afirma que, apesar da elevada mortalidade entre os escravizados, as safras de açúcar e algodão não sofreram a esperada

²⁰⁴ Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, em 8 de fevereiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²⁰⁵ Jornal *O Publicador*, 11/06/1879. Fundação Casa de José Américo (FCJA).

redução, conforme indicariam os registros da Alfândega da cidade (*O Publicador*, 11/06/1879).

Ao projetar o futuro da província, o editorial naturaliza a continuidade da miséria e da morte, afirmando que, em poucos anos, restariam apenas as “pungentes recordações” e o “vácuo” deixado por aqueles que teriam sucumbido à fome, à má alimentação e às epidemias. A projeção do futuro é construída a partir da seca em curso, funcionando no discurso do editorial como um elo entre a crise vivida no presente e a expectativa de perda de vidas e reorganização da força de trabalho.

Já o “vácuo” mencionado não é tratado como uma perda social irreparável, mas como algo passível de reposição, que poderia ser suprido pela importação de colonos estrangeiros “carissimamente importados, e muito bem hospedados” (*O Publicador*, 11/06/1879). Nesse sentido, os escravizados aparecem no texto como parte de um cálculo econômico, cuja destruição é lamentada apenas na medida em que poderia afetar a produtividade, sendo sua substituição apresentada como uma alternativa possível.

É nesse contexto que a análise de Lucian Silva (2021, p. 92) contribui para compreender os silêncios das fontes. Segundo o autor, os efeitos da seca de 1877-1879, e a criação dos núcleos coloniais, poderiam ter acelerado o colapso da escravidão na Parahyba do Norte, devido a ampla disponibilidade de trabalhadores livres e libertos. No entanto, isso não ocorreu: “O apego aos últimos escravizados fez com que os senhores se utilizassem da oferta de mão de obra dos retirantes e não abrissem mão de seus escravizados”, preservando a escravidão como eixo estruturante da produção.

Se a documentação oficial e a imprensa da Parahyba tendem a silenciar o adoecimento e o sofrimento da população escravizada, a literatura produzida no contexto da seca permite vislumbrar outras dimensões dessa experiência. Em *A Fome*, Rodolfo Teófilo constrói a trajetória de Manuel de Freitas, fazendeiro do alto sertão cearense cuja fortuna estava “toda empregada em gados e escravos” (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 16). A seca de 1877, inicialmente desacreditada pelo proprietário, desestrutura progressivamente seu patrimônio, reduzindo não apenas seus rebanhos, mas também as condições mínimas de sustento de sua família e de seus cativos.

A precarização alimentar também atingia a população escravizada, ainda que essa dimensão raramente apareça como objeto de preocupação nas fontes administrativas. No romance, Rodolfo Teófilo afirma que, diante do agravamento da seca, “a ração dos escravos havia sido reduzida a um terço” (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 22), revelando que a escassez comprometia diretamente as condições mínimas de subsistência dessa população.

Além disso, a fome, nesse contexto, fragiliza as relações senhoriais e expõe o caráter profundamente econômico do vínculo escravista: mascates, descritos como “magarefes de gado humano” (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 22), aguardam o momento oportuno para negociar os cativos em troca de farinha.

A reação dos escravizados(as) à iminente venda é significativa. Ao saberem da visita dos traficantes, reúnem-se na senzala e decidem “procurar a liberdade”, fugindo antes do amanhecer em direção ao Piauí (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 23). A fuga coletiva, que deixa a senzala “deserta”, revela as estratégias de sobrevivência diante da ameaça de reescravização em novas paragens. Diferentemente da imagem de passividade frequentemente projetada sobre essa população, o episódio sugere que a seca abriu também brechas de mobilidade e ruptura.

No entanto, os cinco escravizados que permanecem na propriedade acabam sendo vendidos para custear a emigração da família senhorial. A cena descrita por Teófilo, na qual “senhores e escravos” se reúnem para rezar antes da partida, e os cativos se despedem em silêncio, beijando os pés do Crucificado (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 25), constrói um quadro dramático que enfatiza a dor moral da separação. Ainda assim, a decisão final revela a hierarquia estrutural da relação: a venda dos escravizados(as) é apresentada como “a última cartada” para salvar os filhos do fazendeiro (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 24-25).

O romance, portanto, confirma o que as fontes administrativas apenas insinuam: a população escravizada também foi profundamente atingida pela seca, seja pela redução das “rações”, pela ameaça constante de venda, pela fuga em massa ou pela dissolução forçada de vínculos.

Embora a imprensa provincial registre esses efeitos sobretudo sob a perspectiva econômica, ao relacionar a mortalidade e a diminuição do número de cativos aos impactos na produção, e o romance enfatize os aspectos dramáticos da crise, ambos indicam que a escassez alcançou igualmente a população escravizada. Assim, ainda que por linguagens distintas, é possível perceber que a seca agravou suas condições materiais de existência e tornou ainda mais instáveis as relações que sustentavam o regime escravista na província.

Após a apresentação das experiências de diferentes grupos sociais – abordando questões como orfandade, perfis da população assistida e as enfermidades tratadas nos hospitais de Mamanguape e Areia, saúde física e mental, passamos agora à seção seguinte, na qual serão analisados os registros de óbitos e as doenças que mais grassavam a população da Província da Parahyba, em diálogo com ofícios e correspondências produzidos nas localidades mais afetadas pela seca.

3.2 “A FOME, A NUDEZ E AS MOLÉSTIAS CONTINUAM A FAZER VÍTIMAS”: AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE ENTRE 1877 A 1879

Vários acontecimentos marcaram a experiência da seca de 1877-1879, entre eles a criação de medidas emergenciais de combate à crise, como alojamentos provisórios, distribuição de alimentos, roupas e medicamentos, bem como os inúmeros limites e falhas que atravessaram a execução dessas iniciativas. No interior desse contexto, as doenças assumiram centralidade, revelando cenas extremas de sofrimento diante de um mal persistente que a população não conseguia vencer: a fome. Incapaz de ser contida apenas por ações pontuais, a crise expôs tanto a insuficiência das respostas governamentais quanto a dimensão que a seca alcançou em termos sociais, econômicos e demográficos.

Grande parte das enfermidades que vitimaram a população esteve diretamente associada à fome e à desnutrição prolongada; outras relacionavam-se às condições precárias de saneamento, à falta de água potável, às variações climáticas e à circulação de epidemias, como a varíola e as febres de diferentes naturezas. Esses quadros atingiram não apenas a população migrante, mas também aqueles que, embora não tenham se deslocado, foram profundamente afetados pelos efeitos diretos e indiretos da seca.

Ao analisar as principais causas de morte nesse período, este subtópico busca compreender como a fome e as doenças se articularam às condições de vida impostas pela crise, transformando o adoecimento e a morte em experiências amplamente compartilhadas no cotidiano da província. Nesta seção, apresentamos um mapeamento parcial da mesorregião do Sertão da Parahyba, elaborado a partir das fontes às quais foi possível ter acesso para análise. Para tanto, utilizamos os registros de óbitos de 3 municípios: Cajazeiras, Pombal e Teixeira.

Antes de apresentarmos esses resultados e o cruzamento com outras fontes do período, é importante apontar algumas observações e justificativas metodológicas. No que se refere aos registros de óbitos das mesorregiões do Agreste, Borborema e Mata, em especial, a Freguesia de Nossa Senhora das Neves, suas ausências neste levantamento decorrem de limites operacionais da pesquisa, relacionados ao tempo disponível para a coleta e ao elevado volume documental, razão pela qual tais registros não puderam ser incorporados.

Desses três municípios do sertão, levando em consideração as folhas que não estavam disponíveis para consulta e outras que se encontravam ilegíveis em razão da qualidade do documento, computamos 667 registros de óbitos, distribuídos entre 368 homens (55,2%), 283 mulheres (42,4%) e 16 casos sem identificação de sexo (2,4%).

Cabe destacar que os livros paroquiais consultados apresentam coberturas temporais desiguais. Em alguns municípios, os registros restringem-se a apenas um dos anos do recorte temporal, como 1877 ou 1879; em outros, abrangem somente alguns meses desses anos. Nenhum dos livros analisados contempla a totalidade do triênio da seca, tampouco registra um ano completo de forma contínua, o que confere ao conjunto documental um caráter fragmentário e incompleto.

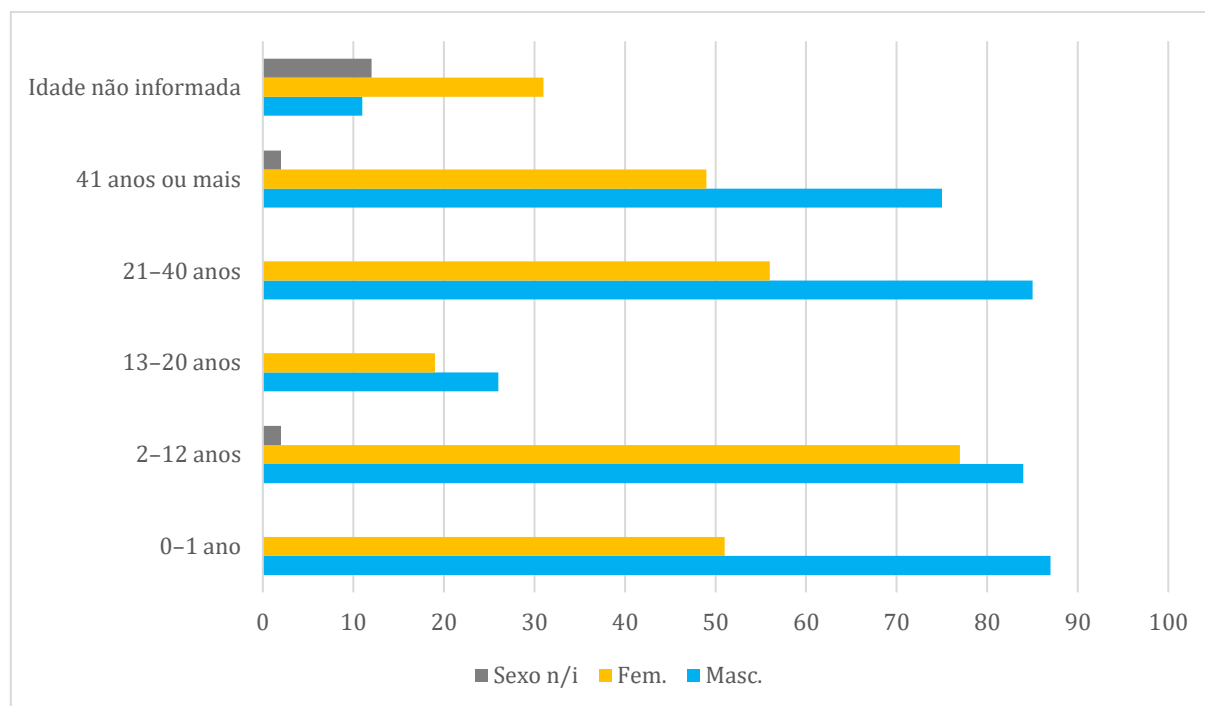
Com relação à distribuição etária dos óbitos, observa-se que a mortalidade no Sertão paraibano, nos municípios de Cajazeiras, Pombal e Teixeira, incidiu de forma particularmente intensa sobre a população infantil. Do total de 667 registros, 301 correspondem a crianças com até 12 anos de idade (45,2%), concentradas nas faixas de 0 a 1 ano e de 2 a 12 anos.

Entre os menores de 1 ano, foram contabilizados 138 óbitos (20,7%), sendo 87 do sexo masculino e 51 do feminino, em sua maioria associados a crianças que morreram ainda nos primeiros dias ou meses de vida, associadas à precariedade alimentar, à incidência de doenças infecciosas, à ausência de cuidados médicos regulares e à recorrência de quadros como os espasmos. Já o grupo de 2 a 12 anos reúne 163 registros (24,5%), sendo 84 do sexo masculino, 77 do feminino e 2 sem identificação de sexo, indicando que a sobrevivência além do primeiro ano não implicava a superação dos riscos impostos pela seca, pela fome e pelas enfermidades recorrentes.

Nas demais faixas etárias, o grupo entre 13 e 20 anos concentra 45 óbitos (6,7%), sendo 26 masculinos e 19 femininos, enquanto a faixa de 21 a 40 anos reúne 141 registros (21,1%), dos quais 85 correspondem a homens e 56 a mulheres, configurando o segmento adulto mais atingido. Entre os indivíduos com 41 anos ou mais, foram registrados 126 óbitos (18,9%), sendo 75 do sexo masculino, 49 do feminino e 2 sem identificação.

Por fim, os 53 casos sem indicação de idade (8,1%), distribuídos entre 11 homens, 31 mulheres e 12 registros sem identificação de sexo, evidenciam os limites da documentação analisada. Ainda assim, o conjunto dos dados indica que, embora a mortalidade atinja diferentes etapas da vida, ela recai de forma desproporcional sobre crianças e adultos jovens, revelando os efeitos estruturais da seca sobre a dinâmica demográfica do Sertão paraibano. Vejamos essa distribuição no gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Distribuição etária dos óbitos por sexo – Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877-1879)



Fonte: Gráfico elaborado por nós, com base em: Paróquia de Santa Maria Madalena (Teixeira, PB). *Livro de óbitos (1867-1884)*. Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Cajazeiras, PB). *Livro de óbitos (1867-1877)*. Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. *FamilySearch*. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8?i=1&cc=3>.

Em paralelo com a mortalidade infantil da população escravizada entre 1877 e 1879, a análise dos registros de óbitos da freguesia de Nossa Senhora das Neves, realizada por Solange Rocha (2007), permite observar uma concentração significativa de mortes nesse período. Nesse conjunto de registros, Rocha identifica 771 óbitos no período, dos quais 154 correspondiam a crianças com menos de um ano de idade (19,9%). A concentração desses óbitos durante os anos da grande seca é significativa: apenas nesse intervalo foram registrados 76 óbitos infantis, o que corresponde a 49,3% do total de mortes de crianças no período analisado (Rocha, 2007, p. 145).

Quando se observa especificamente a população escravizada, a autora destaca que os ingênuos representavam 17,2% do total de pessoas falecidas entre 1869 e 1881, mais da metade dessas mortes (54%) ocorreu durante o período da seca (Rocha, 2007, p. 147). Além disso, 41% dessas crianças tinham até um ano de idade, o que reforça a centralidade da mortalidade infantil escravizada como um dos traços mais dramáticos desse contexto. Esses dados também indicam que a seca não apenas agravou as condições de vida da população em geral, mas incidiu de modo desigual sobre os segmentos mais vulneráveis.

Rocha também chama atenção para o aumento expressivo da mortalidade geral nos anos imediatamente associados à estiagem. Entre 1877 e 1880, por exemplo, 58% das pessoas

negras falecidas nos registros da freguesia concentraram-se nesse curto intervalo temporal, abrangendo indivíduos de diferentes condições jurídicas e faixas etárias (Rocha, 2007, p. 146).

Mesmo reconhecendo que a seca atingiu em menor proporção a zona litorânea, onde se localizava a capital, a autora demonstra que seus efeitos foram suficientemente intensos para provocar um colapso nas condições de sobrevivência da população negra e escravizada. Ainda que, nos municípios sertanejos de Teixeira, Pombal e Cajazeiras, não tenham sido identificados números elevados de pessoas escravizadas nos registros de óbito, os dados analisados por Rocha apontam para uma elevada mortalidade infantil, resultado que converge com esta pesquisa.

Passamos agora para as principais causas de morte identificadas no Sertão: fome (86 óbitos, associada à carência alimentar prolongada), febres (84, categoria ampla que englobava diferentes enfermidades e infecções), diarreia, disenteria, câmaras de sangue e inflamações intestinais (60, geralmente relacionadas à má alimentação e às condições de vida precárias).

Também se observam as mortes causadas por espasmos (52, frequentemente associados a estados convulsivos), tísica (39, forma então corrente de designar a tuberculose), inanição (27, expressão utilizada para indicar um estágio extremo de privação ou ausência alimentar), varíola (23, doença contagiosa de caráter epidêmico) e beribéri (20, enfermidade associada à deficiência nutricional).

Essas doenças e outras causas de morte estão explicitadas no Quadro 5, discriminadas por sexo, pelos casos sem identificação e pelo cálculo do total de óbitos.

Quadro 5 – Principais causas de morte por sexo nos municípios de Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877-1879)

Doenças/Causa	Homens	Mulheres	Sexo n/i	Total
Fome	48	36	2	86
Febres	44	39	1	84
Diarreia, desinteria, câmaras de sangue e inflamações intestinais	32	27	1	60
Espasmos	38	14	0	52
Tísica	27	12	0	39
Inanição	14	13	0	27
Varíola	11	12	0	23
Beribéri	19	1	0	20
Não identificadas (n/i)	46	39	8	93
Outras doenças / causa	89	90	4	183
Total	368	283	16	667

Fonte: Quadro elaborado por nós, com base em: Paróquia de Santa Maria Madalena (Teixeira, PB). *Livro de óbitos (1867-1884)*. Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Cajazeiras, PB). *Livro de óbitos (1867-1877)*.

Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8>.

Com relação à categoria “outras doenças/causas”²⁰⁶, pode-se dizer que ela foi adotada para agrupar ocorrências de baixa frequência individual, que aparecem de forma pontual nos registros de óbitos e que, isoladamente, não alteram os padrões gerais de mortalidade identificados. Nela estão incluídas enfermidades específicas, como apoplexia, gastrite, reumatismo, asma, tuberculose, escorbuto, anasarca e metrites, bem como afecções descritas de maneira mais localizada, a exemplo de inflamações de órgãos específicos (estômago, fígado ou útero).

Também integram esse conjunto causas associadas à infância, como dentição, garrotilho e opilação, além de registros relativos a causas externas e eventos violentos, como ferimentos por arma de fogo ou faca, assassinatos, suicídios, queimaduras e mordeduras de animais, incluindo picadas de cobra. Por fim, essa categoria abrange ainda designações descritivas e pouco precisas do ponto de vista clínico, bastante recorrentes nos registros paroquiais, como “repente”, “subitamente”, “morte natural”, “mal interior”, “uma dor” ou “uma enfermidade”, bem como menções a parto ou a ferimentos vagamente descritos.

Como vimos, as principais doenças e causas de morte estiveram profundamente associadas à fome. Essa realidade atingiu de forma dramática os recém-nascidos, como no caso de Joaquim, pardo, com apenas um mês de vida, residente em Cajazeiras, cuja morte foi registrada como decorrente da fome. Situação semelhante aparece no registro de Maria, criança branca, de 6 anos, natural de Pombal, cuja morte também foi atribuída à fome e cujos pais precisaram recorrer às esmolas para viabilizar o seu sepultamento.²⁰⁷

Entretanto, a fome não se restringiu à infância nem poupou outras faixas etárias. Anacleto, pardo, viúva, com 41 anos, natural de Piancó, mas falecida em Teixeira, teve sua morte atribuída à inanição, indicando os efeitos prolongados da carência alimentar também sobre a população adulta. Da mesma forma, Isabel, parda, viúva, com 80 anos, morreu de

²⁰⁶ A reunião dessas ocorrências em uma única categoria visa, portanto, evitar a fragmentação excessiva da análise e respeitar os limites diagnósticos e administrativos da documentação, sem desconsiderar a diversidade das experiências de adoecimento e morte registradas.

²⁰⁷ Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Cajazeiras, PB). *Livro de óbitos (1867–1877)*. Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8>.

fome em Pombal, sendo igualmente necessário recorrer às esmolas para garantir seu sepultamento “com dignidade”.²⁰⁸

Entre os casos identificados de mortes atribuídas à fome e às condições por ela desencadeadas, um episódio específico ganhou destaque na memória local de Pombal. Trata-se da morte de Maria, criança de apenas quatro anos de idade, cujo registro no livro paroquial aponta como causa mortis “assassinada”. Vejamos as informações que constam no seu registro de óbito:

Aos vinte e sete dias deste mes de março de mil e oitocentos e setenta e nove, neste cemitério de Nossa Senhora do Bom Sucesso desta Cidade de Pombal, **sepultou-se os restos do anjo de nome Maria** branca com idade **de quatro annos**, filha legítima de Domingos Alves Pinheiro e Cândida Maria da Conceição, moradores nesta freguesia, **morreo assignada, por Donária dos Anjos natural de Piancó, tendo sido encontrada devorando o mesmo cadáver da criança, sendo seus restos por mim encomendados e envoltos em habito branco e para constar faço este assento em que eu assino, e que ficará pra eterna memoria** (Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, (PB). Livro de óbitos – 1879. Grifos nossos).

O próprio texto do assento ultrapassa a fórmula sintética habitual dos registros de óbito ao explicitar as circunstâncias do ocorrido. Ao consignar que a criança foi morta por Donária dos Anjos, natural de Piancó, e que esta foi encontrada “devorando o mesmo cadáver da criança”, o vigário não apenas identifica a autora do crime, mas inscreve no livro paroquial um episódio marcado pela violência extrema e pela degradação produzida pela fome. Ainda que sucinto, o relato indica que o assassinato se deu em um contexto de escassez severa, que também atingia a própria acusada.

A descrição presente no registro, entretanto, não esgota a compreensão do caso. O inquérito do processo-crime acrescenta novos elementos ao episódio, permitindo situar a violência praticada por Donária no quadro mais amplo das condições extremas de fome e desamparo vividas durante a seca.

Para aprofundar a compreensão do episódio, recorreremos aos escritos de Wilson Nóbrega Seixas, em *Velho Arraial de Piranhas – Pombal* (1962), que teve acesso ao processo-crime relacionado ao caso. Segundo o promotor público de Pombal, as informações prestadas pela própria Donária indicam que ela tinha 18 anos de idade e que se encontrava em Pombal em busca de melhores condições de vida. Em seu depoimento, a ré afirmou que “cometeu o

²⁰⁸ Paróquia de Santa Maria Madalena (Teixeira, PB). *Livro de óbitos (1867–1884)*. Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. *FamilySearch*. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8?i=1&cc=3>.

crime oprimida pela grande fome que a afligia, e que se achava arrependida de o ter praticado” (Seixas, 1962, p. 166).

Com relação ao episódio em si, a documentação judicial descreve de forma detalhada a sequência dos acontecimentos, informando que a criança foi morta por sufocação e, em seguida, teve o corpo decepado e “reduzido a diversos pedaços de carne”, conforme a própria expressão utilizada na fonte. Ainda segundo o registro, parte do corpo foi cozida e consumida, enquanto outros fragmentos foram guardados e descartados em diferentes locais, sendo alguns devorados por animais e outros enterrados nas proximidades do cemitério “à sombra de uma oiticica, a cabeça de sua desditosa vítima”, onde posteriormente foram exumados (Seixas, 1962, p. 165-166).

Quando relacionamos a leitura desses episódios à História das Sensibilidades, entendida como uma abordagem que busca apreender formas historicamente situadas de perceber, reagir e atribuir sentido à realidade, torna-se possível compreender que, nas denúncias de canibalismo em contextos de fome extrema, mais relevante do que a reconstituição do acontecimento em si é observar como as fontes registram, silenciam e moralizam a experiência. Nesse processo, ganham destaque os termos acionados para qualificar a morte, os rituais que são preservados ou interrompidos e as formas pelas quais se constrói a fronteira entre o aceitável e o intolerável (Barbeiro, 2006; Pesavento, 2007d).

Casos como esse rompem com a visão já reconhecida anteriormente sobre a história das secas – marcada pelo clima quente e seco, pelos auxílios prestados pelas comissões de socorros e pelas mortes atribuídas, sobretudo, à fome e às doenças associadas. No entanto, episódios de canibalismo acabaram por se tornar particularmente marcantes e reiteradamente mobilizados no imaginário da seca. Quando se fala na “Grande Seca” na Parahyba, o chamado “caso da menina de Pombal” emerge quase de forma automática, despertando sentimentos de comoção e repulsa, intensificados à medida que os detalhes do ocorrido se tornam mais conhecidos.

A repercussão desse episódio contribuiu para cristalizar uma memória trágica da seca, frequentemente centrada na figura de Donária dos Anjos, sobre quem recaem as maiores culpas e estigmas. Contudo, uma análise mais atenta das fontes permite relativizar essa leitura moralizante, ao considerar que Donária também se encontrava em um estado extremo de vulnerabilidade física e mental, profundamente marcado pela fome, pelo deslocamento e pela ausência de qualquer rede de amparo. Nesse sentido, mais do que um ato isolado de barbárie, o episódio expõe os limites da sobrevivência humana em contextos de extrema crise, convidando à reflexão sobre como a fome extrema desorganiza normas, sensibilidades e

fronteiras morais, tanto nas experiências vividas quanto nas formas posteriores de lembrança e julgamento.

Se o caso de Pombal permanece fortemente inscrito na memória das secas na Parahyba, no Ceará a literatura registra episódios igualmente – ou ainda mais – extremos, produzidos pela fome, que merecem espaço nesta análise. Em *A Fome*, Rodolfo Teófilo descreve situações em que a escassez absoluta de alimentos levou indivíduos ao completo esgotamento físico e moral. Segundo o autor, a fome atingiu tal intensidade que algumas pessoas se suicidavam diante da ausência de qualquer esperança de que a seca cessaria ou de que receberiam algum auxílio; seus corpos, já profundamente desnutridos, acabavam abandonados e serviam de alimento para cães e urubus famintos (Teófilo, 2015 [1890]a).

O romance também apresenta episódios que guardam semelhanças com o caso de Donária, como o relato de um pai que, tomado pelo desespero, mata o próprio filho para se alimentar das poucas “carnes” que ainda restavam de seu corpo extremamente magro. Em outra passagem, Teófilo narra a história de um migrante identificado como “faminto” que, após ferir o antebraço, não resiste à visão do “sangue incolor como o dos insetos” e, em meio ao delírio provocado pela fome, passa a sugar o pouco líquido que ainda restava em seu corpo, chegando a “comer as próprias carnes”. O episódio culmina em um estado de agonia, seguido de uma convulsão que antecede imediatamente a morte (Teófilo, 2015 [1890]a, p. 65).

Essas narrativas, mesmo que literárias, permitem compreender os limites extremos da experiência humana diante da fome absoluta, contribuindo para a análise das sensibilidades associadas à seca e para a compreensão de como esses episódios foram percebidos, narrados e fixados na memória social do período.

Na Parahyba, até o presente momento da pesquisa, o episódio envolvendo a morte de Maria, em Pombal, constitui o único caso oficialmente registrado de canibalismo relacionado à seca de 1877-1879. Isso não significa, contudo, que práticas semelhantes não tenham ocorrido em outros espaços da província. A documentação administrativa sugere a circulação de rumores e denúncias que, embora nem sempre confirmados, expressam o grau de tensão social e de colapso das sensibilidades provocado pela fome.

Um exemplo significativo aparece em ofício da Comissão de Socorros de Campina Grande²⁰⁹, datado de 8 de fevereiro de 1879, no qual se registra que “corre a dias nesta cidade um boato que parece incrível”, segundo o qual crianças teriam desaparecido e “forão elas mortas, servindo de alimentação a uns retirantes vindos dos Cariris Novos”. O documento

²⁰⁹ Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, em 8 de fevereiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

informa ainda que o desaparecimento de ao menos uma das crianças era real e que a polícia já procedia às “necessárias averiguações” (Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, AWHBD, 08/02/1879).

O teor desse ofício permite ainda avançar para além do episódio em si, ao revelar como determinados grupos sociais passaram a ser representados no contexto da seca. Ao atribuir o suposto desaparecimento e morte das crianças a “retirantes vindos dos Cariris Novos”, a comissão não apenas registra um boato, mas constrói uma imagem de perigo associada à população migrante oriunda do sertão.

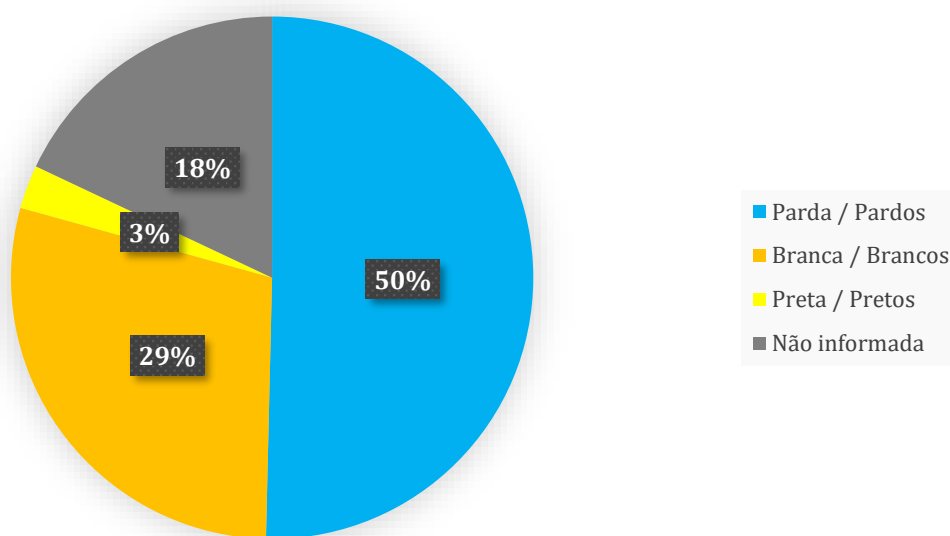
Nesse sentido, mais do que informar sobre um boato de um suposto crime, o texto expressa um imaginário marcado pela desconfiança e pela repulsa em relação aos migrantes, percebidos como corpos estranhos e ameaçadores no espaço urbano. Tal representação dialoga com o que Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011) analisa como parte do processo de construção simbólica do sertão e de seus habitantes, frequentemente associados à barbárie, à violência, ao atraso e à desordem social.

Mesmo sem a confirmação formal do ocorrido, o registro é revelador. Assim como no caso de Donária, o que emerge dessas fontes não é apenas a possibilidade material do canibalismo, mas o horizonte de medo, desespero e ruptura das normas morais instaurado pelas circunstâncias da fome.

A circulação desses boatos indica que a prática de canibalismo passou a ser pensável – e narrável – como último limite da experiência humana, funcionando como marcador simbólico da desagregação social. Nesse sentido, tanto o caso oficialmente registrado em Pombal quanto os rumores provenientes de Campina Grande devem ser compreendidos menos como episódios isolados e mais como expressões de uma sensibilidade coletiva profundamente marcada pela fome, pelas migrações e pela ausência de socorros efetivos.

Voltando para a análise dos dados contidos nos registros de óbitos, a distribuição da cor nos registros de óbitos dos municípios de Cajazeiras, Pombal e Teixeira revela a predominância de indivíduos classificados como “pardos/as”, que somam 336 casos (50,4%) do total de 667 registros, indicando que a mortalidade atingiu em maior proporção a população parda, seguidos pelos “brancos/as”, com 193 óbitos (28,9%). As menções a pessoas “pretas/os” aparecem de forma significativamente menor, totalizando 18 registros (2,7%), enquanto a categoria “não informada” reúne 120 casos (18,0%).

Gráfico 2 – Composição dos registros de óbitos por cor em Cajazeiras, Pombal e Teixeira (1877-1879)



Fonte: Gráfico elaborado por nós, com base em: Paróquia de Santa Maria Madalena (Teixeira, PB). *Livro de óbitos (1867–1884)*. Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Cajazeiras, PB). *Livro de óbitos (1867–1877)*. Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8>.

No que se refere à condição jurídica, os registros de óbito apresentam poucas menções explícitas, totalizando 11 ocorrências ao longo dos três municípios analisados. Desse conjunto, identificam-se 5 pessoas escravizadas e 6 libertas, distribuídas entre homens e mulheres. Paralelamente, um dado relevante identificado especificamente em Pombal diz respeito às práticas funerárias associadas à pobreza: foram registrados 67 enterros realizados por esmola, nos casos em que os falecidos não dispunham de recursos para custear o sepultamento.

Também foi possível obter informações sobre as mortalhas utilizadas nos sepultamentos dos municípios de Cajazeiras e Pombal. Nesses dois municípios, observa-se a predominância de mortalhas brancas, que totalizam 361 ocorrências, frente a 35 registros de mortalhas pretas, além de 43 casos em que a cor da mortalha não foi informada.

Essa predominância dialoga com a documentação produzida pela Comissão Central de Socorros²¹⁰, que registram a preocupação em garantir ao menos um sepultamento “digno” aos mortos em meio à crise. Em ofício encaminhado ao presidente da província, os administradores solicitaram o envio de “25 peças de madapolão para mortalhas”, a fim de

²¹⁰ Comissão Central de Socorros s/d. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

evitar o “escândalo de serem sepultados os mortos com os mesmos andrajos com que expiram”, reconhecendo que, mesmo com o recurso às esmolas, nem sempre era possível prover mortalhas adequadas a todos os falecidos (Comissão Central de Socorros, AHWBD, s/d).

Além disso, a preocupação com a mortalha e com a forma do sepultamento deve ser compreendida no interior de um universo mais amplo de valores associados à chamada “boa morte”, profundamente enraizados nas práticas religiosas e sociais do período. Conforme analisa Laércio Sousa Jr. (2023, p. 64-65), a morte considerada indesejável estava associada à ruptura desses rituais, especialmente quando ocorria em locais públicos, fora de casa, vistos com desconfiança pela população, em razão das mortes e do limitado conhecimento médico sobre as doenças.

Segundo o autor, a ausência “dos sacramentos, da escolha da mortalha, dos rituais domésticos de preparação do cadáver, do velório adequado, da condução do corpo para a encomendação na igreja, do cortejo para a sepultura em local sagrado”, o que contribuía para a percepção de uma morte sem dignidade (Sousa Jr., 2023, p. 64). Nesse sentido, a insistência das comissões de socorros em providenciar mortalhas – ainda que de forma precária – pode ser interpretada como uma tentativa de preservar, minimamente, parte desses rituais, atenuando a ruptura simbólica provocada pela morte em contexto de crise sanitária e social.

Acerca da procedência dos indivíduos registrados nos óbitos constata, em primeiro lugar, a centralidade dos próprios municípios analisados. Cajazeiras, Teixeira e Pombal concentram a maior parte dos registros, com 234, 195 e 110 ocorrências, respectivamente, indicando que a mortalidade atingiu majoritariamente a população residente nesses núcleos sertanejos.

Para além dos municípios centrais, os registros de óbitos indicam a presença de indivíduos oriundos de outros municípios da Parahyba, revelando a circulação interna da população sertaneja no contexto da seca. Nesse conjunto, destacam-se as procedências de Piancó (19 registros) e Catolé do Rocha (10), seguidas por Vila da Misericórdia – atual Itaporanga (6) e São João do Rio do Peixe (6). Também aparecem Patos (4) e São José de Piranhas (4), além de Sousa (3).

Com menor recorrência, figuram localidades como Parque do Arco (Araçagi) (2) e, com um registro cada, Alagoa, Seridó, Olhos d’Água, Santa Fé, Serraria, Santa Ana (Barra de Santana) e São João do Cariri. A diversidade dessas procedências internas reforça que, para além dos grandes núcleos analisados, a mortalidade registrada alcançou indivíduos

provenientes de diferentes pontos da Parahyba, refletindo deslocamentos regionais associados às condições impostas pela seca.

Antes de apresentar os registros que explicitam a condição de “retirantes” e “emigrantes”, é necessário destacar uma limitação recorrente da documentação de óbitos. Sabe-se, a partir de relatórios administrativos, correspondências oficiais, jornais e documentos das comissões de socorros, que a seca de 1877-1879 provocou intensos deslocamentos populacionais, tanto no interior da própria província quanto a partir de regiões circunvizinhas e de outras províncias.

No entanto, essa condição migrante aparece raramente explicitada nos registros paroquiais de óbito. As razões dessa omissão não são claras: pode estar relacionada à informalidade dos registros, à prioridade conferida a outras informações no momento do sepultamento ou mesmo à naturalização da condição migrante em um contexto de crise generalizada. Ainda assim, a baixa frequência dessa informação nos assentos contrasta com o que indicam outras fontes do período, que apontam a presença expressiva de pessoas em situação de deslocamento entre os óbitos registrados, conferindo especial relevância aos poucos casos em que essa condição foi mencionada de forma explícita.

Nesse sentido, os registros que identificam diretamente indivíduos como “retirantes” somam 7 ocorrências, com procedências bem definidas: Cajazeiras (2 casos), São João do Rio do Peixe (2), Piancó (1), Pombal (1) e Cariri (1), além de um registro de “emigrante” sem local especificado. Acrescentam-se ainda 1 ocorrência vinculada à Casa de Caridade e 13 registros sem identificação.

Quanto às procedências oriundas de outras províncias, os registros de óbitos indicam a presença de indivíduos provenientes do Ceará, totalizando 11 ocorrências, com menções a “emigrantes do Ceará” (3 casos) e a localidades específicas como Milagres (4), Crato, Inhamuns, Cariri cearense e Barbalha, com um registro cada. Mesmo que pouco frequentes, essas referências confirmam a circulação interprovincial no contexto da seca.

Além do Ceará, aparecem procedências da província de Pernambuco, somando 9 ocorrências, com destaque para Timbaúba (3), seguidas por Afogados (2) e Vila Bela (2), além de menções pontuais a Exu e Bom Conselho, com um registro cada. Registram-se ainda procedências do Rio Grande do Norte, representadas por Caicó (2 casos) e da Feira de Luís Gomes (1), e da província de Alagoas, com Palmeiras dos Índios (1).

Terminada a análise desses três municípios do Sertão, foi possível observar, a partir dos números de óbitos, que as doenças e outras causas de morte registradas concentram-se em enfermidades associadas à carência alimentar, às infecções transmissíveis, aos distúrbios do

trato digestivo e a processos prolongados de desgaste orgânico, marcados por enfermidades crônicas, recorrência de sintomas e incapacidade de recuperação do corpo.

Além da fome, inanição, beribéri e espasmos remetem ao colapso nutricional, enquanto febres, varíola e tísica indicam a circulação de doenças infecciosas relacionadas a formas específicas de contágio, como a convivência em espaços compartilhados e a exposição contínua a focos de infecção, fatores que se intensificavam em contextos de deslocamento. Já os registros de diarreias, disenterias, câmaras de sangue e inflamações intestinais apontam para o consumo de água imprópria, a ingestão de alimentos deteriorados e a exposição a ambientes insalubres, compondo um quadro de adoecimento no qual diferentes causas atuavam de forma combinada, e não como efeitos automáticos da seca.

Conforme observado na análise dos municípios do Sertão, as febres diversas e a varíola figuraram entre as enfermidades que mais vitimaram a população. Partimos agora para o exame dessas duas doenças em outras localidades da Parahyba, onde também alcançaram número significativo de vítimas ao longo de 1879. A documentação produzida pelas Comissões de Socorros revela a persistência dessas enfermidades e as dificuldades enfrentadas para lidar, de forma simultânea, com a doença, a fome e a insuficiência dos auxílios.

Na Vila de Independência (Guarabira), em comunicação datada de 29 de março de 1879²¹¹, a Comissão de Socorros informava que a varíola “continua ainda a flagelar este lugar”, ainda que apresentasse redução momentânea de intensidade. Segundo o documento, semanalmente “recolhe-se à casa estabelecida aqui para seu tratamento de três a quatro” doentes, havendo, naquele momento, quinze variolosos sob cuidados (Vila de Independência, AHWBD, 29/03/1879).

A comissão solicitava o envio de gêneros alimentícios não apenas para os enfermos, mas também sementes de milho, ressaltando que, apesar da existência de extensos roçados, a população encontrava-se impossibilitada de plantar “pela falta de semente e pelo seu estado de pobreza”, evidenciando como a doença se articulava diretamente à fome e à incapacidade de reprodução da vida material.

Situação semelhante aparece na documentação da Vila de Bananeiras, em 25 de maio de 1879²¹², quando a Comissão comunicou o recrudescimento da epidemia de varíola no

²¹¹ Comissão de Socorros de Independência, 29 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²¹² Vila de Bananeiras, em 25 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

município (Vila de Bananeiras, AHWBD, 25/05/1879). Na Vila de Cabaceiras, em ofício encaminhado ao Palácio da Presidência em 5 de abril de 1879²¹³, a comissão informava que “as moléstias reinantes continuaram, inclusive a varíola”, apontando que a doença teria sido introduzida por um passageiro proveniente das matas da província de Pernambuco, que transitara pela localidade em direção ao Alto Sertão. O documento sintetiza de forma contundente o quadro vivido pela população ao afirmar que “a fome, a nudez e as moléstias continuam a fazer vítimas” (Vila de Cabaceiras, AHWBD, 05/04/1879).

Esses registros permitem estabelecer um diálogo com as reflexões de Janille Maia (2019) sobre o Ceará durante a seca de 1877, quando a autora demonstra que a varíola, por seu caráter contagioso e por já ser uma doença conhecida pela medicina oitocentista, mobilizou com maior intensidade a atenção das autoridades públicas, em contraste com outras enfermidades frequentemente classificadas de forma genérica como “febres” (Maia, J., 2019, p. 91).

No entanto, como observa a autora, a concentração das ações voltadas ao combate da varíola não foi suficiente para conter sua disseminação, sobretudo em um contexto marcado por migrações forçadas, ausência de assistência no interior da província e múltiplas adversidades decorrentes da seca.

Além disso, Maia aponta que sintomas como estado febril, diarreia e vômitos eram frequentemente tratados de forma indistinta, por meio de terapêuticas padronizadas, como o uso da quinina, o que dificultava a identificação precisa das enfermidades e comprometia a eficácia dos socorros públicos (Maia, 2019, p. 92–93). No próximo subtópico, ao analisarmos as práticas de cura, será possível observar convergências entre esses métodos terapêuticos.

Embora diversas enfermidades circulassem simultaneamente durante a seca, Janille Maia demonstra que a varíola ocupou lugar central nas preocupações das autoridades cearenses, em razão de seu caráter contagioso e de sua longa tradição nos debates médicos do século XIX. Enquanto as febres e as doenças intestinais eram frequentemente minimizadas nos relatórios oficiais, a varíola mobilizou a criação de lazaretos, campanhas de vacinação e medidas de isolamento, ainda que tais ações se mostrassem insuficientes para conter a disseminação da doença (Maia, J., 2019, p. 92–93).

Na Parahyba, a documentação também indica uma atenção diferenciada em relação à varíola, especialmente nos momentos em que surgiam temores de epidemia, ao passo que outras doenças associadas à fome e a enfermidades de caráter infectocontagioso continuavam

²¹³ Vila de Cabaceiras – Palácio da Presidência 05 de Abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

a produzir elevados índices de mortalidade, muitas vezes sem respostas institucionais equivalentes por parte do poder público.

Segundo Serioja Mariano (2022, p. 178–179), a incidência da varíola na Parahyba ocorreu cerca de um ano antes da eclosão da seca, tendo vitimado principalmente indivíduos que não confiavam na vacina. Como forma de conter a doença e proteger a vida da população, o governo promoveu o envio de ambulâncias com “o pus vacínico para as Colônias”.

No município de Piancó, no Sertão, a autora constatou que, apesar do fornecimento da linfa vacínica pelo governo, muitos moradores recusavam a vacinação, sendo recorrente a associação, nos registros, entre os óbitos e a chegada de indivíduos provenientes de outras localidades, principalmente da capital, onde a concentração da vacina era maior (Mariano, 2022, p. 180).

Se a varíola ocupou lugar central nas preocupações sanitárias, mobilizando ações específicas de vigilância, vacinação e isolamento, outras enfermidades, em especial as chamadas febres diversas – como a amarela, a intermitente, a contínua, a nervosa, a remitente, a maligna e a pútrida – também marcaram de forma profunda o cotidiano da província ao longo da seca.

Diferentemente da varíola, essas moléstias apareceram de maneira recorrente na documentação, muitas vezes tratadas de forma genérica sendo apenas citadas, sem diagnóstico preciso ou tratamento, o que ajuda a compreender a complexidade do quadro sanitário vivido na Parahyba.

Como pode ser observado no ofício datado de 1º de junho de 1877²¹⁴, o Inspetor de Saúde Pública, Dr. Abdon Felinto Milanez, apresenta informações sobre a vigilância sanitária da capital ao comunicar a chegada ao Porto de Cabedelo de um navio inglês chamado *Goldstream*, que já trazia alguns de seus tripulantes “vítimas de febre amarela”.

Como parte das medidas preventivas adotadas para impedir a propagação inicial da moléstia na província, amparado no Regulamento Sanitário de 23 de janeiro de 1877, o inspetor afirma ter determinado a quarentena da embarcação por cinco dias, restringindo a circulação de pessoas e mercadorias, por considerar tal providência indispensável para resguardar a população diante da possibilidade de disseminação da doença.

Ao detalhar a situação, o inspetor revela também as limitações do aparato de saúde pública. Relata ter solicitado funcionários que não compareceram para prestar apoio, além de mencionar outros pedidos não atendidos, ressaltando a dificuldade de manter o controle

²¹⁴ Inspetoria de Saúde do Porto da Província da Parahyba, 01/06/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

sanitário com recursos tão escassos. Ao mesmo tempo, insiste que agiu “como podia” para resguardar o porto, ciente de que a propagação da febre amarela teria consequências graves em um contexto no qual a seca já fragilizava profundamente as condições de vida da população.

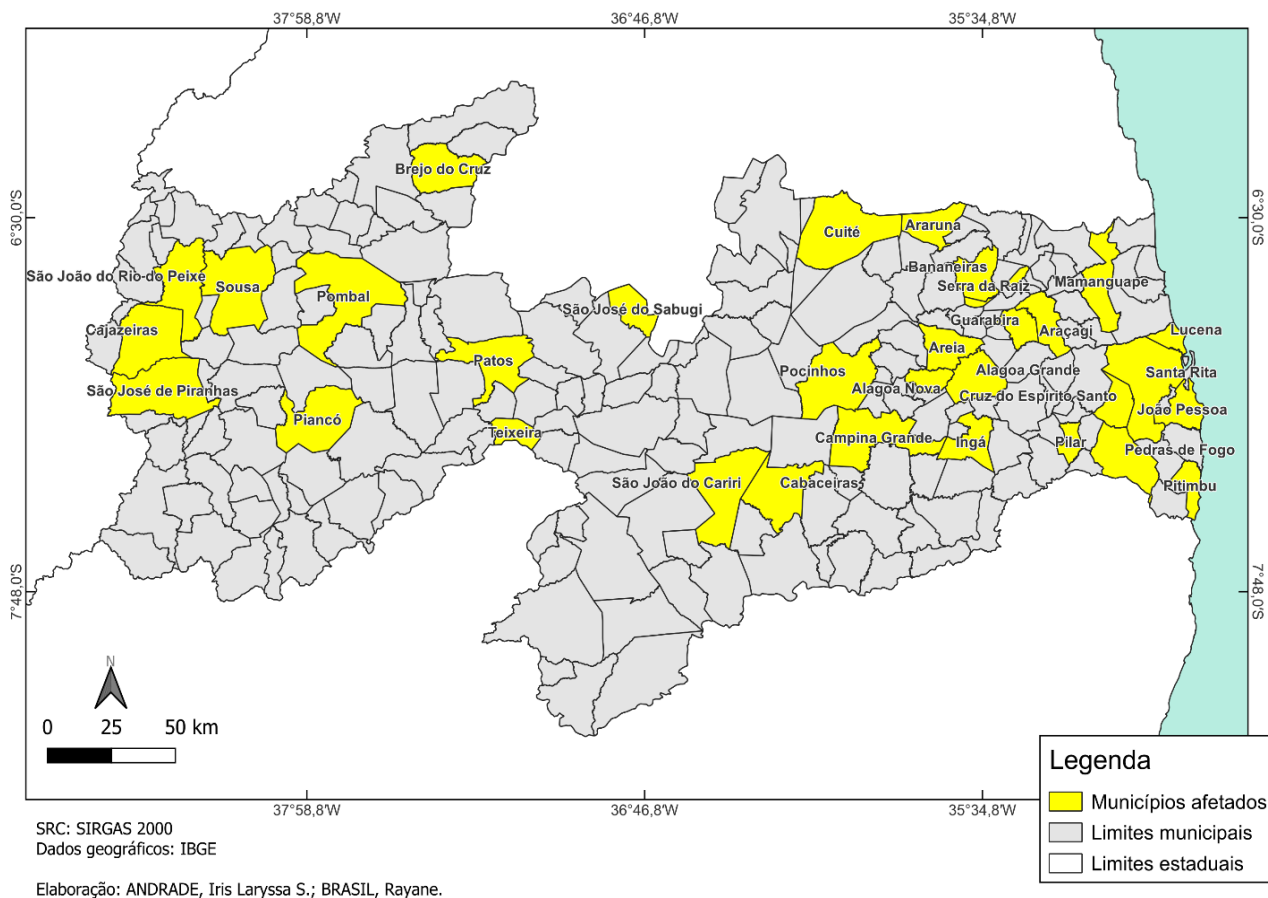
Esse episódio nos mostra que, mesmo antes do avanço mais dramático da seca de 1877-1879, a saúde da população já dependia de medidas preventivas não atendidas, de condições sanitárias instáveis e, muitas vezes, de iniciativas individuais de autoridades locais que buscavam impedir que enfermidades epidêmicas se somassem à calamidade em curso.

No mapeamento realizado por nós, com base nas documentações administrativas, hospitalares e da Inspetoria de Saúde Pública, computamos a ocorrência de epidemias ou surtos de febres de diferentes naturezas em 33 municípios distribuídos pelas quatro mesorregiões da Parahyba. Esses registros indicam a ampla disseminação dos quadros mórbidos no território provincial, atingindo tanto áreas do interior quanto localidades próximas à Capital.

Considerando essa distribuição espacial, os municípios afetados podem ser organizados da seguinte forma: na mesorregião do Sertão, registraram-se ocorrências em Brejo do Cruz, Cajazeiras, Patos, Piancó, Pombal, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, São José do Sabugy, Sousa e Teixeira; na Borborema, em Alagoa Grande, Alagoa Nova, Araruna, Areia, Bananeiras, Borborema, Cabaceiras, Campina Grande, Cuité, Pocinhos e São João do Cariri; no Agreste, em Araçagi, Guarabira, Ingá e Serra da Raiz; e na Mata, em Cruz do Espírito Santo, Capital (atual João Pessoa), Lucena, Mamanguape, Pedras de Fogo, Pilar e Santa Rita.

No mapa da Figura 6, observa-se a proporção assumida pelas febres entre os registros analisados.

Figura 6 – Municípios da Parahyba afetados por febres diversas (1877-1879)



Fonte: Mapa elaborado por Iris Laryssa S. Andrade e Rayane Brasil, com base em relatórios administrativos, registros hospitalares e documentos da Inspetoria de Saúde Pública da Província da Parahyba (1877-1879). Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877-79, Caixas: 61 (A e B) e 62, utilizando o *software QGIS*.²¹⁵

Com o registro acima, percebemos que nos três anos consecutivos de estiagem, a presença de surtos febris tornou-se constante, sendo associada não apenas as circunstâncias já apresentadas, mas também a falta de assistência médica no interior da província, que dependia da atuação de poucos funcionários para atender uma população adoecida e em deslocamento.

Como demonstram Marcus Pierre de Carvalho Baptista e Francisco de Assis de Sousa Nascimento (2025), as febres intermitentes – então denominadas “febres palustres”, “sezões” ou “tremedeiras” – integravam um quadro mais amplo de moléstias que marcaram o século XIX nas províncias do Norte, produzindo alterações profundas no cotidiano e nas sensibilidades das populações atingidas.

²¹⁵ O mapa foi elaborado no *software QGIS*, utilizando como base cartográfica os limites municipais fornecidos pelo IBGE (projeção WGS 84 – UTM).

Os autores ressaltam que essas febres, hoje reconhecidas como malária, eram compreendidas à época como um “mal” de grande letalidade, cujas manifestações cíclicas, acompanhadas de dores, prostração e anemia, tornavam-se parte das experiências coletivas em áreas alagadiças ou próximas a rios (Baptista; Nascimento, 2025, p. 6-7).

Ainda que analisem o surto de febres ocorrido na Vila de Amarração, no Piauí, em 1872, Baptista e Nascimento oferecem interpretações que dialogam diretamente com o contexto da seca de 1877-1879 na Parahyba, ao relatarem como a fome e as doenças, em especial, as febres, entrelaçavam na experiência das populações pobres. Os autores mostram que os jornais da época denunciavam “a miséria com todo seu cortejo de horrores”, destacando que “a classe menos favorecida” sucumbia “mais pela fome do que mesmo pela epidemia” (*O Cearense*, 09/05/1872 *apud* Baptista; Nascimento, 2025, p. 15-16).

Ao mesmo tempo, Baptista e Nascimento observam que as autoridades provinciais mobilizavam recursos para socorrer populações representadas como “classes perigosas”, em um contexto no qual o medo do contágio se somava ao temor de possíveis convulsões sociais (Baptista; Nascimento, 2025, p. 13-14). Essa lógica de representação também esteve presente na nossa análise, quando os migrantes adoecidos eram simultaneamente reconhecidos como vítimas da calamidade e tratados como potenciais focos de disseminação de doenças, o que reforçava a necessidade de vigilância, controle e contenção por parte das autoridades públicas.

Nesse sentido, a análise da mesorregião do Sertão permitiu demonstrar a complexidade e a gravidade do quadro vivido pela população durante a seca. Os registros de óbitos e correspondências revelaram situações-limite de falta de alimentos, que chegaram a produzir práticas extremas, como o canibalismo, ao mesmo tempo em que expuseram a disseminação de enfermidades associadas à debilidade física prolongada. Além disso, a varíola emergiu como uma doença que despertou atenção diferenciada por parte das autoridades, mobilizando ações específicas de vigilância e controle, enquanto as chamadas febres diversas também apareceram de forma recorrente.

A partir desse quadro, torna-se fundamental compreender como se estruturaram as tentativas de enfrentamento do adoecimento, o que nos conduz ao exame dos métodos de cura empregados, da atuação dos médicos e dos práticos, bem como das demais medidas de assistência mobilizadas ao longo da seca.

3.3 “TALVEZ IMERECIDAMENTE, AOS MEUS CUIDADOS NA MEDICINA”: SABERES MÉDICOS, PRÁTICAS DE CURA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Até o momento, analisamos principalmente a atuação política em torno dos meios acionados para amenizar a crise e prestar assistência à população vitimada pela seca. Passamos agora à análise do conjunto de agentes envolvidos no cuidado à saúde, composto por médicos-higienistas, curandeiros, boticários e farmacêuticos, cujas práticas, compreensões e formas de atuação apresentavam especificidades no tratamento dos diferentes grupos sociais e das enfermidades mencionadas ao longo deste capítulo.

Cabe ainda considerar as múltiplas estratégias e procedimentos empregados nos processos de cura, como a forte presença do uso da homeopatia. Nesse sentido, examinaremos as divergências e aproximações entre esses agentes, buscando compreender como cada um atuou no contexto da Seca de 1877-1879.

Nesse primeiro momento, começaremos pela atuação médica. Na Parahyba do Norte, o corpo médico não se consolidou apenas no exercício da prática curativa ou no viés higienista, mas também por sua inserção em espaços estratégicos de poder, atuando em cargos da administração provincial²¹⁶, na instrução pública²¹⁷ e na política, como senadores ou deputados provinciais e gerais²¹⁸ (Mariano, N., 2015, p. 93-95).

Essa presença ampliada dos médicos no cenário público dialoga com a reflexão de Elyonara Targino, ao afirmar que as Faculdades de Medicina também cumpriram um papel central na formação de quadros políticos atuantes na construção do Estado Nacional, uma vez que, a partir da segunda metade do século XIX, ganhava força o discurso médico que defendia a constituição de “uma nação higiênica, civilizada e asseada” (Targino, 2021, p. 62).

Se, no plano discursivo e institucional, os médicos ocupavam posições estratégicas, as fontes também permitem acompanhar quem eram os profissionais que atuaram de forma efetiva durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba. A relação desses agentes, suas funções e os espaços de atuação durante a seca são apresentados no Quadro 6.

²¹⁶ Há registros de médicos que ocuparam o comando da Província da Parahyba, na condição de presidente ou vice-presidente, entre eles o Dr. João José Innocencio Poggi (1866) e o Dr. José Evaristo da Cruz Gouveia (Mariano, 2015, p. 90 e 93).

²¹⁷ Eugênio Toscano de Brito exerceu funções em diferentes esferas, atuando como médico, jornalista e diretor da Instrução Pública, do Liceu e da Escola Normal (Mariano, 2015, p. 95).

²¹⁸ Entre os médicos que exerceram mandatos como deputados, tanto em âmbito provincial quanto nacional, destacam-se José Evaristo da Cruz Gouveia, Manoel Carlos Gouveia e Abdon Felinto Milanez, conforme identificado por Targino (2021, p. 62).

Quadro 6 – Médicos que atuaram durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba

Nome	Naturalidade	Função	Locais de atuação
Abdon Felinto Milanez	Areia (PB)	Médico e Cirurgião	Santa Casa da Misericórdia, Hosp. Cruz do Peixe (Capital) e Inspetoria de Saúde Pública
Antônio da Cruz Cordeiro	Cidade da Parahyba	Médico e Cirurgião	Hosp. Santo Antônio, Nossa Senhora das Neves e Santa Casa da Misericórdia
Antônio de Sousa Nunes Pinto	-	Cirurgião	Hosp. São Pedro (Mamanguape)
João Nepomuceno Dias Fernandes	Recife (PE)	Médico	Hosp. São Pedro (Mamanguape)
Ernesto Feliciano da Silva Tavares	-	Médico e Cirurgião	Hosp. Nossa Senhora das Neves
Fausto Nominando Meira de Vasconcellos	Pilar (PB)	Médico	Sousa
José Lopes da Silva	Salvador (BA)	Médico militar	Interior da Província e Enfermaria do Hosp. Santo Antônio
Luiz José Correia de Sá	Souza (PB)	Médico e Parteiro	Hosp. Santo Antônio (Capital), Inspetoria de Saúde Pública e Comissário Vacinador
José Evaristo da Cruz Gouveia	Areia (PB)	Clínico e cirurgião	Hosp. de Areia

Fonte: Quadro elaborado por nós de acordo com as informações extraídas de diferentes fontes do período, incluindo relatórios da Presidência da Província da Parahyba do Norte, exposições administrativas, mapas e relações de empregados de enfermarias e hospitais, correspondência oficial, consultados no Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD).

Cada um desses nove médicos-cirurgiões possui uma trajetória que pode ser articulada às experiências da população pobre e migrante atingida pela seca. Mais do que nomes e funções, suas atuações revelam formas distintas de inserção no cotidiano da crise, nos espaços de assistência e nas relações estabelecidas com aqueles que buscavam socorro médico em meio à estiagem.

Entre esses médicos, destaca-se a trajetória de Antônio da Cruz Cordeiro, nascido na vila de Independência, em 1831, Cruz Cordeiro era filho de uma família abastada, condição que lhe garantiu acesso aos estudos no Lyceu Paraibano e, posteriormente, à Faculdade de Medicina da Bahia, onde se formou em 1856.

Ao longo de sua vida profissional, atuou em diferentes instituições de assistência, exerceu funções em enfermarias e hospitais e integrou o Corpo de Saúde do Exército, atuando nas províncias da Parahyba, de Sergipe e do Amazonas, acumulando experiências em diferentes realidades regionais (Mariano, S., 2015, p. 300-301).

Paralelamente à prática médica, participou ativamente da vida política provincial, tendo sido deputado pelo Partido Liberal por três legislaturas consecutivas, entre 1864 e 1869. Conforme demonstra Serioja Mariano (2015, p. 300), essa trajetória foi acompanhada por

intensa produção escrita e presença constante na imprensa periódica, fazendo de Cruz Cordeiro um homem das letras, inserido nos circuitos políticos e intelectuais de seu tempo.

Nos concentraremos agora nas interpretações formuladas por Cruz Cordeiro no contexto da seca. Sua atuação simultânea no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, bem como nos hospitais de Santo Antônio e de Nossa Senhora das Neves — neste último com vencimentos de 200\$000 (duzentos mil-réis) — oferece um ponto de observação privilegiado para compreender as explicações construídas diante do elevado número de doenças registradas nesse período. A circulação entre diferentes espaços de atendimento permitia-lhe acompanhar tanto os quadros clínicos recorrentes quanto as condições materiais em que se davam os tratamentos.

Nos relatórios que produziu, o médico ancorava suas análises na teoria miasmática, amplamente difundida na medicina oitocentista, recorrendo a esse referencial para explicar a origem e a propagação das enfermidades que atingiam a população. Ao associar doenças às emanções insalubres do ambiente, à decomposição orgânica e às condições higiênicas precárias, suas interpretações demonstram não apenas um enquadramento científico específico, mas também uma forma particular de compreender a crise sanitária agravada pela seca.

Para fins explicativos, a teoria miasmática partia do pressuposto de que as doenças tinham origem nas condições do ambiente, por meio da deterioração do ar provocada pela decomposição de matérias orgânicas, exalações de pessoas e animais doentes ou pelas condições insalubres dos espaços habitados.

Dessa forma, atribuía à atmosfera e ao meio físico um papel central na explicação da propagação das enfermidades. Para evitar a formação dos miasmas, medidas como a limpeza das ruas, o descarte adequado do lixo, a remoção de matadouros e cemitérios para áreas consideradas menos insalubres, além da utilização de substâncias como o cloro, eram adotadas na tentativa de conter os processos de putrefação percebidos como causadores de riscos à saúde (Martins; Prestes, 2021, p. 431).

Nas pesquisas realizadas por Laércio Sousa Jr. (2023) sobre a epidemia de cólera na Parahyba, evidencia-se que a atuação dos médicos não se limitava à identificação dos focos considerados insalubres, mas também incidia sobre os hábitos e práticas cotidianas da população como um instrumento de regulação social, ensinando a população a temer não apenas a doença em si, mas também o contato com doentes, cadáveres e locais classificados como impuros (Sousa Jr., 2023, p. 52).

Ao transformar o ar, os espaços e os corpos em potenciais fontes de contágio, os médicos influenciavam costumes, sensibilidades e formas de convivência, reforçando atitudes de afastamento, aversão e vigilância, especialmente em contextos epidêmicos como o da cólera. Assim, a medicina participava ativamente da construção de um imaginário sanitário que reorganizava a relação da população com a cidade, com o outro e com o próprio espaço urbano.

Seguindo essas considerações, insere-se a crítica do Dr. Antônio da Cruz Cordeiro em seu relatório que, embora se detenha nos problemas enfrentados pela Santa Casa da Misericórdia, também reserva apontamentos sobre a falta de asseio da Cadeia Pública da Capital. Nas palavras de Cruz Cordeiro, já havia advertido o delegado acerca do pântano que cercava a Cadeia, cujos canais expõem dejetos em estado de putrefação que, além do fedor exalado, contribuíam, segundo ele, “para o desenvolvimento das febres, obstruções e anemias” que afetavam os indivíduos reclusos (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Como parte do avaliamento, o médico constrói um diagnóstico orientado pela teoria miasmática, identificando no espaço físico do edifício os principais fatores de risco à saúde dos presos. Segundo ele, a própria localização da Cadeia já representava um problema, uma vez que, “pelo lado do sul o edifício da Cadeia se acha colocado abaixo de uma ribanceira”, o que favorecia, nos períodos de inverno, a infiltração das “águas torrenciais” no solo, mantendo o pavimento térreo sempre úmido e frio. Para ele, essa umidade, associada às lajes de pedra das prisões situadas ao nível do solo, criava um ambiente insalubre, propício ao adoecimento (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Entretanto, Cruz Cordeiro não restringe sua crítica ao período chuvoso. No contexto da seca, ele identifica um risco ainda mais grave, afirmando que, “pelo tempo de verão ou de seca”, a Cadeia se ressentia de “outro inconveniente não menos perigoso e nocivo à saúde dos presos”, decorrente da “evaporação ativa das águas estagnadas dos pântanos”. Aqui, o médico destaca um elemento central do pensamento miasmático: a associação entre calor, estagnação da água e decomposição orgânica como fontes diretas de doenças e contaminações (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Em consonância com as preocupações expressas por Cruz Cordeiro, Nayana Mariano (2015, p. 106) explica que a Cadeia Pública figurava, já no ano de 1858, quando Henrique Beaurepaire Rohan assumiu a província, entre os espaços mais problemáticos da administração provincial. A autora chama atenção para o fato de que, nos relatórios oficiais, as cadeias da província eram descritas de forma recorrente como edificações improvisadas,

pouco seguras e mal ventiladas, funcionando muitas vezes em casas particulares ou prédios sem qualquer adaptação adequada para o encarceramento.

Somado a esses fatores, em diversas localidades, os edifícios não conseguiam atender às exigências mínimas de salubridade. Pelo viés médico seria apropriado mudanças como “um ambiente maior, arejado, higiênico, com medidas disciplinares que objetivavam a recuperação dos prisioneiros” (Mariano, N., 2015, p. 108).

Como solução, o médico propunha a dissecação total do pântano, com a eliminação dos “detritos dos vegetais, os moluscos, os répteis, os vermes”, além de animais mortos, uma vez que não seria possível transferir a Cadeia Pública para outro local limpo e arejado²¹⁹, “em vista da penúria da Província”. Indicava ainda a necessidade de renovar a pintura da Cadeia, devido às antigas caiaduras das paredes, consideradas por ele como pouco higiênicas, bem como abrir novas áreas que possibilitassem a circulação do “ar limpo”, prevenindo o risco de “constipações e outras moléstias como febres, obstruções, anemias, bronchites” (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Além disso, mencionava a alimentação dos presos, apontando o consumo de banana e de “muitas outras substâncias nocivas aos seus procedimentos crônicos [...], dando origem a outros males”. Segundo sua avaliação, essas condições contribuíam para que os reclusos apresentassem a pele de “cores macilentas” e sinais de “definhamento” (Offício n.º674, AHWBD, 10/07/1877).

Tais interpretações vistas até aqui, do Dr. Cruz Cordeiro, estão inseridas no repertório explicativo da medicina oitocentista, que atribuía ao clima, às variações atmosféricas e às condições ambientais adversas um papel central no adoecimento das populações. Ao privilegiar essas causas naturais, o discurso médico tendia a naturalizar a crise sanitária, minimizando o peso de fatores sociais e políticos, como a fome, a miséria, os deslocamentos forçados e a insuficiência dos socorros públicos, elementos que agravavam de forma decisiva o quadro de adoecimento e negligência pública observado durante a seca.

Nesse sentido, a interpretação médica operava um deslocamento significativo: ao localizar a origem das enfermidades no ar corrompido, nos pântanos ou nas variações climáticas, diluía-se a responsabilidade administrativa pela precariedade das condições de vida da população pobre. A seca aparecia, assim, como fenômeno natural agravado por fatores

²¹⁹ A mesma proposta já havia sido apresentada naquele ano à Santa Casa da Misericórdia pelo presidente da província, Esmerino Parente, que defendia a transferência da instituição para o edifício do antigo Collegio de Educandos de Artificies, espaço que já abrigava as enfermarias destinadas aos variolosos da Cruz do Peixe (Parahyba do Norte, Relatório, 12/08/1877, p. 37).

ambientais, e não como crise também produzida por desigualdades estruturais e limitações das políticas de assistência.

Com relação às intervenções cirúrgicas realizadas tanto por Antônio da Cruz Cordeiro quanto por Abdon Felinto Milanez, observa-se que elas iam desde procedimentos considerados de alto risco até operações de menor complexidade. Entre as cirurgias mais graves, destacavam-se as amputações, as punções de hidrocele (drenagem do líquido acumulado no escroto), as paracenteses (punção da cavidade abdominal para retirada de líquidos), a redução de diferentes tipos de luxações, a extirpação de lipomas, a remoção de tumores e a extração de projéteis, o que remete à gravidade dos quadros clínicos atendidos e à necessidade de intervenções invasivas (Brasil, R., 2023, p. 38).

Paralelamente, eram realizadas operações classificadas como de baixo risco, como dilatações de abscessos, incisões de panarícios (cortes em infecções dos dedos) e de vegetações (remoção de tecidos anormais), cauterizações, aplicação de aparelhos de talas em fraturas e circuncisões, procedimentos associados tanto ao tratamento de infecções quanto à contenção de lesões e à recuperação funcional dos pacientes (Brasil, R., 2023, p. 38).

Dando continuidade à análise dos médicos que contribuíram com seus serviços, destaca-se o Dr. Abdon Felinto Milanez, cuja trajetória evidencia a circulação entre a prática médica e os espaços de poder na Parahyba da segunda metade do século XIX. Natural de Areia, Milanez construiu uma atuação que o projetou tanto no campo da medicina quanto na política provincial, ocupando cargos como o de Inspetor de Saúde Pública e médico da Santa Casa, ao mesmo tempo em que se inseria de forma recorrente nas disputas legislativas (Targino, 2021, p. 75).

Conforme analisa Elyonara Targino (2021), essa dupla inserção não era incomum entre os médicos oitocentistas da província, mas, no caso de Milanez, revela-se particularmente expressiva pela continuidade de sua presença nos cargos públicos, pela produção de discursos vinculados à Saúde Pública nos relatórios presidenciais e pelas redes de sociabilidade das quais participou. Sua atuação parlamentar, que atravessou diferentes legislaturas e alcançou também a esfera geral, como deputado e senador, ocorreu sem o abandono do exercício da medicina, destacando a articulação entre saber médico e atuação política na província (Targino, 2021, p. 75).

No exercício da função de inspetor de saúde pública da Capital, em 1877, o médico passou a deslocar famílias vindas de outras regiões, afetadas pelos males provocados pela seca, para casas particulares situadas fora do centro da cidade, implementando medidas de quarentena, controle da dieta e, quando necessário, a utilização de medicamentos. De forma

complementar, fiscalizava a chegada de navios ao porto, verificando a existência de tripulantes acometidos por enfermidades que pudessem representar riscos à saúde dos demais.

Além das extensas atividades que desempenhava na Capital, nos hospitais já citados e na Cruz do Peixe, era também responsável por administrar e responder às informações enviadas tanto pela Comissão de Socorros Públicos quanto por profissionais de outras localidades e hospitais. Sempre que havia solicitação de ambulâncias com remédios, cabia-lhe autorizar o envio ou determinar o deslocamento de médicos e farmacêuticos para prestar apoio.

Para além das trajetórias de Cruz Cordeiro e Abdon Milanez, outros médicos também desempenharam papéis relevantes na assistência à população durante o período, entre eles o Dr. Ernesto Feliciano da Silva Tavares. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1858²²⁰, já atuava na década de 1860 como 2º cirurgião do Corpo de Saúde do Exército (*Publicador Maranhense* (MA), n.º 21, 30/01/1862, p. 1).

Apesar de não terem sido localizadas informações suficientes que permitam identificar com precisão sua naturalidade, sabe-se que, segundo notícia publicada em 22 de novembro de 1882, no jornal *Gazeta de Notícias* (RJ)²²¹, o médico faleceu em São José de Mupibú, na província do Rio Grande do Norte.

No contexto da assistência hospitalar na Parahyba, o Dr. Silva Tavares atuava no Hospital de Nossa Senhora das Neves²²² desde sua fundação, em 1878, com salário de 400\$000 (quatrocentos mil-réis) e atendendo, em conjunto com o Dr. Antônio da Cruz Cordeiro, uma média mensal de 200 a 300 pessoas (Relação dos empregados do Hospital de N. S. das Neves, AHWBD, 30/06/1879).

Enquanto isso, o Dr. Luiz José Correia de Sá, natural do município de Sousa, atuava como clínico e parteiro e, no Hospital de Santo Antônio, exercia suas funções com dedicação exclusiva, recebendo gratificação mensal de 120\$000 (cento e vinte mil réis) (Relação dos empregados da Enfermaria de S. Antônio, AHWBD, 1878; Mariano, N., 2015, p. 94).

Essa atuação se dava em um cenário de intensa sobrecarga assistencial, uma vez que, conforme o mapa demonstrativo do movimento geral, a instituição recebeu aproximadamente

²²⁰ Conforme o *Livro de Theses da Faculdade de Medicina da Bahia (1836–1888)*, as defesas eram organizadas segundo o formato institucional que distribuía os temas entre ciência cirúrgica, ciência médica e ciência acessória. No caso de Silva Tavares, os temas abordados envolveram o diagnóstico diferencial das prenhez extrauterinas, reflexões sobre o raquitismo e a osteomalácia, a natação e a discussão médico-legal acerca do estupro. A obra foi publicada em Salvador, pela Typographia Carlos Poggetti, em 1858.

²²¹ *Jornal Gazeta de Notícias* (RJ), n.º 325, 22/11/1882, p. 2.

²²² Relação dos empregados do Hospital de N. S. das Neves, em 30 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

4.301 pacientes entre 1º de abril de 1878 e março de 1879, período em que foram registrados 2.264 curados, 414 em recuperação e 1.623 óbitos (Mappa demonstrativo da Enfermaria de S. Antônio, AHWBD, 1879).²²³

No ano de 1879, o Dr. Correia de Sá passou a exercer mais duas funções, as de Inspetor de Saúde Pública da Capital e do Porto e de Comissário Vacinador, em razão do “impedimento efetivo” do Dr. Abdon Felinto Milanez, que, ao ocupar assento na Assembleia Provincial, fez opção pelos vencimentos do mandato.²²⁴ Em decorrência dessa substituição, foi autorizado, pela verba de “Eventuais”, o crédito de 200\$000 réis, destinado ao pagamento dos vencimentos de Correia de Sá, enquanto permanecesse no exercício interino desses cargos (Ministério dos Negócios do Império, AHWBD, 11/03/1879).

Outro médico que colaborou ativamente foi o Dr. José Lopes da Silva, natural de Salvador (BA), que, além de médico militar, também atuava como jornalista e político (Mariano, N., 2015, p. 92). Seu nome aparece em uma relação elaborada pela Comissão Central de Socorros²²⁵, datada de 15 de outubro de 1877, que reunia os residentes da Capital da Província convocados para prestar serviços no enfrentamento da crise. Por essa atuação, recebeu a gratificação de 5\$000 (cinco mil réis) (Relação das pessoas residentes n’esta Capital..., AHWBD, 15/10/1877).

Por meio dessa relação, é possível supor que o Dr. Lopes da Silva tenha atuado em algum município do interior e, em determinados momentos, desempenhado também funções de caráter administrativo. Essa hipótese se sustenta no fato de seu nome figurar entre os coordenadores da Comissão de Socorros em correspondência encaminhada ao presidente da província, na qual se comunicava o recebimento de doações provenientes da loja maçônica da Capital, *Vigilância e Segredo* (Cidade da Parahyba do Norte, AHWBD, 29/06/1877).²²⁶

Posteriormente, entre 1878 e 1879, passou a atuar na Enfermaria do Hospital de Santo Antônio, ao lado dos médicos Cruz Cordeiro e Correia de Sá (Enfermaria de Santo Antônio

²²³ Mappa demonstrativo do movimento geral da Enfermaria de Santo Antônio desde o 1º de abril de 1878, data de sua instalação, até o último de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²²⁴ Ministério dos Negócios do Império. Directoria N.º 1043. Rio de Janeiro, em 11 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²²⁵ Relação das pessoas residentes n’esta Capital, que se dignaram, accendendo ao pedido da Commissão Central de Socorros as victimas da secca, subscrever para de alguma forma minorar os rigores da fome e da nudês de que se acham presos milhares de infelizes no interior da Província, em consequencia da desastrada secca que a flagela. 15 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²²⁵ Cidade da Parahyba do Norte em 29 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²²⁶ Cidade da Parahyba do Norte em 29 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

da Parahyba, AHWBD, 02/05/1879). De acordo com notícia publicada no jornal *A Opinião*, em março de 1879, o Dr. Lopes da Silva teria trabalhado ativamente “durante toda essa longa crise de fome, peste e miséria, em que a população desvalida reclamava o seu valioso concurso médico”, tendo pedido licença de três meses para visitar sua família na Bahia (*A Opinião*, 03/1879 *apud* Castro, O., 1945, p. 122).

Já o Dr. Fausto Nominando Meira de Vasconcellos apresenta uma trajetória distinta no interior desse conjunto de profissionais. Nascido no município de Pilar e formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, construiu sua atuação médica fora dos grandes centros, exercendo a clínica em diferentes localidades do interior da província.

Ainda na década de 1860, ocupou funções na administração local, como a de delegado do termo de Sousa, ao mesmo tempo em que se vinculava à Guarda Nacional, onde alcançou o posto de capitão e exerceu o cargo de cirurgião-mor do Comando Superior, com atuação nas regiões de Pombal, Sousa, Catolé do Rocha, Patos e Piancó (*O Publicador*, n.º 1304, 18/01/1867, p. 1; Mariano, N., 2015, p. 93).

Durante a seca de 1877-1879, foi o único entre esses médicos que não esteve ligado a um hospital, concentrando sua atuação exclusivamente no município de Sousa – uma das áreas mais atingidas pela estiagem, conforme discutido anteriormente.²²⁷ Assim como os demais, enfrentou limitações impostas pela escassez de recursos financeiros e de medicamentos, agravadas pela redução dos repasses autorizados pela presidência da província, à época sob a administração do Dr. Ulysses Machado Pereira Viana (Comarca de Souza, AHWBD, 17/07/1878).

Do mesmo modo que o Dr. Antônio da Cruz Cordeiro defendia a teoria miasmática como principal fator de propagação de epidemias e doenças, o Dr. Meira de Vasconcellos seguia a mesma linha de pensamento, bastante comum ao longo do século XIX. Para ele, no segundo ano da estiagem, a recorrência de casos de doenças infecciosas, intestinais, carenciais, dermatológicas, respiratórias, oftálmicas e venéreas decorria das “influências das mudanças meteorológicas” (Comarca de Souza, AHWBD, 17/07/1878).

Essas indicações formuladas pelo médico também influenciavam os membros da Comissão de Socorros em Sousa²²⁸, que, ao enumerarem as circunstâncias enfrentadas naquela localidade, afirmavam que a falta de higiene dos “infelizes lhe trazem diversas

²²⁷ Comarca de Souza, 17 de julho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²²⁸ Comarca de Souza, 13 de novembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

doenças”, tornando necessário o amparo do governo para retirar uma população que “está reduzida ao estado dos primitivos habitantes pela nudez de seus membros e habitação das selvas, onde, ao mesmo tempo que procuram os alimentos salutareis, já escassos, escondem o vergonhoso de sua cruel situação” (Comarca de Souza, AHWBD, 13/11/1878).

Desse modo, constatamos a repetição e a progressiva consolidação de um discurso higiênico influenciado pela teoria miasmática que, no contexto da seca, passou a operar com alvos específicos: os migrantes, principalmente aqueles oriundos do sertão ou que nele permaneciam.

Mais do que explicar doenças, esse discurso contribuía para classificar sujeitos. Ao associar falta de higiene, nudez e hábitos considerados inadequados ao risco sanitário, produzia-se uma hierarquização moral dos corpos, na qual os migrantes apareciam como foco privilegiado de vigilância e intervenção.

Concordamos com Nayana Mariano (2015, p. 84) ao classificar esse discurso como parte dos preceitos “da ordem, da civilização e do progresso”, uma vez que as estratégias de sobrevivência dessas populações chamavam mais atenção do que as possibilidades de ação governamental ainda existentes.

Logo, em meio à extrema miséria e à insuficiência de uma assistência eficaz, tornava-se mais recorrente descrevê-las por meio de um processo de desumanização discursiva, no qual o vocabulário médico e administrativo convergia para justificar intervenções sobre corpos considerados fora da ordem social e moral.

Como indicado no Quadro 6, o Dr. João Nepomuceno Dias Fernandes era o responsável pelo Hospital de São Pedro. Natural da cidade do Recife, na província de Pernambuco, formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1850, apresentando a dissertação: *Sobre os dous pontos das sciencias accessorias e chirurgicas e algumas proposições relativamente ao ponto das sciencias medicas*.

Sua tese, tinha como objetivo apresentar os fundamentos da química médica, fisiologia, eletroquímica e aspectos das intervenções cirúrgicas, com especial atenção às teorias que explicavam os fenômenos químicos e às indicações clínicas para a extirpação do globo ocular (Fernandes, J., 1850).

Quanto a outros aspectos, as fontes não permitem reconstituir com maior detalhe sua atuação cotidiana à frente da instituição, que teve como desfecho a solicitação de exoneração do cargo e sua substituição pelo cirurgião Dr. Antônio de Sousa Nunes Pinto.

A atuação do cirurgião Nunes Pinto esteve estreitamente vinculada ao município de Mamanguape desde a década de 1850, quando participou ativamente do enfrentamento de

epidemias como a febre amarela e o *cholera morbus*. Para além da prática médica, manteve inserção no campo político, com filiação ao Partido Conservador, e ocupou cargos administrativos, como o de subdelegado de polícia. Esse percurso culminou em sua nomeação como capitão-cirurgião-mor da Guarda Nacional, reforçando a circulação desse profissional entre os campos médico, administrativo e militar (Souza Jr., 2023, p. 117).

Durante a seca, destacou-se como um médico atento às condições dos enfermos, cuidando de pobres, órfãos e migrantes abrigados no Hospital de São Pedro. Ao mesmo tempo, sua presença era sentida em toda a localidade de Mamanguape, já em 1877. Em carta²²⁹ encaminhada ao inspetor de saúde pública, Dr. Abdon Felinto Milanez, e ao presidente da Província, Dr. Esmerino Gomes Parente, o juiz de direito José Paulino de Figueiredo relatava que Sousa Nunes manifestava as angústias da “classe desvalida”, fortemente atingida pelas febres intermitente (Juízo de Direito da Comarca de Mamanguape, AHWBD, 28/10/1877).

Essa atuação, já reconhecida pelas autoridades locais, também se expressava nas correspondências oficiais enviadas pelo próprio Dr. Nunes Pinto. Em uma delas, o médico fazia um desabafo sensível ao reivindicar melhorias nas condições sanitárias da população pobre, apontadas pelos seus colegas como um dos fatores para a elevada incidência de doenças entre os migrantes, bem como a necessidade de garantir um tratamento adequado aos enfermos.

Ao afirmar que os doentes se encontravam “talvez imerecidamente, aos meus cuidados na medicina” (Cidade de Mamanguape, AHWBD, 20/03/1879)²³⁰, o médico revelava não apenas o sentimento de sobrecarga profissional, mas também a percepção de que o aparato assistencial disponível era insuficiente para responder à magnitude da crise vivida naquele momento.

Como se não bastasse ser, provavelmente, o único médico disponível na localidade, o Dr. Nunes Pinto ainda precisava lidar com uma realidade recorrente do período: o atraso no envio de medicamentos destinados ao tratamento dos enfermos.

Diante desse cenário, sua atuação revela como, naquele contexto de crise, gestos de compromisso profissional e solidariedade ganhavam se faziam presentes. Isso se verifica quando o próprio cirurgião “se oferece para prestar-lhes gratuitamente os seus serviços”, sinalizando tanto as limitações materiais da assistência quanto a centralidade da iniciativa

²²⁹ Juízo de Direito da Comarca de Mamanguape, 28 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²³⁰ Cidade de Mamanguape, em 20 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

individual no enfrentamento das enfermidades (Juízo de Direito da Comarca de Mamanguape, AHWBD, 28/10/1877).

Apesar das reclamações e cobranças anteriores, desta vez a solicitação do Dr. Nunes Pinto foi recebida e atendida de imediato pelo Dr. Abdon Milanez²³¹, que apontava que, além das febres intermitentes, as febres perniciosas e outras moléstias vinham causando pânico entre os migrantes. No entanto, Milanez foi enfático ao informar que realizou alterações nas quantidades de medicamentos solicitadas pelo cirurgião, por lhe “parecerem excessivas” (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 03/11/1877).

Mais tarde, em outubro de 1879, ainda diante do elevado número de pacientes atendidos no hospital, o Dr. Nunes Pinto encaminhou nova solicitação de medicamentos às autoridades provinciais. Diferentemente do que ocorrera em 1877 — quando o pedido contemplava 28 itens e sofreu alterações por parte do Dr. Milanez —, nessa ocasião a relação foi mais enxuta, restringindo-se a 13 substâncias.

Além disso, não se registra qualquer modificação ou interferência posterior, o que pode indicar tanto uma redefinição mais objetiva das necessidades terapêuticas quanto uma mudança na dinâmica administrativa entre os responsáveis pela assistência médica.

Em relação ao nome, às características e à finalidade dessas substâncias, para uma melhor compreensão, reunimos as duas listas, organizada por ano (1877 e 1879), ambas solicitadas pelo Dr. Nunes Pinto e apresentadas no Quadro 7, logo a seguir. A partir dessa sistematização, discutiremos as medidas de profilaxia adotadas por esses médicos, com especial atenção para a homeopatia, que se fez bastante presente não apenas na segunda metade do século XIX, mas também no contexto da seca.

²³¹ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 3 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Quadro 7 - Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos na Comarca de Mamanguape (1877 e 1879)

SOLICITADOS EM 26/10/1877		
Medicamento	Características/origem	Finalidade
Althea Francesa (raiz)	Planta; emoliente;	Tosse e Gargarejo
Água de Labarraque	Substância química	Limpeza e desinfecção
Bálsamo Tranquilo	Óleo calmante	Dores reumáticas, ciática e gota
Ácido Sulfúrico Diluído	Substância química	Cauterização de mordidas
Casca peruviana em jiló	Planta tóxica	Diurética e laxante
Camphora	Planta tóxica	Moléstias internas e externas
Extrato de alcaçuz	Arbusto	Massas peitorais e inflamações
Espírito de vinho	Álcool etílico	Antisséptico e conservante
Flores de sabugueiro	Flores brancas e aromáticas	Defluxo; bronquite e fumigação
Goma arábica	Resina natural extraída da acácia	Inflamações no estômago
Linhaça em Grãos	Planta do linho	Reumatismo e inflamações
Laudano de Sydenham	Extrato de ópio com álcool	Analgésico e sedativo
Massa cáustica	Substância química	Cauterização de feridas; crancos
Manná	Resina extraída de árvores doces	Problemas intestinais; purgante
Marcella galega	Planta herbácea	anti-inflamatória, calmante
Nitrato de prata	Substância química	Cauterização
Ópio purificado	Substância química, alopático	Dores; diminuição da fome
Óleo de ricino	Planta mamona; tóxica	Purgante
Poaia em pó	extraído da planta ipecacuanha	Lavagem gástrica; intoxicações
Ruibarbo em pó	Planta tóxica	Laxante; prisão de ventre
Sulfato de quinina	Substância química e alopática	Febres intermitentes; anasarca
Hamamelis virginiana	Arbusto florido	Inflamações na pele; circulação
Sene	Planta herbácea	Purgante
Tártaro Stibiatus (emético)	Substância química; tóxico	Expectorante; vômito; purgante
Tintura de Noz Vômica	Planta venenosa	Doenças cardiorespiratórias
Unguento de Basilicão	Extrato de Manjerição	Antisséptico
Vinho Branco	Uvas de polpa clara	Diurético; anasarca; escorbuto
Xarope Comum	Expectorante	Tosse; gripe e resfriados
SOLICITADOS EM ABRIL DE 1879		
Bálsamo apodeldoc	Alopático	Contusões, câibras, reumatismo
Bolas contra a diarreia	-	Constipação
Emplasto anodino	Emplastro adesivo	Calmante, analgésico
Espírito de sal-amoniaco	Substância química; alopático	Estimulante, expectorante
Espírito odontálgico	Álcool com analgésico; alopático	Dor de dente
Éter sulfúrico	Substância química	Antiespasmódico; calmante
Manná comum	Resina extraída de árvores doces	Problemas intestinais; purgante
Pastilhas de angico	Resina da árvore de angico	Bronquite, inflamação pulmonar
Pílulas ante-boubaticas	Mercúrio metálico, alcaçuz, rosas	Lesões de pele; boubas
Pílulas ante-cibum	Alopático	Indigestão
Senne	Planta herbácea	Purgante
Sulfato de quinino puro	Substância química e alopática	Febres intermitentes, anasarca
Tintura de centeio espigado	Esporão (fungo parasita)	Hemorragias, miliete, paralisias

Fonte: Quadro elaborado e adaptado por nós com base na *Carta enviada pelo Juiz de Direito a pedido do Dr. Antonio de Sousa Nunes Pinto*, em 26 de outubro de 1877, e no *Relatório da Secretaria do Hospital de S. Pedro em Mamanguape, no ano de 1879*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Como apresentado no quadro acima, elaborado a partir da adaptação de registros do período e acrescido de colunas que indicam os medicamentos solicitados e efetivamente enviados, observa-se a circulação de 41 medicamentos, entre os quais se destacam substâncias de natureza homeopática, química e alopática. Esses medicamentos eram empregados no tratamento de enfermidades já conhecidas no contexto da seca, reconhecidamente difíceis de serem enfrentadas diante das condições de escassez material e precariedade sanitária então vigentes.

A análise do conjunto revela que, apesar da diversidade de substâncias, havia uma finalidade terapêutica relativamente homogênea, voltada ao alívio de sintomas associados às febres intermitentes, às afecções respiratórias, aos distúrbios gastrointestinais, às inflamações e às dores corporais. Predominam medicamentos de ação purgativa, emética, expectorante, calmante e antisséptica, como o sulfato de quinina, o óleo de rícino, o sene, a poaia, o láudano, a cânfora e os diversos bálsamos e unguentos, indicando a centralidade do tratamento sintomático e do controle das manifestações imediatas da doença.

Observa-se ainda que muitas dessas substâncias – independentemente de serem classificadas como químicas, alopáticas ou de origem vegetal – cumpriam funções semelhantes, especialmente no combate às febres, às inflamações e aos quadros de anasarca, o que reforça a ideia de que a escolha dos medicamentos estava menos vinculada a uma adesão rígida a um sistema terapêutico específico e mais orientada pela experiência prática, pela disponibilidade e pela urgência do socorro. Em consequência, a recorrência de substâncias tóxicas ou potencialmente agressivas, como o nitrato de prata, o tártaro estibiado, a noz-vômica e o ópio, também demonstram a adoção de intervenções mais severas, compatíveis com a gravidade do quadro sanitário enfrentado durante a seca.

A presença recorrente da homeopatia nesse conjunto terapêutico abre uma série de questões que orientam a análise a seguir. Em que medida os médicos envolvidos defendiam efetivamente esse tipo de tratamento? Havia disputas entre a homeopatia e a alopatia no interior do campo médico provincial? Como o cuidado com os enfermos era conduzido em um cenário marcado por constantes denúncias de insalubridade e proliferação dos miasmas? Além disso, esses profissionais atuavam de forma isolada no atendimento à população migrante e aos demais atingidos pela seca, ou compartilhavam esse espaço com outros agentes, como curandeiros, boticários e farmacêuticos?

De modo explicativo, as terapêuticas alopáticas, então predominantes no campo médico, estavam associadas ao tratamento sintomático das doenças e à aplicação de múltiplas intervenções, como sangrias, purgantes e medicamentos químicos. A maior recorrência da

homeopatia nesse contexto, frequentemente solicitada sem que os médicos apresentem justificativas explícitas para sua escolha, não indica a substituição dessas práticas, mas revela que ambos os tratamentos eram acionados de forma concomitante, compondo um mesmo repertório de práticas de cura em disputa e empregado no interior da assistência prestada durante a seca.

Em termos gerais, a homeopatia, ao priorizar o enfermo “a quem se oferece terapêutica específica”, integra o conjunto das práticas de cura, entendidas como o conjunto de saberes, técnicas, rituais, usos de substâncias e procedimentos utilizados para o alívio do sofrimento e o tratamento das enfermidades em diferentes pacientes (Beltrão, 1997, p. 19).

Nesse sentido, a homeopatia constitui uma terapêutica cujas substâncias podiam ter origem animal, mineral ou vegetal, submetidas a processos específicos de preparo e diluição (Mota e Albuquerque, 2018). No caso analisado, a documentação registra a presença de diversas plantas medicinais, algumas listadas de forma genérica, o que sugere que os envios correspondiam aos insumos brutos, e não aos medicamentos já processados. É provável que, uma vez chegadas ao destino final, essas plantas fossem manipuladas pelos próprios médicos ou agentes de cura, a partir da extração de partes como caules, folhas e arbustos, podendo ser empregadas isoladamente ou combinadas entre si.

Enquanto a alopatia, ainda que pudesse coexistir com a homeopatia, era com frequência apresentada como sua contraposição, aparecia associada a um modelo terapêutico de caráter sintomático, marcado pela multiplicidade de intervenções e pelo uso simultâneo de diversos medicamentos, cada um direcionado a um sintoma específico da enfermidade, a homeopatia se estruturava a partir de uma lógica distinta. Para os médicos defensores da alopatia “não reconheciam a homeopatia e lutavam pelo monopólio acadêmico, e os que passaram a utilizá-la com terapêutica” (Mariano; Mariano, 2022b, p. 244).

Nos resultados da sua pesquisa, Jane Beltrão (1997, p. 20-21) observa que as fontes sobre a epidemia de cólera no Grão-Pará recorrem com frequência à crítica da terapêutica alopática, descrita como excessiva e agressiva, além de pouco eficaz frente à velocidade do avanço da doença. Já a homeopatia é identificada nas fontes como uma terapêutica que se propunha a simplificar o tratamento, recorrendo a poucos medicamentos escolhidos a partir da lei dos semelhantes, com o objetivo de tratar o conjunto da enfermidade, e não seus sintomas isolados (Beltrão, 1997, p. 21).

Retomando a problemática, o que chama atenção é o silêncio que envolve essas solicitações de medicamentos. Não há, por parte dos médicos responsáveis pelas listas – tanto daqueles que realizaram os requerimentos quanto dos que autorizaram os envios – qualquer

discussão ou comentário acerca dos critérios que orientaram a escolha dessas substâncias, do modo como deveriam ser utilizadas, por quanto tempo, ou das razões que fundamentavam sua suposta eficácia.

Diferentemente do que se observa em outros contextos epidêmicos, nos quais médicos recorreram aos jornais e aos próprios relatórios administrativos para defender determinadas terapêuticas, indicando cuidados, formas de aplicação e tempo de uso, no caso analisado a documentação se limita ao registro do pedido. Ao todo, foram identificadas seis listas de medicamentos requeridos, nenhuma delas acompanhada de explicações quanto à finalidade ou ao modo de emprego das substâncias solicitadas.

Esse silêncio contrasta com outros episódios nos quais os médicos não hesitaram em tornar públicas suas posições terapêuticas. Como analisado por Serioja Mariano e Nayana Mariano (2022, p. 236-237), desde seus primeiros usos na província da Parahyba, em 1849, essa terapêutica passou a ser observada com desconfiança por parte de setores da elite médica e das autoridades locais, principalmente quando praticada por indivíduos que não possuíam formação acadêmica ou títulos legalmente reconhecidos. As fontes do período revelam que a circulação da homeopatia esteve associada a temores quanto à segurança dos tratamentos, à eficácia dos medicamentos e, principalmente, ao risco de que práticas consideradas irregulares ou improvisadas colocassem em perigo a vida dos enfermos.

Mais do que uma rejeição à homeopatia em si, o que se evidencia nesse contexto é a preocupação com o controle do exercício das artes de curar e com a preservação da autoridade médica. Conforme apontam as autoras, as críticas dirigidas aos que faziam uso da homeopatia enfatizavam a ausência de habilitação legal, a suposta superficialidade do conhecimento e o caráter empírico dos procedimentos adotados, mobilizando um discurso que aproximava esses agentes da figura do “charlatão” (Mariano; Mariano, 2022, p. 237-238).

Nesse sentido, a homeopatia passou a ocupar um lugar ambíguo: ao mesmo tempo em que despertava interesse e era incorporada em determinados contextos, tornava-se alvo de vigilância institucional e de disputas públicas nos jornais, evidenciando que sua introdução na província ocorreu sob um clima de receio, tensão e conflito entre diferentes concepções de cura e de legitimidade médica (Mariano; Mariano, 2022, p. 238).

Podemos supor que muitos médicos tinham conhecimento e utilizavam a homeopatia, mas não a defendiam ou a justificavam, pelo menos no contexto em questão, no que diz respeito às escolhas terapêuticas realizadas. Há de se considerar, ainda, que, por ser uma prática bastante utilizada por curandeiros, boticários, sangradores e parteiras, sua adoção explícita poderia fragilizar o próprio saber médico. Não se pode esquecer também que a

homeopatia, ao questionar a agressividade e a fragmentação do tratamento alopático, colocava em xeque a autoridade da medicina acadêmica.

Além disso, a escolha da homeopatia por médicos diplomados não implicava uma identificação pública como homeopatas, mas podia representar uma estratégia pragmática e discursivamente cautelosa em um campo médico atravessado por disputas, ou em momentos de crise, quando a necessidade de respostas rápidas relativizava fronteiras doutrinárias e institucionais (Beltrão, 1997).

Como já apresentado, a lista de medicamentos elaborada pelo Dr. Nunes Pinto demonstra que ele não era o único a solicitar o uso da homeopatia. No entanto, essa prática não se configurava como um sistema terapêutico adotado de forma integral, mas como o uso pontual de alguns medicamentos homeopáticos, que circulavam paralelamente aos alopáticos.

Em Pitimbu, por exemplo, o administrador da Comissão de Socorros e também professor público João Manoel da Silva encaminhou duas relações distintas: uma de medicamentos homeopáticos (25 itens), destinados ao curativo dos “enfermos desvalidos”, e outra de medicamentos alopáticos (11 itens), voltados ao tratamento das doenças. Esse procedimento indica que a organização da assistência provavelmente se dava sob a orientação do inspetor de saúde pública, uma vez que não foram localizadas referências à atuação de médico ou prático residente na localidade.

A relação de medicamentos homeopáticos solicitados para Pitimbu, em 1879, apresenta padrões muito semelhantes aos observados no caso de Mamanguape, principalmente no que diz respeito às finalidades terapêuticas e aos tipos de enfermidades visadas. Assim como naquele município, predominam substâncias voltadas ao tratamento de afecções gastrointestinais, febres, dores reumáticas, distúrbios respiratórios e doenças de pele, problemas recorrentes em contextos marcados pela fome, pela insalubridade, pela falta de assistência entre outras causas.

Observa-se também a presença de medicamentos associados ao tratamento de doenças venéreas e lesões cutâneas, como sífilis, boubas, crancos e abscessos, a exemplo do mercúrio, do caustico, da dulcamara e do *hepar sulphuris*. Esse padrão já havia aparecido em Mamanguape e reforça a ideia de que essas enfermidades ocupavam lugar central nas preocupações médicas e administrativas durante a seca, sendo interpretadas como resultado direto das más condições de higiene, da promiscuidade forçada e do enfraquecimento orgânico da população.

Vejamos essas e outras informações a partir do Quadro 8 abaixo.

Quadro 8 – Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos em Pitimbu (1879)

HOMEOPÁTICOS (15/05/1879)		
Medicamento	Características/origem	Finalidade
Aconito	Planta tóxica	Asma, hidropisia e reumatismo
Arsenico	Substância química	Limpeza e desinfecção
Aquina-vírus	N/i	N/i
Belladona	Planta tóxica	Anestésico e antiespasmódico
Brigonia	Planta tóxica	Diarreia, candidíase
Chamomilla	Planta comum; tônico	Indigestão, fastio, histeria
China	Planta tóxica	Moléstias sífilíticas
Coffea	Arbusto	Nervosismo, insônia
Caustico	Substância química	Absorção do vírus sífilítico
Arnica	Planta tóxica	Febres, reumatismo, quedas
Crocus-sativus	Planta que produz o açafrão	Cólicas menstruais
Laudano de Sydenham	Extrato de ópio com álcool	Analgésico e sedativo
Dulcamara	Planta tóxica; sudorífero	Sífilis, moléstias de pele
Hepar sulphuris	Enxofre e carbonato de sódio	Abscessos, furúnculos
Ipecacuanha	Planta tóxica, emético	Diarreias e bronquites
Lycopodium	Planta (musgo)	Azia, gases, má digestão
Mercúrio	Químico	Crancos, sífilis, boubas
Nux-vomica	Planta tóxica	Distúrbios hepáticos e digestivos
Pulsatilla	Planta tóxica	Irritabilidade, ansiedade
Rhus Tox	Planta tóxica	Dores reumáticas, articulares
Sépia	Derivado do molusco cefalópode	Problemas ginecológicos
Sulphurio	Químico	Cauterizações, hemorragias
Sambucos	Sabugueiro	Tosse seca, obstrução nasal
Antimonium crudum	Químico	Problemas gástricos e de pele
Calcarea- carb	Carbonato de sódio (Químico)	Deficiência de cálcio
ALOPÁTICOS (15/05/1879)		
Óleo de rícino	Planta mamona; tóxica	Purgante
Água amarga	Substância natural e mineral	Purgante
Vinho quinado	Preparação secreta de quina	Febres intermitentes
Vinho de genciana	Raízes da planta genciana	Tônico digestivo e estimulante
Arnica	Planta tóxica	Febres, reumatismo, quedas
Óleo de amendoa doce	Extraído da amêndoa doce	Irritações e inflamações da pele
Pílulas de Alisons	Extrato da planta cardo-mariano	Problemas digestivos
Marcella	Fitoterápica; planta herbácea	Digestiva, antiespasmódica
Flor de sabugo	Sabugueiro	Gripes, resfriados, tosse
Sal amargo	Sulfato de magnésio	Laxante
Vermifugo	Químico	Prevenir parasitas internos

Fonte: Quando elaborado e adaptado por nós com o acréscimo das características e finalidade dos medicamentos consultados no *Dicionário de Medicina Popular do Dr. Chernoviz* (1890), com base nas *Relação dos medicamentos pedidos pela comissão de socorros públicos de Pitimbu, para o curativo dos enfermos desvalidos – Homeopathsicos* - 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.; *Relação dos remédios allopathicos requisitados pela Comissão de Socorros Públicos de Pitimbu para o tratamento dos enfermos desvalidos* - 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Outro ponto de convergência importante é a recorrência de medicamentos destinados ao controle de sintomas, como diarreias, cólicas, insônia, nervosismo, histeria e dores em

geral. Substâncias como chamomilla, coffea, ipecacuanha, nux-vômica e arnica indicam que a assistência se orientava, em grande medida, para o alívio imediato do sofrimento, mais do que para intervenções preventivas ou estruturais, aspecto já identificado em Mamanguape. Além disso, a presença de remédios com função calmante, sedativa ou antiespasmódica, como *belladonna* e *laudano de Sydenham*, sugere uma atenção não apenas às manifestações físicas da doença, mas também aos estados de agitação, inquietação e exaustão.

Por fim, assim como em Mamanguape, chama atenção o uso recorrente de substâncias tóxicas que, no uso homeopático, eram submetidas a processos de diluição, o que possibilitava sua aplicação terapêutica, ou potencialmente agressivas, como arsênico, mercúrio, *antimonium* e *nux-vômica*, indicando a adoção de práticas compatíveis com a gravidade do quadro nosológico enfrentado. Essa escolha reforça a leitura de que, apesar da classificação homeopática, os critérios de seleção dos medicamentos em Pitimbu se aproximavam daqueles observados em outros municípios, orientados pela urgência do socorro e pela tentativa de responder a enfermidades associadas à seca.

Em relação aos remédios alopáticos, a própria composição do quadro revela uma heterogeneidade terapêutica, com a presença de substâncias de origem vegetal, mineral e química que também circulavam em outros sistemas de cura, inclusive na homeopatia e na fitoterapia. Isso indica que a classificação adotada pela Comissão não obedecia a critérios rígidos de distinção entre sistemas médicos, mas se orientava possivelmente pela finalidade prática do tratamento.

Do ponto de vista das finalidades terapêuticas, observa-se uma concentração significativa de medicamentos voltados ao funcionamento do sistema digestivo e intestinal, como purgantes, laxantes e vermífugos. Substâncias como óleo de rícino, água amarga, sal amargo e vermífugos indicam a recorrência dos casos necessários para a limpeza intestinal, prática amplamente difundida na medicina oitocentista e associada à ideia de expulsão de humores nocivos e substâncias consideradas prejudiciais ao organismo (Mota; Albuquerque, 2018).

A maior solicitação de medicamentos, tanto homeopáticos quanto alopáticos, partiu do Hospital de Areia, localizado em uma das regiões mais favorecidas em termos climáticos do brejo parahybano. Esse quadro não se explica diretamente pela seca, mas pela intensa concentração populacional resultante dos deslocamentos forçados, que ampliou de forma significativa as demandas por assistência médica e hospitalar. Ainda que o brejo apresentasse melhores condições naturais, a infraestrutura disponível mostrou-se insuficiente para absorver o volume de migrantes e atender às necessidades sanitárias decorrentes desse contexto.

Com relação ao quadro de funcionários do hospital, os medicamentos encontravam-se sob a supervisão do farmacêutico Manuel da Silva, responsável pela organização e controle dos fármacos, conforme indica sua assinatura na lista analisada. No que diz respeito à assistência direta aos enfermos, a principal autoridade médica da instituição era o Dr. José Evaristo da Cruz Gouveia (Almeida, H., 1958, p. 132). Natural de Areia, Gouveia era médico e cirurgião formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atuando profissionalmente tanto em sua cidade natal quanto na capital da província.

De acordo com as informações reunidas por Nayana Mariano (2015, p. 93, 294), sua trajetória ultrapassava o exercício da medicina: vinculado ao Partido Conservador, exerceu mandatos como deputado provincial em diferentes legislaturas, entre 1858 e 1871, e ocupou por três vezes o cargo de presidente da Província da Parahyba, nos anos de 1871, 1872 e 1873. Ao longo de sua carreira, acumulou ainda funções administrativas, como inspetor de Saúde Pública, inspetor do Tesouro e diretor da Instrução Pública, além de ter sido agraciado com condecorações imperiais, como a Ordem de Cristo e a Imperial Ordem da Rosa. Essa atuação multifacetada ajuda a compreender como a direção médica do hospital estava inserida em um circuito mais amplo de poder político e administrativo provincial.

Dos 51 medicamentos listados, não foi possível identificar o nome de 5 itens em razão da qualidade do documento. Entre os 46 identificados, observa-se a predominância de substâncias de origem química e mineral, associadas à terapêutica alopática praticada ao longo do século XIX. A maioria dos fármacos – como o bicloreto de mercúrio, cloretos, acetatos, nitratos, ácidos, hipofosfitos e compostos ferruginosos – indica uma medicina marcada pelo uso recorrente de agentes cauterizantes, antissépticos, estimulantes e purgativos, inclusive quando se tratava de substâncias reconhecidamente tóxicas.

Conforme analisam Karla Mota e Suzana de Albuquerque (2018), a alopatia oitocentista se estruturava como uma medicina fundada no racionalismo e no materialismo, legitimada pelas instituições médicas e pelo Estado, e orientada pela intervenção direta sobre os processos orgânicos da doença. Nesse modelo, o sofrimento do paciente e os riscos do tratamento eram frequentemente compreendidos como parte aceitável da prática terapêutica, sobretudo em contextos de crise sanitária.

Segundo as autoras, a partir da análise do periódico *Sciencia*²³², é possível identificar como essa medicina alopática, dominante e institucionalmente legitimada, também foi alvo

²³² Fundado no Rio de Janeiro em 1847, teve como principais colaboradores os médicos homeopatas Dr. Bento Mure e Dr. João Vicente Martins. Voltada à circulação entre a elite médica e intelectual do Império, a revista abordava diferentes campos do conhecimento científico e assumia como um de seus objetivos centrais a

de críticas ao longo do século XIX. No discurso dos discípulos de Hahnemann²³³, a medicina clássica era apresentada como uma ciência ultrapassada e ineficaz, excessivamente voltada à elaboração teórica sobre as causas das doenças, em detrimento da atenção direta ao doente e à sua recuperação (Mota e Albuquerque, 2018, p. 80).

Nessa perspectiva, a terapêutica alopática era acusada de agravar o estado dos pacientes e, em alguns casos, de conduzi-los à morte, sem que tais desfechos fossem devidamente investigados, uma vez que os médicos tradicionais contavam com respaldo institucional e governamental. Ao examinarem sistematicamente as matérias publicadas no periódico, as autoras demonstram como essas críticas se articulavam à defesa da homeopatia como uma nova ciência médica, em oposição à medicina oficial vigente (Mota e Albuquerque, 2018, p. 80-81).

Em termos quantitativos e funcionais, observa-se que os medicamentos alopáticos superaram amplamente os de caráter homeopático, sendo estes últimos praticamente residuais no conjunto. A terapêutica utilizada também revela preocupações centrais com anemias, fraqueza orgânica, febres intermitentes, doenças venéreas, verminoses, afecções respiratórias e lesões cutâneas, quadros compatíveis com uma população afetada pela desnutrição, pela fome e pela ausência de assistência direcionada.

Já os produtos de origem animal, como o óleo de fígado de bacalhau e a banha de porco, ocupam lugar secundário, associados ao tratamento do raquitismo, da debilidade orgânica e à preparação de unguentos. A presença recorrente de substâncias consideradas perigosas, como mercúrio, arsênico, estricnina, ácido fênico e nitrato de prata, aponta não apenas os limites do conhecimento médico do período, mas também a urgência da assistência prestada em um hospital sobrecarregado, no qual os riscos do tratamento eram frequentemente sobrepostos à necessidade imediata de conter doenças e infecções.

O Quadro 9 sistematiza os fármacos identificados, a origem e finalidade, possibilitando visualizar a predominância de substâncias de caráter alopático e intervencionista, bem como os tipos de enfermidades que se buscava tratar no contexto da seca.

divulgação e a defesa da homeopatia como alternativa terapêutica legítima frente à medicina alopática (Mota; Albuquerque, 2018, p. 70).

²³³ Foi um médico alemão, considerado o fundador da homeopatia. Insatisfeito com as práticas da medicina alopática de seu tempo, formulou, a partir do final do século XVIII, uma nova proposta terapêutica baseada no princípio *similia similibus curentur* (o semelhante cura o semelhante).

Quadro 6 – Lista de Medicamentos solicitados pelo Hospital de Areia (1879)

Medicamento	Características/origem	Finalidade
Bicloreto de mercúrio	Químico	Sífilis, úlceras e lesões cutâneas
Chlorhydrato de amoníaco	Químico	Afecções respiratórias
Ferro de Quevenne	Mineral/químico	Anemia, convalescença
Chloreto de potassa	Mineral/químico	Hidropisia/anasarca
Pílulas de Vallet	Químico	Escrófulas
Pilulas de Blancard	Químico; iodeto de ferro	Cachexia escrofulosa
Vesicatório de Albespeyres	Vegetal/químico	Anemia, doenças do sangue
Opodeldoc	Químico	Fricções, dores reumáticas
Emplasto de Vigo	Emplastro adesivo	Calmante, analgésico
Hydrato de Chloral	Químico sintético	delírio, agitação, “loucura”
Vermifurgo de --	Natural	Vermes
Extracto de Cicutia	Plantas apiáceas, venenosa	Crando do fígado,
Óleo de fígado de bacalhau	Animal	Raquitismo
Ácido sulfúrico	Químico	Cauterização
Musgo islândico	Vegetal (líquen)	Tosse seca, bronquite, asma
Pílulas de Leroy	Vegetal/mineral	Purgante
Chloreto de zinco	Químico/mineral	Antisséptico; cauterizante
Proto-cloreto de ferro	Químico	Caústico; antisséptico
Sulfato de strychnine	Sal solúvel; Alcaloide vegetal	estimulante cardíaco e intestinal
Arseniato de soda	Químico	Coreia, moléstias da pele
Acetato de amônio	Químico	Diurético, expectorante
Acetato de estricnina	Químico/extraído da noz-vômica	Estimulante do sistema nervoso
Água raz	Vegetal, extraída de resinas	Dores reumáticas e musculares
Tartarato de ferro e potássio	Químico/mineral	Anemias, clorose, fraqueza
Ópio	Planta tóxica	Úlcera, enterite aguda, dores
Hypophosphito de soda	Químico	Tísica, anemia, tosse crônica
Hypophosphito de cálcio	Químico/sal inorgânico	Tísica, raquitismo, fraqueza
Xarope de Auberguir	Vegetal	Fraqueza, anemia, tosses
Vinho digestivo de chasser	Vegetal	Digestão, convalescença
Naphtalina	Químico	Inseticida
Escamônea	Planta tóxica	Purgante, hydropisia
Resina de jalapa	Extraída das plantas trepadeiras	Purgante
Magnésio calcinada	Químico/mineral	Laxante, acidez gástrica
Xarope de quinino e ferro	Extraído da casca de cinchona	febres intermitentes, palustres
Água de Labarraque	Substância química	Limpeza e desinfecção
Ácido phenico	Químico	Raiva, mordidas, bexigas
Banha de porco	Animal	Unguento
Nitrato de prata fundido	Químico	Cauterização, controle do sangue
Resina de batata	Raízes da batata-de-purga	Purgante e vermífugo
Tamina	Tomateiro	Antioxidante
Sementes de linhaça	Planta do linho	Reumatismo e inflamações
Arnica em pó	Planta tóxica	Febres, reumatismo, quedas
Pílulas de dehan	N/i	N/i
Extrato de ópio	Planta tóxica	Úlcera, enterite aguda, dores
Extrato de extramonio	Planta herbácea	Asma, bronquite, tosse
Água de louro cereja	Folhas coriáceas	Problemas respiratórios, digestão

Fonte: Quando elaborado e adaptado por nós com o acréscimo das características e finalidade dos medicamentos consultados no *Dicionário de Medicina Popular do Dr. Chernoviz* (1890), com base na *Relação do Hospital da*

Cidade de Areia em 26 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Depois de examinar Mamanguape, Pitimbu e Areia, destaca-se a Enfermaria do Hospital dos Variolosos, localizada nas matas do Engenho de Santa Rita, que adotou tanto o tratamento homeopático quanto o alopático. Muito provavelmente, sua criação esteve relacionada à sobrecarga dos demais hospitais emergenciais e de suas respectivas enfermarias, responsáveis pelo atendimento dos pacientes acometidos pela varíola.

No registro²³⁴ elaborado pelo administrador da enfermaria e do hospital, Domiciano Lucas de Souza Rangel, registrava-se que a iniciativa de sua construção partiu dele próprio, uma vez que já não suportava ver “como vagavam pelas estradas os variolosos, e alli sem recurso algum pereciam e erão por lá mesmo sepultados”. O administrador também reconhecia a existência de falhas estruturais, mas destacava que se tratava de um local arejado, que não oferecia riscos de contágio. Também ressaltava que o funcionamento da enfermaria demandava poucos recursos do governo, uma vez que o pároco Manoel Gervazio Ferreira da Silva havia dado “benção a um terreno próximo ao referido Hospital” (Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, AHWBD, 10/06/1879).

Diante de um intenso fluxo de pessoas acometidas pela varíola, a instituição recebeu, entre agosto de 1878 e 30 de junho de 1879, um total de 446 pacientes²³⁵. Desse conjunto, entre os homens adultos, 73 obtiveram alta, 35 vieram a óbito e 3 permaneceram em tratamento. Entre os menores do sexo masculino, 55 foram curados, 10 faleceram e 4 continuaram sob cuidados médicos (Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita, AHWBD, 06/1879).

No caso das mulheres adultas, registraram-se 139 curas, 44 óbitos e 16 pacientes em tratamento. Já entre as meninas, 48 foram consideradas curadas, 13 faleceram e 6 continuaram internadas. No total, o hospital contabilizou 315 pessoas curadas, 102 óbitos e 29 pacientes em acompanhamento ao final do período em questão (Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita, AHWBD, 06/1879).

Com relação aos serviços prestados, a instituição contava com quatro enfermeiros (as) – dois homens e duas mulheres –, além de uma servente (Enfermaria do Hospital dos

²³⁴ Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, em 10 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²³⁵ Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita de 15 de agosto do anno passado a 30 de junho do corrente anno. Tibiry, junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Variolosos em S. Rita, AHWBD, 10/06/1879). Em nossas consultas, não identificamos a presença de médicos diretamente vinculados ao hospital. Ainda assim, conforme registrado no Quadro 10, o administrador encaminhou ao Inspetor de Saúde Pública, Dr. Milanez, uma solicitação para que fossem “fornecidos alguns remédios próprios para o tratamento de intermitentes” (Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, AHWBD, 02/06/1879).

Quadro 7 – Lista de medicamentos solicitados para o tratamento dos enfermos no Hospital dos Variolosos em Santa Rita (1879)

SOLICITADOS EM 02/06/1879		
Medicamento	Características/origem	Finalidade
Quinino	Substância química, alopático	Cicatrizante, febres, anasarca
Tartaro emetico	Substância química; tóxico	Expectorante; vômitico; purgante
Aquina-vírus	N/i	N/i
Óleo de rícino	Planta mamona; tóxica	Purgante
Tintura de ipecacuanha	Planta tóxica, emético	Diarreias, náuseas e bronquites

Fonte: Quando elaborado e adaptado por nós com o acréscimo das características e finalidade dos medicamentos consultados no *Dicionário de Medicina Popular do Dr. Chernoviz* (1890), com base na lista de *Pedido de medicamentos para os doentes na Enfermaria de Variolosos na Povoação de Santa Rita e em outros doentes desvalidos na mesma povoação. Santa Rita, 2 de junho de 1879*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

O conjunto de medicamentos apresentados acima, destinado ao tratamento das chamadas “intermitentes”, evidencia, mais uma vez, como as ocorrências de febres aterrorizavam diversas localidades. Como é sabido, o sulfato – ou simplesmente o quinino – era amplamente utilizado no combate a esse tipo de febre (Chernoviz, 1890, p. 1094). Ao lado dele, aparecem medicamentos de ação purgativa e emética, como o tártaro emético, o óleo de rícino e a tintura de ipecacuanha, indicando que o tratamento era pensado de maneira mais ampla, articulando-se à necessidade de eliminação de matérias consideradas nocivas e à regulação das funções corporais. Essa combinação sugere que a terapêutica adotada se orientava por práticas difundidas na medicina do período, nas quais purgações, vômitos e evacuações eram compreendidos como recursos para o restabelecimento do organismo, mesmo quando a queixa principal era de natureza febril.

Outro ponto que chama atenção diz respeito ao modelo de assistência, marcado pela dependência das instâncias superiores, e ao fato de que o hospital provavelmente não dispunha de um médico específico para atender os 446 pacientes acometidos pela varíola. Nessas circunstâncias, o cuidado cotidiano recaía sobre os funcionários da instituição, o pároco e o próprio administrador (Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita, AHWBD, 06/1879).

Até o momento, observamos a atuação de nove médicos, seu cotidiano profissional, os espaços em que clinicavam e os principais métodos de cura empregados. Partimos agora para a atuação de quatro farmacêuticos, a saber: Antônio Thomas Carneiro da Cunha Sênior, Manuel da Silva, José Francisco de Moura Júnior e Luiz Baptista Silva Júnior. Identificamos ainda a atuação de um boticário, o Tenente Antônio Imploronio Rodrigues Lima, bem como de dois curandeiros não identificados, contratados para atuar no Hospital de Bananeiras.

No quadro abaixo constam informações referentes aos locais de atuação e às funções exercidas por esses práticos.

Quadro 8 – Lista dos práticos que atuaram durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba

Práticos	Função	Locais de atuação
Antônio Thomas Carneiro da Cunha Sênior	Boticário, Farmacêutico, Tenente cirurgião do batalhão de reserva	Hosp. Cruz do Peixe e Capital
Manuel da Silva	Farmacêutico	Hosp. de Areia
José Francisco de Moura Júnior	Farmacêutico	Capital
Luiz Baptista Silva Júnior	Farmacêutico	Capital
Tenente Antônio Imploronio Rodrigues Lima	Tenente e boticário	Campina Grande
Não identificado	Curandeiro	Hosp. de Bananeiras
Não identificado	Curandeiro	Hosp. de Bananeiras

Fonte: Quadro elaborado por nós de acordo com as informações extraídas de diferentes fontes do período, incluindo relatórios da Presidência da Província da Parahyba do Norte, exposições administrativas, mapas e relações de empregados de enfermarias e hospitais, correspondência oficial, consultados no Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD).

Começamos primeiro pelos quatro farmacêuticos práticos. De acordo com Oscar Oliveira de Castro (1945, p. 285), apesar de concentrarem suas boticas ou farmácias²³⁶ na Capital, também exerciam as terapêuticas nos interiores da Província: “Mamanguape, Cajazeiras, Catolé do Rocha e Bananeiras já tiveram suas celebridades”.

Ainda sobre as atribuições de um farmacêutico, segundo Tânia Pimenta (2004), a partir da legislação de 1832, passaram a integrar formalmente o conjunto de profissionais legalmente autorizados a exercer atividades terapêuticas, ao lado de médicos, cirurgiões e parteiras, ficando proibido a qualquer outro indivíduo “curar, ter botica ou partejar” sem respaldo legal. Apesar disso, Pimenta destaca que, na prática, o controle sobre o exercício

²³⁶ No século XIX, os termos *botica* e *farmácia* eram frequentemente utilizados como sinônimos na documentação, referindo-se aos estabelecimentos destinados à preparação e venda de medicamentos. Cabe destacar, contudo, que existiam distinções importantes entre ambos. A botica estava tradicionalmente associada a práticas mais artesanais, como a chamada “*botica doméstica*”, entendida como uma espécie de maleta contendo diversos medicamentos destinados ao tratamento das enfermidades mais recorrentes e comuns (Chernoviz, 1890, p. 352), bem como ao ofício do boticário. Já a farmácia passou a se vincular a processos de regulamentação, formação técnica e profissionalização do farmacêutico.

desses ofícios era frágil e marcado por flexibilizações, como nas regiões onde faltavam profissionais diplomados.

Nesse contexto, apareciam tanto como agentes reconhecidos pela legislação quanto como participantes de uma rede local de cura, por vezes envolvidos em abaixo-assinados, licenças temporárias e pedidos de exceção, como no caso de boticários que confirmavam a necessidade da atuação de terapeutas não acadêmicos em determinadas freguesias. Foi apenas na década de 1840 que a Câmara passou a organizar listas mais sistemáticas dos profissionais autorizados – incluindo explicitamente os farmacêuticos – com o objetivo de identificar e coibir o exercício considerado irregular, ainda que as punições continuassem raras (Pimenta, 2004, p. 72-73).

Feitas essas pontuações, partimos para a atuação de Antônio Thomaz Carneiro da Cunha Sênior. Natural de Goiana (PE), desempenhou diversas funções para além do ofício de boticário e farmacêutico. Comerciante, possuía sua própria botica, localizada na Rua do Conde d'Eu, n.º 70, e atuou também como substituto de tenente-cirurgião do Batalhão de Reserva, em dezembro de 1867 (Freire, 2022, p. 18). Contribuiu ainda com o fornecimento de medicamentos homeopáticos para o Hospital da Cruz do Peixe e, ao que indicam os registros, provavelmente permaneceu na capital durante os efeitos da seca, prestando seus serviços nesse período (*O Despertador*, 24/11/1883, n.º188, p. 4; Hospital da Cruz do Peixe, AHWBD, 12/02/1880).

Já o farmacêutico atuante no Hospital de Areia, Manuel da Silva, diplomado desde 1862 e proprietário de uma botica na mesma cidade, exercia uma atuação que ia além da manipulação e da distribuição de medicamentos, envolvendo também a aplicação de mezinhas, a realização de curativos e o atendimento à população, inclusive em outras regiões (Almeida, H., 1958, p. 172).

Nesse contexto, o farmacêutico desempenhava funções que extrapolavam a simples manipulação ou dispensação de medicamentos, assumindo também responsabilidades relacionadas ao acompanhamento dos pacientes submetidos a tratamento medicamentoso, sem que isso implique atribuir-lhe o exercício pleno da medicina. Como observa Betânia Figueiredo (2002, p. 190), a função do boticário ou farmacêutico ia muito além da simples manipulação ou venda de medicamentos, sendo também responsável por auxiliar “nos momentos de dor física, ouvia os sintomas, os problemas e as queixas dos que o procuravam”.

De modo semelhante ao farmacêutico Manuel da Silva, destaca-se o tenente Antônio Imploronio Rodrigues Lima, que também exercia a função de boticário. Sua atuação foi contínua no município de Campina Grande entre 1878 e 1879. Segundo registros da Diretoria

Geral de Socorros Públicos²³⁷, havia “entre os emigrantes diversas moléstias”, o que levou a Comissão a defender a necessidade de criação de um hospital e, paralelamente, a solicitar a contratação de alguém responsável pelos curativos da população adoecida “que acham-se muitos com os dedos dos pés e das mãos caindo, e com feridas”. Para a execução desses serviços, a Comissão recorreu ao tenente, já conhecido na localidade (Diretoria Geral de Socorros Públicos, AHWBD, 22/04/1879).

Assim como em Campina Grande e em outras localidades situadas fora do centro da província, eram raros os casos de médicos atuantes no contexto da seca. Nessas circunstâncias, tornava-se comum que o boticário ou farmacêutico assumisse um papel de destaque na assistência, pois, na ausência de médicos, “o boticário sempre estava por perto” e, em não poucos casos, era “a primeira e muitas vezes a única pessoa que cuidava daqueles doentes” (Figueiredo, 2002, p. 190-191). Não por acaso, esses profissionais constituíam amplas redes de sociabilidade, estabelecendo vínculos com a comunidade por meio da recomendação de medicamentos, do auxílio nos processos de cura e do atendimento a outras demandas relacionadas às condições de saúde da população (Figueiredo, 2002, p. 193).

No conjunto dos farmacêuticos identificados na documentação, José Francisco de Moura Júnior aparece com maior frequência nos registros relacionados ao preparo e ao envio de medicamentos para diferentes localidades da província. Embora sejam escassas as informações sobre sua trajetória pessoal, sua atuação profissional pode ser observada a partir dessas solicitações e remessas, que o inserem de forma recorrente nas dinâmicas da assistência durante a seca.

À época, a formação em Farmácia compreendia um curso de três anos e, à medida que esses profissionais conquistavam reconhecimento junto à população, passavam também a estabelecer relações de confiança com autoridades públicas e médicos (Figueiredo, 2002, p. 194), o que ajuda a compreender a prestação de seus serviços às comissões de socorros e à Inspetoria de Saúde Pública. A Capital constituía sua principal área de atuação, onde mantinha botica na Rua Conde d’Eu, n.º 48, mas sua inserção não se limitava a esse espaço, integrando uma rede mais ampla de circulação de medicamentos. Além disso, sua botica e seus serviços eram amplamente divulgados em jornais que circulavam na província, como *O Liberal* (PB), *O Despertador* (PB) e *O Liberal Parahybano* (PB).

Para além da Capital, foi no município de São João do Cariri, situado na região da Borborema, que Moura Júnior concentrou o maior envio de medicamentos. As primeiras

²³⁷ Diretoria Geral de Socorros Públicos – Campina Grande, 22/04/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

notícias sobre a gravidade da situação surgiram em 20 de novembro de 1877, em carta do Dr. Abdon Milanez²³⁸ ao então presidente da província, Dr. Esmerino Gomes Parente, na qual se relatava o avanço de febres de caráter maligno e as recorrentes solicitações por remédios. O quadro se agravava pela inexistência de médicos nas localidades vizinhas, levando Milanez a apontar a necessidade de nomeação de um diretor encarregado de acompanhar os tratamentos e fiscalizar a assistência, ainda que não se tratasse de médico ou prático (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 20/11/1877).

Três dias depois, Moura Júnior foi encarregado de enviar duas ambulâncias com remédios para aquela localidade, “em benefício desses infelizes perseguidos pela febre e assolados pela seca” (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 23/11/1877).²³⁹ Ainda assim, a assistência mostrava-se insuficiente. Em um registro feito pelo Dr. Abdon Milanez²⁴⁰, manifestava a preocupação de que tanto as ambulâncias quanto o dinheiro autorizado “não chegará a oitava”, sugerindo que os doentes continuariam concentrados “no pátio das enfermarias”, possivelmente em referência à transferência para algum hospital da Capital, sem que isso resultasse em melhora efetiva das condições de atendimento (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 24/11/1877).

Outros problemas começam a surgir, entre os auxílios que deveriam constar nas ambulâncias, a comissão informava que não haviam chegado “três garrafas de agua inglesa que deles farião parte, como disem as instruções” (Villa de S. João, AHWBD, 29/11/1877).²⁴¹ Como resposta, o Dr. Milanez, justificava como dispensável e que também teria removido de outras ambulâncias (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 11/12/1877).²⁴²

Outros fornecimentos de ambulâncias com medicamentos homeopáticos, selecionados por Moura Júnior, foram destinados à realização dos “curativos de indigentes de varíola” no município de Pitimbu (Ministério dos Negócios do Império, AHWBD, 22/01/1877).²⁴³ Além disso, remessas semelhantes voltadas ao tratamento de febres perniciosas e de outras

²³⁸ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 20/11/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²³⁹ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 23/11/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²⁴⁰ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 24 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²⁴¹ Villa de S. João, 29 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²⁴² Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 11 de dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²⁴³ Ministério dos Negócios do Império, Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

enfermidades foram encaminhadas para Mamanguape (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 13/11/1877).²⁴⁴

No cotidiano das enfermarias durante a seca, a atuação dos farmacêuticos também era atravessada por disputas e improvisações. Ao assumir a administração da Enfermaria instalada no Convento de Santo Antônio²⁴⁵, em março de 1878, Joaquim Victor Pereira informa que o fornecimento de medicamentos já vinha sendo realizado pelo farmacêutico Moura Jr., ainda que “nenhum contracto encontr[e]i sobre este assumpto”, evidenciando a informalidade que, em diversas ocasiões, marcava essas relações em contextos de urgência (Enfermaria Provisória no Convento de S. Antônio, AHWBD, 04/05/1878).

Com o aumento do número de receitas a serem aviadas e diante da necessidade de que os doentes fossem “quanto antes medicados”, tornou-se necessário recorrer também ao farmacêutico Luiz Baptista Silva Júnior, sobre o qual não foram localizadas informações adicionais além de sua atuação na Capital e de sua condição profissional. Segundo o administrador, Baptista Júnior comprometeu-se a fornecer os medicamentos “nas mesmas condições daquele outro Moura Junior”, passando ambos a atender simultaneamente à enfermaria, “de acordo com o médico da Casa” (Enfermaria Provisória no Convento de S. Antônio, AHWBD, 04/05/1878).

À medida que o fornecimento se intensificava, surgiram as discussões em torno dos descontos aplicados às contas – o chamado “abate”, que variava entre 16% e 25% – e, posteriormente, a interrupção do fornecimento por parte de Moura Jr., revelando as tensões entre a urgência do socorro e as tentativas de controle fiscal.

É nessas circunstâncias que o pedido final para a abertura de uma licitação para o fornecimento de medicamentos e gêneros “pelo menor preço possível” ganha sentido, expressando o esforço tardio de regularizar uma prática que, até então, funcionava de modo improvisado (Enfermaria Provisória no Convento de S. Antônio, AHWBD, 04/05/1878). O episódio ilumina não apenas as dificuldades administrativas da assistência durante a seca, mas também a centralidade do farmacêutico como agente indispensável na mediação entre a assistência ao tratamento dos doentes e as engrenagens do governo provincial.

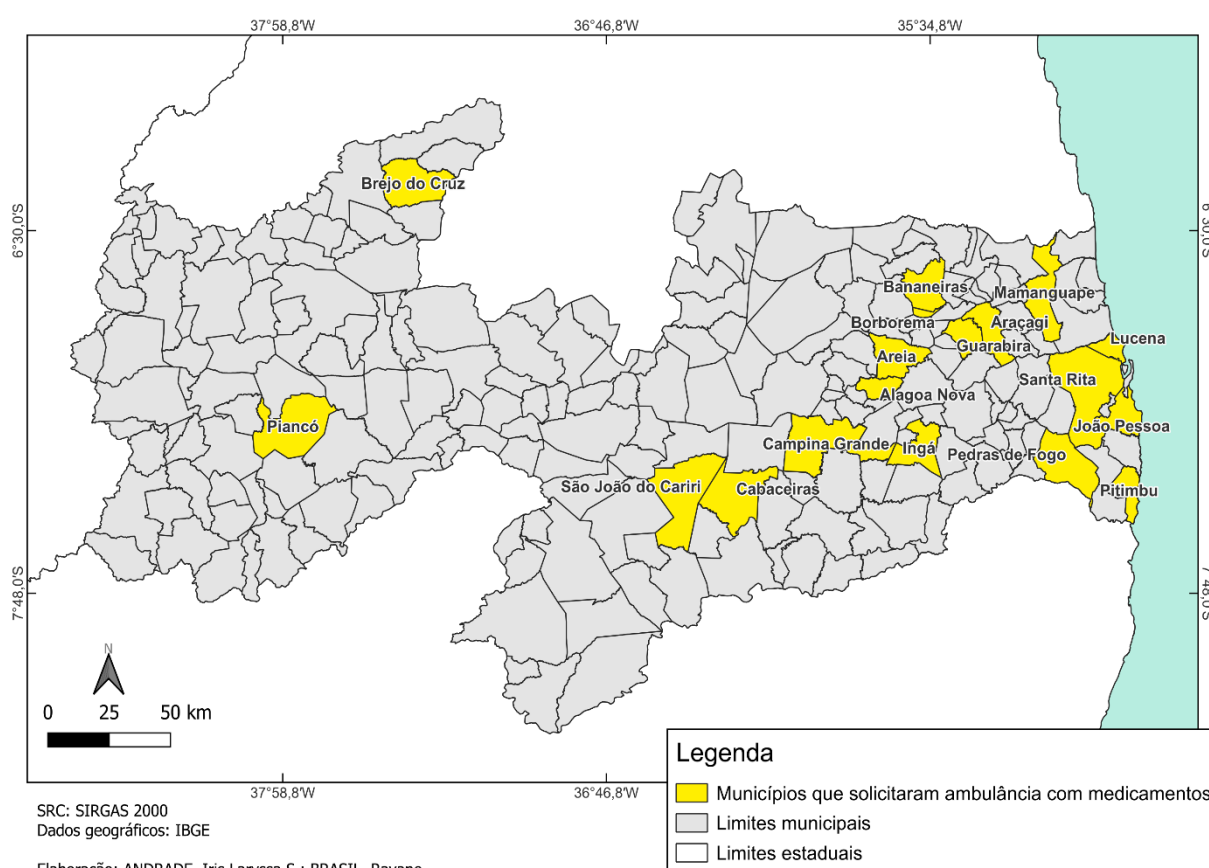
Até o presente momento, foram analisadas diversas listas de medicamentos, bem como pedidos e envios de ambulâncias destinadas ao transporte desses insumos. Ao todo, 18

²⁴⁴ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 13 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

²⁴⁵ Enfermaria Provisória no Convento de S. Antonio em 4 de Maio de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

municípios apresentaram reclamações relacionadas à escassez de remédios ou ao agravamento do quadro de saúde da população, o que exigia algum tipo de tratamento, seja alopático ou homeopático, sendo este último o mais recorrente. Diante disso, apresenta-se o Mapa da Figura 7 com os municípios que receberam essas ambulâncias.

Figura 7 – Envio de ambulâncias com medicamentos aos municípios da Parahyba (1877-1879)



Fonte: Mapa elaborado por Iris Laryssa S. Andrade e Rayane Brasil, a partir de dados extraídos de 17 documentações sobre envios e solicitações de ambulâncias para várias comarcas/vilas e freguesias da Província da Parahyba do Norte. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877-79, Caixas: 61 (A) e (B) e 62, utilizando o *software QGIS*.²⁴⁶

Conforme indicado no mapa, no Sertão apenas Piancó e Brejo do Cruz receberam ambulâncias, apesar de municípios como Sousa, Patos, Cajazeiras, Pombal e Teixeira registrarem com frequência quadros de adoecimento da população e solicitarem reiteradamente o envio “o quanto antes”. Além desses, receberam ambulâncias São João do

²⁴⁶ O mapa foi elaborado no *software QGIS*, utilizando como base cartográfica os limites municipais fornecidos pelo IBGE (projecção *WGS 84 – UTM*).

Cariri, Cabaceiras, Campina Grande, Ingá, Alagoa Nova, Areia, Borborema, Bananeiras, Guarabira, Araçagi, Mamanguape, Lucena, Santa Rita, Capital, Pedras de Fogo e Pitimbu.

Por fim, identificamos a presença de dois curandeiros, cujos nomes não foram registrados, contratados em agosto de 1878 para prestar serviços conforme solicitação da Comissão de Socorros, com o objetivo de criar um hospital de caráter emergencial na colônia “Riacho do Mulungú”, em Bananeiras, onde se encontravam abrigadas cerca de 30 famílias e que se encontrava afetada por diversas moléstias (Offício n.º 1438, Palácio da Presidência, AHWBD, 27/08/1878).²⁴⁷

O pedido da Comissão enfatizava que não se tratava da contratação de quaisquer curandeiros, mas especificava a necessidade de “um homeopatha e outro alopatha”. Essa distinção sugere não apenas o reconhecimento da existência de especializações no interior das práticas de cura, mas também as incertezas e ambiguidades quanto à condução terapêutica mais adequada em um contexto de emergência (Silva, W., 2020, p. 35-36).

De acordo com Wuendisy Silva (2020, p. 101), o universo dos métodos de cura não se estruturava exclusivamente a partir das propriedades químicas das substâncias ou de suas classificações enquanto naturais ou manipuladas. Havia uma dimensão menos passível de demonstração empírica, mas socialmente eficaz, que orientava as escolhas terapêuticas e conferia legitimidade aos tratamentos no interior da mentalidade oitocentista.

Essa perspectiva contribui para compreender a convivência entre práticas alopáticas, homeopáticas e fitoterápicas observada na documentação analisada e, no caso específico deste estudo, as escolhas entre terapêuticas distintas, que podem ser interpretadas tanto como uma tentativa de ampliar as possibilidades de cuidado quanto como uma adaptação às circunstâncias da crise, uma vez que, como evidenciam as listas examinadas, os tratamentos frequentemente combinavam medicamentos de diferentes naturezas.

A leitura dessas práticas também pode ser aprofundada por uma chave foucaultiana do discurso, tal como operacionalizada por Ferreira e Traversini (2013). Em vez de tomar relatórios, ofícios e prescrições sanitárias apenas como registros descritivos da crise, torna-se possível tratá-los como práticas discursivas que produzem os próprios objetos de que falam, isto é, que fazem existir, como problema nomeável e governável, o “corpo perigoso”, o “foco de contágio”, o “varioloso” e o “indigente insalubre” como categorias de intervenção.

Nesse quadro, os mecanismos de vigilância e isolamento não aparecem somente como respostas técnicas às doenças, mas como parte de uma ordem que regula o que pode ser dito,

²⁴⁷ Offício n.º 1438, Palácio da Presidência, AHWBD, 27/08/1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

por quem e em quais circunstâncias, estabelecendo uma hierarquia de vozes legítimas no interior da assistência (Ferreira; Traversini, 2013, p. 212). Além disso, a centralidade do saber médico e dos dispositivos sanitários se sustenta por uma “vontade de verdade” que confere a determinados enunciados o estatuto de verdade válida, articulada a suportes institucionais e a modos específicos de distribuição e valorização do saber (Ferreira; Traversini, 2013, p. 212-213).

Assim, medidas como a remoção da Cadeia Pública, o envio de pacientes para a Ilha da Restinga e para lazaretos podem ser lidas, ao mesmo tempo, como ações de contenção do contágio e como práticas que organizam a circulação de corpos e definem quais sujeitos passam a ser administrados prioritariamente como risco coletivo.

Acerca dos curandeiros que atuaram na Parahyba durante a seca, a possível contratação para o Hospital de Bananeiras constituiu a única ocorrência encontrada nas fontes. Ainda assim, na década de 1890, observa-se a atuação de curandeiros em circulação na capital, como no caso do “Curandeiro Prático”, que publicava intruções na imprensa e se dirigia aos doentes como autoridade terapêutica. Como mostram Serioja Mariano (2022, p. 183-184), suas recomendações não se limitavam a “simpatias” ou a receitas simples, mas orientavam sobre os cuidados e as fases das doenças, além de indicar os remédios homeopáticos.

Ainda sobre a homeopatia, de acordo com Serioja e Nayana Mariano (2022, p. 256-257), ao longo da segunda metade do século XIX ela continuou integrada às práticas terapêuticas em circulação na Parahyba, aparecendo tanto em contextos epidêmicos quanto no uso cotidiano. Mesmo com a vacinação contra a varíola já disponível, a resistência da população e a confiança em formas de cura conhecidas favoreceram a permanência dos tratamentos homeopáticos, inclusive com respaldo pontual do governo provincial, que autorizava sua aplicação em situações de emergência (Serioja; Mariano, 2022, p. 258).

Nessas circulações de saberes e práticas de cura que permeavam a “grande seca”, corroboramos as constatações apresentadas por Janyne Barbosa (2018, p. 36), as quais ajudam a iluminar os resultados encontrados nesta pesquisa. Ao analisar o cotidiano médico durante a Guerra do Paraguai, a autora demonstra que, diante da ausência de métodos de cura estáveis, da fragilidade dos diagnósticos e da escassez de medicamentos, muitos profissionais recorreram de forma pragmática à apropriação de saberes e recursos tradicionalmente associados aos práticos, como o uso de ervas medicinais e receitas empíricas, incorporando-os ao cotidiano dos hospitais e enfermarias. Esse movimento não significava o abandono da medicina acadêmica, mas antes sua adaptação às circunstâncias, revelando um campo médico menos rígido do que os discursos normativos sugerem.

Nesse sentido, os dados investigados no contexto da seca apontam para uma dinâmica semelhante. O uso recorrente de medicamentos de diferentes naturezas, a presença simultânea de terapêuticas alopáticas e homeopáticas e, sobretudo, o silêncio dos médicos quanto à justificativa de suas escolhas terapêuticas indicam estratégias cautelosas de atuação em um cenário marcado pela urgência, pela escassez de recursos e pela pressão institucional.

Assim como observado por Janyne Barbosa, a prática médica mostrou-se permeável à incorporação de repertórios diversos, ao mesmo tempo em que buscava preservar sua autoridade e legitimidade. Esses elementos reforçam a compreensão de que, em contextos de crise, as fronteiras entre os saberes médicos tornavam-se mais flexíveis, permitindo arranjos que respondiam menos à coerência dos sistemas terapêuticos e mais às exigências de um regime de *poder-saber*, no qual o fundamental era manter a autoridade médica e a capacidade de intervenção sobre os corpos (Foucault, 1979a).

Além da forte presença da biopolítica, observa-se que os relatos acerca do adoecimento dessa população dialogam diretamente com as proposições de Susan Sontag sobre a doença como metáfora, isto é, como uma chave interpretativa para compreender os sentidos atribuídos às enfermidades registradas durante a seca de 1877-1879 na Parahyba. Sontag (1984) argumenta que determinadas doenças ultrapassam o campo estritamente biológico e passam a operar como construções simbólicas, condensando medos sociais, juízos morais e ansiedades coletivas. A enfermidade, nesse sentido, não é apenas um fato clínico, mas também uma linguagem por meio da qual se expressam tensões e hierarquias sociais.

No contexto da seca, as doenças mapeadas (febres, disenterias, varíola, beribéri e anasarca) não eram apenas efeitos fisiológicos da fome, da desnutrição e das condições precárias de higiene. Elas passaram a funcionar como sinais visíveis da desordem social associada à migração forçada. Os corpos dos migrantes, marcados pela debilidade física, pelo inchaço, pela pele ressecada e por lesões, tornaram-se suportes materiais de uma metáfora mais ampla: a do corpo social contaminado, ameaçado pela presença daqueles que encarnavam, aos olhos das autoridades e da população urbana, a própria imagem da miséria.

Assim como Sontag observa que certas doenças foram historicamente associadas à degeneração moral ou à fraqueza individual, na Parahyba Oitocentista as enfermidades que atingiam os migrantes frequentemente eram interpretadas não apenas como resultado das condições estruturais da seca, mas como expressão de desordem, sujeira e perigo. A figura do migrante doente condensava o medo da propagação epidêmica e, ao mesmo tempo, a ansiedade diante do colapso das fronteiras entre o espaço urbano “ordenado” e o sertão “faminto” que avançava sobre ele.

Desse modo, a metáfora da doença contribuiu para reforçar processos de estigmatização. Ao serem percebidos como focos potenciais de contágio, os migrantes passaram a ser tratados não apenas como vítimas da seca, mas como ameaças à saúde coletiva. A enfermidade, mais do que uma condição orgânica, transformava-se em marcador social. Tal como aponta Sontag, a linguagem da doença frequentemente produz culpabilizações sutis; no caso da seca, ela ajudou a deslocar o debate das responsabilidades estruturais do Estado para o controle e a contenção dos corpos considerados perigosos.

Por fim, ao longo deste capítulo, apresentamos as condições de vida e saúde da população migrante e daqueles não migrantes que, de diferentes formas, foram afetados pela seca. Nesse percurso, destacaram-se as casas de caridade e demais centros hospitalares, responsáveis por atender e abrigar pessoas provenientes de diversas localidades.

Além disso, realizamos um mapeamento – ainda que parcial, em razão das lacunas das fontes – que permitiu identificar a concentração das doenças mais incidentes, como as febres de diferentes naturezas, a varíola, as disenterias, além das doenças carenciais, responsáveis por agravar quadros de extrema debilidade, levando muitos à morte por fome, amarelidão ou opilação, entre outros males. Foram também identificados casos extremos de canibalismo e numerosas mortes de indivíduos cujas vidas foram “ceifadas” pela estiagem. Por fim, analisamos a atuação dos médicos, o uso da homeopatia e da alopatia, bem como a presença de sete práticos, entre farmacêuticos, boticários e curandeiros.

O próximo e último capítulo tem por objetivo apresentar e discutir as medidas finais adotadas para a cessação dos auxílios públicos, as doenças que ainda despertavam temor na população, os destinos dos migrantes e as estratégias criadas para enfrentar esse novo momento. Busca-se analisar até que ponto o governo manteve o acompanhamento e a assistência a esses indivíduos, com destaque para a Villa do Teixeira, onde, ainda em 1880, havia migrantes tentando obter algum alimento, sobrevivendo em meio às doenças e sendo empregados na grande obra da Represa de Poços.

4 “IRREGULARIDADE DE CONDUTA E MAUS COSTUMES”: O CAMINHO DE VOLTA PARA CASA EM 1880

Até aqui, discutimos a chegada da seca e a forma como ela desestruturou o cotidiano das diferentes mesorregiões da província da Parahyba do Norte, exigindo a adoção de medidas emergenciais de assistência e enfrentamento, como a criação dos núcleos coloniais e a atuação das comissões de socorros públicos. Ao longo dos capítulos anteriores, analisamos também os deslocamentos da população afetada – homens, mulheres, crianças, órfãos, idosos e pessoas escravizadas –, as doenças que os atingiram, bem como a atuação de médicos, farmacêuticos e práticos envolvidos na assistência à saúde durante o período crítico da seca.

Neste capítulo, voltamo-nos para as experiências do pós-seca, com especial atenção ao retorno dos migrantes, seu “apagamento” nas fontes do período e à permanência da crise social em 1880. Em um primeiro momento, examinamos as doenças que continuavam a afetar a população, bem como o processo de encerramento dos hospitais e enfermarias emergenciais criados durante a seca, com destaque para a Vila do Teixeira, no alto sertão. Esse recorte permite apreender, de forma mais precisa, como a assistência à saúde foi sendo progressivamente desmontada e como persistiam mecanismos de controle e administração da população migrante, associados à redução sistemática dos gastos públicos.

Na sequência, analisamos a dissolução dos núcleos coloniais e o fim dos auxílios alimentares, atentando para as formas como essas medidas foram implementadas e para as narrativas construídas pelas autoridades para justificar o encerramento dos socorros. Por fim, o capítulo aborda as grandes obras públicas empreendidas como resposta de longo prazo à seca, com destaque para a construção da Represa de Poços, na Vila do Teixeira – a maior obra hidráulica do período. Longe de representar apenas um projeto de progresso, essa experiência foi atravessada por fome, doenças e mortes entre os trabalhadores empregados, revelando a precariedade das condições de trabalho e a insuficiência da assistência governamental.

O capítulo se encerra com um balanço dos efeitos da chamada “Grande Seca” de 1877–1879, considerando seus impactos sociais, as ações e omissões do poder público e as permanências que se projetaram nas secas posteriores. Para essas análises, mobilizamos relatórios presidenciais, mapas de movimento dos hospitais e enfermarias emergenciais, cartas, relatórios e correspondências produzidas pelas comissões de socorros e por outros centros de assistência, fontes que permitem compreender tanto a dimensão administrativa quanto as experiências vividas pela população afetada.

4.1 “TODA MASSA POPULAR TINHA A SAÚDE COMPLETAMENTE ARRUINADA”: AS DOENÇAS QUE AINDA GRASSAVAM NA PROVÍNCIA

Ainda não é completamente favorável o estado sanitario desta Capital, apesar de se poderem **considerar extintas muitas das molestias, que reinarão com caracter epidemico.**

As febres de toda a natureza, as anemias profundas, as hydropesias, a variola e o scorbutto são as entidades morbidas, e affectão, de preferencia, aos retirantes, existentes nos nucleos coloniaes (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880).

A epígrafe que abre este capítulo foi extraída da Exposição com que o Dr. José Rodrigues Ferreira Junior passa a administração da Província ao Pe. Felipe Benicio da Fonseca Galvão, então 2.º Vice-Presidente, em 30 de abril de 1880. Longe de se limitar a um simples balanço político-administrativo, o trecho oferece importantes indícios sobre o estado sanitário da província no imediato pós-seca, revelando tanto as permanências do quadro de adoecimento quanto os limites das ações públicas naquele momento.

Ao afirmar que o “estado sanitario desta Capital” ainda não era “completamente favorável”, mesmo com a extinção de parte das moléstias que haviam reinado “com caracter epidemico”, o presidente reconhece a persistência de um cenário sanitário ainda instável, marcado menos por grandes surtos epidêmicos e mais pela continuidade de doenças associadas à fome, à miséria e às migrações forçadas provocadas pela seca.

Essa formulação também revela um esforço de distinção discursiva entre o período mais agudo da crise e o momento posterior, no qual a administração provincial buscava sinalizar algum grau de normalização, ainda que reconhecesse a continuidade dos problemas de saúde. Ao deslocar o foco das epidemias para as doenças crônicas e carenciais, o relatório constrói uma narrativa de “superação” parcial da calamidade, sem, contudo, ocultar a permanência do sofrimento entre os grupos mais vulneráveis.

A enumeração das enfermidades: febres, anemias, hidropisias, varíola e escorbuto, evidencia não apenas a permanência, mas também a diversidade dos quadros mórbidos ainda presentes em 1880, ao mesmo tempo em que explicita sua incidência preferencial sobre os migrantes concentrados nos núcleos coloniais.

Nesse sentido, o documento sugere que, embora a seca tivesse arrefecido enquanto fenômeno climático extremo, seus efeitos sociais – em especial aqueles relacionados à saúde da população – permaneciam ativos, prolongando-se no tempo e tensionando as estruturas hospitalares e assistenciais da província. Assim, o ano de 1880 não pode ser compreendido

como um momento de ruptura definitiva com a crise, mas como uma fase de transição marcada pela tentativa de reorganização administrativa, pela redução progressiva dos auxílios públicos e pela permanência de pessoas em situações precárias de saúde, alimentação e moradia.

No entanto, esse breve relato ainda permite apreender muito mais sobre o contexto sanitário do pós-seca. Em 1880, foram publicados seis relatórios e três exposições administrativas, mas este é o único documento que apresenta informações mais detalhadas sobre o quadro nosológico da província. Ao avançarmos para outras documentações, observa-se que, em determinadas localidades, os problemas de saúde persistiam de forma preocupante, como no caso da vila de Teixeira, no alto sertão, onde as doenças registradas em 1879 continuaram a se manifestar no ano seguinte.

Neste primeiro momento, concentrarem-nos no relatório apresentado pela Comissão da Vila de Teixeira em 15 de outubro de 1879, bem como em cartas posteriormente enviadas no decorrer de 1880. Embora o relatório trate da construção da Represa de Poços – tema que será analisado com maior profundidade no próximo subtópico –, ele também aborda aspectos relacionados às condições de vida e de saúde da população local e migrante, revelando desdobramentos que se articularam à própria dinâmica da obra.

Segundo os administradores²⁴⁸, muitos indivíduos “pareciam antes fantasmas do que entes vivos”, expressão que remete a sujeitos ainda vivos, porém consumidos pela fome prolongada e pelas doenças, sobrevivendo na expectativa de que alguém lhes repartisse ao menos um pedaço de pão. Esse alimento, quando obtido, ainda precisava ser dividido com as crianças – entre elas, bebês recém-nascidos – que choravam incessantemente, compondo um quadro marcado pela dor e pela extrema (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Mais do que uma descrição circunstancial, essa metáfora, recorrente no relatório, carrega um forte sentido social e político. Ser reduzido à condição de “fantasma” implica deixar de ser reconhecido como sujeito pleno, portador de história, vínculos e direitos. Esses indivíduos passam a figurar como presença incômoda ou como custos a serem administrados pelo poder público, aparecendo de forma fragmentada nos documentos oficiais. A imagem do fantasma, nesse sentido, expressa um apagamento simbólico, no qual a vida persiste, mas sem importância social e desprovida de valor político.

Diante da dimensão da catástrofe, a comissão concluiu que “toda a massa popular tinha a saúde completamente arruinada”. Entre as doenças que continuavam a provocar temor e a

²⁴⁸ Relatório apresentado pela Comissão de Socorros da Villa do Teixeira ao Ilmo. Exmo. Sr. Dr. José Rodrigues Pereira Junior – Presidente desta Província, em 15 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

ocasionar mortes, destacavam-se as disenterias. Essas enfermidades aparecem associadas, na documentação, às práticas alimentares observadas durante a crise, sendo recorrente a menção ao consumo de restos de animais encontrados nas estradas ou de alimentos obtidos de forma precária, muitas vezes já deteriorados pelo tempo e pela falta de condições adequadas de conservação. O adoecimento, nesse contexto, não se limitava a episódios isolados, mas integrava um quadro mais amplo de enfraquecimento orgânico e de colapso das condições mínimas de sobrevivência.

É nesse sentido que a interpretação de Josué de Castro contribui para compreender a situação vivida no sertão. Em *Geografia da fome*, o autor analisa a fome não apenas como ausência de alimentos, mas como um fenômeno fisiológico, social e sensorial, capaz de alterar profundamente o corpo, os sentidos e o comportamento humano. Ao tratar da fome quantitativa e das carências prolongadas, descreve corpos emagrecidos até o limite, crianças com crescimento interrompido, edemas carenciais e uma população marcada pela exaustão orgânica e pela perda progressiva da vitalidade. A fome, assim, opera como um processo contínuo de degradação física que compromete a saúde coletiva e fragiliza as formas de resistência do organismo (Castro, J., 1984, p. 228-229).

Essa leitura dialoga diretamente com a realidade sertaneja observada na Vila do Teixeira. Quando a comissão descreve uma população “semi-morta”, “inconsciente” pela fome, disputando um mínimo pedaço de pão ou mesmo “as carniças aos cães e aos corvos”, além do abandono dos corpos sem direito ao sepultamento, não está apenas recorrendo a imagens de impacto, mas registrando os efeitos concretos da carência alimentar extrema sobre corpos já debilitados. Tal como aponta Josué de Castro, a fome produzia indivíduos enfraquecidos, suscetíveis às doenças e incapazes de resistir por longos períodos, o que ajuda a compreender tanto a rapidez das mortes quanto o esfacelamento de práticas sociais elementares, como o enterramento dos mortos.

Além disso, a observação de Josué de Castro de que a fome altera os sentidos – intensificando a percepção visual e submetendo o indivíduo a uma vigilância constante do ambiente, voltada à identificação de qualquer possibilidade imediata de alimento, água ou abrigo – contribui para interpretar o sertão descrito nas fontes como um espaço em que a sobrevivência se tornava cada vez mais instintiva.

A busca incessante por qualquer recurso possível empurrava homens, mulheres e crianças para uma existência marcada pelo esgotamento e pela perda gradual de referências sociais, dissolvendo fronteiras entre vida e morte. Nessa experiência prolongada de privação,

a degradação corporal não surgia como exceção, mas como parte constitutiva do cotidiano imposto pela seca (Castro, J., 1984, p. 245).

A própria fonte associa a propagação dessas enfermidades às condições de preparo e consumo dos alimentos, ao mencionar o “pouco aceio das comidas”. O consumo recorrente de carnes salgadas e de bacalhau sem a retirada adequada do sal tornava-se especialmente prejudicial em um contexto de escassez extrema de água potável, frequentemente descrita como “pesada” ou mesmo imprópria para o consumo (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879). Nessas circunstâncias, tornava-se inviável tanto o correto preparo dos alimentos quanto a ingestão de água em quantidade suficiente para amenizar os efeitos do excesso de sal no organismo, agravando quadros de debilidade e adoecimento.

Essas observações dialogam com as análises de Josué de Castro (1984, p. 197) sobre os regimes alimentares no sertão nordestino, nos quais a conservação da carne por meio do uso intensivo do sal – como no caso da carne-de-sol e do charque – constituía uma adaptação às condições climáticas e à ausência de refrigeração.

Embora eficaz como técnica de conservação em ambientes de baixa umidade, esse tipo de preparo tornava-se problemático em contextos de escassez hídrica prolongada, quando a população não dispunha de água suficiente para dessalgar os alimentos ou para compensar, no consumo cotidiano, os efeitos do excesso de sal no organismo. Nessas circunstâncias, segundo o autor, a alimentação deixava de cumprir sua função nutritiva plena, passando a contribuir para o desgaste físico e orgânico dos indivíduos, além de favorecer o surgimento e o agravamento de doenças associadas ao aparelho digestivo.

Inserida nesse cenário marcado pelo sofrimento prolongado e pela persistência das enfermidades, a comissão decidiu pela criação de um hospital provisório destinado ao tratamento dos doentes. Diante da inexistência de um edifício com dimensões adequadas, optou-se pela construção de uma instalação de caráter improvisado, descrita na documentação como uma “casa de palha”, que passou a exercer funções hospitalares.

Segundo o relatório, essa estrutura teria permitido melhor acomodação e maior controle cotidiano dos enfermos, o que contribuiu para uma redução relativa da mortalidade entre os internados. No mesmo período, foi ainda criado um hospital/enfermaria específico para variolosos, igualmente apresentado como responsável por “excelente resultado”, sendo ambas as iniciativas mencionadas como parte de um conjunto de medidas cujo funcionamento e duração seriam demonstrados em mapas estatísticos produzidos pela administração provincial.

No que se refere ao movimento dos pacientes atendidos no hospital, registraram-se 403 entradas, das quais 334 resultaram em altas médicas e 69 em óbitos ocorridos no interior da instituição. Paralelamente, o obituário geral do serviço contabilizou 111 mortes no período, número mais amplo que abrange não apenas os falecimentos registrados no hospital, mas também aqueles verificados fora de suas dependências, incluindo 10 casos atribuídos à varíola (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Apesar da importância desses dados quantitativos para dimensionar a gravidade do quadro sanitário, não foram localizadas informações mais detalhadas sobre o perfil dos doentes, sua procedência ou as condições específicas em que se encontravam, o que impõe limites à compreensão mais aprofundada do atendimento prestado e das causas da mortalidade registrada.

O hospital recebia, além dos casos de disenterias, outros males, como as febres malignas, já analisadas no capítulo 2, que atingiam proporções consideradas alarmantes, ocupando grande parte dos leitos disponíveis e exigindo cuidados contínuos. A permanência prolongada de muitos enfermos nessas instituições pode ser compreendida à luz do estado geral de debilidade física provocado pela fome e pelas privações acumuladas, bem como pela associação ou reincidência de diferentes enfermidades.

Soma-se a isso o fato de que, fora do espaço hospitalar, grande parte da população não dispunha de condições mínimas de abrigo, alimentação ou acompanhamento médico, o que transformava o hospital não apenas em local de tratamento, mas também em espaço de amparo provisório e de contenção da população adoecida. Além disso, o elevado número de variolosos dificultava o tratamento dos internados, em particular dos indigentes, indo contra o ideal sanitário formulado pelas autoridades, além da forma como a assistência era prestada durante a crise (Garcia, 2014c, p. 126).

Vemos, mais uma vez, que a criação dessas enfermarias foi apresentada nos discursos oficiais como uma resposta alinhada aos preceitos da ciência médica e da higiene pública. Conforme analisa Juciêdo Alexandre, tais espaços integravam uma estratégia das autoridades voltada à contenção do risco de contágio, ao mesmo tempo em que facilitavam o atendimento e prestação de auxílios; contudo, não deixavam de operar também como “medida segregadora, circunscrevendo a pobreza doente em determinadas áreas” específicas e afastadas do convívio urbano mais amplo (Alexandre, 2024b, p. 41).

Na prática, essas enfermarias funcionaram em condições precárias, marcadas pela insuficiência de recursos materiais, pela superlotação e pela limitação do atendimento, revelando o distanciamento entre o discurso médico-sanitário e as possibilidades efetivas de

assistência. A esse quadro acrescentamos as enfermidades de evolução lenta e recorrente, como a opilação, também conhecida como amarelão, caracterizada pela debilidade física acentuada e pela geofagia (hábito de comer terra), essa afecção comprometia a capacidade de recuperação dos indivíduos, prolongando sua permanência nos espaços de assistência (Silva *et al.*, 2015, p. 1428).

De modo semelhante, a hidropisia, frequentemente associada à desnutrição proteica e ao enfraquecimento orgânico, manifestava-se como expressão visível do desgaste físico, exigindo cuidados contínuos e dificultando a concessão de altas rápidas. A presença dessas doenças mostra que o hospital abrigava não apenas casos agudos, mas também enfermidades crônicas e estados de exaustão prolongada, que tornavam a internação uma condição duradoura para muitos dos doentes.

No ano seguinte, em 1880, as doenças já mencionadas – opilações, hidropisia e disenterias – continuavam a afetar a população da vila do Teixeira. Entre elas, destacavam-se as febres malignas e a varíola, esta última descrita na documentação como uma enfermidade “que ainda grassava”, concentrando maior número de vítimas no período (Comissão da Villa do Teixeira, AHWBD, 04/03/1880).

Conforme analisa Serioja Mariano (2022), na década de 1880 a varíola permanecia “na ordem do dia”, suscitando temores recorrentes entre a população. Como uma das medidas adotadas para conter os danos provocados pela doença, o governo intensificou as campanhas de vacinação e ampliou a circulação, nos jornais, de notícias com caráter informativo sobre práticas terapêuticas, apresentadas como formas de orientar e auxiliar a população diante do avanço da enfermidade (Mariano, S., 2022, p. 182).

Com os focos da epidemia de varíola ainda em circulação, a assistência hospitalar na vila do Teixeira dava sinais claros de instabilidade, marcada pela precariedade das estruturas disponíveis, pela escassez de servidores e pela superlotação dos espaços de atendimento, o que empurrava os doentes para uma condição-limite.

Essa situação não se restringia à realidade local, mas se inseria em um quadro mais amplo observado em outras províncias do Norte do Império. Como analisa Janille Campos Maia (2022, p. 146), nos primeiros anos da década de 1880, os relatórios oficiais insistiam na necessidade de corrigir os erros cometidos durante a grande crise anterior, mantendo em evidência os debates sobre a salubridade pública, especialmente diante do temor de novos surtos epidêmicos.

No Ceará, a Inspetoria de Saúde Pública reforçava a vacinação como estratégia central para evitar a reativação dos fluxos migratórios e, com eles, o recrudescimento da varíola; no

entanto, a própria autora aponta que a falta de linfa comprometia a eficácia dessas ações. Na Parahyba, embora a vacinação tenha sido realizada em diversas localidades do interior, a documentação referente à vila do Teixeira não menciona a chegada de vacinadores ou ambulâncias com medicamentos, mesmo com a persistência da varíola vitimando a população. Esse contraste evidencia os limites da atuação estatal no pós-seca e a desigual distribuição das medidas de assistência, deixando determinadas localidades à margem das políticas sanitárias anunciadas nos discursos oficiais (Maia, J., 2022, p. 148-149).

Ainda sobre os hospitais, que “regorgitavam de doentes”, a comissão reconhece a impossibilidade de sustentar a permanência dos internados em condições minimamente adequadas. A observação de que, “com graves sacrifícios da Comissão, apenas se as não deixava morrer de fome”, é particularmente significativa, pois indica que a fome não se limitava ao espaço externo ao hospital, mas atravessava o cotidiano da própria instituição. Mesmo entre aqueles que recebiam algum tipo de atendimento médico, a insuficiência alimentar comprometia a recuperação e agravava quadros que, em outras circunstâncias, poderiam não ser fatais (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Essa situação se torna ainda mais clara quando o relatório registra que “os sadios pedião pão, que não lhes dava, porque não havia”. A presença desses indivíduos revela que o hospital reunia não apenas doentes em estado grave, mas também pessoas fisicamente extenuadas, famintas e sem qualquer possibilidade de subsistência fora daquele espaço. Nesses casos, o hospital assumia uma função que ultrapassava o tratamento das enfermidades, operando também como local de abrigo temporário para aqueles que já não conseguiam se manter por conta própria.

A falta de alimentos, entretanto, inviabilizava tanto a recuperação quanto a permanência prolongada desses sujeitos. Incapazes de enfrentar os “climas doentios do litoral” e sem forças para retornar às “mattas donde já havião voltado”, muitos eram compelidos a deixar o hospital e “tomavam partidos diversos”, sem que os administradores da comissão ou qualquer outra autoridade responsável indicassem orientação, acompanhamento ou um destino definido para esses indivíduos. Esse movimento, identificado na documentação como “reemigração”, expressa um deslocamento forçado e incerto, marcado pela ausência de alternativas eficazes e pela dissolução de vínculos, no qual a saída do hospital não significava restabelecimento, mas apenas a transferência da sobrevivência para outros espaços igualmente precários (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

O relato aprofunda ainda mais esse quadro ao mencionar que “alguns abandonados as famílias desapareção”, indicando a ruptura de laços familiares e a perda de referências sociais

básicas. Outros, segundo a comissão, “erravam por lugares vizinhos”, numa circulação marcada pela busca frustrada por abrigo e sustento. A maior parte acabava “atirando-se aos matos”, retornando a espaços já percorridos e esgotados pela seca, onde “encontrava mísero auxílio nas macambiras das pedras” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879). Desse modo, o hospital aparece menos como um espaço de cura e mais como um ponto temporário em trajetórias sucessivas de deslocamento, marcadas pela desagregação familiar, pela fome e pela ausência de alternativas eficazes de sobrevivência.

A referência à “macambira das pedras” remete a práticas alimentares extremas, acionadas quando todas as demais possibilidades já haviam se esgotado. Como observa Câmara Cascudo em *História da Alimentação no Brasil*, o sertanejo recorria à macambira como alimento de emergência, obtido a partir da fécula extraída da planta, seca ao sol e transformada em um pirão amargo, cuja ingestão se impunha mais pelo desespero do que por qualquer valor nutritivo efetivo (Cascudo, 1967, p. 160).

Além da macambira, também eram utilizadas sementes de mucunã e partes do xique-xique, compondo um repertório alimentar acionado em situações-limite de fome (Cascudo, 1967, p. 160). O recurso a essas plantas explicita o grau de precariedade enfrentado por aqueles que, afastados dos hospitais e desprovidos de meios regulares de subsistência, viam-se obrigados a extrair da terra seca os últimos recursos possíveis à sobrevivência.

A comissão também dirigia críticas às condições de higiene e salubridade dos ranchos destinados a abrigar os migrantes, apontando a forma e o local de sua construção como fatores agravantes do quadro sanitário. Em um dos registros, observava-se que os ranchos haviam sido edificadas “entre grandes lagêdos, dos quais reverbera[m] contínuos calôres”, o que comprometia a ventilação, intensificava o calor e favorecia a insalubridade dos espaços de repouso (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Essa leitura atribuía às condições físicas dos abrigos parte da responsabilidade pela propagação das doenças, reforçando a percepção de que os locais de dormitório, longe de oferecer proteção, acabavam por contribuir para o adoecimento contínuo da população migrante. Ao enfatizar os aspectos materiais do espaço – calor excessivo, má ventilação e localização inadequada –, o discurso administrativo deslocava o foco do problema para a precariedade dos ranchos, minimizando a discussão sobre a insuficiência das medidas de assistência adotadas.

A descrição das condições dos corpos que ocupavam esses espaços reforça ainda mais o caráter crítico atribuído aos ranchos pela comissão. Os migrantes são apresentados como “pallidos, opilados ou tendo a pele sobre os ossos, assombrajosos, se não nús”, imagens que

condensam os efeitos combinados da fome, das doenças e da exaustão física (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Ao registrar essa cena, os administradores sugerem que a permanência prolongada nesses locais apenas aprofundava a degradação dos indivíduos, razão pela qual se defendia que não “se demorem ali”, evitando “maior ruína aos de sua condição”. Dentro desse quadro, o estado corporal dos migrantes passa a operar como argumento para justificar a urgência de sua retirada, ao mesmo tempo em que revela o esgotamento das condições sociais, no qual “o povo que restava havia chegado ao estado de desesperação” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Como observou Ana Karine Martins Garcia na análise desse processo a partir da experiência dos migrantes em Fortaleza, sua interpretação permite compreender como, em diferentes províncias do Norte do Império, a higiene foi usada como instrumento de normatização dos corpos, convertendo o asseio em objeto de vigilância e disciplina (Garcia, 2014c, p. 116). Na Parahyba, ainda que com dinâmicas próprias, a crítica às condições de abrigo e aos hábitos dos migrantes aponta para a circulação desse mesmo repertório higienista.

Desse modo, a necessidade de intervir nos atos e costumes dos sertanejos também esteve presente na formulação e na aplicação dessas normas sanitárias. Inserido no vocabulário higienista do período, o ideal de limpeza associado ao uso regular da água passou a orientar discursos e prescrições médicas, que enfatizavam os banhos e distanciamento frequentes como medida indispensável à prevenção das doenças. Essas recomendações, entretanto, não se limitavam ao campo estritamente médico, mas integravam um conjunto mais amplo de tentativas de regular os corpos, os hábitos e as formas de viver da população atingida, especialmente daqueles considerados mais vulneráveis e perigosos do ponto de vista sanitário (Foucault, 1979).

Mais uma vez, ao longo dos três anos de seca já analisados, percebe-se que, em 1880, essa lógica permanecia em funcionamento: a saúde coletiva deixava de ser compreendida apenas como questão de cura individual e passava a ser tratada como um problema de administração da população, no qual comportamentos cotidianos – como higiene, alimentação e circulação – tornavam-se objeto de vigilância e regulação. Trata-se de uma racionalidade que se aproxima do que Michel Foucault conceitua como *biopolítica*, isto é, um conjunto de práticas e saberes voltados à gestão da vida, à normatização dos corpos e à condução das condutas em nome da preservação da ordem social e do equilíbrio sanitário.

As reflexões de Nayana Mariano (2015, p. 83) ajudam a compreender esse ideal de regulamentação e ordenamento da vida social formulado pelo saber médico na Parahyba do

Norte, especialmente no que diz respeito à capital e aos espaços onde o aparato administrativo e sanitário se encontrava mais estruturado. No entanto, quando deslocamos o olhar para o sertão, essa lógica revela limites particulares. Não se trata da inexistência de normas ou prescrições, mas da ausência das condições materiais e institucionais necessárias para sua efetiva aplicação e funcionalidade.

Entretanto, a aplicação dessas normas esbarrava em limites evidentes quando confrontada com a realidade do interior da província. A atuação do Inspetor de Saúde Pública, por exemplo, concentrava-se majoritariamente na capital, de onde partiam ordens e recomendações que raramente se materializavam nas vilas sertanejas. A escassez de médicos é reveladora: não havia profissionais atuando no hospital de Teixeira, o que expõe a distância entre o modelo higiênico idealizado pelas autoridades e as condições concretas de vida da população local.

Nessas localidades, a atuação médica assumia um caráter irregular e insuficiente, frequentemente subordinada às urgências imediatas e à improvisação dos socorros. Essa dinâmica também se refletia na composição e no funcionamento das comissões locais, formadas por agentes sem formação médica ou farmacêutica especializada, além disso, não encontramos a presença de nenhum prático. Essas comissões orientavam-se por determinações gerais e executavam medidas quando formalmente instruídas, o que ajuda a compreender os limites entre o discurso sanitário formulado pelas autoridades e sua aplicação no sertão paraibano.

A partir desse quadro observado no interior da província, torna-se necessário deslocar o olhar para a capital, onde o pós-seca assumiu contornos próprios e igualmente reveladores. Em 1880, as preocupações centrais da administração provincial voltavam-se para a reorganização da assistência pública, tendo como questão fundamental a prestação de contas dos centros de saúde em funcionamento e a dissolução progressiva dos hospitais e enfermarias criados durante o período mais crítico da seca.

Esses processos integravam tanto os esforços de encerramento das medidas emergenciais quanto uma política de transparência administrativa em relação aos estabelecimentos que ainda atendiam migrantes naquele momento, permitindo observar como o governo provincial buscava recompor a normalidade institucional ao mesmo tempo em que administrava os vestígios sociais e sanitários deixados pela crise.

Ainda em julho de 1879, portanto antes do encerramento formal dos auxílios e da reorganização administrativa observada em 1880, já se delineavam sinais claros das fragilidades no funcionamento dos hospitais da capital. Em ofício dirigido ao presidente da

província, o inspetor de Saúde Pública, Dr. Abdon Felinto Milanez²⁴⁹, após realizar uma visita e um “exame minucioso” no Hospital de Nossa Senhora das Neves, afirmou ter se convencido de que o número de empregados era excessivo para o tratamento dos “indigentes” então existentes, podendo ser reduzido sem prejuízo do serviço (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 13/07/1879).

Além disso, Milanez chamou atenção para a disparidade nos vencimentos pagos aos funcionários desse hospital em comparação com outros estabelecimentos da capital, inclusive o hospital de variolosos, não encontrando justificativa para tal desigualdade quando os serviços prestados eram considerados equivalentes. Ao sugerir a redução tanto do pessoal quanto dos salários, o inspetor não apenas transparecia os problemas de organização e critérios administrativos, como também indicava que, já em 1879, a assistência hospitalar passava a ser avaliada sob a lógica do ajuste e da contenção de gastos, antecipando o movimento de dissolução e retração das estruturas de socorro que se consolidaria no ano seguinte (Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, AHWBD, 13/07/1879).

Já em novembro de 1879, a lógica de retração da assistência hospitalar se concretizava de forma explícita na capital. Em ofício²⁵⁰ dirigido ao presidente da província, o fiscal Mathias da Gama Cabral de Vasconcellos informava que, tendo sido reduzido a 23 o número de doentes internados no Hospital de Nossa Senhora das Neves, procedeu à transferência desses enfermos para o Hospital de Santo Antônio, em cumprimento a ordens superiores (Cidade da Parahyba, AHWBD, 01/11/1879). Com isso, declarava-se extinto o referido hospital, bem como dispensados todos os seus empregados. A decisão revela que o encerramento da unidade não decorreu da completa resolução das demandas sanitárias, mas de um cálculo administrativo baseado na redução numérica dos internados e na reorganização dos serviços existentes.

Ao mesmo tempo, o fiscal faz questão de registrar que os funcionários dispensados haviam se portado “com a maior dignidade e humanitariamente no tratamento dos infelizes emigrantes”, destacando nominalmente o escriturário João Monteiro de Medeiros pelo zelo e pela dedicação no exercício de suas funções (Cidade da Parahyba, AHWBD, 01/11/1879). Esse reconhecimento, longe de contradizer o fechamento do hospital, retrata a coexistência de duas dimensões distintas: de um lado, o empenho individual de servidores no cuidado

²⁴⁹ Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 13 de Julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²⁵⁰ Cidade da Parahyba, 1 de Novembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

cotidiano dos doentes; de outro, a decisão administrativa de extinguir estruturas emergenciais, mesmo com a permanência de populações doentes que ainda demandavam assistência.

O hospital e a enfermaria da Cruz do Peixe figuravam entre as instituições que recebiam avisos recorrentes de fechamento, mas cuja extinção era sucessivamente adiada em razão do fluxo constante de doentes. A documentação indica que a permanência dessas unidades estava diretamente relacionada ao acréscimo da população, composta por emigrantes que, acometidos por diversas moléstias, não conseguiam regressar aos seus lares.

Segundo relatório do provedor da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, o volume de atendimentos aumentava tanto pela facilidade de recolhimento quanto pelo tratamento ali oferecido, cenário que se tornaria ainda mais intenso caso se confirmasse o fechamento do Hospital da Cruz do Peixe, “como já tem sido anunciado” (Relatório do Provedor Lindolfo José Correia das Neves, 02 jul. 1880, f. 9, *apud* Alves, 2018, p. 58). Esse quadro revela como, mesmo diante das tentativas administrativas de reduzir ou encerrar as estruturas emergenciais, a pressão exercida pela presença contínua de doentes impunha sucessivos adiamentos, prolongando o funcionamento de instituições concebidas como provisórias.

Para se ter uma ideia da dimensão do público atendido pelo hospital e pela enfermaria da Cruz do Peixe, basta observar que, apenas entre os meses de janeiro e março de 1879, foram registradas 258 mortes no total (Galvão *apud* Alves, 2018, p. 55). Esses números ajudam a dimensionar a pressão exercida sobre a instituição no auge da crise e servem de referência para compreender o movimento observado no ano seguinte, quando, em 1880, mesmo com a redução formal das estruturas emergenciais e o anúncio de encerramento de hospitais, a assistência ainda precisava lidar com a permanência de doentes e com a reorganização dos atendimentos na capital.

Já em dezembro de 1879, O *Mappa Demonstrativo do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe*²⁵¹ revela a ampliação do papel dessa instituição no momento final da seca, quando passou a absorver pacientes provenientes de outros estabelecimentos de saúde da província. Ao longo do mês, foram registrados 424 doentes, dos quais 211 eram oriundos do extinto Hospital de Santo Antônio, sendo 109 homens e 102 mulheres, o que demonstra o impacto direto do fechamento daquela unidade sobre a reorganização da assistência hospitalar na capital (Mappa..., AHWBD, 12/1879).

A esse contingente somaram-se 15 pacientes transferidos da Santa Casa, entre os quais oito homens e sete mulheres, além de 59 indivíduos provenientes da enfermaria de variolosos,

²⁵¹ Mappa demonstrativo do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe durante o mez de dezembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

sendo 15 homens e 44 mulheres. Registraram-se ainda 139 novas entradas ocorridas no próprio mês, das quais 63 eram do sexo masculino e 76 do feminino. No mesmo período, contabilizaram-se 149 altas por cura – 75 homens e 74 mulheres – e 34 óbitos, distribuídos entre 14 homens e 20 mulheres, totalizando 183 saídas (Mappa, AHWBD, 12/1879).²⁵²

Como resultado desse movimento, 241 pacientes permaneceram em tratamento ao final de dezembro, número que corresponde ao saldo da enfermaria após o cômputo das transferências, novas admissões, altas e falecimentos. Esses dados indicam que o encerramento de outras instituições não implicou uma redução imediata da demanda por atendimento, mas levou à concentração dos serviços hospitalares no Hospital da Cruz do Peixe, que passou a operar como principal espaço de acolhimento dos doentes naquele momento.

Cabe observar, entretanto, que o mapa referente ao mês seguinte registra apenas 135 internos provenientes do período anterior, o que sugere a ocorrência de novas altas, transferências ou óbitos no intervalo entre os dois registros, ainda que tais movimentações não tenham sido detalhadas na documentação disponível, revelando os limites e as descontinuidades do controle administrativo sobre a assistência hospitalar no pós-seca.

Vejamos todos esses dados no Quadro 12 abaixo:

Quadro 9 – Movimento dos doentes no Hospital da Cruz do Peixe (dezembro de 1879)

Categoria	Descrição	Homens	Mulheres	Total
Doentes atendidos no mês	Total de pacientes registrados em dezembro de 1879	-	-	424
Transferidos do Hospital de Santo Antônio	Pacientes oriundos do hospital extinto	109	102	211
Transferidos da Santa Casa	Pacientes transferidos da Santa Casa	8	7	15
Provenientes da enfermaria de variolosos	Pacientes oriundos da enfermaria específica	15	44	59
Novas entradas no mês	Pacientes admitidos diretamente no hospital	63	76	139
Altas por cura	Saídas por recuperação	75	74	149
Óbitos	Falecimentos registrados no mês	14	20	34
Total de saídas	Altas + óbitos	-	-	183
Pacientes remanescentes	Permaneceram internados ao final de dezembro	-	-	241
Internos registrados em jan. de 1880	Pacientes provenientes de dezembro	-	-	135

²⁵² Mappa demonstrativo do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe durante o mez de dezembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Fonte: Quadro elaborado e adaptado por nós com base no *Mappa Demonstrativo do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe durante o mez de dezembro de 1879* Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1879, Caixa 062; *Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de janeiro de 1880*. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

No mês seguinte, janeiro de 1880²⁵³, os registros do Hospital da Cruz do Peixe apontam para uma redução gradual do número de internos, sem que isso significasse o esvaziamento da assistência. Dos 135 pacientes que permaneciam em tratamento desde dezembro de 1879, somaram-se 79 novas entradas, totalizando 214 pessoas atendidas ao longo do mês. Desse contingente, 80 receberam alta por cura e 12 faleceram, resultando na permanência de 122 internos para o período subsequente (Mappa..., AHWBD, 01/1880).

Esse conjunto de dados evidencia que, mesmo após o encerramento formal dos socorros públicos, a demanda por atendimento hospitalar permanecia significativa, ainda que em processo de redução. A dinâmica observada sugere uma transição marcada pela reorganização dos serviços e pela concentração dos atendimentos em unidades remanescentes, mais do que uma interrupção imediata das necessidades sanitárias da população atendida.

Além disso, o controle de gastos permaneceu como uma preocupação constante ao longo de 1880. Em ofício encaminhado pelo administrador do Hospital da Cruz do Peixe²⁵⁴ – responsável também pelo cemitério a ele vinculado – ao presidente da província, Dr. José Rodrigues Pereira Júnior, informava-se que, mesmo após a dispensa de um enfermeiro e de duas lavadeiras, o quadro funcional havia sido reduzido a apenas dez funcionários, que se revezavam entre as atividades do hospital e do cemitério. Ainda assim, o administrador solicitava autorização para a contratação de um servente, com o objetivo de atender à crescente demanda dos serviços funerários (Parahyba do Norte, Hospital da Cruz do Peixe, AHWBD, 25/02/1880).

No mês de fevereiro de 1880, o Hospital da Cruz do Peixe manteve elevado volume de atendimentos. Segundo o *Mappa do movimento dos doentes*²⁵⁵, passaram do mês anterior 225 pacientes, aos quais se somaram 140 novas entradas, totalizando 365 pessoas assistidas ao longo do período. Registraram-se 126 altas por cura e 32 óbitos, resultando na permanência de 207 internos ao final do mês. Ainda que os números iniciais não correspondam exatamente

²⁵³ Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de janeiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁵⁴ Parahyba do Norte, Hospital da Cruz do Peixe, 25 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁵⁵ Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

ao saldo registrado em janeiro, o conjunto dos dados evidencia a continuidade da demanda por atendimento hospitalar, bem como os limites do controle administrativo sobre a circulação dos doentes entre os diferentes estabelecimentos de saúde (Mappa..., AHWBD, 02/1880).

Em março de 1880²⁵⁶, permaneceram em tratamento 207 pacientes provenientes do mês anterior, aos quais se acrescentaram 147 novas admissões, elevando o total de atendimentos no período. No mesmo mês, 129 doentes receberam alta por cura e 26 faleceram, resultando na permanência de aproximadamente 197 internos ao final do período. Embora o mapa apresente pequenas variações numéricas, o movimento registrado confirma a manutenção de um fluxo constante de entradas e saídas, indicando que o hospital continuava a operar em ritmo intenso mesmo após o encerramento formal dos socorros públicos (Mappa..., AHWBD, 03/1880).

Já no mês de abril de 1880²⁵⁷, observa-se uma redução gradual do número de internos, ainda que sem esvaziamento da assistência. Permaneceram em tratamento 197 pacientes oriundos de março, aos quais se somaram 102 novas entradas, totalizando 299 atendimentos no período. Registraram-se 81 altas por cura e 22 óbitos, resultando na permanência de 196 doentes ao final do mês. Esses dados sugerem uma diminuição progressiva da pressão sobre a instituição, embora o hospital continuasse a desempenhar papel central na assistência à população adoecida da capital (Mappa..., AHWBD, 04/1880).

O Quadro 13 abaixo sistematiza essas informações:

Quadro 10 – Movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe (jan.–abr. 1880)

Mês/Ano	Passaram do mês anterior	Novas entradas	Altas por cura	Óbitos	Permaneceram em tratamento	Total
Janeiro/1880	135	79	80	12	122	214
Fevereiro/1880	225	140	126	32	207	365
Março/1880	207	147	129	26	197	354
Abril/1880	197	102	81	22	196	299
Total	764	468	416	92	722	1.232

Fonte: Quadro elaborado e adaptado por nós com base nos *Mapas do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe*, janeiro a abril de 1880.²⁵⁸ Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁵⁶ Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de março de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁵⁷ Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de abril de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁵⁸ As variações entre os totais finais de um mês e os valores iniciais do mês seguinte indicam movimentações não detalhadas nos mapas (como transferências, admissões extraordinárias ou óbitos fora do período mensal).

O acompanhamento do movimento mensal do Hospital da Cruz do Peixe entre janeiro e abril de 1880 permite compreender a dinâmica da assistência hospitalar no imediato pós-seca, marcada menos por um encerramento abrupto dos atendimentos e mais por um processo gradual de reorganização e concentração dos serviços. Mesmo com a redução progressiva do número de internos ao longo dos meses, os dados mostram que a demanda permaneceu elevada, principalmente em fevereiro e março, quando o hospital absorveu tanto pacientes provenientes de outras instituições extintas quanto novas admissões.

As oscilações entre os saldos mensais e os números iniciais de cada período indicam a circulação constante de doentes, transferências pouco registradas e dificuldades administrativas em acompanhar com precisão esses fluxos. Nesse sentido, o Hospital da Cruz do Peixe não operou apenas como espaço de tratamento médico, mas como um ponto central de acolhimento e contenção da população adoecida, evidenciando que os efeitos sanitários da seca ultrapassaram seu término climático e continuaram a tensionar as estruturas de saúde da capital ao longo de 1880.

Com relação aos demais hospitais da província, como os das cidades de Areia e Mamanguape, o presidente Dr. José Rodrigues Ferreira Junior informou que, no hospital “estabelecido n’aquella cidade, para tratamento dos indigentes, vítimas da secca, não fosse mais admittido doente algum”. Já no caso do hospital de Mamanguape, determinou-se que fossem “apenas recebidos os colonos affectados de molestias que, por sua natureza ou gravidade, não podessem ser tratados nas proprias colonias” (Parahyba do Norte, *Exposição*, 30/04/1880, p. 1).

Essas determinações indicam que, em 1880, a política provincial caminhava para a restrição progressiva da assistência hospitalar, redefinindo o papel das instituições criadas durante a seca. Ao vedar novas admissões no hospital de Areia e limitar o atendimento em Mamanguape aos casos considerados mais graves, o governo sinalizava o esgotamento dos socorros emergenciais e a transferência da responsabilidade pela sobrevivência dos indivíduos para outros espaços, como as colônias ou o retorno forçado às localidades de origem.

Diante desse cenário, o próximo tópico desloca o olhar para outras formas de dissolução administrativa implementadas no pós-seca, como o encerramento dos auxílios alimentares e o progressivo desmonte dos núcleos coloniais. Nesse movimento, ganha centralidade a análise da construção da grande Represa de Poços, erguida no sertão da Villa do Teixeira como uma das principais obras públicas do período. A partir desse caso, discutem-se os impasses entre trabalho, fome, doenças e morte, que continuaram a marcar a experiência

dos trabalhadores empregados na obra, revelando os limites das soluções adotadas pelo governo para enfrentar os efeitos sociais e sanitários da seca.

4.2 “OS QUE FORAM RICOS JÁ ESTARÃO POBRES, E OS ABASTADOS MENDIGOS”: O TÉRMINO DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA E O RETORNO DOS MIGRANTES PARA CASA

A importancia de todos os creditos por mim abertos á verba “Soccorros Publicos”, desde que assumi a administração desta Provincia até esta data, monta em 925:600\$000, sendo 600:000\$000, para pagamento de despesas do exercicio de 1878-1879, e 325:600\$000, para as do exercicio corrente.

[...]

Segundo me acaba de communicar o Inspector da Thesouraria de Fazenda, por officio de hontem datado, acha-se esgotado o ultimo dos creditos por mim abertos supra-mencionados, e resta pagar de despesas de soccorros, cujos documentos existem n’esta Repartição, a quantia de quatro contos, cento e oitenta e sete mil, sete centos e oitenta e nove réis (4:187\$789), e as despesas com as enfermarias e almoxarifado, relativamente a este mez, as quaes importão em oito contos de réis (8:000\$000) (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880, p. 3).

A epígrafe que abre este subtópico foi extraída da Exposição²⁵⁹ apresentada por ocasião da passagem da administração da Província da Parahyba do Norte entre o Dr. José Rodrigues Ferreira Junior para o Pe. Felipe Benicio da Fonseca Galvão, então 2º Vice-Presidente, no dia 30 de abril de 1880. Trata-se de um documento produzido em um momento de transição administrativa, no qual o presidente que deixava o cargo prestava contas da situação financeira da província ao seu sucessor.

Longe de constituir apenas um balanço contábil, a Exposição revela os limites materiais da ação governamental no pós-seca, ao explicitar o esgotamento dos créditos destinados à verba de “Soccorros Publicos” e a existência de despesas ainda pendentes, como as enfermarias e almoxarifados (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880).

Ao indicar que todos os créditos abertos para os socorros se encontravam consumidos, ao mesmo tempo em que permaneciam valores a pagar, o presidente revela o encerramento, até então formal, da assistência pública em um contexto no qual a crise ainda não havia sido plenamente superada. A menção às despesas remanescentes, como aquelas relacionadas às enfermarias, sugere que a retirada dos recursos não correspondeu ao desaparecimento imediato das necessidades sanitárias e sociais da população atingida pela seca.

²⁵⁹ PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. Dr. José Rodrigues Ferreira Junior passou a administração desta Província ao Exm. Sr. Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão - 2o. Vice-Presidente em 30 de abril de 1880. p. 3.

O que podemos compreender, nesse momento, é o término da assistência não como um processo gradual e planejado, mas como uma ruptura administrativa marcada pela exaustão financeira do governo provincial, criando as condições que levaram ao retorno dos migrantes aos seus locais de origem, muitas vezes em situação de fragilidade, doença e desamparo.

Em 15 de maio de 1880, ao assumir interinamente a administração provincial, o Pe. Felipe Benicio da Fonseca Galvão²⁶⁰ confirma o quadro de esgotamento financeiro apresentado por seu antecessor, informando que, no momento de sua posse, o crédito aberto para a verba de “Socorros Publicos” já se encontrava integralmente consumido. Diferentemente da Exposição de 30 de abril, voltada à prestação de contas, o documento do mês de maio determina as primeiras medidas administrativas adotadas diante dessa limitação material, entre elas a extinção do “Almoxarifado de Socorros Públicos”, o recolhimento dos gêneros remanescentes aos armazéns da Alfândega e a remessa dos livros à Tesouraria de Fazenda para a tomada de contas (Parahyba do Norte, Exposição, 15/05/1880, p. 2).

Ao mesmo tempo, reconhece que as despesas continuavam a se avolumar, inclusive aquelas relacionadas às enfermarias e ao pessoal nelas empregado, ainda que reduzido ao “estricamente necessario”. A justificativa apresentada para não solicitar a abertura de novo crédito, baseada na expectativa de permanência breve no cargo, revela o caráter provisório e improvisado da gestão dos socorros nesse momento final, constatando que o encerramento da assistência pública não resultou de uma avaliação sobre a superação da crise, mas da ausência de recursos e de autorizações administrativas (Parahyba do Norte, Exposição, 15/05/1880, p. 2). Assim, a transição entre abril e maio de 1880 permite observar como o fim dos socorros se consolidou não como uma política planejada, mas como consequência da exaustão e reorganização contábil do governo provincial.

A situação se agravou ainda pela impossibilidade de criação de novas fontes de receita e pela inadimplência no pagamento das prestações de empréstimos. A receita provincial, que alcançava 405:746\$810 (quatrocentos e cinco contos, setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e dez réis) no exercício de 1876-1877, sofreu uma queda expressiva nos anos seguintes, reduzindo-se a 241:353\$382 (duzentos e quarenta e um contos, trezentos e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta e dois réis). Entre 1877 e 1878, atingiu o menor valor

²⁶⁰ PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. 2º. Vice-Presidente Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão passou a administração desta Província ao 1º. Vice-Presidente Dr. Antonio Alfredo de Gama e Mello no dia 15 de maio de 1880.

do período analisado, totalizando 170:485\$115 (cento e setenta contos, quatrocentos e oitenta e cinco mil e cento e quinze réis), conforme dados sistematizados por Diana Galliza.²⁶¹

Já a dívida pública da província alcançou 832:369\$703 (oitocentos e trinta e dois contos, trezentos e sessenta e nove mil e setecentos e três réis) em agosto de 1878, ultrapassando 1:000:000\$000 (um milhão de réis) até meados de 1882. A retomada parcial da arrecadação só ocorreu em 1879 e 1880, quando a receita subiu para 318:819\$586 (trezentos e dezoito contos, oitocentos e dezenove mil e quinhentos e oitenta e seis réis) (Galliza, 1979, p. 57-58).

Vemos, nessas primeiras discussões, que a seca de 1877-79 não foi apenas um desastre natural, mas o catalisador de uma crise estrutural complexa, expondo a fragilidade da economia provincial diante das intempéries prolongadas e da ausência de reservas institucionais e fiscais.

Conforme analisado por Lucian Silva (2021b, p. 38)²⁶², os números entre os anos de 1877 e 1880 revelam um padrão de grave instabilidade econômica provocada pela seca. Em 1877 e 1878, os déficits foram crescentes: 89:375\$775 (oitenta e nove contos, trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e setenta e cinco réis) e 138:959\$741 (cento e trinta e oito contos, novecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e um réis), respectivamente, resultado direto do aumento de despesas com alimentação, moradia, assistência médica para a população migrante, além dos gastos referentes à construção de obras públicas.

Enquanto em 1879, observa-se um superávit expressivo de 138:597\$069 (cento e trinta e oito contos, quinhentos e noventa e sete mil e sessenta e nove réis), explicado pelas várias aberturas de crédito realizadas pelo governo imperial. No entanto, essa recuperação foi efêmera: em 1880, já em pleno processo de tentativa de reestruturação pós-seca, a receita despencou e o déficit atingiu o maior nível até então: 174:289\$051 (cento e setenta e quatro contos, duzentos e oitenta e nove mil e cinquenta e um réis), revelando a permanência da crise econômica mesmo após o arrefecimento da seca (Silva, L., 2021b, p. 38).

Em relação às variadas aberturas de crédito e às doações provenientes de outras províncias e instituições ao longo do triênio da seca, observa-se que, para o ano de 1880, foi autorizada apenas uma única abertura de crédito, no valor de 30:000\$000 (trinta contos de

²⁶¹ Análise feita a partir dos dados recolhidos no *Quadro n.º 12 Receita da Paraíba 1870-1888*, elaborado por Galliza (1979, p. 57-58), com base na edição do dia 21 de setembro de 1888, do *Jornal da Parahyba* n.º 2727.

²⁶² Para uma análise mais detalhada sobre a economia parahybana entre 1870 a 1888, consultar a tese de doutorado do referido autor: SILVA, Lucian Souza da. **Esmagando a cabeça da Hidra: escravidão, liberdade e abolição na Paraíba do Norte, 1877-1888**. 2021. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. p. 31-56.

réis). A solicitação partiu do presidente da província e foi autorizada em 31 de janeiro de 1880, com o objetivo de “recorrer ao pagamento de despesas com socorros às vítimas da sêcca” (Ofício n.º 782, Ministério dos Negócios do Império, AHWBD, 28/02/1880)²⁶³. O montante reduzido dessa concessão, quando comparado às cifras mobilizadas nos anos anteriores, evidencia a retração do apoio financeiro externo e reforça o caráter residual da assistência pública no contexto pós-seca.

Assim, a crise financeira que se aprofundou entre 1877 e 1880 impôs limites reais à continuidade da assistência pública, convertendo o encerramento dos socorros em uma resposta condicionada pela escassez de recursos e pelo endividamento das rendas da província. É a partir dessas circunstâncias que marca o início de um retorno forçado dos migrantes aos seus locais de origem, em um cenário no qual persistiam a precariedade das condições de vida e a ausência de meios eficazes de reintegração social.

Dessa forma, podemos afirmar que o encerramento da assistência pública ocorreu de forma desproporcional, marcado pela ausência de planejamento. Mesmo que a seca tenha se prolongado por cerca de três anos, a documentação interna do período indica que, já no início de 1879, começaram a ser adotadas medidas voltadas à cessação dos auxílios alimentícios.

Nesse sentido, a última remessa destinada à Comissão de Socorros da Capital foi registrada em 8 de agosto daquele ano, marcando o fim do abastecimento regular para os migrantes concentrados na cidade. No interior da província, os últimos socorros foram remetidos até 3 de novembro, quando se encerrou o envio geral de gêneros, mantendo-se, após essa data, apenas o atendimento pontual às colônias ainda em funcionamento e ao município de Teixeira, caso que será analisado mais adiante (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880, p. 2).

Outra medida adotada foi a dissolução gradual das colônias formadas durante a seca, que, ao todo, perfaziam 31 núcleos. Desses, 24 localizavam-se na Capital, reunindo 1.507 famílias, o que correspondia a 7.047 pessoas, o que indica que a Capital funcionou como principal polo de recepção e fixação provisória da maioria dos migrantes; um núcleo situava-se em Independência (Guarabira), com 137 famílias e 648 pessoas; e seis estavam em Mamanguape, com 1.216 famílias. Esses 7 núcleos demonstram as tentativas de dispersão dessas famílias para além do centro urbano, ainda que em escala mais limitada.

²⁶³ Ofício n.º 782, Diretoria do Ministério dos Negócios do Império. Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

No conjunto, esses núcleos abrigavam 1.882 famílias, totalizando 8.911 pessoas²⁶⁴ – número que já havia alcançado cerca de 12 mil migrantes, entre homens, mulheres e crianças, segundo a Exposição de 30 de abril de 1880 (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880, p. 5).

Alguns desses núcleos reuniam contingentes mais elevados, como Mussuré, que se destacou como o mais populoso, com 1.677 pessoas, seguido por Jagaraú (521), Espírito Santo (484) e Abiay (414), todos localizados na Capital. Fora desse perímetro, Mata Limpa, em Independência (Guarabira), também se sobressaiu por abrigar um número expressivo de famílias (137) e pessoas (648). Já em Mamanguape, núcleos como Nascimento de Uma (275) e Miriri do Meio (267) concentraram os maiores contingentes daquela região.

Para melhor visualização e compreensão, apresentamos a seguir, o Quadro 14 com os 31 núcleos coloniais formados, incluindo o número de pessoas, famílias, nome dos núcleos e proprietários, e também onde estavam localizados.

Quadro 11 – Núcleos coloniais fundados durante a Seca de 1877-1879 na Parahyba do Norte (1880)

Pessoas	Famílias	Núcleos	Locais	Proprietários
1677	366	Mussuré	Capital	Lindolfo José Correia das Neves
414	111	Abiay	Capital	Salustino Ephigenio Carneiro da Cunha
405	78	Puxi de baixo	Capital	Francisco Ignácio Pereira de Castro
521	96	Jagaraú	Capital	Antonio Cabral de Vasconcelos
206	45	S. Izabel	Capital	Cipriano d'Arrochelas Galvão
305	69	Nova Libéria	Capital	José Joaquim d'Abreu
332	80	Amparo	Capital	Porfírio Venâncio da Costa Bahias
109	16	Barra de Gramame	Capital	José Lins de Vasconcelos
147	32	Jacaré	Capital	José Alves de Souza
86	20	Ribeira	Capital	Francisco Pinto Pessoa
484	75	Espírito Santo	Capital	Edmundo do Rego Barros
329	85	Pau Brasil	Capital	José Moreira d'Oliveira
127	27	Ponte de Gramame	Capital	Manoel Paulino dos Santos Leal
118	30	Tauá de S. André	Capital	Antonio Xavier Monteiro da Franca
157	56	Camoc M.	Capital	Manoel Cavalcante de Sá Albuquerque
233	50	S. S. Cosme e Damião	Capital	Bento da Costa Vilar
273	45	S. Ana de Gargaú	Capital	João José de Almeida
134	30	Marcos João	Capital	Francisco Benevides Pessoa
97	21	Cana-Brava	Capital	Manoel Soares Nogueira de Moraes

²⁶⁴ O número foi calculado com os dados prestados no *Quadro demonstrativo dos nucleos coloniales fundados com retirantes na Província da Parahyba*. Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880. p. 5.

186	24	Ilha	Capital	Luiz Marcio da Gama
191	20	Rio do meio, 1º	Capital	José Francisco d'Albuquerque Maranhão
93	22	Rio do meio 2º	Capital	Mathias da Gama Cabral de Vasconcelos
392	94	Tauá de tibiri	Capital	Domiciano Lucas de Souza Rangel
58	14	Gramame	Capital	José Antonio Lisboa
648	137	Mata limpa	Independência	João Alves Trigueiro
76	14	Miriri do lagamar	Mamanguape	Cesário Correia Lima
232	46	Guarita	Mamanguape	Manoel Joaquim Peixoto de Vasconcelos
267	49	Miriri do meio	Mamanguape	José Felix Correia
275	58	Nascerça de Una	Mamanguape	Henrique Ribeiro Pessoa de Vasconcelos
133	29	Leite mirim 2º	Mamanguape	Daniel Rafael de Freitas
233	42	Leite mirim 1º	Mamanguape	Antonio Pinto de Carvalho Pelado

Fonte: Quadro elaborado por nós com base no *Quadro demonstrativo dos nucleos colonias fundados com retirantes na Província da Parahyba*. In: PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. Dr. José Rodrigues Ferreira Junior passou a administração desta Província ao Exm. Sr. Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão – 2º. Vice-Presidente- 30 abril 1880. p. 5.

Segundo o presidente da província, Dr. José Rodrigues Ferreira Júnior, três das 24 colônias instaladas na Capital foram dissolvidas durante sua administração, assim como um núcleo localizado em Mamanguape. Conforme recorda o presidente, esses núcleos haviam sido concebidos para oferecer moradia e alimentação em troca de trabalho, com pagamento semanal, prevendo-se uma duração máxima de até oito meses para esse arranjo (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880, p. 2).

Além disso, a Exposição indica que o encerramento de parte das colônias não decorreu apenas do cumprimento desse prazo. Em muitos casos, a dissolução esteve diretamente associada à interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios, enquanto aquelas que continuaram em funcionamento o fizeram por ainda contarem com estoques remanescentes, armazenados na alfândega e enviados anteriormente pelo governo.

Outra justificativa que ganhava força para o encerramento desses núcleos apoiava-se em um discurso já identificado ao longo desta dissertação, que representava os migrantes como ameaça à ordem, propagadores de doenças, dependentes dos cofres públicos e alvos de práticas de disciplinamento e controle.

Essa leitura também aparece na Exposição de 30 de abril de 1880, na qual o secretário interino José Bezerra Cavalcante de Albuquerque atribuía aos migrantes a “irregularidade de conduta e maus costumes”, bem como a ausência ou recusa ao trabalho, elementos apontados como causas da expulsão de diversas pessoas e, posteriormente, do encerramento do núcleo (Parahyba do Norte, Exposição, 30/04/1880, p. 5).

Tais expressões, não devem ser tomadas como descrições objetivas de comportamentos efetivamente verificados, mas como categorias administrativas e morais acionadas no interior do discurso oficial, funcionando como justificativa para o enfraquecimento e o encerramento da assistência pública.

A partir dessa lógica, diversos administradores dos núcleos passaram a encaminhar denúncias tanto à delegacia de polícia quanto ao presidente da província. Entre os casos, citamos um episódio envolvendo os colonos Laurentino Ferreira do Nascimento, Lyndolpho de Souza Cunha e Mauro Vicente de Oliveira, pertencentes à Colônia do Amparo, localizada no Distrito de Jacoca, que abrigava 80 famílias com cerca de 332 pessoas no total.²⁶⁵ O conflito resultou no encaminhamento deste último para atendimento no Hospital da Capital (Colônia do Amparo no Distrito da Jacoca, AHWBD, 05/02/1880).

No ofício, o administrador do núcleo afirmava não saber ao certo a origem da confusão, alegando a inexistência de corpo de delito e dificuldades relacionadas ao escrivão da delegacia. Ainda assim, na tentativa de se eximir de responsabilidades – ou de prevenir eventuais acusações contra sua administração –, encaminhou uma lista com os nomes dos colonos do sexo masculino, solicitando providências “a fim da punição dos criminosos, uma vez que a esta administração só convém severo exemplo” (Colônia do Amparo no Distrito da Jacoca, AHWBD, 05/02/1880).

Para além dos encerramentos das colônias, a documentação registra a ocorrência de situações, tanto dentro quanto fora dos núcleos ainda em funcionamento, que alimentavam discursos em torno da imagem depreciativa dos migrantes e de sua associação à criminalidade. Esses discursos eram frequentemente utilizados como justificativa para a dissolução completa dessas estruturas.

Além disso, os registros indicam a existência de várias exigências impostas aos administradores e aos demais funcionários dos núcleos e das comissões de socorros, o que dificultava o funcionamento dessas instâncias. Diante dessas imposições, outro grande desafio consistia no cumprimento das determinações do Ministério da Agricultura, segundo as quais todos os polos de assistência criados no contexto da seca deveriam seguir as diretrizes estabelecidas pela pasta

[...] com urgência, faça recolher e transmitir todos os esclarecimentos possíveis, relativos ao numero de retirantes flagelados da sêcca que foi aplicado em obra de utilidade publica nesta localidade, e suas circunvizinhanças, com declaração das que foram recebidas, discriminando mesmo a natureza destas, isto é, se geraes, se

²⁶⁵ Colônia do Amparo no Distrito da Jacoca em 5 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

provinciaes, ou municipaes, determinando, se for possível o valor de cada uma (Engenho Pão D'Arco, AHWDBD, 02/03/1880).²⁶⁶

Nesse contexto de esgotamento dos socorros, de aumento das exigências administrativas e de reordenamento da assistência, ao longo do ano de 1880 a administração provincial passou por sucessivas mudanças, mas manteve a mesma orientação quanto à progressiva desativação dos núcleos coloniais.

Esse processo alcançou também os últimos núcleos ainda em funcionamento na região de Mamanguape. O encerramento dessas experiências foi registrado no relatório apresentado pelo Dr. Gregório de José de Oliveira Costa Júnior, em 3 de setembro de 1880, no qual afirmava ter promovido a “extinção gradual dos mesmos, conciliando, dessa forma, os princípios econômicos com os sentimentos de caridade” (Parahyba do Norte, Relatório, 03/09/1880, p. 9).²⁶⁷

Diferentemente do Ceará, onde as comissões locais e o próprio governo foram obrigados a prestar contas de forma detalhada sobre os recursos mobilizados ao longo dos 32 meses de seca, na Parahyba a documentação revela outra dinâmica. Na província cearense, os registros discriminavam os valores destinados às redes de assistência alimentar aos migrantes e trabalhadores, ao transporte de gêneros, à manutenção de casas-escola, ao fornecimento de vestuário, às despesas com medicamentos empregados no enfrentamento das diversas doenças e epidemias, bem como às gratificações pagas a médicos, enfermeiros e demais funcionários dos hospitais, chefes e administradores de núcleos e comissões, engenheiros, além das operações de importação e exportação realizadas entre 1879 e 1880 (Teófilo, 1883b, p. 461-463).

Na Parahyba, entretanto, a tentativa de impor exigências semelhantes de fiscalização e transparência passou a gerar certas resistências e dificuldades práticas. Ainda que o discurso administrativo enfatizasse a necessidade de controle sobre os recursos, começaram a surgir reclamações por parte das instâncias de socorros.

A Comissão de Areia²⁶⁸ foi uma das primeiras a se manifestar em nome de várias outras, considerando a decisão um tanto “embaraçada”, uma vez que, segundo os administradores, tratava-se de uma responsabilidade “impossível” de ser cumprida, diante do

²⁶⁶ Engenho Pão D'Arco, 02 de março de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁶⁷ PARAHYBA DO NORTE, Relatório apresentado pelo Illm. e Exm. Sr. Doutor Greogorio José d'Oliveira Costa Junior presidente d'esta provincia ao primeiro vice-presidente Bacharel Antonio Alfredo da Gama e Mello em 3 de setembro de 1880.

²⁶⁸ Comissão de Socorros, Cidade de Areia, 15 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

elevado número de migrantes distribuídos por diversas obras públicas, tanto no município de Areia quanto em localidades vizinhas (Comissão de Socorros, Cidade de Areia, AHWBD, 15/02/1880).

Outras explicações apresentadas pela Comissão referem-se ao fato de que, entre 1877 e 1879, nunca teriam chegado “livros e papeis, [...] do que fizera anteriormente à data em que começou a funcionar esta mesma comissão”. A ausência desses registros e materiais administrativos dificultava a prestação de contas, uma vez que, segundo os próprios membros, não havia como apresentar informações detalhadas sobre atividades e despesas sem a documentação necessária (Comissão de Socorros, Cidade de Areia, AHWBD, 15/02/1880).

A Comissão também destacou a escassez de gêneros enviados durante o período, observando que, sem o recebimento regular de cargas, não haveria como responder às exigências de fiscalização. Aqueles que ainda recebiam algum tipo de socorro o faziam por serem considerados “válidos”, pois estavam empregados em obras como “estradas e ruas da cidade” e, portanto, tinham direito ao auxílio. Diante desse cenário, os administradores afirmaram ainda que tais ordens nunca lhes haviam sido impostas anteriormente e que só poderiam cumprir essas novas determinações caso houvesse recursos para indenizar terceiros; sem meios financeiros para isso, a execução da tarefa tornava-se inviável (Comissão de Socorros, Cidade de Areia, AHWBD, 15/02/1880).

A única pauta que a Comissão afirmava conseguir informar com maiores níveis de detalhe referia-se aos empreendimentos realizados por alguns colonos, como os melhoramentos das estradas de Alagoa Grande, a reconstrução de um açude em Arara e de outro de menor porte em Areia, bem como os reparos no prédio da Cadeia Pública de Areia e na Casa de Caridade, além de intervenções em ruas e estradas. Ainda assim, ressaltava que todas essas atividades exigiam dispêndios financeiros e o fornecimento de gêneros “em não pequena quantidade”, mas que não possuía condições de informar valores parciais ou totais com segurança, atribuindo à Secretaria do Governo da Província a responsabilidade por esses dados e respectivos registros (Comissão de Socorros, Cidade de Areia, AHWBD, 15/02/1880).

É a partir dessas alegações que se tornam mais visíveis os pontos frágeis da gestão voltada à intervenção nos males causados pela seca. As reclamações apresentadas pelas comissões ganham sentido quando se observa a inexistência de mecanismos efetivos de fiscalização, tanto sobre a chegada das cargas quanto sobre seu destino final. A ausência de controle comprometia a prestação de contas e revelava os limites administrativos de uma

política de socorros que, embora formalmente existente, operava de maneira precária e desarticulada.

Além disso, a documentação nos mostra a consolidação de um critério seletivo de acesso aos auxílios, segundo o qual apenas os indivíduos considerados “aptos” ao trabalho deveriam ser assistidos. Essa lógica contribuía para a exclusão daqueles já debilitados pela fome e pelas doenças. Ao condicionar o socorro à capacidade laboral, a assistência deixava de responder às necessidades mais urgentes, reforçando, ao mesmo tempo, o agravamento do quadro sanitário e social no pós-seca.

A Comissão de Campina Grande²⁶⁹ foi mais uma a demonstrar resistência em prestar esclarecimentos, tanto em nível geral quanto municipal, acerca dos “retirantes flagelados”. Nas primeiras respostas, justificava que as informações solicitadas “não podem assentar em base certa e segura, [...] mas não são exageradas”. Diferentemente da Comissão de Areia, apresentou um cálculo aproximado do número de migrantes que teriam recebido socorros, estimado em cerca de “dez mil pessoas de todas as idades e de ambos os sexos” (Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880).

Outra alegação apresentada dizia respeito ao fato de que, entre os cerca de dez mil migrantes, havia aqueles oriundos do alto sertão, para os quais caberia à Comissão providenciar a compra das passagens de retorno aos seus locais de origem. A Comissão fazia questão de ressaltar que “dêo sempre rações aos mesmos emigrantes sem que se demorassem aqui”, indicando que o socorro prestado tinha caráter transitório e estava orientado a evitar a permanência prolongada desses sujeitos na localidade (Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880).

Ainda de acordo com os administradores, apenas uma ou duas mil pessoas foram consideradas “válidas” para o emprego em algumas obras, como os reparos na Cadeia Pública e na Igreja, a construção do Açude Novo de Campina Grande e de outro denominado “Riacho Piabas”, na região próxima, além das estradas que seguiam para Alagoa Nova e para a Capital da Província. Entretanto, essas atividades foram paralisadas com o encerramento do envio de alimentos, o que contribuiu para o desfalque no número de trabalhadores empregados (Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880).

O que essas evidências revelam é que a cessação dos auxílios alimentícios ocorreu de forma antecipada em relação à realidade vivida pela população atingida. Ainda em 1880, as próprias comissões registravam a permanência de migrantes que continuavam a demandar

²⁶⁹ Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

socorros, o que indica que a crise não havia sido plenamente superada, muito menos no momento em que os envios de alimentos começaram a ser interrompidos, já em 1879.

Ao declarar o encerramento da assistência quando ainda existiam sujeitos dependentes dela, a administração provincial produziu um descompasso entre o tempo administrativo do fim da seca e o tempo social da crise, aprofundando situações de precariedade que persistiam no pós-seca. Ao restringir a assistência e o monitoramento nesse contexto, deixou de reconhecer, ou desconsiderou, o quadro ainda marcado por abandono e desgaste nos âmbitos econômico, físico, social e estrutural, realidade registrada pelas próprias comissões.

No pós-seca, a permanência dessas condições de precariedade não se deu de forma neutra, mas articulada a uma lógica de troca e submissão, na qual o acesso à assistência era condicionado a decisões impostas pelo poder público. Essa dinâmica pode ser observada de forma expressiva no Ceará, a partir do relato de Rodolfo Teófilo. Na *História da Seca do Ceará* (1877 a 1880), o autor descreve o retorno dos migrantes ao interior como um processo marcado pela incerteza climática e pela administração calculada da miséria. Mesmo com a expectativa generalizada de que o inverno estivesse próximo, nos primeiros meses de 1880, os sinais atmosféricos desmentiam essa esperança: o calor persistente, os ventos secos e a ausência de qualquer indício de chuva reproduziam o cenário de janeiro de 1877 (Teófilo, 1883b, p. 422).

Ao narrar esse momento, Rodolfo Teófilo expõe as medidas adotadas pela presidência da província sob a responsabilidade do Dr. José Júlio de Albuquerque Barros. A solução consistia em estimular a saída organizada dos migrantes considerados aptos ao trabalho, condicionando o acesso aos socorros à disposição de retorno ao interior.

Aqueles que aceitassem partir dentro do prazo estipulado receberiam provisões mínimas para a viagem, enquanto os que permanecessem nos abarracamentos sem justificativa perderiam o direito à assistência. Apenas os órfãos e os enfermos continuariam incluídos no sistema de socorros. Teófilo apresenta essa política como uma decisão arriscada, pois dependia inteiramente da regularidade das chuvas para evitar um agravamento ainda maior da crise vivida nos três anos anteriores (Teófilo, 1883b, p. 422).

Realidades como essas nos fazem pensar como a persistência da estiagem tornava essa espera angustiante, não apenas pela incerteza climática, mas também por fatores como a contenção de gastos públicos, o controle da população abarracada e as perdas de entes familiares que haviam se deslocado para a capital e outras regiões movidos por expectativas de sobrevivência que, muitas vezes, não se concretizavam. Como interpretou Teófilo (1883b, p. 422), tratava-se de um momento de aposta perigosa, no qual o destino da população

cearense permanecia submetido ao acaso climático, mesmo após anos de sofrimento e deslocamento forçado.

À luz dessas circunstâncias, o Sertão da Parahyba, região que havia experimentado de forma mais intensa os efeitos da seca, encontrava-se, em 1880, longe de qualquer processo efetivo de recuperação. Além da persistência da fome, das doenças e da morte, a criminalidade também não havia cessado, em especial na comarca de Pombal, que ainda se encontrava em processo lento de recomposição.

Naquele contexto, os chamados “assassinos e salteadores” continuavam a provocar temor não apenas em Pombal, mas também nas regiões vizinhas. Entre eles destacava-se Jesuíno Brilhante²⁷⁰, descrito na documentação como integrante de um grupo composto por mais de quinze homens, dos quais sete eram escravizados, classificados como “completamente flagiciosos”.²⁷¹ O grupo era capitaneado por Honorário Rodrigues dos Santos²⁷², cuja atuação reforçava o clima de insegurança que persistia no Sertão no pós-seca. Segundo os registros, cometeram diversos roubos, ferimentos e assassinatos, que atingiam desde fazendeiros até “uma infeliz senhora, irmã do Padre, no termo de S. João” (Cidade de Pombal, AHWB, 08/12/1880).

Embora a repressão não tenha eliminado por completo os episódios de violência registrados em 1880, o caso de Jesuíno teve um desfecho ainda no final de 1879, com a chegada de um novo promotor público. Este mobilizou a força policial da 1ª linha de Pombal, resultando na morte de Jesuíno e na prisão de Honorário (Cidade de Pombal, AHWB, 08/12/1880).

Consequentemente, a permanência de grupos armados no Sertão, como aquele liderado por Jesuíno Brilhante, deve ser compreendida no interior de uma conjuntura mais ampla, marcada pela crise social desencadeada pela seca, pela retração da assistência pública e pela fragilidade das estruturas estatais.

Também se deve considerar que esses grupos armados não atuavam de forma homogênea ou isolada, sendo frequentes as disputas internas com outros salteadores, muitas

²⁷⁰ Jesuíno Brilhante nasceu em 2 de janeiro de 1844, no sítio Tuiuiú, nas proximidades da vila do Patu, na então província do Rio Grande do Norte. Sua trajetória foi marcada por conflitos familiares que resultaram em um homicídio no início da década de 1870, episódio que o levou a abandonar sua região de origem e a viver em constante deslocamento pelo sertão. A partir de então, passou a atuar à margem da legalidade, sendo associado ao banditismo sertanejo até sua morte, ocorrida em 1879 (Sousa, M., 2023, P. 412).

²⁷¹ Cidade de Pombal, 08 de agosto de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

²⁷² De acordo com os jornais da época, passou a atuar na região de Pombal, na Paraíba, ao lado de seu irmão Joaquim Rodrigues dos Santos, após a morte de Francisco Rodrigues dos Santos, também seu irmão, ocorrida em decorrência de um conflito de natureza amorosa (Sousa, M., 2023, P. 413).

vezes decorrentes de conflitos familiares, rivalidades locais ou vinganças antigas. Inseridas nesse contexto de violência difusa e de fragilidade da ordem pública, tais ocorrências foram posteriormente interpretadas pela historiografia como antecedentes de formas de banditismo que se consolidariam nas primeiras décadas do século XX, sendo identificadas como práticas que antecederam o fenômeno do cangaço (Neves, 2000, p. 28).

Conforme apontam Litwak e Sá (2023), o banditismo sertanejo do final do século XIX não pode ser reduzido a uma expressão isolada de criminalidade, pois está inserido em contexto de disputas de poder, ausência governamental e aprofundamento das tensões sociais, intensificadas em períodos de estiagem.

Nesse cenário, a repressão armada acionada pelas autoridades provinciais operava menos como solução para as causas estruturais da violência e mais como instrumento simbólico de afirmação da ordem e da autoridade estatal. Ao eleger figuras como Jesuíno e seu grupo como inimigos públicos, o governo deslocava o foco da crise – provocada pela seca, pela fome e pela exclusão – para o campo da segurança, transformando conflitos sociais em problemas de polícia.

Assim, a repressão funcionava como uma estratégia política de contenção, buscando demonstrar controle em um Sertão ainda marcado pela precariedade material, pela dissolução dos socorros e pela ausência de políticas efetivas de reintegração da população atingida (Litwak; Sá, 2023).

Voltando para as prestações de contas, a única comissão que afirmou ter atendido a boa parte das exigências atribuídas pelo Ministério da Fazenda e pela administração provincial foi a do município de Teixeira, no alto sertão, em 15 de outubro de 1879.

Em relatório extenso²⁷³, seus administradores informavam que as falhas na distribuição regular dos alimentos em 1877 decorreram, segundo eles, da circulação constante da população migrante, que “errava de comissão em comissão, [...], na esperança de ser socorrida, gastava lentamente as forças, exauria-se, chegava ao estado de inanição, e perecia pela fome!!!”.

Diante desse diagnóstico, a comissão adotou um plano que previa a realização da distribuição em dias previamente fixados, bem como o racionamento por famílias, e não por indivíduos. Na avaliação de seus administradores, o resultado teria sido positivo, por ter sido considerado “econômico em favor dos indigentes”, além de coibir práticas classificadas como

²⁷³ Relatório apresentado pela Comissão de Socorros da Villa do Teixeira ao Ilmo Exmo Sr. Dr. José Rodrigues Pereira Junior – Presidente desta Província, em 15 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

fraudulentas e conferir à distribuição um caráter de “honestidade” e “justiça”, ao mesmo tempo em que reforçava a união entre os membros de cada família (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Encontramos nessas alegações uma contradição pertinente. Ao atribuir à população migrante a responsabilidade pelas falhas na distribuição dos alimentos, a comissão desloca para os socorridos a culpa por uma crise que também revela limites e omissões da própria assistência. Se esses sujeitos circulavam constantemente entre Teixeira e localidades vizinhas, é plausível supor que, além da fome persistente, a distribuição não fosse suficiente nem regular

Nesse sentido, aquilo que a comissão classificava como “fraude” pode ser interpretado como práticas de sobrevivência, tais como a circulação constante entre os pontos de socorro, a ampliação do número de dependentes declarados, a circulação entre diferentes polos de assistência ou, ainda, a permanência na condição de dependência quando a administração já considerava encerrada a ajuda.

Além disso, os membros comissionados reconheciam a falência do sistema de assistência do qual dependiam aquela população. No mesmo relatório, a comissão desloca parte da responsabilidade para o presidente da província, o Dr. Ulysses Viana, ao afirmar que, apesar dos pedidos reiterados por providências “promptas”, estas não teriam sido atendidas, enquanto “com dor e magoa via sucumbir a fome centenas de nossos patrícios bem dignos de melhor sorte!” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Se raras são as fontes que permitem reconstruir o caminho de volta de muitos desses migrantes, o mesmo não se aplica àqueles que retornavam para Teixeira e localidades vizinhas, cuja presença reaparece com maior frequência na documentação do pós-seca.

Em primeiro lugar, a comissão responsabiliza as migrações ocorridas em 1877, afirmando que elas não teriam sido benéficas para ninguém. Como justificativa, descreve esse deslocamento como um percurso marcado pelo esgotamento extremo, no qual os retirantes teriam sorvido “até a última gota as fezes mais amargas do cálice das provações, e experimentado nesta quadra as dores mais pungentes dos açoites da miséria!!” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Em seguida, sustenta que os migrantes não alcançaram aquilo que buscavam nos brejos e litorais, sendo retratados como “mal educados, e sem princípios de economia doméstica”. Por fim, a situação teria se agravado porque, acostumados ao clima semiárido do sertão, não conseguiam se adaptar “aos climas húmidos e doentios do litoral”. Também alegava que esses indivíduos não encontravam abrigo adequado. Segundo esse discurso, por cama restavam “as lamas da rua”, “por vestido trapos”, “por cobertura a chuva, o sol e o

sereno”, e “por alimento a fome”. Ainda que a documentação mostre situações diversas – com parte dos migrantes dormindo ao relento e outros ocupando espaços públicos ou casas de caridade –, essa descrição reforça a imagem de abandono associada ao retorno (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Além disso, lembrava-se, ainda, de que poucos escapavam da miséria e das epidemias. A comissão afirmava que mais da metade da população que migrou havia morrido, e que os sobreviventes regressavam “cobertos de chagas” e “moribundos”, sem alternativas, restando-lhes apenas o desejo de voltar à terra natal (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Chama atenção, nesse conjunto de relatos, a recorrência da descrição do estado físico dos migrantes no momento do retorno, sempre apresentada de forma marcante nos discursos do pós-seca. Além de Teixeira, outros municípios do sertão, como Pombal, Patos, São José do Sabugy e Santa Luzia, passaram a receber esses migrantes, cuja condição física é descrita nos mesmos termos: “estão cobertas de vírus e quase moribundas” (Gabinete Central da Comissão de Socorros Públicos, AHWBD, 08/02/1880).²⁷⁴

Com relação as referências das “chagas” dizem respeito às feridas visíveis no corpo – lesões de pele abertas, muitas vezes associadas à exposição prolongada ao sol, à falta de higiene, à desnutrição e ao contato com doenças infecciosas –, enquanto a menção aos “vírus” aponta para a circulação de enfermidades contagiosas ainda ativas entre aqueles que retornavam. Esses registros permitem perceber como a doença deixava marcas visíveis nos corpos, na condição física e na aparência geral dos migrantes, revelando que muitos voltavam não apenas empobrecidos, mas também adoecidos.

Para Frederico de Castro Neves (2000, p. 92-93), todos esses efeitos causados pela seca de 1877-79, desencadeou um conjunto de sentimentos e sensibilidades que estão diretamente associados às experiências vividas pela população atingida. Essas sensibilidades, em um primeiro plano, vinculam-se ao impacto imediato da catástrofe sobre os corpos e o cotidiano, expressando-se por meio do sofrimento, da fome, das doenças, das mortes e de práticas extremas como o suicídio. Em um segundo plano, essas experiências passam a ser reelaboradas em um registro mais reflexivo e moral, no qual a seca é interpretada, julgada e convertida em discursos que fundamentam denúncias, justificativas e projetos de ordenamento, controle e disciplinamento social (Neves, 2000, p. 93).

Nesse processo, uma sensibilidade particularmente significativa diz respeito ao rompimento da visão tradicional da pobreza como condição natural, passiva e restrita à

²⁷⁴ Gabinete da Comissão Central de Socorros da Parahyba do Norte, em 8 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

carência material. A presença massiva de migrantes nas cidades desperta o temor de que a miséria pudesse se converter em revolta, ainda que tal reação não fosse reconhecida como ação política consciente ou reivindicação legítima de direitos. As atitudes dos pobres passam a ser interpretadas como impulsos descontrolados, respostas instintivas à fome e à privação, frequentemente descritas como “respostas espasmódicas” ou “forças subterrâneas” da sociedade (Neves, 2000, p. 98–99).

É nesse quadro que se insere o plano adotado no município de Teixeira. Longe de responder exclusivamente a uma necessidade emergencial, sua atuação esteve atravessada por interesses econômicos e por estratégias de disciplinamento dos corpos submetidos à caridade pública.

Como já informado, a Parahyba adotou duas vertentes no enfrentamento da seca: uma de caráter humanitário e outra hidráulica. Esta última chegou a ser posta em prática ao longo do período, mas encontrou entraves que, caso tivessem sido enfrentados, poderiam ter reduzido o sofrimento da população.

Enquanto se discutia a escolha dos locais e a construção de açudes, nos primeiros momentos a população recorreu aos reservatórios particulares. Em Piancó, por exemplo, existiam cerca de cinquenta açudes; com o avanço da seca, a pressão demográfica e a falta de meios de abastecimento, esse número se reduziu a apenas dois em condições de uso. Outro reservatório citado como mais estável, que contribuiu para suprir a necessidade de água da população, pertencia ao Padre Rolim, em Cajazeiras (Almeida, J., 2012 [1923], p. 176).

Ainda que os relatórios dos presidentes de província registrem autorizações para a construção de açudes, essas obras não se realizavam com rapidez nem em grande número. Pelo contrário, muitas das que haviam sido iniciadas ou mesmo concluídas acabaram interrompidas. Com a redução dos auxílios e das remunerações destinadas aos migrantes, a mão de obra foi escasseando, e diversas construções desapareceram ou ficaram paradas “por falta de conservação” (Almeida, J., 2012 [1923], p. 221).

É preciso considerar que, em outras províncias, como o Ceará, diversos estudos foram debatidos e, em alguns casos, colocados em prática, a exemplo das propostas do Instituto Politécnico, das análises do engenheiro André Rebouças e das contribuições de outros estudiosos que se dedicaram a examinar as causas da seca e possíveis formas de enfrentamento. Nesse contexto, cabia às comissões de engenheiros estudar os locais mais adequados para a construção de açudes, o nivelamento de poços, a disponibilidade de pastagens para evitar a morte do gado, entre outros (Teófilo, 1883b).

Segundo José Américo (2012 [1923], p. 251), essa dinâmica não se repetiu na Parahyba. Embora o engenheiro Francisco Pereira da Silva tenha sido consultado por ordem do próprio presidente da província, as considerações técnicas apresentadas não avançaram.

Entre as obras levadas adiante, a que recebeu maior volume de recursos e foi apresentada como a principal represa de poços construída durante a “grande seca” na província da Parahyba do Norte localizou-se em Teixeira.

Solicitada em junho de 1878 pelo presidente Dr. Ulysses Vianna, tinha a função de socorrer a população naquele contexto e, segundo as expectativas então formuladas, atender “no futuro a milhares”. Teve como principal administrador, além dos chefes da comissão, o cônego Bernardo de Carvalho Andrade²⁷⁵, que passou a articular os recursos disponíveis não apenas como medida emergencial, mas como investimento duradouro.

A escolha de Teixeira não foi aleatória. Situado no semiárido parahybano, na área serrana que leva seu nome, o município apresenta relevo acidentado, regime irregular de chuvas e condições que favorecem a erosão e o desgaste dos mananciais durante e após os períodos de estiagem (Ramalho; Guerra, 2018, p. 62).

Ou seja, não era um espaço favorável à conservação dos mananciais, mas um espaço onde se acreditava ser possível concentrar água, ainda que por tempo limitado. Essas características influenciam tanto a disponibilidade hídrica quanto a conservação dos mananciais, tornando os reservatórios mais vulneráveis ao assoreamento e à perda de capacidade de armazenamento, especialmente nos períodos de retorno das chuvas (Ramalho; Guerra, 2018, p. 62).

A represa, também conhecida como *Açude de Poços*, enfrentou uma série de dificuldades que comprometeram o ritmo de sua execução. A principal esteve relacionada à falta de socorros, situação que levou à paralisação da obra mesmo quando o aterro já estava concluído. Esse quadro foi agravado pelo crescimento da população adventícia, resultado de um novo movimento migratório desencadeado pela notícia dos trabalhos em Poços. Segundo os administradores, as pessoas que anteriormente haviam deixado o sertão durante a seca passaram a afluir novamente, vindas da capital da província, de Pernambuco, das matas, dos

²⁷⁵ Nasceu em Teixeira, Paraíba. Ordenou-se sacerdote em 1860, após concluir os cursos de Filosofia e Teologia no Seminário de Olinda (PE). Iniciou sua atuação pastoral na capelania de Santa Luzia do Sabugi (PB) e, em 7 de julho de 1861, tomou posse como vigário da igreja de Santa Maria Madalena, em Teixeira. Além da trajetória eclesástica, teve participação na vida política provincial como deputado, destacando-se, durante a seca de 1877-1879, pela iniciativa de conduzir a construção do açude de poços no mesmo município (Baptista, 1933, p. 7).

brejos, do Sul e de outros lugares, atraídas pela expectativa de trabalho e assistência (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Ao chegarem na obra, se depararam com outra realidade. O número de migrantes era tão superior ao que tinha previsto a comissão que não tinham alimentos para nem da metade, o que gerava outro golpe: muitos ficavam a mercê e “se debatião com a fome”, outros apelaram para os locais de onde já haviam saídos enquanto a outra parcela pagavam com a própria “vida a temeridade a que se tinham exposto” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Os critérios de acesso aos benefícios baseavam-se na capacidade de trabalhar e a recusa à “ociosidade”, cabendo aos administradores “distribuir esmola a quem é robusto e são”. Já não importava distinguir trajetórias sociais ou posições anteriores à seca: diante da catástrofe, segundo essa lógica administrativa, restavam apenas a caridade e a disposição para o trabalho. Como registram no próprio relatório, “o pobre já não encontrava abrigo na terra em que o rio nascer; porque os que forão ricos já estarão pobres, e os abastados mendigos”, o que indica que a assistência passou a operar menos como socorro universal e humanitário e mais como instrumento de seleção, controle e ordenamento social (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Os trabalhos começaram apenas em agosto de 1878, devido à ausência inicial de suprimentos, ferramentas e verbas. De acordo com a comissão, a execução das obras teria contribuído para reanimar parte da população, tanto pelo acesso ao “fraco pão pra remir a vida” mediante o trabalho quanto pela percepção de que deixavam de ocupar uma posição considerada humilhante, associada à esmola e mendicância, vista como degradante (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Diante do conjunto de relatos produzidos pela comissão acerca da população migrante e não migrante, é possível identificar contradições marcadas por idas e vindas em seus discursos. No subtópico anterior, dedicado à saúde e às doenças desses grupos, notamos que a comissão não poupou palavras ao descrever as condições de higiene, recorrendo a representações depreciativas dos corpos e das próprias condições de vida.

No entanto, observa-se agora uma redefinição nesse discurso. Com as obras adquirindo certa continuidade, sem interrupções atribuídas à falta de auxílios, a comissão passou a exaltar o desempenho da vila, apresentada como a única que “obriga a trabalhar”, e, pela primeira vez, elogiou a massa trabalhadora, afirmando que “já não erão os leprosos de então” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Poucas páginas adiante do relatório, a própria comissão volta a expor os limites dessa narrativa otimista. Além de registrar a diminuição no número de trabalhadores acometidos por doenças que os tornavam “inválidos de qualquer espécie”, reconhece a existência de “embaraços e obstáculos” que comprometiam a regularidade das obras. Persistiam a falta de água para o consumo e para a execução dos trabalhos de alvenaria, bem como a ocorrência de epidemias de febres diversas, disenteria, varíola e outras não especificadas, que haviam “chegado ao maximo de intensidade”, paralisando mensalmente os trabalhos e ocasionando “grandes males” (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

A própria Comissão reconhecia que a continuidade das obras dependia diretamente da regularidade dos socorros destinados aos “indigentes” reunidos no Teixeira. Temendo que, diante da miséria cotidiana, os trabalhos fossem interrompidos e a população empregada retornasse às “duras provações como de antes”, a Comissão buscou, em outubro do ano anterior, entendimento com o então presidente da província para que fosse ampliado o número de volumes remetidos mensalmente.

A reclamação foi atendida pelo presidente Dr. Ulysses Vianna, que autorizou o acréscimo de cem volumes em cada remessa, alegando tanto a necessidade de socorrer os indigentes quanto o interesse em levar a obra a termo. Ainda assim, apesar da “boa vontade” atribuída ao governo provincial, dificuldades no transporte dos socorros – motivadas pelas delongas impostas aos condutores e pelo receio das viagens nos meses de novembro e dezembro – resultaram na interrupção das remessas nesses meses, privando a população dos auxílios e paralisando as obras por vários dias (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Desse modo, ainda que a Comissão buscasse reiteradamente se apresentar como a mais bem-sucedida na condução das obras, não conseguia ocultar as falhas do governo provincial no provimento de assistência médico-alimentar e de condições mínimas de higiene, nem a intensidade com que as doenças e epidemias continuavam a vitimar a população daquela vila.

Além disso, enquanto a população acumulava doenças, fome e uma série de circunstâncias críticas, a Comissão seguia apresentando justificativas para a continuidade da construção da represa de Poços. Nelas, ressaltava-se a utilidade da obra para os sertões atingidos pela seca, argumentando que, se até mesmo os pequenos açudes particulares, erguidos em córregos de pouca extensão, ofereciam auxílio restrito a seus proprietários, maiores ainda seriam os benefícios das “grandes e profundas represas, que jamais secarão”.

Diferentemente dos açudes já existentes no termo de Teixeira – que naquele ano não haviam recebido água por falta de riachos permanentes –, a represa de Poços, ainda inacabada, já teria acumulado volume suficiente para suprir as necessidades do município, mesmo em

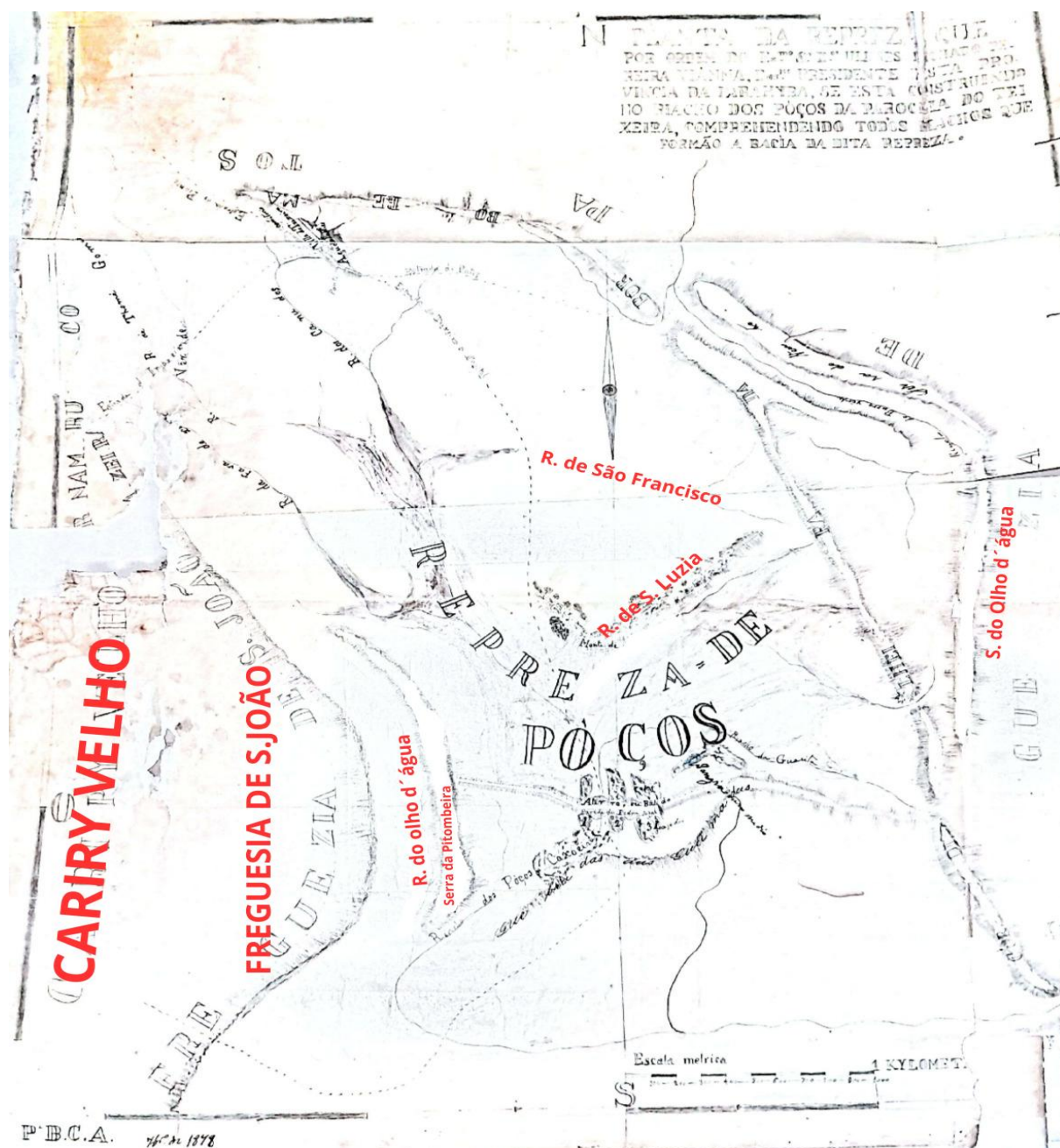
um contexto de chuvas escassas. Segundo o relatório, além de garantir o abastecimento imediato, essas obras permitiriam mitigar os efeitos futuros das secas por meio da ampliação das áreas úmidas para cultivo, da irrigação, da criação de animais e da melhoria das condições sanitárias, associadas à presença constante da água (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Outra preocupação central era que a Represa ainda não havia alcançado o primeiro sangradouro, condição considerada indispensável para garantir a segurança da estrutura diante das enchentes do inverno. Caso os trabalhos fossem interrompidos antes desse ponto, advertia-se para o risco de ruína total da obra, com prejuízos tanto financeiros quanto humanos, uma vez que os migrantes haviam sustentado o empreendimento com trabalho pesado em troca de uma alimentação mínima. Nesse contexto, a comissão defendia a continuidade imediata dos socorros e das obras como única forma de preservar o que já havia sido construído e evitar o agravamento da crise alimentar ainda presente no sertão.

No estado em que se encontrava, a represa possuía fundamentos lançados, com aterro de 200 metros de comprimento, base de 52 metros e altura média de 11 metros, além de estruturas em pedra e cal destinadas a conter infiltrações e desabamentos. A comissão afirmava que, embora apenas uma parte da capacidade total estivesse em funcionamento, o reservatório já fornecia água a centenas de pessoas e que, uma vez concluído, “remirá da fome, em tempos maus, mais de 8 mil pessoas”. Além disso, para alcançar o sangradouro médio considerado adequado, ainda seriam necessários novos trabalhos de elevação do aterro, condicionados, porém, à continuidade dos socorros à população empregada, de modo a evitar a interrupção das obras e o risco de perda do que já havia sido construído (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Conforme indicado no relatório, a planta apresentada a seguir permite compreender os riachos que formam a bacia da represa, assim como sua topografia, dimensões e a superfície provável dos terrenos a serem alagados.

Figura 8 – Planta da Represa de Poços da Vila do Teixeira (1879)



Fonte: Relatório apresentado pela comissão de socorros da Villa do Teixeira ao Ilmo Exmo Snr Dr. José Rodrigues Pereira Júnior Presidente desta Província, em 15 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062. Digitalização feita por nós a partir da imagem original, com realce e inserção de legendas para facilitar a leitura.

Não foram localizadas listas nominais dos trabalhadores envolvidos, mas é possível identificar as funções exercidas na construção da represa. Desde o início das obras, reuniam-se no Teixeira “quase dois mil indigentes”, número que foi sendo progressivamente reduzido em razão das doenças e mortes frequentes da reemigração para outras localidades e da

escassez de alimentos e de água, fazendo com que esse contingente diminuísse para menos da metade (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

À medida que esses fatores passaram a comprometer o andamento das obras, o relatório informa que, entre a data de sua publicação, em 15 de outubro de 1879, e abril de 1880 – provável momento de conclusão da represa –, o trabalho mensal, calculado em 25 dias úteis, passou a exigir 130 homens e 100 “meninos”, provavelmente menores de idade, ambos empregados como serventes ou pedreiros (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Somavam-se ainda 100 mulheres, destinadas a atividades como lavagem de roupas, limpeza e preparo de alimentos, funções recorrentes no contexto da seca. Essa composição sugere, em alguns casos, o envolvimento de membros de uma mesma família. Além disso, foram solicitados 4 apontadores, 1 revisor de trabalhos, 1 mestre de pedreiro, 1 oficial de obras de pedreiro, 2 oficiais para a capina e 2 para os serviços de ferraria (Relatório da Villa do Teixeira, 15/10/1879).

Apesar disso, é possível supor que não houve a contratação de engenheiros, tanto pelo custo elevado quanto pelo fato de se tratar de um trabalho executado, em geral, pela própria população local ou por migrantes, que conheciam o terreno e possuíam experiência prévia em obras semelhantes, como a construção de outros açudes (Teófilo, 1883, p. 317).

Diante da análise da construção da represa de Poços, na Vila do Teixeira, cabe ainda tecer algumas considerações de conjunto. No balanço das iniciativas adotadas durante a seca, essa experiência aparece como uma das poucas que alcançaram algum grau de efetivação, ainda que marcada por atrasos, interrupções e limitações. O fato de resultados mais concretos se concentrarem em Teixeira reforça o caráter pontual dessas ações, que não se estenderam de forma consistente a outros municípios do sertão nem às áreas da Borborema, mesorregião vizinha e historicamente articulada ao semiárido.

Nesse sentido, as vertentes humanitária e hidráulica assumidas pela administração provincial mostraram-se vinculadas a um contexto emergencial, sem desdobramentos capazes de alterar, de modo mais duradouro, as condições estruturais da região. A ausência de investimentos contínuos e de estudos mais sistemáticos – como aqueles desenvolvidos no Ceará – contribuiu para que tais iniciativas não se consolidassem como políticas permanentes, permitindo a persistência dos mesmos problemas nas secas que se seguiriam.²⁷⁶

²⁷⁶ Segundo José Américo de Almeida (2012 [1923], p. 263), após a seca de 1877–1879, foram poucos os açudes construídos na província. Em 1919, aqueles então em execução eram de pequeno porte, localizados nos municípios de Soledade e Bodocongó, enquanto outros dois, em Mogeiro e Cajazeiras, encontravam-se em processo de reconstrução.

Em paralelo, a experiência da Represa de Poços também ajuda a compreender por que determinados autores passaram a defender soluções de maior alcance para o enfrentamento das secas. Irineu Joffily, por exemplo, ao dialogar com as propostas de André Rebouças, advogava a necessidade da “factura de açudes na maior escala que fosse possível”, associada à construção de diques, como forma de intervir de maneira mais decisiva no “estado físico” do sertão (Joffily, 1892, p. 107).

Para o autor, tais obras poderiam contribuir para a regularização hídrica e para o estímulo à criação de gado e à agricultura, ao mesmo tempo em que funcionariam como uma espécie de escola prática, envolvendo os sertanejos na execução dos próprios empreendimentos (Joffily, 1892, p. 107). Essa perspectiva revelava uma confiança acentuada na capacidade das obras hidráulicas de produzir transformações duradouras na paisagem e nas condições climáticas da região, expressando uma visão tecnocrática e otimista sobre o papel da engenharia na superação das secas.

Além disso, bastaram pouco mais de nove anos para que, entre 1888 e 1889, outra seca severa voltasse a produzir medo, adoecimento e mortes (Almeida, J., (2012 [1923], p. 177). Esse novo episódio ocorreu quando a população ainda sentia os efeitos da seca de 1877–1879, o que colocava em xeque o alcance das medidas então adotadas. A repetição da crise expôs, de forma clara, como a ausência de ações estruturais naquele momento fez com que os limites do enfrentamento anterior se fizessem sentir já na seca seguinte.

No que se refere ao balanço de contas elaborado pelo governo provincial e pelas demais instâncias concentradas na capital, ao longo dos anos de 1877 a 1880, a documentação administrativa passou a registrar de forma sistemática as ações adotadas no enfrentamento da seca. Nesses registros, destacavam-se a abertura de créditos extraordinários, o envio de gêneros de subsistência, a contratação de indivíduos já vinculados aos quadros da política, da saúde, da segurança pública ou da administração econômica, bem como a criação e a manutenção de polos de assistência.

Essas iniciativas passaram a ser apresentadas como resultados diretos da atuação de cada presidente ou vice-presidente em exercício, compondo um balanço predominantemente positivo das gestões. Como já discutido, entretanto, essa leitura não era consensual. Em diferentes momentos, os relatos de vigários do interior da província apontavam em sentido oposto, assim como as informações produzidas pelas comissões de Areia, Campina Grande e Teixeira, analisadas neste subtópico.

Não podemos deixar de lembrar que essas comissões, apesar de serem formadas por representantes locais das comunidades, nem sempre atuavam de forma isenta. Ou seja, era

comum que seus membros “tirassem proveito para si ou fizessem vista grossa para os desvios”, favorecendo parentes, protegidos ou pessoas próximas. Essas práticas incluíam desde o desvio de suprimentos até irregularidades no transporte das cargas, o que contribuía para fragilizar a assistência prestada e reforçar as denúncias sobre o mau uso das verbas destinadas aos socorros públicos (Ferreira, 1993, p. 66).

Os periódicos de oposição também não poupavam críticas à administração provincial. Durante a gestão do Dr. Ulysses Vianna, entre março de 1878 e fevereiro de 1879, vinculada ao Partido Liberal, o *Jornal A Parahyba*²⁷⁷, em edição de 17 de abril de 1879, publicou acusações severas, atribuindo à sua administração o desvio da verba de socorros públicos em benefício de aliados políticos. Em tom abertamente acusatório, o periódico afirmava que tais práticas teriam ocorrido “sob qualquer ponto de vista”, denunciando o uso dos recursos em favor de “coadjuvadores na passada farsa eleitoral”, mesmo que isso implicasse, segundo o jornal, a morte de “muitos milhares de indivíduos, que sucumbiram à fome” (*Jornal da Parahyba*, 17/04/1879, p. 4 *apud* Aguiar, 1999, p. 161).

Tais acusações evidenciam como a seca e a administração dos socorros públicos foram continuamente apropriadas como instrumentos de disputa política, sem que isso implicasse mudanças substantivas na condução da assistência. Ao contrário, a distribuição dos recursos manteve-se marcada por práticas seletivas e desiguais, funcionando, como bem definiu Lúcia de Fátima Guerra Ferreira (1993, p. 15), “como fonte de benefícios para uns em detrimento de muitos”. Essa lógica, longe de se esgotar no contexto da seca de 1877-1879, tenderia a se reproduzir e a se consolidar em episódios posteriores, especialmente nas secas do século XX, ainda que sob novos arranjos institucionais e discursivos.

Apesar das reclamações locais e das condições extremas vividas pela população afetada, a crise acabou sendo esvaziada em meio aos discursos que atribuíam a responsabilidade ao elevado número de migrantes, à chamada “ociosidade”, à “mendicância” e aos maus costumes.

Se, durante os anos mais agudos da seca, o migrante figurava nos relatórios como vítima da calamidade, corpo faminto e doente a ser socorrido, em 1880 sua posição no discurso oficial se altera de maneira sensível. Aquele que antes aparecia como objeto de cuidado passa a ser descrito como suspeito; o corpo enfermo converte-se em corpo desviado; a emergência

²⁷⁷ Fundado em 1862, o *Jornal da Parahyba* esteve, desde sua origem, ligado às lideranças conservadoras da província da Parahyba do Norte. Sua direção inicial coube a Silvino Elvídio Carneiro da Cunha – figura de destaque do Partido Conservador provincial e que, posteriormente, receberia o título de Barão de Abiaí –, o que evidenciava o alinhamento político do periódico e sua inserção nas disputas partidárias do período (Peixoto, 2023b, p. 42).

humanitária transforma-se em incômodo social; e o objeto de assistência cede lugar ao objeto de repressão e vigilância.

Essa mudança não se opera de forma abrupta, mas progressiva, acompanhando o esgotamento dos recursos públicos e a necessidade administrativa de justificar o encerramento dos socorros. Ao mesmo tempo em que a seca deixa de ser apresentada como calamidade incontornável, a responsabilidade pelo prolongamento da crise passa a ser atribuída aos próprios indivíduos atingidos.

Dessa forma, as dificuldades enfrentadas pelo governo eram justificadas menos pela insuficiência das políticas adotadas e mais pela própria presença dos migrantes, enquanto a gravidade da crise permanecia, muitas vezes, restrita às páginas dos jornais de oposição.

Como observa Jucieldo Alexandre (2024b), ao final das crises epidêmicas era comum que as narrativas oficiais exaltassem os governos que estavam no poder e suas filiações partidárias, ao mesmo tempo em que alimentava críticas por parte dos adversários. Nesse processo, membros dos altos escalões também apareciam como figuras centrais, frequentemente exaltadas nos impressos por sua atuação, entre eles “padres, médicos, funcionários públicos, proprietários rurais e negociantes, entre outros indivíduos abastados” (Alexandre, 2024b, p. 143).

Para além dos elogios públicos, esse mesmo grupo também foi contemplado financeiramente, inserindo-se como uma “política de gratificações adotada nas monarquias portuguesa e brasileira” (Alexandre, 2024b, p. 144). Entre os casos registrados, destacam-se os médicos Dr. Abdon Felinto Milanez e Dr. Antônio da Cruz Cordeiro, que receberam gratificações “em razão do excesso de trabalho”, com valores iguais destinados a cada um pelos serviços prestados durante e após a seca (Paço da Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte, AHWBD, 02/10/1879²⁷⁸).

Com relação a narrativa oficial de encerramento da crise da seca apresenta-se no relatório de 3 de setembro de 1880²⁷⁹, no qual a situação é descrita como um ciclo concluído após “trez annos de soffrimentos e difficuldades”. O presidente afirma, com “viva satisfação”, o término do “período crítico da secca”, associando o fim do sofrimento da população à cessação dos “sacrifícios do Thesouro” (Parahyba do Norte, Relatório, 03/09/1880, p. 8).

²⁷⁸ Paço da Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte, em 2 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

²⁷⁹ PARAHYBA DO NORTE, Relatório apresentado pelo Illm. e Exm. Sr. Doutor Greogorio José d'Oliveira Costa Junior presidente d'esta provincia ao primeiro vice-presidente Bacharel Antonio Alfredo da Gama e Mello em 3 de setembro de 1880. p. 9.

Os dados financeiros divulgados reforçam essa lógica. Ao discriminar os valores despendidos pelo Governo Imperial até abril e após essa data, o relatório procura demonstrar a magnitude do investimento realizado – mais de 2.665:322\$437 réis (dois mil seiscentos e sessenta e cinco contos, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete réis) – e, ao mesmo tempo, justificar o encerramento progressivo da assistência (Parahyba do Norte, Relatório, 03/09/1880, p. 8).

Além disso, o presidente deixa claro que ainda existiam despesas em processamento e possíveis divergências nos cálculos, atribuídas à impugnação de contas pela Tesouraria. Tratava-se, portanto, de um cenário administrativo ainda tensionado por pendências financeiras, como já identificado em outros registros, apesar do discurso oficial de superação da crise. Assim, mesmo ao declarar o fim da seca, o presidente admitia a permanência de obrigações não quitadas, problema que perdurou na administração provincial e nas comissões de socorros no pós-seca.

Por fim, o presidente relembra as aberturas de crédito autorizadas durante a gestão – entre elas, a quantia de 30:000\$000 réis (trinta contos de réis), em julho –, as quais aparecem como medidas pontuais e insuficientes para sustentar a continuidade de uma política ampla de socorros. O caráter limitado desses créditos reforça a interpretação de que, em 1880, a assistência pública já se encontrava em um processo avançado de retração, funcionando mais como um mecanismo residual do que como uma política estruturada de assistência aos migrantes que ainda não haviam retornado aos seus locais de origem (Parahyba do Norte, Relatório, 03/09/1880, p. 8).

Ainda que esta dissertação se restrinja à seca de 1877–1879, com desdobramentos até 1880, não se pode ignorar que esse episódio contribuiu para a conformação de práticas e discursos que atravessaram as secas posteriores. Conforme aponta Lúcia de Fátima Guerra (1993, p. 31), ao longo do século XX a representação do Norte como espaço de “atraso, fome e miséria” foi reiteradamente usada para a obtenção de recursos federais, ao mesmo tempo em que alimentava disputas políticas em torno da produção agrícola e das assimetrias econômicas regionais.

A partir desse processo, os acontecimentos vivenciados durante a crise de 1877 se consolidam como discurso político e regional, mobilizado para a obtenção de recursos financeiros. Trata-se do que se pode denominar de um “discurso das oligarquias sobre a seca”, no qual a experiência da calamidade passa a ser instrumentalizada politicamente. Paralelamente, os estudos sobre as causas da seca e sobre as medidas de prevenção dos danos

sociais e econômicos eram acionados como argumento para a ampliação de investimentos estatais e para o fortalecimento do poder regional (Albuquerque Jr., 1988a, p. 262).

As reflexões de Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1988) ajudam a compreender como as elites nortistas se apropriaram da primeira seca que se converteu em um “problema nacional”, mobilizando-a em favor de reivindicações que atendiam, sobretudo, a seus próprios interesses.

Coube a esses grupos a tarefa de representar a população atingida, que, mais uma vez, foi colocada na condição de dominada, como sujeitos apresentados no discurso dessas elites “que devem ser protegidos, devem ser interpretados, [...]”, é necessário que se interpretem as suas dores e seus sofrimentos”, cabendo-lhes ainda a missão de “fazer chegar aos ouvidos do poder público os reclamos desta população desprotegida” (Albuquerque Jr., 1988, p. 269).

A partir dessa lógica, o discurso oligárquico sobre a seca estruturou-se a partir da ideia de que apenas as elites nortistas seriam capazes de compreender plenamente a dimensão do problema e, por isso, legitimadas a falar em nome da população atingida. Ao se colocarem como intérpretes exclusivos do sofrimento dos chamados “flagelados” e “indigentes” esses grupos assumiram para si a função de mediadores entre o povo e o poder público, convertendo a defesa dos interesses regionais em uma obrigação política e moral (Albuquerque Jr., 1988, p. 271).

Tal operação reforçava, ao mesmo tempo, a condição de subordinação dessa população e o protagonismo das elites na reivindicação de providências estatais, consolidando um modelo de representação que articulava dominação social, discurso humanitário e disputa por recursos (Albuquerque Jr., 1988, p. 271).

Como encerramento deste capítulo, os relatos e acontecimentos analisados permitem afirmar que as experiências vividas pela população migrante rompem com a interpretação da seca como um fenômeno restrito à ausência de chuvas ou as variações climáticas que atingiam o Norte do Brasil.

Por fim, é preciso evitar a leitura linear segundo a qual a sequência entre seca, retorno das chuvas e deslocamento de volta às localidades de origem implicaria, necessariamente, a recomposição da normalidade. O chamado “caminho de volta para casa” não se deu de forma homogênea nem pacífica. Envolveu mortes no percurso, permanências forçadas nas cidades, reinserções precárias em terras já empobrecidas e, em muitos casos, novos deslocamentos.

Para parte da população, o retorno significou apenas a transferência da precariedade para outros espaços igualmente frágeis. Assim, 1880 não marca o encerramento da crise, mas sua transformação — da calamidade visível da fome e das epidemias para a da calamidade

visível da fome e das epidemias para a transferência da responsabilidade aos próprios migrantes.

Ainda ressaltamos que conforme observado por Avohanne Araújo, os discursos e as ações governamentais frequentemente culpabilizavam a população migrante pela propagação das doenças, desviando a atenção das causas estruturais do problema. Em sua análise, conclui que “as ações governamentais [...] eram mais medidas paliativas e emergenciais do que políticas voltadas para uma atuação mais sistemática dos problemas de saúde e doença decorrente dos problemas alimentares e da fome” (Araújo, A., 2022, p. 248).

Ao afetar diferentes camadas sociais – das mais pobres às mais abastadas – e ao conduzir indivíduos a situações extremas de degradação humana, marcadas pela dependência da ajuda governamental e de terceiros, a fome e a desestruturação social revelam a seca como um fenômeno de natureza profundamente social. Trata-se, portanto, de uma experiência que ultrapassa o episódio climático imediato e cujos efeitos se projetam para além do século XIX, incidindo nos períodos posteriores até o tempo presente (Neves, 2000, p. 50).

Nessa mesma perspectiva, a seca pode ser compreendida também como um fenômeno político, na medida em que expõe os limites da ação estatal, tensiona as relações entre governantes e governados e transforma a assistência aos migrantes em objeto de disputas e controle social. Além disso, assume um caráter cultural, uma vez que as experiências dos sobreviventes produzem modos de interpretação e compreensão da vida social, da pobreza e da possibilidade de ação autônoma e consciente, construídos em situações de catástrofe que extrapolam o cotidiano (Neves, 2000, p. 99).

Não podemos deixar ainda mencionar que, ao longo da seca, observamos como as elites passaram a enquadrar os migrantes, desde os primeiros momentos, como uma “ameaça cotidiana”. Nesse registro, eles eram apresentados como responsáveis pela “desordem física, moral e social da cidade” (Mafalda, 1994, p. 37). Essa percepção, que se manteve até o término da crise, ajuda a compreender o apagamento progressivo do destino final dessa população.

Uma vez identificados como problema, deixava de importar a continuidade da assistência ou mesmo o acompanhamento de seus deslocamentos, das condições de alimentação, das perdas familiares ou da situação de seus bens materiais. O foco deslocava-se da sobrevivência dos migrantes para o controle de sua permanência nos espaços urbanos e para a contenção dos gastos públicos com obras, núcleos coloniais, hospitais, enfermarias emergenciais e outros auxílios.

Esse apagamento também se produziu de forma perceptível nas fontes oficiais. À medida que a crise avançava, os registros passaram a tratar o destino da população migrante

de maneira cada vez mais fragmentada, dispersa e pouco conclusiva. Informações sobre retornos, reassentamentos, mortes ou permanências deixaram de ser acompanhadas de forma sistemática, surgindo apenas de modo episódico, muitas vezes diluídas em relatórios administrativos ou locais voltados prioritariamente à prestação de contas das obras, dos gastos e das medidas de contenção.

Nos registros de 1880, esse silenciamento se torna ainda mais perceptível: o foco desloca-se do acompanhamento das trajetórias dessa população para a gestão dos espaços urbanos e para a racionalização dos socorros, contribuindo para que o desfecho dos migrantes permanecesse indefinido, quando não completamente ausente da documentação.

Os migrantes, que durante o período crítico ocupavam lugar central nas narrativas administrativas — com números, diagnósticos, listas de enfermos e relatórios detalhados sobre sua situação — passam, em 1880, a desaparecer progressivamente como sujeitos de cuidado. Quando reaparecem, já não são descritos em sua condição de vulnerabilidade, mas como “ociosos”, “indisciplinados” ou ameaça à ordem pública. Esse apagamento documental não indica a superação da crise social, mas uma mudança no enquadramento institucional: deixa-se de acompanhar suas trajetórias para enfatizar a necessidade de controle, normas de higiene, contenção de despesas e restauração da normalidade administrativa.

É a partir desse conjunto de questões que se encaminham as reflexões finais desta dissertação, voltadas a pensar os sentidos socioculturais e históricos da seca, da saúde e das doenças, bem como da assistência pública e da população migrante, no contexto da “Grande Seca” de 1877-1879 e de seu desdobramento imediato, em 1880, na Província da Parahyba do Norte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, buscou-se compreender como a saúde e as doenças no contexto da Seca de 1877-1879 foram tratadas pela historiografia e pela literatura, com atenção particular à província da Parahyba do Norte. O trabalho partiu do diálogo com diferentes vertentes interpretativas – técnicas, políticas e sociais – articulando produções consideradas clássicas com abordagens mais recentes, voltadas às dimensões socioculturais da seca e de seus impactos sobre as populações atingidas, em especial os migrantes.

A partir desse percurso, procurou-se contribuir para o campo historiográfico ao enfrentar questões que ainda apareciam de forma limitada nos estudos sobre a Parahyba e que emergiram do contato sistemático com a documentação. A análise de correspondências oficiais, relatórios administrativos, mapas de distribuição de gêneros e medicamentos, bem como registros de óbitos, permitiu observar a complexidade das experiências vividas durante a crise, afastando interpretações homogêneas tanto sobre o funcionamento da assistência quanto sobre a condição dos migrantes.

Além disso, a pesquisa demonstra que a Seca de 1877-1879 na Província da Parahyba do Norte não pode ser compreendida como um episódio climático circunscrito ao tempo da estiagem, mas como um processo histórico prolongado, cujos efeitos sociais, sanitários e políticos ultrapassaram o momento da falta de chuvas e se aprofundaram no pós-crise. A seca, longe de constituir apenas uma interrupção da normalidade, produziu transformações duradouras nas formas de administrar a população, reorganizar o espaço provincial e redefinir os limites da assistência pública.

Ao deslocar o olhar para a saúde e as doenças, esta dissertação contribui diretamente para o campo da História da Saúde e das Doenças ao demonstrar que o adoecimento não foi apenas consequência da fome e da precariedade alimentar, mas também instrumento de poder, administração e controle das populações em contexto de crise. A gestão das epidemias, a organização dos hospitais emergenciais, a distribuição de medicamentos e a aplicação de critérios morais no acesso aos socorros revelam que a assistência operou simultaneamente como mecanismo de cuidado e de controle. A saúde, nesse contexto, deixou de ser apenas questão médica para tornar-se eixo central na administração da crise e na condução das condutas consideradas aceitáveis.

Nesse processo, o conceito de migrante constituiu o principal eixo interpretativo da pesquisa. Ao longo da análise, o migrante deixou de ser compreendido apenas como vítima

da seca para ser analisado como sujeito histórico em circulação, cuja experiência foi atravessada por trabalho, adoecimento, disciplinamento e abandono. A mobilidade não aparece como efeito secundário da estiagem, mas como dimensão estruturante da crise, produzindo novos arranjos sociais, tensões urbanas e mecanismos de seleção que redefiniram quem poderia permanecer, circular ou ser assistido.

A investigação também evidencia que a seca produziu corpos vulnerabilizados, e não apenas corpos doentes. Entre 1877 e 1879, o migrante figurava como corpo enfermo, objeto de socorro e de intervenções médico-higienistas; já em 1880, com o encerramento progressivo das estruturas emergenciais, esse mesmo sujeito passa a ser enquadrado como corpo indesejado, associado à ociosidade, ao desvio e ao incômodo social.

O pós-seca, portanto, não representou o retorno à normalidade, mas o início de um novo ciclo marcado pela retração da assistência, pela moralização das experiências migratórias e pela transferência gradual da responsabilidade pela sobrevivência aos próprios indivíduos atingidos.

Ao acompanhar esse deslocamento, a pesquisa demonstra que o governo provincial oscilou entre assistência e controle. Se, no auge da crise, a abertura de créditos, a formação de núcleos coloniais e a criação de enfermarias emergenciais sinalizavam uma resposta humanitária, o ano de 1880 evidenciou a centralidade da contenção de despesas, da prestação de contas e da dissolução das estruturas de socorro. A reorganização administrativa não coincidiu com a superação da crise social, mas com sua reconfiguração.

O desaparecimento progressivo dos migrantes das fontes após 1879 não indica que suas trajetórias tenham sido concluídas ou que a crise tenha sido superada. Ao contrário, revela os limites documentais e as escolhas administrativas que deixaram de acompanhar essas vidas quando se encerravam os socorros. Reconhecer esse silêncio não constitui fragilidade analítica, mas consciência metodológica: quando as fontes deixam de registrar, também expressam as prioridades e omissões do poder público.

Dessa forma, esta dissertação contribui para a História Regional ao aprofundar a compreensão da experiência da Parahyba do Norte no contexto da “Grande Seca”, para a História Social das Secas ao evidenciar os mecanismos de mobilidade, trabalho e exclusão que estruturaram a crise, e para a História da Saúde e das Doenças ao demonstrar como o adoecimento foi incorporado às estratégias de administração das populações em situação de vulnerabilidade.

O estudo evidencia, por fim, a necessidade de novas investigações sobre as trajetórias daqueles que permaneceram fora dos registros oficiais, sobre as redes de solidariedade não institucionalizadas e sobre as formas de reinserção social no pós-seca. As análises aqui desenvolvidas demonstram que a seca de 1877-1879 extrapolou a condição de fenômeno puramente climático, configurando-se como processo profundamente social, atravessado por decisões políticas, econômicas e administrativas que redefiniram o cotidiano das diferentes regiões da província.

Ao desestruturar circuitos produtivos, intensificar deslocamentos populacionais e tensionar as instituições de assistência e saúde, a crise produziu efeitos que ultrapassaram o triênio da estiagem, projetando-se no pós-seca e servindo de referência para experiências posteriores. Compreendida como processo histórico, a seca permite não apenas revisitar o passado provincial, mas analisar como calamidade, migração, saúde, doença e poder se entrelaçam na produção de desigualdades sociais duradouras.

REFERÊNCIAS

ACERVO DIGITAL FAMILYSEARCH

PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA (Teixeira, PB). *Livro de óbitos (1867–1884)*. Imagens digitais. In: **Brasil, Paraíba, Registros da Igreja Católica, 1731–2016**. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8>. Acesso em: 17 set. 2025.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO (Pombal, PB). *Livro de óbitos (1879)*. Livro paroquial manuscrito. Imagens digitais. In: **Brasil, Paraíba, Registros da Igreja Católica, 1731–2016**. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P92-HN8>. Acesso em: 28 set. 2025.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE (Cajazeiras, PB). *Livro de óbitos (1867–1877)*. Livro paroquial manuscrito. Imagens digitais. In: **Brasil, Paraíba, Registros da Igreja Católica, 1731–2016**. FamilySearch. Disponível em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-253C-8B>. Acesso em: 30 set. 2025.

ACERVO DA HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL

<https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

JORNAIS

- A Opinião* (1877), n.º 65, 13/12/1877, p. 2.
- A Reforma* (RJ), n.º 264, 21/11/1877, p. 2.
- A Reforma* (RJ), n.º 122, 15/08/1877, p. 3.
- A Reforma* (RJ), n.º 98, 02/05/1878, p. 2.
- A Reforma* (RJ), n.º 199, 01/09/1878, p. 2.
- Echo Escolastico* (PB), n.º 8, 19/09/1877, p.1.
- Gazeta de Notícias* (RJ), n.º 325, 22/11/1882, p. 2.
- O Publicador* (PB), n.º 1304, 18/01/1867, p. 1.
- O Publicador* (PB), n.º 1511, 30/09/1867, p. 3.
- O Despertador* (PB), n.º 188, 24/11/1883, p. 4.

ARQUIVO HISTÓRICO WALDEMAR BISPO DUARTE – AHWBD

- Carta enviada pelo Juiz de Direito a pedido do Dr. Antonio de Sousa Nunes Pinto, em 26 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).
- Casa de Caridade da Villa de Cabaceiras aos 16 de dezembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Cidade da Parahyba do Norte em 29 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).
- Cidade da Parahyba, 1 de Novembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Cidade de Mamanguape, 20 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Cidade de Mamanguape, em 20 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Cidade de Pombal, 08 de agosto de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.
- Colônia do Amparo no Distrito da Jacoca em 5 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.
- Colônia do Mussuré. 15 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Colônia do Mussuré. 16 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.
- Colônia do Mussuré. 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Colônia Rio do Meio. 26 de setembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comarca de Cajazeiras em 01 de Novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Comarca de Souza, 17 de julho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Comarca de Souza. 13 de novembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Comissão Central de Socorros s/d. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão da Villa de Mamanguape em 28 de junho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

Comissão de Socorros da Cidade de Areia, em 26 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande em 21 de setembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande em 26 de janeiro de 1879 Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, em 8 de fevereiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros da Cidade de Campina Grande, em 8 de fevereiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros da Villa de Pilar em 04 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Comissão de Socorros de Araçagy, 24 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros de Independência, 29 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Comissão de Socorros Públicos da Cidade de Campina Grande, AHWBD, 20/02/1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Comissão de Socorros públicos na Povoação de Pitimbu em 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Comissão de Socorros, Cidade de Areia, 15 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Delegacia de Polícia da Capital em 11 de Dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Diretoria Geral de Socorros Públicos – Campina Grande, 22/04/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, AHWBD, 02/06/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, AHWBD, 10/06/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, em 10 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Enfermaria do Hospital dos Variolosos em S. Rita, em 2 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Enfermaria Provisória no Convento de S. Antonio em 4 de Maio de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Engenho Pão D'Arco, 02 de março de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Gabinete da Comissão Central de Socorros às Victimas da Seca na Parahyba, 8 de Outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Gabinete da Comissão Central de Socorros às victimas da Seca na Parahyba, 12 de setembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877, caixa 061 (A).

Gabinete da Comissão Central de Socorros as victimas da sêcca na Parahyba, 8 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1877, caixa 061 (A).

Gabinete da Comissão Central de Socorros da Parahyba do Norte, em 8 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Gabinete da Comissão Central de Socorros, em 30 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Hospital da Cruz do Peixe, em 12 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880, Caixa 063.

Hospital de Nossa Senhora das Neves em 12 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Hospital de Nossa Senhora das Neves em 17 de julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Hospital de Nossa Senhora das Neves, 24 de dezembro de 1878. N.º93. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde do Porto da Província da Parahyba, 01/06/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahiba, em 18 de maio de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 11 de dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 13 de Julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 13 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 20/11/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 23/11/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 24 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Inspetoria de Saúde Pública da Parahyba, 3 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Juiz Municipal do Termo de Souza em 11 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875-1878, caixa 061 (B).

Juiz Municipal do Termo de Souza em 17 de julho de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875-1878, caixa 061 (B).

Juizado de Direito da Comarca da Independência em 23 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Juizado de Direito da Comarca da Independência em 23 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Juízo de Direito da Comarca de Mamanguape, 28 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Lista dos gêneros alimentícios remetidos às diversas comissões de socorros do interior de 14 de março á 3 de abril. 05 de Abril de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Mappa demonstrativo do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe durante o mez de dezembro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Mappa demonstrativo do movimento geral da Enfermaria de Santo Antônio desde o 1º de abril de 1878, data de sua instalação, até o último de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de janeiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de março de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Mappa do movimento dos doentes do Hospital da Cruz do Peixe no mez de abril de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Mappa dos enfermos existentes no hospital desta cidade. Areia, 22 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Ministério dos Negócios do Império, Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Ministério dos Negócios do Império. Directoria N.º 1043. Rio de Janeiro, em 11 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita de 15 de agosto do anno passado a 30 de junho do corrente anno. Tibiry, junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Movimento do Hospital de Variolosos da Freguesia de Santa Rita, AHWBD, 06/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Officio do Sítio Alagoa, 22/10/1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Officio enviado pelo padre Lindolfo Correia das Neves. 23 de Julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Officio n.º674, da Santa Casa da Misericórdia enviado ao presidente da província Dr. Esmerino Gomes Parente, 10/07/1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Officio N.º 1358. 17 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Officio n.º 1438, Palácio da Presidência, AHWBD, 27/08/1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Officio N.º 467- Informe a Repartição de Socorros. Palacio da Presidência 1º de Março de 1879. Comissão de Socorros Públicos da povoação de Água Doce da Comarca de Ingá 1º de Março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Officio n.º57, Paço da Camara Municipal da Capital da Parahyba, em sessão extraordinária de 19 de janeiro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Officio, 15/05/1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Oficio da Comarca de Bananeiras, em 6 de abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Oficio n.º 782, Diretoria do Ministério dos Negócios do Império. Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Paço da Câmara Municipal da Cidade de Areia em 07 de junho de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras em Sessão Ordinária, 10 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Paço da Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras em Sessão Ordinária, 30 de Outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Paço da Câmara Municipal da Villa de Bananeiras em Sessão Ordinária de 26 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Paço da Câmara Municipal da Villa de Patos em Sessão Extraordinária, 28 de Abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Pagadoria dos Trabalhadores Retirantes na Capital da Parahyba. 24 de setembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Parahyba do Norte - Thesouraria da Fazenda, em 5 de abril de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Parahyba do Norte, Hospital da Cruz do Peixe, 25 de fevereiro de 1880. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1880/1881, Caixa 063.

Parahyba, 22 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Pedido de medicamentos para os doentes na Enfermaria de Variolosos na Povoação de Santa Rita e em outros doentes desvalidos na mesma povoação. Santa Rita, 2 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação das pessoas residentes n'esta Capital, que se dignaram, accendendo ao pedido da Comissão Central de Socorros as victimas da secca, subscrever para de alguma forma minorar os rigores da fome e da nudês de que se acham presos milhares de infelizes no interior da Província, em consequencia da desastrada secca que a flagela. 15 de outubro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Relação do Hospital da Cidade de Areia em 26 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação dos empregados da Enfermaria de S. Antônio, 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Relação dos empregados do Hospital de N. S. das Neves, em 30 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação dos medicamentos pedidos pela comissão de socorros públicos de Pitimbu, para o curativo dos enfermos desvalidos – Homeopathicos - 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação dos remédios allopathicos requisitados pela Comissão de Socorros Públicos de Pitimbú para o tratamento dos enfermos desvalidos - 15 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação dos Trabalhadores restantes empregados nas divisas da entrada de Varzea Nova a S. Bento, a contar de 20 a 27 julho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relação dos Trabalhadores Retirantes Empregados em Obras Públicas – Estrada de Tambaú – 1ª Turma, 8 de Janeiro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relatório apresentado pela Comissão de Socorros da Villa do Teixeira ao Ilmo Exmo Sr. Dr. José Rodrigues Pereira Junior - Presidente desta Província, em 15 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Relatório da Secretaria do Hospital de S. Pedro em Mamanguape, no ano de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 10 de outubro de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 24 de março de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Repartição de Socorros Públicos da Parahyba, 26 de dezembro de 1878. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

Repartição de Socorros Públicos Parahyba. 15 de Maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

Sala das reuniões das comissões de socorros de Mamanguape, 26 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Capital da Parahyba em 18 de dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte. Ano: 1875-1878, Caixa 061 (B).

Secretaria do Hospital de S. Pedro - Relação dos órfãos e outras pessoas válidas no Hospital da Cidade de Mamanguape, no dia 7 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Secretaria do Hospital de S. Pedro, em Mamanguape, 23 de abril de 1879 - Lista das pessoas desamparadas, que comem no Hospital S. Pedro na Cidade de Mamanguape. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Secretaria do Hospital de São Pedro em Mamanguape, 28 de junho de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Subdelegacia de Polícia do Districto da Povoação de Bodocongó em 29 de abril de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Subdelegacia do 2º distrito da Capital da Parahyba, 20 de dezembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Thesouraria da Fazenda da Parahyba, 20 de junho de 1879 - Relação das pessoas que percebem gratificação pela verba Socorros Públicos. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Trabalhadores Retirantes Empregados em Obras Públicas na Parahyba do Norte (1879). Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062

Vila de Bananeiras, em 25 de maio de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Villa de Patos, abril de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (A).

Villa de Pedras de Fogo. 22 de agosto de 1879. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1879, Caixa 062.

Villa de S. João, 29 de novembro de 1877. Arquivo Histórico Waldemar Bispo Duarte (AHWBD). Ano: 1875/1878, Caixa 061 (B).

COLEÇÃO DAS LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL DE 1862

Brasil, Coleção de Leis do Império do., 11 de setembro de 1862. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/items/058762a4-7845-4f20-b23c-8645a32a87c7>. Acesso em 2 dez. 2024.

FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO (FCJA)

O Publicador (PB), 11/06/1879.

JORNAIS E FOLHETINS LITERÁRIOS DA PARAÍBA NO SÉCULO 19

<https://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/diversos.html>

JORNAIS

O Liberal Parahybano (PB), 02/08/1879, n.º 37, p. 2. Disponível em: Acesso em: 25 de ago. 2023.

<https://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/oliberalparahybano1879.html>

O Liberal Parahybano (PB), 05/08/1879, n.º 38, p. 2. Disponível em:

<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=704989&Pesq=retirante&pagfis=56>. Acesso em: 30 de jul. 2025.

O Liberal Parahybano (PB), 09/08/1879, n.º 39, p. 1. Disponível em:

<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=704989&Pesq=retirante&pagfis=56>. Acesso em: 30 de jul. 2025.

O Liberal Parahybano (PB), 26/08/1879, n.º 45, p. 3. Disponível em:

<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=704989&Pesq=retirante&pagfis=56>. Acesso em: 30 de jul. 2025.

MAPAS

ALMEIDA, Candido Mendes de. **Atlas do Império do Brasil**. Instituto Philomathico, 1868. Adaptado por nós para destacar as mesorregiões da Parahyba do Norte.

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL – NDIHR

A Opinião 1877, n.º 60, 25/11/1877, p. 4.

PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL

<https://bd.camara.leg.br/bd/items/d5107902-a992-4ba9-b652-eeb666357517>

ANAIS DO PARLAMENTO BRAZILEIRO

BRASIL. **Anais do Parlamento Brasileiro:** Câmara dos Srs. Deputados. Primeiro anno da décima-sétima legislatura: sessão de 1878. Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879.

BRASIL. **Anais do Parlamento Brasileiro:** Câmara dos Srs. Deputados. Primeiro anno da décima-sétima legislatura, sessão de 1878. Tomo IV. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1879.

BRASIL. **Annaes do Parlamento Brasileiro:** Câmara dos Srs. Deputados. Segundo anno da décima-sexta legislatura. Sessão de 1877. Tomo II. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. de Villeneuve & C., 1877.

REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES

<https://www.crl.edu/>

Relatórios de Presidente de Província da Parahyba

PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. 2o. Vice-Presidente Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão passou a administração desta Província ao 1o. Vice-Presidente Dr. Antonio Alfredo de Gama e Mello no dia 15 de maio de 1880.

PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. Dr. José Rodrigues Ferreira Junior passou a administração desta Província ao Exm. Sr. Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão - 2o. Vice-Presidente em 30 de abril de 1880.

PARAHYBA DO NORTE, Exposição com que o Exm. Sr. presidente Dr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva, passou a administração da província da Parahyba do Norte ao 2.º vice-presidente padre Francisco Pinto Pessoa em 9 de abril de 1869. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º20, 1869.

PARAHYBA DO NORTE, Exposição feita pelo Exm. Sr. presidente da provincia da Parahyba do Norte Dr. Venancio José d'Oliveira Lisbôa ao passar a administração da mesma ao Exm. Senhor senador Frederico de Almeida e Albuquerque em 24 de outubro de 1870. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1870.

PARAHYBA DO NORTE, Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. 3o. vice-presidente da provincia, Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 16 de outubro de 1871. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1871.

PARAHYBA DO NORTE, Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. 3o. vice-presidente da provincia, Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 7 de junho de 1872. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1872.

PARAHYBA DO NORTE, Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. presidente da provincia, Dr. Francisco Teixeira de Sá, em 6 de setembro de 1873. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1873.

PARAHYBA DO NORTE, Inspectoria da Saúde Publica da Parahyba, Anexo B, 1 de Setembro de 1875. In: Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da provincia da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 9 de outubro de 1875. Typ. do Jornal da Parahyba - Rua da Matriz, n. 4, 1875.

PARAHYBA DO NORTE, Officio com que o Exm. Sr. vice-presidente Dr. José Paulino Figueiredo passou a administração da provincia ao Exm. Sr. Dr. Ulysses Machado Pereira Vianna no dia 11 de março de 1878.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da provincia da Parahyba do Norte pelo presidente, Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, em 7 de agosto de 1874. Typ. do Jornal da Parahyba - Rua da Matriz, n. 4, 1874.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da provincia da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 9 de outubro de 1875. Typ. do Jornal da Parahyba - Rua da Matriz, n. 4, 1875.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da provincia da Parahyba do Norte pelo presidente, Exm. Sr. senador Barão de Mamanguape, em 21 de maio de 1876. Typ. do Jornal da Parahyba - Rua da Matriz, n. 4, 1876.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da Provincia da Parahyba do Norte pelo presidente Exm. Sr. Doutor Esmerino Gomes Parente, em 12 de agosto de 1877. Typ. Liberal Parahybana, - Rua Visconde de Inhaúma n. 12, 1878.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial da provincia da Parahyba do Norte pelo presidente, Exm. Sr. Doutor Ulysses Machado Pereira Vianna, em 1o. de janeiro de 1879. Typ. Liberal Parahybana - Rua Duque de Caxias n. 85, 1879.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório apresentado à Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte, no dia 31 de maio de 1862, pelo presidente, Dr. Francisco d'Araujo Lima. p. 67. Tipografia de José Rodrigues da Costa, Rua Direita N.º 20, 1862.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado pelo Illm. e Exm. Sr. Doutor Greogorio José d'Oliveira Costa Junior presidente d'esta provincia ao primeiro vice-presidente Bacharel Antonio Alfredo da Gama e Mello em 3 de setembro de 1880.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo excellentissimo presidente da provincia, o dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, em 2 de agosto de 1851. Tipografia José Rodrigues da Costa, 1851.

PARAHYBA DO NORTE, Relatorio com o que o Exm. Sr. 2o. Presidente Padre Felipe Benicio da Fonseca Galvão passou a administração d'esta provincia ao Exm. Sr. Doutor

José Rodrigues Pereira Junior em 12 de junho de 1879. Typ. Liberal Parahybana - Rua Duque de Caxias n. 85, 1879.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório com o que o Exm. Sr. Dr. José Paulino Gomes de Figueiredo, 1o. Vice-presidente, passou a administração da província da Parahyba ao Exm. Sr. Dr. Esmerino Gomes Parente no dia 24 de abril de 1877. Typ. do Jornal da Parahyba, - Rua Visconde de Pelotas n. 10, 1877.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Esmerino Gomes Parente passou a administração da província ao 1o. vice-presidente, Dr. José Paulino de Figueiredo, em 1 de março de 1878. Typ. Liberal Parahybana - Rua Visconde de Inhaúma n. 12, 1878.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório com que S. Exc. o Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, 1o. vice-presidente, passou a administração da província da Parahyba do Norte ao Exm. Sr. Dr. Venancio José de Oliveira Lisboa em 11 de junho de 1869. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º20, 1869.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório da Inspeção de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo H, 12 de agosto de 1869. In: Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte no dia 2 de outubro de 1869 pelo Exmo. Presidente Dr. Venancio José de Oliveira Lisboa. Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita n.º20, 1869.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório da Inspeção de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo II, 13 de junho de 1871. In: Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. 3o. vice-presidente da província, Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa em 16 de outubro de 1871. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1871.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório da Inspeção de Saúde Pública da Parahyba do Norte, Anexo II, 1 de agosto de 1873. In: Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Exm. Sr. presidente da província, Dr. Francisco Teixeira de Sá, em 6 de setembro de 1873. Typ. Conservadora. Rua do Visconde de Pelotas n. 24, 1873.

PARAHYBA DO NORTE, Relatório... Barão de Mamanguape – 9 de janeiro de 1877. 1877. Relatório anual apresentado à Assembleia Legislativa da Província da Parahyba do Norte. Typ. do Jornal da Parahyba, - Rua Visconde de Pelotas n. 10, 1877.

Bibliografia

AGUIAR JÚNIOR, Fernando Domingos de. **Imagens da doença, políticas da notícia:** Cenários e representações da aids na imprensa paraibana (1980). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9568?locale=pt_BR. Acesso em: 15 de jun. de 2025.

AGUIAR, Wellington. **A velha Paraíba nas páginas de jornais.** João Pessoa: A União, 1999.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A Invenção do nordeste e outras artes**. São Paulo: Cortez, 2011.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **Falas de astúcia e de angústia: A seca no imaginário nordestino- de problema a solução (1877-1922)**. 1988. 449 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade de Campinas, 1988.

ALEXANDRE, Jucieldo Ferreira. **Quando o anjo do extermínio se aproxima de nós: representações sobre o cólera no semanário cratense O Araripe (1855-1864)**. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2010a. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6019?locale=pt_BR. Acesso em: 3 maio de 2025.

ALEXANDRE, Jucieldo Ferreira. **A peste serve a qual partido? Disputas políticas e epidemia do Cólera (Ceará, 1862-1863)**. Niterói: Eduff – Editora da Universidade Federal Fluminense, 2024b.

ALMEIDA, Elpídio. **História de Campina Grande**. Campina Grande: [s.n.], 1962.

ALMEIDA, Horácio de. **Brejo de Areia: Memórias de um Município**. Publicação do Ministério da Educação e Cultura - Serviço de Documentação. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1958a.

ALMEIDA, Horácio de. **História da Paraíba**. Editora Universitária/UFPB, João Pessoa. v. 2, 1978b.

ALMEIDA, José Américo de. **A Paraíba e Seus Problemas**. Brasília: Senado Federal, 2012 [1923].

ALMEIDA, Maurílio Augusto de. **Presença de D. Pedro II na Paraíba**. 2. ed. Petrópolis, Vozes, 1982 [1975].

ALVES, Gerlane Farias. **A administração da loucura: a Santa Casa da Parahyba do Norte no tratamento dos alienados (1858-1892)**. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13219?locale=pt_BR. Acesso em: 4 de jan. de 2026.

ARAÚJO, Avohanne Isabelle Costa de. **Alimentação, saúde e doenças carenciais em períodos de seca nos Sertões do Rio Grande do Norte (1877-1935)**. 2022. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://arca.fiocruz.br/items/fd73f59b-be7c-4655-847a-100b010e7c03>. Acesso em: 8 de jun. de 2025.

ARAÚJO, Maria Mafalda Balduino de. **Cotidiano e pobreza: impasse da sobrevivência em Teresina**. 1994. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

ARAÚJO, Rafael Nóbrega. **O “terrível flagello da humanidade”: os discursos médico-higienistas no combate à sífilis na Paraíba (1921–1940)**. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Campina Grande, 2020. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/12461>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BARBALHO, Alexandre Almeida. **Corpos e mentes dilacerados: o grotesco nas imagens da seca de 1877. Trajetos Revista de História UFC**, Fortaleza, v. 3, n. 6, p. 139-150, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/19985>. Acesso em: 29 maio 2025.

BARBEIRO, Alan. Prefácio. In: ERTZOGUE, M. H.; PARENTE, T. G. **História e sensibilidade**. Brasília: Paralelo 15, 2006. p. 11- 16.

BARBOSA, Janyne P. P .L. **Uma guerra sangrenta, epidêmica e doente: espaços de cura e cotidiano médico na guerra do Paraguai (1864 – 1870)**. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/11899?locale=pt_BR. Acesso em: 3 de maio de 2025.

BARBOSA, Socorro de Fátima Pacífico (org). **Pequeno dicionário dos escritores / jornalistas da Paraíba do século XIX**: de Antonio da Fonseca a Assis Chateaubriand. João Pessoa, 2009. Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/jornaise folhetins/>.

BARROS, José D’Assunção. **O campo da história: especialidades e abordagens**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

BARROS, S. P. A. Graciliano Fontino Lordão: um professor ‘de côr’ na Parahyba do Norte. **Revista Brasileira de História da Educação**, v. 18, p. e033, 2 out. 2018. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/article/view/44836>. Acesso em: 14 de out. de 2025.

BAPTISTA, M. P. de C., & NASCIMENTO, F. de A. de S. (2025). “A epidemia accommetteu a povoação de Amarração”: Febres intermitentes/palustres e seus efeitos no litoral leste do Ceará na divisa com o Piauí em 1872. **Cordis: Revista Eletrônica De História Social Da Cidade**, v. 34, <https://doi.org/10.23925/2176-4174.34.2025e68932>. Acesso em: 30 nov. 2025.

BELTRÃO, Jane Felipe. A arte de curar em tempo de cólera.. ou o uso da Homeopatia durante o flagelo – Grão-Pará, século XIX. **Revista da SBHC**, n. 18, p. 17-38, 1997.

BRASIL. IBGE, **Recenseamento do Brasil em 1872**, Rio de Janeiro: Typographia G. Leuzinger, s.d. [prov. 1874]. Parahyba, p. 115. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=225477>. Acesso em: 2 jul. 2025.

BRASIL, Rayane de Lima. **Tudo é Consternação, Miséria e Desespero: Seca e Doenças na Província da Parahyba na Década de 1870**. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal da Paraíba (UFPB). João Pessoa, 2023.

BRASIL, Rayane; MARIANO, Serioja R.C. A Saúde e as Doenças da População Escravizada nos anúncios de jornais da Paraíba (1850-1869). In: **XX Encontro Estadual de História: Independência, Revoluções e Modernismos**. João Pessoa: Editora do CCTA, 2022. v. 1. p. 767-776.

BRASIL, R. L.; MARIANO, S. R. C. *Em todas as ruas veem-se cadáveres ambulantes e nus sem forças para implorarem uma esmola (...). a morte tem arrebatado muitas vidas: Doenças na Parahyba no Contexto da Seca de 1877-1879*. **Revista Espacialidades**, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 704–720, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/espacialidades/article/view/38462>. Acesso em: 19 jun. 2025.

BURGUIÈRE, André. A demografia. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. **História**. Novas Abordagens. Tradução de Henrique Mesquita. Rio de Janeiro: F. Alves, 1995, p.59-82.

BURITY, Luiz Mário Dantas. **José Américo de Almeida: da infância no Engenho Olho d'Água à campanha presidencial de 1937**. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.unirio.br/cchs/ppgh/producao-academica/teses-de-doutorado-e-egressos-pasta/jose-americo-de-almeida-da-infancia-no-engenho-olho-d2019agua-a-campanha-presidencial-de-1937>. Acesso em: Acesso em: 2 jul. 2025.

BURKE, Peter. **O que é História Cultural?** Trad. Sérgio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.

CAMPOS, José Nilson B. Secas e políticas públicas no semiárido: ideias, pensadores e períodos. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 28, n. 82, p. 65–88, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/ChKDycNnwbM7ZFqMNH8wDjk/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

CÂNDIDO, Tyrone Apollo Pontes. **Proletários das secas: arranjos e desarranjos nas fronteiras do trabalho (1877-1919)**. 2014. 354f. – Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em História Social, Fortaleza (CE), 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8993>. Acesso em: 11 de abr. de 2025.

CARDOSO, Ciro F. e BRIGNOLI, Héctor P. História demográfica. In: CARDOSO, Ciro F. e BRIGNOLI, Héctor P. **Os métodos da História**. Tradução João Maia. 6 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 107-203.

CARVALHO, D. M. O regimento contra a pestilência e a receita do bálsamo: alguns comentários à luz da ‘medicina científica’. História, Ciências, Saúde – **Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 853–867, set.–dez. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/wZKkRD6WgdCnTtTWN7p8gKn/?format=pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CARVALHO, José Murilo de. **A construção da ordem: a elite política imperial**. Teatro de sombras: a política imperial. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

CARVALHO, José Murilo de. Introdução. In: Congresso Agrícola do Rio de Janeiro (1878). **Anais do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1878. p. v-ix.

CASCUDO, Luís da Câmara. **História da alimentação no Brasil**. vol.1. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967.

CASTRO, Oscar Oliveira. **Medicina na Paraíba: flagrantos de sua evolução**. João Pessoa: A União, 1945.

CASTRO, Josué de. **Geografia da fome: o dilema brasileiro – pão ou aço**. Rio de Janeiro: Edições Antares, 1984. (Clássicos das Ciências Sociais no Brasil).

CERTEAU, Michel de. **A escrita da história**. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

CHALHOUB, Sidney. **Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte imperial**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

CHARTIER, Roger. **A História Cultural: entre práticas e representações**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil / Lisboa: Difel, 1990a.

CHARTIER, Roger. **A história ou a leitura do tempo**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009b.

COELHO FILHO, H.A. epidemia de cólera morbo na Paraíba em 1856. **Revista Medicina**, n. 19 e 20, 1959, p. 29-34.

COSTA, I. D. N. **Demografia histórica: algumas observações**. *Sæculum - Revista de História*, [S. l.], n. 24, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/view/12443>. Acesso em: 6 jul. 2025.

CURY, Claudia Engler; FLORES, Élio Chaves; CORDEIRO JÚNIOR, Raimundo Barroso. (Org.). **Cultura Histórica e Historiografia: legados e contribuições do século 20**. 1ªed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2010.

DAVIS, Mike. **Holocaustos coloniais: clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo**. Rio de Janeiro: Record. 2002.,

DIAS, Margarida Maria dos Santos. **Intrépida ab origine: o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a produção da História local**. João Pessoa: Almeida Gráfica e Editora LTDA, 1996.

DÔSO, Milena de Farias. **O cotidiano da morte nas freguesias de Cabaceiras e São João do Cariri - PB (1856)**. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30972?locale=pt_BR. Acesso em: 15 de jun. de 2025.

EUGÊNIO, Alisson. **Lágrimas de sangue: a saúde dos escravos no Brasil da época de Palmares à Abolição**. São Paulo: Alameda, 2016.

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA. **Livro de Theses da Faculdade de Medicina da Bahia (1836–1888)**. Bahia: Typographia Carlos Poggetti, 1858. Disponível em:

https://www.academia.edu/121214077/Livro_de_Theses_da_Faculdade_de_Medicina_da_Bahia_vol_1_1_8_3_6_a_1_8_8_8_e_di%C3%A7%C3%A3o_semidiplom%C3%A1tica_descri%C3%A7%C3%A3o_e_coment%C3%A1rios. Acesso em: 12 dez. 2025.

FERNANDES, Irene R. S. A economia paraibana na fase do isolamento relativo (1585-1930). In: FERNANDES, Irene Rodrigues da Silva. BARACUHY, Laura Helena. **Atividades produtivas na Paraíba**. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 1999, p. 21-48.

FERNANDES, João Nepomuceno Dias. **Os dous pontos das sciencias accessories e cirúrgicas e algumas proposições relativamente ao ponto das sciencias médicas**. 1850. Tese (Doutorado em Medicina) – Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Typographia de F. A. de Almeida, 1880.

FERNANDES, Ocione do Nascimento. Entre a Geografia e a História: **Um olhar sobre a obra de Irineu Joffily**. In: SÁ, Ariane Norma de Menezes & MARIANO, Serioja. (org.). **Histórias da Paraíba: autores e análises historiográficas sobre o século XIX**. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2003.

FERREIRA, Lúcia de Fátima G. **Estrutura de poder e seca na Paraíba (1877-1922)**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Pernambuco, 1982.

FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. **Raízes da indústria da seca: o caso da Paraíba**. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1993.

FERREIRA, Mauricio dos Santos; TRAVERSINI, Clarice Salete. A análise foucaultiana do discurso como ferramenta metodológica de pesquisa. **Educ. Real.**, Porto Alegre, v.38, n. 01, p. 207-226, março 2013. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010031432013000100012&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 26 Jan. 2026.

CHALHOUB, Sidney. **Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte imperial**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

CHERNOVIZ, Pedro Luiz Napoleão. **Dicionário de medicina popular**. 6. ed. Paris: A. Roger & F.Chernoviz, 1890.

FLORES, E. . C. . Dos feitos e dos ditos: História e Cultura Histórica. **Saeculum**, [S. l.], n. 16, 2007 .Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11374>. Acesso em: 2 ago. 2024

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. **A arte de curar: cirurgiões, médicos, boticários e curandeiros no século XIX em Minas Gerais**. Rio de Janeiro. Vício de Leitura, 2002.

FOUCAULT, Michel. **O nascimento da medicina social**. In: Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 1. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979a. p. 79–98.

FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In: **Historia da Sexualidade I: a vontade de saber**. 7. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988b.

FOUCAULT, Michel. **Em defesa da sociedade**. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999c.

FRANCO, Sebastião Pimentel. **O terrívelíssimo mal do Oriente: o cólera na província do Espírito Santo (1855-1856)**. Vitória: EDUFES, 2015.

FREIRE, Maria de Deus Santos. **Educação moral e religiosa na Paraíba Oitocentista: o livro Imitação de Cristo (1864)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Federal da Paraíba, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25669>. Acesso em: 17 dez. de 2025.

GALLIZA, Diana Soares de. **O declínio da escravidão na Paraíba 1850-1888**. João Pessoa, Editora universitária/UFPB, 1979.

GARCIA, Ana Karine Martins. **A sombra da pobreza na cidade do sol: o ordenamento dos retirantes em Fortaleza na segunda metade do século XIX**. São Paulo, 2006a, 208f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Estudos de Pós-Graduação em História Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006a. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_c5b2f9ffa8df98283dac2860f7e66cf9. Acesso em: 5 de jan. de 2025.

GARCIA, Ana Karine Martins. **A ciência na saúde e na doença: atuação e prática dos médicos em Fortaleza (1900-1935)**. 2011. Tese (Doutorado em História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011b.

GARCIA, Ana Karine Martins. Em tempos de seca: as intervenções higiênicas e as questões de saúde em Fortaleza (1877-1879). **História e Culturas**, Fortaleza, v. 2, n. 4, 31 dez. 2014c. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revistahistoriaculturas/article/view/383>. Acesso em: 24 Jan. 2026.

GAREIS, Maria da Guia Santos. O grito da elite agrária nordestina: realidade ou mito?. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, [S. l.], n. 9, p. 49–63, 1993. DOI: 10.37370/raizes.1993.v.538. Disponível em: <https://raizes.revistas.ufcg.edu.br/index.php/raizes/article/view/538>. Acesso em: 20 out. 2026.

GODOY SILVEIRA, R. M. . A Cultura Histórica em representações sobre territorialidades. **Saeculum**, [S. l.], n. 16, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11370>. Acesso em: 16 ago. 2024.

GUERRA, Felipe, GUERRA, Teófilo. **Secas Contra a Seca**. 3ª ed. Coleção Mossoroense, vol. XXIX, Brasília, Centro Gráfico do Senado Federal, 1980.

GUIMARÃES, Matheus Silveira. **Diáspora Africana na Paraíba do Norte: trabalho, tráfico e sociabilidades na primeira metade do século XIX**. Dissertação (Mestrado em História), PPGH/UFPB, João Pessoa, 2015. Disponível em: https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3393703. Acesso em: 2 jul. 2025.

HELLER, Agnes. **O cotidiano e a história**. 11º ed. São Paulo / Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

JOFFILY, Irenêo. **Notas sobre a Parahyba**. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio de Rodrigues & C., 1892.

JUNQUEIRA, Helmara Giccelli F. Wanderley. **Doidos[as] e Doutores: A medicalização da loucura na Província/Estado da Parahyba do Norte 1830-1930**. 2016.Tese. (Doutorado em História).PPGH, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/314>. Acesso em: 15 de jun. de 2025.

KODAMA, Kaori. Antiescravidão e epidemia:" O tráfico dos negros considerado como a causa da febre amarela", de Mathieu François Maxime Audouard, e o Rio de Janeiro em 1850. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 16, p. 515-520, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/xfD7m46j3S348md86hpKhjj/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

KUSWETTER, A.A.S. Parecer sobre a agricultura de Pernambuco oferecido ao Congresso pelo Revmº Cônego Augusto Adolpho Soares Kuswetter. In: **Trabalhos do Congresso Agrícola do Recife**, 1878. Edição Fac-Similar reproduzida do original publicado em 1879 pela Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco. p. 237-243.

LE GOFF, Jacques (org). **As Doenças têm história**. Lisboa: Terramar, 1982a.

LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. Tradução Bernardo Leitão; 5ª edição; Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp, 2003b.

LIMA, Danielle Ventura Bandeira de. **A caridade segundo Ibiapina: história e imaginário na Casa de Santa Fé**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência das Religiões) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/4175?locale=pt_BR. Acesso em: 10 de dez. de 2025.

LIMA, Guaraciane Mendonça de. **O Collegio de Educandos Artífices 1865-1874: a infância desvalida da Parahyba do Norte**. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6031>. Acesso em: 3 jun. 2025.

LIMA, Luciano Mendonça de. **Quebra-Quilos: uma revolta popular na periferia do Império**. In: DANTAS, Monica Duarte (org.). *Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX*. São Paulo: Alameda, p. 449-483, 2011.

LIMA E MOURA, Francisco Coutinho de. *A Seca de 1877 na Capital*. In: AGUIAR, Wellington; MELO, José Octávio de (Org.). **Uma cidade de quatro séculos**. João Pessoa: Governo do Estado da Paraíba, 1985. p. 77-79.

LUCA, Tânia Regina de. *História dos, nos e por meio dos periódicos*. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org^a). **Fontes Históricas**. São Paulo: Contexto, 2008. p. 111-153.

MACÊDO, Daniel. *Entre retirantes e flagelados:: palavras e significações dos sertanejos migrantes em testemunhos da seca de 1877 no Ceará*. **Dispositiva**, Belo Horizonte, v. 13, n. 24, p. 101–120, 2024. DOI: 10.5752/P.2237-9967.2024v13n24p101-120. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/dispositiva/article/view/P.2237-9967.2024v13n24p101-120>. Acesso em: 14 jan. 2026.

MAIA, Doralice Sátyro. *Habitação popular e o processo de periferização e de fragmentação urbana: uma análise sobre as cidades de João Pessoa – PB e Campina Grande – PB*. In: **Anais do XV Encontro Nacional da ANPUH**. ANPUH: Recife, 2014.

MAIA, Janille Campos. **O cortejo da moléstia: varíola, seca e assistência à saúde no Ceará (1877-1913).** 2022. Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://arca.fiocruz.br/items>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MARANDOLA JR, Eduardo; DAL GALLO, Priscila Marchiori. Ser migrante: implicações territoriais e existenciais da migração. **Revista brasileira de estudos de População**, v. 27, p. 407-424, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepop/a/rzmFzZWXRmZVHZhFGWSR6wn/?lang=pt&format=html> Acesso em: 30 jun. 2025.

MARIANO, Nayana R.C. **Educação pela higiene: a invenção de um modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte (1849-1886).** João Pessoa: Ideia, 2015.

MARIANO, Serioja; MARIANO, Nayana. **Oh! Da Polícia, e da Câmara Municipal, Alerta!** A homeopatia na Província da Parahyba em tempos de epidemias (1850-1860). In: MIRANDA, Carlos A.; MARIANO, Serioja R. C (orgs). **Saúde e sociedade no Brasil: uma perspectiva histórica.** Recife: Ed. UFPE, 2022. v. 1. P.236-263.

MARIANO, Serioja; MARIANO, Nayana. O MEDO ANUNCIADO: A FEBRE AMARELA E O CÓLERA NA PROVÍNCIA DA PARAÍBA (1850-1860) . **Fênix - Revista de História e Estudos Culturais**, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 1–20, 2012. Disponível em: <https://www.revistafenix.pro.br/revistafenix/article/view/415>. Acesso em: 01 ago. 2024.

MARIANO, Serioja R. C. Em favor da hygiene publica, da polícia sanitária e do bem geral: as medidas de combate à varíola na Parahyba no século XIX. **ANPUH-BRASIL: 30º Simpósio Nacional de História**, 2019a.

MARIANO, Serioja R. C. Conselhos do Curandeiro Prático - Para o Bem da Humanidade: a varíola na Província da Parahyba nas Décadas de 1870-1890. In: BATISTA, Ricardo dos Santos; SOARES JÚNIOR, Azemar dos Santos (org.). **História, saúde e doença no Nordeste do Brasil.** Natal: EDUFRN, 2022c. p.180-194.

MARIANO, S. R. C. Não há mais grave, mais perigosa, e mais temível: a sífilis na Província da Parahyba (1860-1880). **Saeculum**, [S. l.], v. 25, n. 43 (jul./dez.), p. 263–279, 2020b. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/srh/article/view/53080>. Acesso em: 7 jun. 2024.

MARIANO, Serioja R. C.; BRASIL, Rayane de Lima. Peste, Fome e Miséria: Doenças na Parahyba do Norte Durante a Seca de 1877-1879. In: CASTRO, Tatiana C.; FARIAS, Ana

Elizabete M.; SILVA, Maria Larisse E. (Org.). **Pesquisa histórica em perspectiva: cultura, sociedade e política**. 1ª ed. Campina Grande/PB: Amplla Editora, 2023, v. 01, p. 58-74.

MARIZ, Celso. **Apanhados Históricos da Paraíba**. 2º Ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1980b.

MARIZ, Celso. **Evolução econômica da Paraíba**. 2ª edição. João Pessoa: A União, 1978a.

MARIZ, Celso. **Memória da Assembleia Legislativa**. João Pessoa: A União, 1987c.

MAROJA, Flávio. Nossa hygiene. Considerações gerais. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba**, João Pessoa, v.03, p. 431-437, 1911.

MARTINS, Nereida Soares. **Santa Casa dos mortos: ritos fúnebres, mortalidade e relações de poder na Paraíba oitocentista**. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-Graduação em História, Recife, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/314>. Acesso em: 16 de dez. de 2025.

MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; PRESTES, Maria Elice de Brzezinski. **Dos miasmas ao vírus: o conhecimento sobre as epidemias ao longo da história**. In: CERQUEIRA, Fábio Vergara; AXT, Gunter; FERREIRA, Renata Brauner (org.). Viver e morrer na peste: Epidemia na história. Vol. 1. Pelotas: Editora da UFPel, 2021. p. 423-440.

MATTOS, João Cancio Nunes de. **Influencia da syphilis sobre a marcha da prenhez**. 1870. 22 f. Dissertação (Doutoramento em Medicina) – Faculdade de Medicina da Bahia, Bahia, 1870. Disponível em: <http://resource.nlm.nih.gov/101464116>. Acesso em: 13 dez. 2025.,

MOTA, Karla R.; ALBUQUERQUE, Suzana L. **A Ciência na Sciencia: homeopatia versus alopatia no periódico brasileiro oitocentista (1847–1848)**. Revista Tecnia, Goiânia, v. 3, n. 2, p. 68–89, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ifg.edu.br/tecnia/article/view/913>. Acesso em: 25 jan. 2026.,

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. “Desafios e possibilidades na apropriação de cultura política pela historiografia”. In MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Org.). **Cultura Política na História: Novos Estudos**. Belo Horizonte: Argumentum, 2009, pp. 13-37.

NASCIMENTO, Dilene Raimundo do. **As pestes do século XX: tuberculose e Aids no Brasil, uma história comparada**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.

NASCIMENTO, George Silva do. **Pátrio-biografia: Horácio de Almeida e a sua História da Paraíba**. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5953?locale=pt_BR. Acesso em: 15 jun. 2025.

NASCIMENTO, Emanuel Calixto do. **“A lepra e a ordem”**: uma história da construção do Hospital Colônia Getúlio Vargas – Paraíba (1929-1941). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/19429?locale=pt_BR. Acesso em: 15 jun. 2025.

NAXARA, Márcia Regina Capelari. **Estrangeiro em sua própria terra: Representações do brasileiro (1870/1920)**. São Paulo: Annablume, 1998.

NEVES, Frederico de Castro. **A multidão e a história**: saques e outras ações de massas no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2000.

Ó, ALARCON AGRA DO. **Relatos de Males**: notas acerca dos modos de adoecer na Paraíba Imperial. In: Ó, Alarcon Agra do et al. *A Paraíba no Império e na República: estudos de história social e cultural*. 2ª. Ed. João Pessoa: Ideia, 2005. p. 11-45.

PATROCÍNIO, José do. **Os Retirantes**. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, 2014.

PEIXOTO, Thayná Cavalcanti. **José Rodrigues da Costa**: um tipógrafo na Cidade da Parahyba (1848-1866). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017a. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9514?locale=pt_BR. Acesso em: 23 de dez. de 2025.

PEIXOTO, Thayná Cavalcanti. **O Publicador (1862-1886)**: o circuito de comunicação do primeiro jornal diário da Paraíba do Norte. 2023. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/4601bf40-7887-4c65-8f80-860a154042f3>. Acesso em: 23 de dez. de 2025.

PEREIRA, Fábio da Silva. Fatores econômicos na Guerra da Tríplice Aliança nos anos de 1865 a 1876. In: XXIX Simpósio Nacional de História, 2017, Brasília. Anais eletrônicos. Brasília: **Anais do XXIX Simpósio Nacional de História - contra os preconceitos: história e democracia**, 2017. v. 1. p. 1-16.

SANTOS, J. C. P.; SILVA, L. S..UMA DE SUAS MAIS BEM FECUNDAS ESPERANÇAS: A TRAJETÓRIA DE MANOEL PEDRO CARDOSO VIEIRA. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), [S. l.], v. 12, n. Ed. Especi, p. 479–503, 2020. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/959>. Acesso em: 24 jul. 2025.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História & história cultural**. 2ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2004b.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e literatura: uma velha-nova história. In: COSTA, Cléria Botelho da & MACHADO, Maria Clara Tomaz. **História e literatura: identidades e fronteiras**. Uberlândia: EDUFU, 2006c.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **O imaginário da cidade: visões literárias do urbano**: Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Editora da Universidade/UFRGS, 1999a.

PESAVENTO, Sandra Jatay; LANGUE, Frédérique. (Orgs.). **Sensibilidades na história: memórias singulares e identidades sociais**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007d.

PINTO, Irineu Ferreira. O cholera-morbus na Paraíba. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba**, n. 2, 1910, p. 117-132.

PINTO, Irineu Ferreira. **Datas e Notas para a História da Parahyba**. João Pessoa: UFPB, 1977.

PIMENTA, T. S. Transformações no exercício das artes de curar no Rio de Janeiro durante a primeira metade do Oitocentos. História, Ciências, Saúde – **Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 11, supl. 1, p. 67–92, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/jdFKcM8qzkYTRR3g6t6fXLJ/?lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2025.

PORTER, Roy. História do corpo. In: BURKE, Peter (org.). **A escrita da história: novas perspectivas**. São Paulo: Unesp, 1992. p. 293-310.

RAMALHO, Maria Francisca de Jesus Lírio; GUERRA, Antonio José Teixeira. O risco climático da seca no semiárido brasileiro. **Territorium**, n. 25, p. 61-74, 2018. Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/1647-7723_25-1_5. Acesso em: 19 de jan. de 2026.

REBOUÇAS, André. **As seccas nas províncias do Norte**. Rio de Janeiro: Tipografia G. Leuzinger e Filhos. 1877.

REVEL, Jacques; PETER, Jean-Pierre. O Corpo – O Doente e Sua História. In: LE GOFF, Jacques (dir.). **História: Novos Objetos**. Rio de Janeiro: F. Alves, 1995. P. 141-159.

RIBEIRO, Filipe Nicoletti. **A “Constituinte constituída”**: o Poder Moderador, o ministério Sinimbu e o parlamento nos antecedentes da adoção da eleição direta no Império do Brasil (1878-1880). Almanack, p. 242-265, 2018.

ROCHA, Solange Pereira da. **Gente Negra na Paraíba Oitocentista**: população, família e parentesco espiritual. Recife: Tese (Doutorado em História), PPGH/UFPE, 2007a.

ROCHA, Solange P. Cardoso Vieira, um homem negro na composição das elites da Paraíba Oitocentista: Biografia, Memória e História. **Revista Crítica Histórica**, v. 3, n. 6, 2012b. Disponível em: <https://periodicos.ufal.br/criticahistorica/article/view/2893>. Acesso em: 10 de dez. de 2025.

ROHAN, Henrique de Beaurepaire, Visconde de Beaurepaire, 1812-1894. **Considerações acerca dos melhoramentos de que, em relação às secas são susceptíveis algumas províncias do norte do Brasil**. 2.ed. Rio de Janeiro: Typ. do Globo, 1877. 20 p.

RÜSEN, Jorn. **Razão histórica**: teoria da historia: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: EDUNB, 2001.

SCOVILLE, André. **A literatura das secas**: um estudo das representações da seca na literatura brasileira. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Literatura, Curitiba, 2011. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/26633/Andre%20Scoville%20-%20Tese%20Literatura%20das%20secas%20-%20versao%20final.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 23 jul. 2025.

SÁ, Ariane Norma de Menezes. **Escravos, livres e insurgentes**: Paraíba, 1850-1888. João Pessoa: Editora UFPB, 2009.

SECRETO, María Verónica. A seca de 1877-1879 no Império do Brasil: dos ensinamentos do senador Pompeu aos de André Rebouças: trabalhadores e mercado. História, Ciências,

Saúde – **Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 33–51, jan.–mar. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/ynZxC9TkBJS5GdCnjKXmGKd/>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SEGAL, Myraí Araújo. **Espaços de autonomia e negociação**: a atuação dos deputados provinciais paraibanos no cenário político imperial (1855-1875). Dissertação (Mestrado em História) - João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9616?locale=pt_BR. Acesso em 14 de set. de 2025.

SEIXAS, Wilson Nóbrega. **Velho Arraial de Piranhas (Pombal)**: no centenário de sua elevação à cidade. Pombal: A União, 1962.

SILVA, A. C. H. da. POR UMA SOCIONOMIA OITOCENTISTA: PENSAMENTO, VIDA E AÇÃO DE ANDRÉ REBOUÇAS, SÉCULO XIX. **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**, [S. l.], v. 10, n. 25, p. 08–25, 2018. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/604>. Acesso em: 1 jul. 2025.

SILVA, F. T.; DIAS, M. O.; PINTO, A. C.; SANTOS, N. P. “Pós de doliarina e ferro”: um dos remédios importantes da Farmácia Peckolt. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, p. 1427-1439, out./dez. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702015000400012>. Acesso em: 23 Jan. 2026.

SILVA, Gilson Lopes da. A fundação das casas de caridade ibiapinianas na região nordeste (1860-1872). **VII CONEDU - Conedu em Casa..** Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/79715>. Acesso em: 22/12/2025 09:24

SILVA, Júlio César Alves da. **Para a melhoria da raça e a civilização do povo paraibano**: uma história da eugenia na Paraíba (1914-1921). 2013. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/5991?locale=pt_BR. Acesso em: 15 de jun. de 2025.

SILVA, Lucian Souza da. **Nada mais sublime que a liberdade**: O processo de abolição da escravidão na Parahyba do Norte (1870-1888). Dissertação (Mestrado em História), PPGH/UFPB, João Pessoa, 2016a. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9529?locale=pt_BR. Acesso em: 24 de out. de 2025.

SILVA, Lucian Souza da. **Esmagando a cabeça da Hidra**: escravidão, liberdade e abolição na Paraíba do Norte, 1877-1888. 2021. Tese (Doutorado em História) - Universidade

Federal de Pernambuco, Recife, 2021b. Disponível em:
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/314>. Acesso em 14 de jun. de 2025.

SILVA, Márcio Douglas de Carvalho. MIGRAÇÕES, MOLÉSTIAS, SOBREVIVÊNCIAS: CEARENSES E PIAUIENSES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (TERESINA-1879). **Almanack**, 2024. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/alm/a/drZMNV6zCdZ867bfcmlr6Gq/abstract/?lang=pt>. Acesso em 21 de dez. de 2025.

SILVA, Márcio Douglas de Carvalho e. As disputas políticas em torno do fornecimento da carne verde no Piauí, na seca de 1877–1879. **Revista Trilhas da História**, Campo Grande, v. 14, n. 29, p. 422–438, set. 2025. DOI: 10.55028/th.v14i29.22685. Disponível em:
<https://periodicos.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/22685>. Acesso em: 15 jan. 2026.

SILVA, Rosimeire Pereira da. **Morte e Seca**: a cidade de São João do Rio do Peixe (PB) durante a estiagem de 1877/79. Monografia/História/UFCG, 2012. Disponível em:
<https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/10694>. Acesso em: 17 de fev. de 2025.

SILVA, Wuendisy Fortunato. **Artes de curar em confronto?** disputas, ofícios e práticas de cura na Paraíba Imperial (1870-1880). Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2020. Disponível em:
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22015?locale=pt_BR. Acesso em: 6 de jan. de 2026.

SILVEIRA, A. J. T. A medicina e a influenza espanhola de 1918. **Tempo**, Rio de Janeiro, n. 19, p. 91–105, dez. 2005. DOI: 10.1590/S1413-77042005000200007. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/tem/a/NKD7ySCGFvVHcsMWWVb5cQH/?format=pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVEIRA, Anny Jackeline Torres; NASCIMENTO, Dilene Raimundo. A doença revelando a história. Uma historiografia das doenças. In: NASCIMENTO, Dilene Raimundo; CARVALHO, Diana Maud (orgs). **Uma história brasileira das doenças**. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 13-30.

SILVEIRA, Regina P. S. **(Re)lendo "História de Campina Grande" de Elpídio de Almeida**: uma construção histórica da "grande" campina. 2014. 121f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/items/676949d3-fcb1-4947-bb3b-67ba77cce9e9>. Acesso em: 14 de dez. de 2025.

SILVEIRA, R. M. G. A Cultura Histórica em representações sobre territorialidades. **Saeculum**, [S. l.], n. 16, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/11370>. Acesso em: 16 ago. 2024.

SIMONINI, Yuri. Do vazio incógnito a problema nacional: o Nordeste brasileiro sob o olhar politécnico, 1877-1909. **História e Cultura**, v. 9, n. 1, p. 118-137, 2020. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10100152.pdf>. Acesso em 15 dez. 2024.

SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René. **Por uma história política**. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1986.

SOARES JR. A. S. **Physicamente vigorosos**: medicalização escolar e modelação de corpos na Paraíba (1913-1942). Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8230?locale=pt_BR. Acesso em: 10 jun. 2025.

SOARES JR., Azemar S. História e historiografia da saúde e das doenças na paraíba. **Fênix** - Revista de História e Estudos Culturais, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 100–133, 2021. Disponível em: <https://www.revistafenix.pro.br/revistafenix/article/view/1116>. Acesso em: 22 jun. 2024.

SONTAG, Susan. **A doença como metáfora**. Tradução de Márcio Ramalho. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

SOUSA, Eveline Almeida de. **Território nacional em movimento**: a trajetória de Henrique Beaurepaire Rohan (1844–1884). 2022. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022. Disponível em: <https://catalogobibliotecas.uff.br/acervo/321601>. Acesso em: 10 dez. 2024.

SOUSA, Máira Oliveira de. O sertão ao som dos bacamartes: a atuação de bandoleiros nas regiões de divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba no período de 1877 a 1879. **Revista Hydra**: Revista Discente de História da UNIFESP, São Paulo, v. 6, n. 12, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/view/14293>. DOI: 10.34024/hydra.2023.v6.14293. Acesso em: 09 jan. 2026.

SOUZA JR., Laércio de Araújo. **Um luctuoso theatro de dor e desesperação**: emoções fúnebres na Parahyba do Norte diante da epidemia de cólera-morbo (1854-1858). Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.unirio.br/cchs/ppgh/producao-academica/dissertacoes-de-mestrado-e-egressos-pasta/um-luctuoso-theatro-de-dor-e-desesperacao-emocoes-funebres->

[na-parahyba-do-norte-diante-da-epidemia-de-colera-morbo-1854-1858](#). Acesso em: 10 de dez. 2025.

SOUZA, Maria Regina Santos de. A lei do recrutamento militar de 1874 e as resistências abertas a esta nas províncias do Norte do Brasil (1875). In: **Encontro internacional de jovens investigadores**, 1., 2018, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Realiza Editora. p. 1-12. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/49448>. Acesso em: 08 jun. 2025.

TARGINO, Elyonara de Brito Lyra. **Para além dos muros hospitalares: a atuação médica na Parahyba na segunda metade do oitocentos**. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23057?locale=pt_BR. Acesso em: 6 de jan. de 2026.

TEÓFILO, Rodolfo M. **A Fome: cenas da seca do Ceará**. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2015a. (Coleção Clássicos Cearenses).

TEÓFILO, Rodolfo M. **Historia da secca do Ceará**, 1877 a 1880. Typ. do Libertador, 1883a.

THOMPSON, Edward P. **A miséria da teoria ou um planetário de erros**. Rio de Janeiro: Zahar, 1981b.

THOMPSON, Edward P. **A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade**. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997b. p. 9-14.

THOMPSON, Edward P. **As peculiaridades dos ingleses**. In.: NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Sergio (orgs.). E. P. Thompson: as peculiaridades dos ingleses e outros artigos. 3. ed. Campinas: Unicamp, 1998c. v. 1. (Coleção Textos Didáticos).

TRABALHOS DO CONGRESSO AGRÍCOLA DO RECIFE. 1878. **Edição Fac-Similar reproduzida do original publicado em 1879 pela Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco**. Recife, CEPA/PE. Disponível em: <https://abrir.link/SaUsq>. Acesso em: 12 out. 2024.

TWAK, Marcelo Messias; SÁ, Evandro Duarte de. **O banditismo social no cangaço romântico de Jesuíno Brilhante**. [S. l.], [s. n.], 2023. PDF disponível em: https://univisa.edu.br/wp-content/uploads/2023/07/ATHOS_08_O-banditismo-social-no-cangaco-romantico-de-Jesuino-Brilhante.pdf. Acesso em: 23 jan. 2026.

VAINFAS, Ronaldo. **História das Mentalidades e História Cultural**. In: CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 189-241.